醫師二階136題
錯題詳解彙編

iPad閱讀版 · 更新日期：2026年10月10日

使用方式

點選題號可跳到詳解；每頁右下角可返回題號目錄。保留文字搜尋、書籤、來源連結與離線閱讀。

內容與本次校正

本冊收錄136題。依原始成績單修正醫學（三）Q6、Q7轉錄錯誤：新增Q6詳解，Q7個人選項改為C並重寫失分推論。其餘134題保留既有正文，未在本次全面重新驗證醫學正確性。既有補寫版、重建版的標示與日期保留。

原對話部分試題附圖尚未嵌入；保留原有影像描述與考選部試題連結。

醫學（六）· 32題

Q1 補寫 · p.4	Q2 補寫 · p.6	Q7 · p.9	Q10 · p.12
Q14 · p.15	Q16 · p.19	Q17 · p.23	Q18 · p.26
Q20 · p.29	Q21 · p.32	Q24 · p.35	Q26 · p.38
Q29 · p.41	Q32 · p.44	Q35 · p.47	Q37 · p.50
Q40 · p.53	Q42 · p.56	Q45 · p.59	Q48 · p.63
Q50 · p.67	Q51 · p.70	Q53 · p.74	Q55 · p.78
Q58 · p.82	Q60 · p.85	Q61 · p.89	Q62 · p.93
Q70 · p.96	Q72 · p.100	Q77 · p.104	Q80 · p.107

醫學（五）· 29題

Q1 · p.110	Q4 · p.113	Q8 · p.116	Q11 · p.119
Q12 · p.122	Q18 · p.126	Q19 · p.130	Q26 · p.133
Q27 · p.136	Q28 · p.140	Q30 · p.143	Q31 · p.147
Q33 · p.151	Q37 · p.155	Q38 · p.159	Q39 · p.163
Q40 · p.168	Q45 · p.171	Q48 · p.174	Q55 · p.178
Q56 · p.182	Q59 · p.186	Q63 · p.190	Q66 · p.193
Q68 · p.196	Q71 · p.199	Q72 · p.202	Q75 · p.205
Q76 補寫 · p.208			

醫學（四）· 47題

Q2 · p.210	Q3 · p.214	Q4 · p.218	Q5 · p.222
Q6 · p.226	Q7 · p.229	Q8 · p.232	Q9 · p.235
Q11 補寫 · p.239	Q12 補寫 · p.241	Q13 補寫 · p.243	Q15 補寫 · p.245
Q16 重建 · p.248	Q18 重建 · p.250	Q20 · p.252	Q21 · p.254
Q22 · p.256	Q24 · p.259	Q26 · p.262	Q30 · p.264
Q31 · p.266	Q32 · p.268	Q36 · p.271	Q37 · p.273
Q41 · p.276	Q42 · p.278	Q44 重建 · p.280	Q45 重建 · p.282
Q48 · p.284	Q51 · p.287	Q52 · p.290	Q54 · p.293
Q55 · p.296	Q56 · p.298	Q58 · p.300	Q59 · p.302
Q60 · p.305	Q61 · p.308	Q63 · p.310	Q64 · p.313
Q66 · p.316	Q68 · p.318	Q69 · p.321	Q71 · p.323
Q72 補寫 · p.325	Q76 補寫 · p.328	Q77 · p.331	

醫學（三）· 28題

Q4 · p.334	Q5 · p.336	Q6 新增 · p.338	Q7 校正 · p.340
Q12 · p.343	Q16 · p.346	Q17 · p.349	Q18 · p.352
Q21 · p.354	Q24 · p.357	Q26 · p.359	Q33 · p.361
Q34 · p.363	Q35 · p.366	Q42 · p.368	Q43 · p.370
Q44 · p.372	Q46 · p.374	Q47 · p.376	Q49 · p.378
Q51 · p.380	Q56 · p.383	Q57 · p.386	Q60 · p.389
Q61 · p.391	Q67 · p.393	Q69 · p.395	Q78 · p.398

本次作答與成績核對

項目	校正後
醫學（三）Q6 / Q7	B / C（官方C / A）
醫學（三）正式計分	51/80 = 63.75，與原始成績單相符
心臟血管 / 急救分類	8/11 = 72.7%（沿用先前分類）
複習清單	醫學三28 + 四47 + 五29 + 六32 = 136

Q40按原規格排除所有多答案題，因此醫學（三）正式失分29題、複習28題。

「補寫」與「重建」保留原版日期；Q6為2026-10-10新增，Q7為本次校正。Q7先前以選B推論的影像失誤撤回，改以實際選C安排選藥、抗凝及迷走刺激的複習。

醫學（六）Q1

本次補寫版 2026-10-07

主題：拔管期氣道併發症與肺水腫機轉

本次補寫版，2026年10月7日完成。原始詳解尚未回收；以下依正式試題、原始答案、最終更正及所列醫學來源重建。

題目與答案對照

手術完成後，全身麻醉甦醒拔管（extubation of the trachea）時期，下列何者是最不可能發生之氣道相關併發症？

- A. 上呼吸道阻塞
- B. 支氣管痙攣
- C. 杓狀軟骨脫位（arytenoid dislocation）
- D. 神經性肺水腫

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
A	D	D	無；本題未列於更正備註

參考來源：考選部正式試題；考選部原始答案；考選部最終更正檔。

個人作答取自本對話已保存的80題作答序列；以上三份官方檔案均於本次補寫重新核對。

核心考點

本題要區分**氣道操作直接相關的事件**與**嚴重中樞神經損傷引起的肺水腫**。拔管後喉痙攣或上呼吸道阻塞，可以造成負壓性肺水腫；不能把這個機轉寫成神經性肺水腫。

負壓性肺水腫（NPPE / postobstructive pulmonary edema）發生在患者對抗阻塞用力吸氣後；神經性肺水腫（NPE）則與急性腦傷、蜘蛛網膜下腔出血或癲癇等神經事件相關。兩者可能有相似的低血氧、肺水腫外觀，病因分類卻不同。

各選項解析

A．上呼吸道阻塞——可能發生

殘餘麻醉作用、舌根後墜、喉頭水腫、分泌物或喉痙攣，均可使拔管後氣道不通。因此A是重要的拔管期風險，不是本題最不可能的選項。

B．支氣管痙攣——可能發生

氣道刺激、氣道高反應性或既有氣喘等情境下，可發生支氣管痙攣。它是下呼吸道事件，與喉頭層級的喉痙攣不同；不能因患者已拔管就排除。

C．杓狀軟骨脫位——少見但屬氣道操作併發症

氣管插管或其他喉部操作可能造成環杓關節損傷，術後可表現為持續聲音沙啞、發聲或吞嚥異常。原始研究確實記錄插管後杓狀軟骨脫位。

它不必在拔管瞬間才形成，也不代表所有術後沙啞都是脫位；本題將它列為氣道操作相關事件，在四個選項中仍比D有直接關聯。

D．神經性肺水腫——最不可能，為官方答案

神經性肺水腫的關鍵背景是顯著中樞神經事件及相關自主神經 / 交感反應；題幹未提供這類病史。一般拔管後阻塞所接續的肺水腫，更直接聯想到NPPE。

『最不可能』不是『任何手術情境都絕不可能』。若同時有嚴重腦傷、顱內出血或癲癇，仍需把NPE納入鑑別。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選A可能是低估麻醉甦醒期仍會上呼吸道阻塞；也可能記得拔管後會肺水腫，卻沒有再辨認負壓性與神經性這兩個名稱的機轉差異。

這是複習用的可能解釋，不能據此確認你作答當時的實際思路。

失分類型

- 氣道併發症辨識
- 相近名稱與病理機轉
- 題幹未提供的神經事件背景

數秒判斷規則

> **拔管後喉痙攣、阻塞再肺水腫，先想負壓性；嚴重腦部事件後肺水腫，才優先想神經性。**

投資報酬率

高。可延伸至麻醉甦醒、急性低血氧、喉痙攣及肺水腫的鑑別。

國考答案與現代臨床差異

- 國考答案D合理，但不是禁止在神經外科或腦傷患者考慮NPE。
- NPPE與NPE是不同的病因分類；臨床另須排除吸入性損傷、心因性或容量負荷相關肺水腫。
- 若拔管後持續沙啞，需依病程與喉鏡檢查區分水腫、聲帶麻痺及杓狀軟骨損傷，不能單憑症狀直接診斷。

補寫所用來源

- OpenAnesthesia 阻塞後肺水腫
- 神經性肺水腫與急性腦傷的證據回顧
- 插管後杓狀軟骨脫位的原始研究

醫學（六）Q2

本次補寫版 2026-10-07

主題：輸液反應性與動態指標

本次補寫版，2026年10月7日完成。原始詳解尚未回收；以下依正式試題、原始答案、最終更正及所列醫學來源重建。

題目與答案對照

78歲洗腎病人被公車撞，導致骨盆及大腿骨骨折，經急救復甦後入住加護病房，並使用呼吸器治療。在給與輸液或輸血治療時，下列何者為最合適此病人使用的輸液反應（fluid responsiveness）評估指標？

- A. 量測中央靜脈壓（central venous pressure）
- B. 計算脈壓變異率（pulse pressure variation）
- C. 被動式抬腿測試（passive leg raising test）
- D. 量測血壓

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
A	B	B	無；本題未列於更正備註

參考來源：考選部正式試題；考選部原始答案；考選部最終更正檔。

個人作答取自本對話已保存的80題作答序列；以上三份官方檔案均於本次補寫重新核對。

核心考點

輸液反應性指的是增加前負荷後，**心搏量或心輸出量是否會增加**。它不是現在的血壓高低，也不是用單一靜態壓力判定體內水量。

題幹的選擇線索是機械通氣、骨盆及大腿骨骨折：在適用条件成立時，PPV可利用呼吸造成的心肺交互作用評估反應；抬腿則可能不適合這名有骨盆及下肢創傷的患者。2025 ESICM指引支持在適當情境優先使用動態變數。

各選項解析

A．CVP——不能以單一數值可靠預測輸液反應

CVP會受到右心功能、胸腔壓力、靜脈回流及容量狀態等影響。同一個CVP，患者可能有反應，也可能沒有反應，不能直接等同Frank–Starling曲線所在位置。

這不代表CVP完全沒有用途：它可協助評估右心充盈、靜脈壅塞或追蹤變化。錯的是把它當成本題最佳的單一輸液反應性指標。

B．PPV——本題最佳答案，但有適用限制

PPV是呼吸週期內脈壓的相對變化，常用公式為（PPmax - PPmin）/ 平均脈壓×100%。在充分控制的正壓通氣與規則心律下，較能反映前負荷依賴。

須確認無明顯自主呼吸干擾、心律規則、潮氣量足以產生可判讀的心肺交互作用；低潮氣量、嚴重右心功能異常或其他特殊情境可能使結果失真。題幹未完整交代這些條件，所以不能記成『接呼吸器就一定用PPV』。

C．PLR——方法本身有效，但本例有操作限制

PLR可作為可逆的前負荷挑戰；若能安全操作並即時測量心輸出量或心搏量變化，對自主呼吸或某些心律不整患者也有價值。

本例有骨盆、大腿骨骨折，抬腿與改變姿勢可能造成疼痛、移位或操作困難，應先評估安全性與固定情形。這是個案限制，不應寫成PLR對所有呼吸器患者都無效。

D．血壓——重要監測，但不等於輸液反應性

血壓除了心輸出量，也受血管張力影響。升壓藥可能提高血壓而不增加心搏量；正常血壓亦不能保證組織灌流充分。單看血壓因此不如適用條件下的動態評估。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選A可能是把常用的CVP監測直接當成輸液反應預測，或沒有利用骨盆、下肢骨折來辨認PLR的操作限制。

這是複習用的可能解釋，不能據此確認你作答當時的實際思路。

失分類型

- 動態與靜態指標
- 操作適用條件
- 輸液反應性與輸液需要區分

數秒判斷規則

先問能否安全做PLR；控制通氣且PPV條件成立可選PPV。CVP、血壓不能單獨預測補液反應。

投資報酬率

極高。可延伸至休克、敗血症、創傷復甦及透析患者的容量管理。

國考答案與現代臨床差異

- 國考選B；題幹省略了PPV成立條件，臨床必須補問通氣模式、心律與潮氣量等資訊。
- 有輸液反應不等於一定需要輸液。還須確認低灌流是否會受益，以及肺水腫、靜脈壅塞等風險；洗腎患者尤其不能只依PPV反覆補液。
- 輸血的適應症還要結合活動性出血、血紅素、凝血及整體復甦需要，不能由PPV單獨決定。

補寫所用來源

- 2025 ESICM 指引原始論文
- ESICM 官方指引摘要
- ESICM 官方圖解摘要

醫學（六）Q7

對話詳解原文

1. 題目

下列何者**不是**聚焦心臟超音波檢查（focused cardiac ultrasound, FoCUS）最主要的視圖（view）？

- A. 心尖長軸視圖（apical long-axis view, ALAX）
- B. 胸骨旁短軸視圖（parasternal short-axis view, PSAX）
- C. 心尖四腔視圖（apical four-chamber view, A4C）
- D. 劍突下四腔視圖（subcostal four-chamber view, SC4）

2. 作答對照

- 使用者答案：C
- 考選部原始答案：A
- 考選部最終更正答案：A
- 是否有多答案接受或一律給分：否

考選部的醫學六原始答案與最終更正答案在 Q7 均為 A。

3. 核心考點

本題不是問「哪個視圖完全不能用於心臟 POCUS」，而是問**基礎 FoCUS 標準掃描的核心視圖集合**。

EACVI 的 FoCUS core syllabus 將標準視圖列為：

- 胸骨旁：PLAX、PSAX
- 心尖：A4C
- 劍突下：SC4、IVC

其中並不包含 ALAX。EACVI FoCUS core syllabus

最容易混淆的是：

> 標準核心長軸視圖是 **PLAX（parasternal long-axis）**，不是 **ALAX（apical long-axis）**。

4. 各選項逐一解析

A. 心尖長軸視圖（ALAX）——國考答案

ALAX 又稱 apical three-chamber view，可看見左心房、二尖瓣、左心室、左心室流出道、主動脈瓣及近端主動脈。

它是**有效而且臨床可使用的心臟超音波視圖**，但不屬於 EACVI 所列的基本 FoCUS 核心視圖，因此在「最主要的視圖」這個語境下應選 A。

要注意：ACC 的 cardiac POCUS workbook 確實把 ALAX 列入較完整的 POCUS 影像取得流程，所以不能把本題記成「FoCUS 絕對不做 ALAX」；正確記法是「ALAX 不是基本核心集合」。ACC Cardiovascular POCUS Workbook

B. 胸骨旁短軸視圖（PSAX）——核心視圖

PSAX 是標準 FoCUS 視圖，可從不同高度觀察：

- 主動脈瓣與右心流出道
- 二尖瓣
- 乳突肌層級的左右心室
- 左心室整體收縮
- 右心壓力負荷造成的 D-shaped LV

題目沒有提供任何理由排除 PSAX。

C. 心尖四腔視圖（A4C）——核心視圖

A4C 是標準核心視圖，可比較：

- 左右心室大小
- 整體雙心室收縮功能
- 心房大小
- 二尖瓣、三尖瓣
- 心包膜積液

ASE 指出心尖視圖相對較難取得，且容易因 foreshortening 產生誤判；但「比較難做」不等於「不是核心視圖」。ASE FoCUS Recommendations

D. 劍突下四腔視圖（SC4）——核心視圖

SC4 是標準核心視圖，對仰臥、重症、創傷或 CPR 患者尤其實用，可評估：

- 心包膜積液
- 心包填塞相關腔室塌陷
- 左右心室整體狀態
- 延伸至 IVC 容量狀態評估

因此 D 不能選。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

你選了 C，可能是因為知道 ASE 曾提醒「心尖視圖較難取得、較容易 foreshortening」，進而把「技術上較困難 / 某些情境較不優先」誤當成「不屬於主要視圖」。

另一個可能是沒有立即辨識：

- 正確的基礎長軸：**PLAX**
- 選項偷偷換成：**ALAX**

這是典型的縮寫與視圖層級辨識題。

6. 失分類型

- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 次標籤：名詞混淆
- 次標籤：核心視圖與延伸視圖
- 輕度爭議或低效度題

之所以帶有輕度爭議，是因為 ALAX 並非錯誤或不能使用的 POCUS 視圖；答案依賴「最主要」所指的核心 syllabus。

7. 下次判斷規則

> FoCUS 基本視圖記成 **PLAX**、**PSAX**、**A4C**、**SC4 + IVC**；看到 ALAX，先判斷它是否只是拿來偷換 PLAX。

8. 投資報酬率

高

- FoCUS 視圖、心包填塞、右心負荷及容量評估都常考。
- 能延伸至休克、創傷、麻醉與 ACLS 題。
- 十月值得用一張圖重新整理各視圖及可回答的臨床問題。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**A。
- **現代臨床實務：**ALAX 是真實且有用的視圖，也可能出現在較完整的 cardiac POCUS protocol。
- **爭議或限制：**本題只能依「基本核心視圖」解讀；若題目問「何者不能用於 POCUS」，A 就不再是嚴謹答案。

醫學（六）Q10

對話詳解原文

1. 題目

一位高度近視患者最近突然出現明顯之飛蚊症，眼底檢查結果如圖所示，此患者最有可能出現下列何種疾病？

題目附圖可見一個明顯的**馬蹄形 / 瓣狀視網膜裂孔**。

- A. 牽引性視網膜剝離（tractional retinal detachment）
- B. 裂孔性視網膜剝離（rhegmatogenous retinal detachment）
- C. 滲出性視網膜剝離（exudative retinal detachment）
- D. 葡萄腫（staphyloma）

完整附圖可見考選部醫學六正式試題。

2. 作答對照

- 使用者答案：C
- 考選部原始答案：B
- 考選部最終更正答案：B
- 是否有多答案接受或一律給分：否

Q10 在原始答案及最終更正答案均為 B。

3. 核心考點

本題要求將三項線索串成同一個病理機轉：

1. **高度近視**：裂孔性視網膜剝離危險因子。
2. **突然大量飛蚊症**：急性後玻璃體剝離、視網膜裂孔或剝離的警訊。
3. **眼底馬蹄形裂孔**：全層視網膜破裂，液化玻璃體可經裂孔進入視網膜下。

因此機轉是：

> 視網膜裂孔 → 液化玻璃體進入視網膜下腔 → 裂孔性視網膜剝離。

NEI 對三型剝離的區分也以此為核心：裂孔性有 tear/break；牽引性由疤痕組織拉扯；滲出性則是無裂孔的液體滲漏。美國 National Eye Institute

4. 各選項逐一解析

A. 牽引性視網膜剝離——錯誤

牽引性剝離是纖維血管膜或疤痕組織收縮，把視網膜拉離眼底。

典型條件包括：

- 增殖性糖尿病視網膜病變
- 早產兒視網膜病變
- 其他造成增殖性視網膜病變或瘢痕的疾病

外觀常呈凹面、帳篷狀或固定皺褶，通常**不需要全層裂孔**。本題沒有糖尿病、纖維血管膜或瘢痕，反而直接顯示馬蹄形裂孔。

B. 裂孔性視網膜剝離——正確

本型定義就是存在視網膜裂孔，使液化玻璃體進入視網膜下。

題幹支持點：

- 高度近視增加裂孔性剝離風險。
- 突發飛蚊症提示急性玻璃體—視網膜牽引。
- 圖片顯示典型 horseshoe/flap tear。

ASRS 將高度近視列為裂孔性視網膜剝離的危險因子，典型症狀包括飛蚊、閃光及視野簾幕感。 American Society of Retina Specialists

C. 滲出性視網膜剝離——錯誤

滲出性剝離是血管滲漏或發炎，使液體累積於視網膜下，**但沒有裂孔，也不是疤痕牽拉**。

常見背景包括：

- 葡萄膜炎或其他眼內發炎
- 脈絡膜腫瘤
- Coats disease
- 嚴重血管滲漏
- 部分脈絡膜或黃斑疾病

本題圖片明確出現裂孔，因此與滲出性剝離的定義相反。

D. 葡萄腫——錯誤

葡萄腫是眼球壁局部向外膨出，常見於病理性高度近視，尤其是後葡萄腫。

「高度近視」確實支持葡萄腫背景，但：

- 葡萄腫無法解釋圖中的馬蹄形裂孔。
- 通常不是以突然大量飛蚊症作為典型表現。
- 它可以與高度近視共存，卻不是本題的最佳診斷。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

你選了 C，可能是看到視網膜似乎隆起或周圍有視網膜下液，便從「有液體」直接連到滲出性剝離，沒有先辨認中央最具鑑別力的**馬蹄形全層裂孔**。

另一種可能是沒有把三型剝離依「液體如何進入 / 視網膜如何被拉開」分類：

- 裂孔性：液體經裂孔進入。
- 牽引性：瘢痕從內側拉起。
- 滲出性：血管滲漏，無裂孔。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 次標籤：影像辨識
- 次標籤：病理機轉分類
- 次標籤：危險因子與症狀線索

7. 下次判斷規則

> 眼底只要看到明確裂孔，先選裂孔性；牽引性看纖維膜，滲出性則必須沒有裂孔。

8. 投資報酬率

高

- 三型視網膜剝離的機轉、危險因子及外觀是常見考點。
- 能延伸至糖尿病視網膜病變、後玻璃體剝離、急性飛蚊症及眼科急症處理。
- 十月值得連同 retinal tear、PVD、lattice degeneration 一起複習。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**B，沒有答案爭議。
- **現代臨床實務：**本圖最直接顯示的其實是「症狀性馬蹄形視網膜裂孔」；它是裂孔性剝離的前驅或致病裂孔，不必等到出現大片剝離才處理。
- **臨床行動：**突然增加的飛蚊、閃光或視野簾幕感應接受緊急散瞳周邊視網膜檢查，因未及時處理可能造成永久視力損失。NEI 2025 臨床資訊
- **限制：**單張眼底照片不能判定完整剝離範圍、黃斑是否受累或最佳手術方式，但不影響本題 B 的計分。

醫學（六）Q14

對話詳解原文

1. 題目

關於原發性隅角開放青光眼（primary open-angle glaucoma, POAG），下列何者正確？

① 兩眼眼壓差距 4 mmHg 以上是危險因子
② 女性較男性多
③ 70 歲以上族群，亞洲人的盛行率比白種人高
④ 是歐洲人及非洲人最多的青光眼種類

- A. ①③
- B. ②④
- C. ②③
- D. ①④

題目核對自考選部醫學六正式試題。

2. 作答對照

- 使用者答案：A
- 考選部原始答案：D
- 考選部最終更正答案：D
- 是否有多答案接受或一律給分：否

原始答案與最終更正答案均將 Q14 列為 D。

3. 核心考點

本題測試兩個層次：

1. **青光眼可疑徵象：**兩眼眼壓明顯不對稱。

2. **不同族群的青光眼型態：**

- 非洲血統：POAG 盛行率最高、發病較早且較嚴重。
- 歐洲血統：仍以 POAG 為主要類型。
- 亞洲族群：原發性閉角型青光眼的相對負擔較高，但不能因此推成「亞洲老人 POAG 比白人更多」。

舊有年齡分層統合分析估計，70 歲以上 POAG 盛行率約為黑人16%、白人6%、亞洲人3%，因此③錯誤。Rudnicka 等人的族群盛行率統合分析

4. 各選項逐一解析

① 兩眼眼壓差距 4 mmHg 以上是危險因子——國考判定正確

同一患者兩眼受到的全身性因素大致相同，因此持續存在的明顯眼壓差異可提示：

- 較高眼壓眼的青光眼風險或損害可能較大。
- 是否有單眼繼發性因素。
- 是否需要進一步檢查視神經、RNFL、視野與隅角。

但這句話在現代實務中需要修正：主要指引列出的確立危險因子是**較高的眼壓本身**，並未普遍把「剛好 ≥4 mmHg」列成獨立、固定的診斷門檻。AAO POAG Preferred Practice Pattern

此外，眼壓受測量誤差、中央角膜厚度、時間與晝夜變化影響。單次相差4 mmHg只能算警訊，不能單獨診斷 POAG。

國考採用傳統教科書式記憶點，將①視為正確。

② 女性較男性多——錯誤

近年大型統合分析多顯示男性的 POAG 風險或盛行率稍高；一項全球風險因子統合分析中，女性相對男性的 POAG 風險較低，meta-OR 約0.76。2024全球青光眼風險因子統合分析

不過性別效應遠弱於：

- 年齡
- 眼壓
- 非洲血統
- 家族史
- 較薄中央角膜

部分地區可能因女性平均壽命較長而有較多女性患者，但不能據此把「女性」當成穩定的 POAG 危險族群。

③ 70歲以上亞洲人盛行率高於白種人——錯誤

這是你本題真正判斷錯誤的敘述。

亞洲人整體承受很大的青光眼疾病負擔，但其特色之一是**閉角型青光眼比例相對較高**；這不能直接套用到 POAG。

年齡標準化及年齡分層資料顯示，黑人 POAG 盛行率明顯最高；70歲以上的亞洲族群並沒有高於白人。全球研究也反覆確認非洲地區的 POAG 盛行率最高。全球 POAG 盛行率統合分析

④ POAG是歐洲人及非洲人最多的青光眼種類——正確

在歐洲及非洲血統族群，原發性青光眼主要由 POAG 構成。

其中非洲血統不只是盛行率較高，還常有：

- 較早發病
- 診斷時較嚴重

- 較快進展
- 較高失明風險

相對而言，原發性閉角型青光眼的全球病例高度集中於亞洲；估計全球八成以上 PACG 病例位於亞洲。
亞洲 PACG 系統性回顧

因此①④正確，答案為 D。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

你選 A，表示已接受①，但在③與④之間選錯。最可能是把：

> 亞洲人青光眼 / 閉角型青光眼負擔較高

過度延伸成：

> 亞洲老人的 POAG 盛行率也高於白人。

這不是完全不知道族群差異，而是**沒有把青光眼總體負擔、POAG與PACG分開**。

6. 失分類型

- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 次標籤：疾病亞型混淆
- 次標籤：族群流行病學
- 輕度爭議或低效度題

爭議主要在①的固定4 mmHg門檻，而不是最終答案中的③、④判斷。

7. 下次判斷規則

> 族群題先分型：**非洲血統想到 POAG；亞洲特色想到 PACG**，不要把「亞洲青光眼多」直接等同「亞洲 POAG 多」。

8. 投資報酬率

中高

- 青光眼分型與危險因子常考。
- 可延伸至 POAG、NTG、PACG及青光眼可疑患者。
- 精確族群百分比不值得死背，但「非洲—POAG、亞洲—PACG相對突出」值得保留。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**D，①④。

- **現代臨床實務：**持續眼壓不對稱是值得追查的警訊，但單次相差4 mmHg不是獨立診斷標準；應合併視神經、OCT、視野、角膜厚度、隅角及重複眼壓。
- **爭議或限制：**①使用「危險因子」而不是「青光眼可疑徵象」，措辭不夠精確；但③明顯錯、④明顯對，因此不影響國考唯一最佳答案。

醫學（六）Q16

對話詳解原文

1. 題目

有關典型視神經炎（typical optic neuritis）的臨床特徵，下列敘述何者正確？

- A. 視神經炎可能是多發性硬化症（multiple sclerosis）的第一個臨床症狀
- B. 視覺誘發電位的 P100 脈衝潛伏時間（latency）縮短
- C. 特徵多為無痛性急性失明
- D. 常合併視網膜滲出（retinal exudates）和棉絮斑（cotton-wool spots）

2. 作答對照

- 使用者答案：C
- 考選部原始答案：A
- 考選部最終更正答案：A
- 是否有多答案接受或一律給分：否

Q16 在考選部原始及更正檔中均為 A，沒有答案修正。

3. 核心考點

傳統所稱「典型視神經炎」，主要是年輕成人的典型脫髓鞘性、常與 MS 相關的 optic neuritis。典型表現可記成：

- 單眼為主
- 視力在數小時至數天內惡化，而不是瞬間達到最低點
- 眼球轉動疼痛
- 色彩飽和度下降，尤其紅色
- 相對性傳入瞳孔缺損（RAPD）
- 常有中央暗點
- 約三分之二眼底初期正常，即 retrobulbar neuritis
- VEP P100 latency延長

4. 各選項逐一解析

A. 可能是MS第一個臨床症狀——正確

視神經炎可以是 clinically isolated syndrome，也是 MS 的首次表現。

近期資料約估計，急性視神經炎是約四分之一 MS 患者的初始表現；MS患者終生約50–70%曾發生視神經炎。ECTRIMS 2025更新

但反向不能成立：第一次視神經炎不等於已經確診 MS。未來風險需依：

- 腦部及眼眶 MRI
- 是否已有其他脫髓鞘病灶
- CSF oligoclonal bands
- 臨床時間與空間播散
- 是否符合 MOGAD、NMOSD 或其他病因

B. P100 latency縮短——錯誤

脫髓鞘會使神經傳導變慢，因此 VEP 的典型變化是：

> **P100 latency延長，而非縮短。**

2025年針對2024 McDonald criteria的視神經評估文件指出，急性症狀眼約77–100%可檢出 P100 latency delay；恢復後延遲可能部分改善，但仍可持續存在。ACTRIMS / Lancet Neurology文件

快速區分：

- 脫髓鞘：latency延長較突出。
- 嚴重軸索喪失：amplitude下降或波形消失較突出。

C. 多為無痛性急性失明——錯誤

這是你的作答選項，也是本題最重要的校正點。

典型 MS-associated optic neuritis 通常有眼球轉動疼痛，疼痛常先於視力變化；視力多在數天內逐漸惡化，在約兩週達到低點，而不是典型的「突然、無痛、立即失明」。2024急性視神經炎臨床綜述

「突然且無痛的單眼視力喪失」反而要先考慮：

- 前部缺血性視神經病變（AION）
- 視網膜中央動脈阻塞
- 視網膜靜脈阻塞
- 視網膜剝離
- 其他血管性視神經病變

視神經炎確實可能無痛，也可能造成非常嚴重的視力損失，尤其 AQP4-ON；但那不能作為「典型視神經炎多為如此」的描述。

D. 常合併視網膜滲出與棉絮斑——錯誤

典型脫髓鞘性視神經炎主要侵犯視神經，不是以視網膜血管滲漏為核心。

常見眼底狀況為：

- 約三分之二視神經盤外觀正常。
- 約三分之一可能有視神經盤水腫。
- 不應「常見」明顯 retinal exudates 或 cotton-wool spots。

若看到大量視網膜滲出、棉絮斑、出血或 macular star，需考慮：

- 神經視網膜炎
- 高血壓或糖尿病視網膜病變
- 感染性病因
- 缺血性視神經病變
- 其他非典型 optic neuropathy

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

你選 C，可能把「視神經炎造成急性單眼視力下降」壓縮成「無痛性急性失明」，遺漏了典型表型中辨識度最高的**眼球轉動疼痛**與**數天進展**。

也可能把視神經炎與 AION 的典型輪廓對調：

- 視神經炎：年輕、痛、數天、色覺下降。
- AION：較年長、突然、無痛、常有血管危險因子。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 次標籤：典型症候群辨識
- 次標籤：時間軸與疼痛線索
- 次標籤：視神經炎與缺血性視神經病變鑑別

7. 下次判斷規則

> 年輕人單眼視力在數天內下降 + 轉眼痛 + 色覺下降，先想視神經炎；年長者突然無痛單眼視損，先想缺血或視網膜血管事件。

8. 投資報酬率

高

- 視神經炎與 AION 的鑑別是眼科、神經科共同常考題。
- 可延伸至 MS、NMOSD、MOGAD、RAPD、VEP與MRI判讀。
- 十月值得系統重讀，尤其是典型與非典型紅旗。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**A。

- **現代臨床實務：**現在不應把所有 optic neuritis 都塞入 MS；需區分 MS-ON、MOG-ON、AQP4-ON、感染與其他免疫性病因。
- **VEP定位：**P100延長支持脫髓鞘性視路損害，但不是視神經專一性，嚴重近視或黃斑疾病也可能影響結果，需與MRI及OCT合併解讀。
- **爭議或限制：**視神經炎可以無痛，也可能極嚴重；然而題目限定「典型」，因此 C 仍然明確錯誤。

醫學（六）Q17

對話詳解原文

1. 題目

甲狀腺眼病變患者若同時有眼瞼內縮（lid retraction）、眼球活動困難（decrease of eye movements）以及凸眼（exophthalmos），導致角膜破皮及視力受損，應優先考慮下列何種治療？

- A. 口服硒（selenium）100 μg，每天2次
- B. 眼皮矯正手術
- C. 眼肌肉手術
- D. 眼窩減壓手術

題目核對自考選部醫學六正式試題。

2. 作答對照

- 使用者答案：A
- 考選部原始答案：D
- 考選部最終更正答案：D
- 是否有多答案接受或一律給分：否

原始答案及最終更正答案均為 D。

3. 核心考點

本題不是單純問甲狀腺眼病變有哪些治療，而是要求依嚴重度選擇優先處置。

題幹已有兩個視力威脅警訊：

- 角膜破皮：嚴重暴露性角膜病變，可能進展至潰瘍、感染或穿孔。
- 視力受損：須同時排除壓迫性視神經病變。

這已屬於需要緊急眼科處理的 sight-threatening thyroid eye disease。四個選項中，眼窩減壓最能處理嚴重凸眼、眼窩壓力及暴露問題；硒、一般眼瞼矯正與斜視手術都不是此情境的主要優先治療。

4. 各選項逐一解析

A. 口服硒100 μg，每天2次——錯誤

硒可考慮用於：

- 輕度、近期發生且仍在活動期的甲狀腺眼病變。
- 改善輕度症狀及生活品質。
- 尤其適用於硒攝取不足的地區。

傳統療程為100 μg、每日兩次、共6個月。但它不能迅速解除嚴重眼球突出、角膜暴露或視神經壓迫。

題幹已出現角膜破皮及視力受損，治療強度不能停留在輕症藥物。EUGOGO也將硒定位於輕度活動性疾病，而不是視力威脅型疾病。2021 EUGOGO指引

B. 眼皮矯正手術——不是本題最佳答案

眼瞼手術可以改善眼瞼內縮及角膜暴露，但一般復健性手術通常安排在疾病穩定、非活動期，且常置於眼窩減壓及眼位矯正之後。

典型分期順序是：

1. 眼窩減壓。
2. 斜視 / 眼外肌手術。
3. 眼瞼位置矯正。

原因是減壓手術可能改變眼球位置，而眼外肌手術又可能影響眼瞼高度。

不過，現代臨床上若角膜已瀕臨潰瘍或穿孔，暫時性瞼緣縫合、眼表保護或其他緊急眼瞼處置也可能立即進行。因此「眼皮矯正手術」並非在所有急症中都不合理；只是題目沒有寫成具體的暫時性瞼緣縫合，而且患者同時有嚴重凸眼及視力受損，D仍是四項中的最佳答案。

C. 眼肌肉手術——錯誤

眼外肌手術主要處理：

- 限制性斜視。
- 穩定存在的複視。
- 疾病進入非活動期後的眼位偏差。

活動期的眼外肌腫脹與纖維化程度仍可能改變，過早手術的眼位結果不穩定。更重要的是，它不能直接解除嚴重眼球突出、眼窩尖端壓迫或暴露性角膜病變，因此不是視力受威脅時的第一步。

D. 眼窩減壓手術——正確

眼窩減壓藉由移除部分眼窩骨壁、脂肪或兩者，使腫大的眼外肌與脂肪有更多空間，可達到：

- 降低眼窩內壓力。
- 使眼球後退，改善嚴重凸眼。
- 減少角膜暴露。
- 必要時解除眼窩尖端的視神經壓迫。

因此，在本題「嚴重凸眼 + 角膜破皮 + 視力受損」的情境中，應優先考慮D。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇A可能表示已記得「甲狀腺眼病變可以補充硒」，但沒有先依嚴重度分層，因而把輕症治療套用到已有視力威脅的患者。

題目真正的決策關鍵不是疾病名稱，而是：

角膜破皮及視力受損是否已把病例升級為眼科急症。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 題幹理解 / 推理失誤
- 次標籤：嚴重度分層
- 次標籤：治療優先序
- 次標籤：適應症 / 禁忌症
- 次標籤：輕症治療套用至重症

7. 下次判斷規則

甲狀腺眼病變一旦出現角膜破損或視力下降，先當作視力威脅型急症；硒退場，立即保護角膜並評估類固醇與眼窩減壓。

8. 投資報酬率

高

- 疾病嚴重度與治療優先序是常考題型。
- 可延伸至壓迫性視神經病變、暴露性角膜病變及手術排序。
- 十月值得系統整理「輕度、活動性中重度、視力威脅型」三層治療。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**D，眼窩減壓手術。
- **現代臨床實務：**視力下降原因必須立即區分角膜病變與 dysthyroid optic neuropathy。視神經病變通常先給予高劑量靜脈注射 methylprednisolone；反應不佳時緊急減壓。嚴重角膜暴露則需密集潤滑、抗感染、保護性瞼緣縫合或其他手術，不能只等待減壓。EUGOGO指引、ATA / ETA共識聲明
- **爭議或限制：**題目把不同視力下降機制合在一起，也沒有提供活動度、視神經功能及角膜損害程度。實務處置會多線並進；但在所列四項中，D仍是唯一能處理嚴重眼窩擁擠與凸眼的最佳答案。

醫學（六）Q18

對話詳解原文

1. 題目

甲狀腺眼病變（thyroid eye disease）的患者，下列哪條眼內肌肉較容易受到影響，而造成眼球活動障礙？

- A. 上直肌
- B. 下直肌
- C. 下斜肌
- D. 外直肌

2. 作答對照

- 使用者答案：D
- 考選部原始答案：B
- 考選部最終更正答案：B
- 是否有多答案接受或一律給分：否

考選部原始及更正答案均為B。

題目所稱「眼內肌肉」依選項及疾病機轉，實際指的是眼外肌。

3. 核心考點

甲狀腺眼病變造成的是眼外肌發炎、腫大及後續纖維化所導致的**限制性眼球運動障礙**。

傳統受累頻率可記為：

Inferior rectus → Medial rectus → Superior rectus → Lateral rectus → Oblique muscles

亦即 **I’ M SLOw**。其中下直肌最常受累。

下直肌攣縮時會把眼球限制在較向下的位置，造成：

- 上視受限。
- 低位眼（hypotropia）。
- 垂直複視。

4. 各選項逐一解析

A. 上直肌——錯誤

上直肌可以受累，但通常不是最常見者。

若上直肌 / 提上瞼肌複合體產生明顯限制，可能造成下視受限及垂直眼位偏差。影像上也可能看到上肌群腫大，但整體仍以下直肌最具代表性。

B. 下直肌——正確

下直肌是甲狀腺眼病變最常受累的眼外肌。

其病理變化包括：

- 眼窩纖維母細胞活化。
- 糖胺聚醣沉積與水腫。
- 肌腹腫大。
- 後期纖維化及攣縮。

經典影像表現為眼外肌**肌腹腫大、肌腱附著處相對保留**。下直肌變緊後，最明顯的表現通常不是下視無力，而是眼球被拉向下方、上視受限。

專業眼科資料仍將下直肌列為最常受累肌肉，其後通常是內直肌。AAO EyeWiki、2024眼外肌受累研究

C. 下斜肌——錯誤

斜肌也可能受影響，但遠少於直肌，並非甲狀腺眼病變最典型的首要受累肌肉。

若題目問「最常見」，看到斜肌通常可先排除。

D. 外直肌——錯誤

外直肌可以受累，但發生頻率通常低於下直肌、內直肌與上直肌。

若外直肌攣縮，可能限制內收；但本題沒有提供特定眼球運動方向，問的是整體最常受累肌肉，因此不能選D。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

可能把甲狀腺眼病變視為眼外肌「麻痺」，並依某個缺失的眼球運動方向反推負責該動作的肌肉。

但本病主要是**限制性肌病**：

- 神經麻痺：該肌無法把眼球拉向其作用方向。
- 甲狀腺眼病變：攣縮的肌肉把眼球拉住，限制的是相反方向。

例如下直肌變緊時，最明顯的是上視受限；不能因為患者無法向上看，就誤認為主要病變在上直肌。

另一個可能是尚未牢固記住受累順序「I’ M SLOw」。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 次標籤：解剖定位

- 次標籤：限制性與麻痺性眼球運動混淆
- 次標籤：最常見極性字眼

7. 下次判斷規則

> 甲狀腺眼病變先背 **I’ M SLOw：下直、內直、上直、外直、斜肌**；緊的是下直肌，受限的卻是向上看。

8. 投資報酬率

高

- 下直肌最常受累是高頻國考記憶點。
- 可延伸至限制性斜視、影像判讀及複視方向。
- 同時建立「緊肌限制反方向」的概念，可處理多種眼球運動題。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**B，下直肌。
- **現代臨床實務：**不同研究族群及影像判定方式可能得到稍有差異的受累排序，多條眼外肌同時受累也很常見；但下直肌仍是最經典且通常最常受累的肌肉。
- **爭議或限制：**僅知道最常受累肌肉不足以解讀個別患者的複視。仍需以九向眼位、forced-duction test、眼窩影像及斜視測量確認實際限制來源。

醫學（六）Q20

對話詳解原文

1. 題目

鼻咽癌可經由海綿竇（cavernous sinus）侵犯哪些腦神經？

- A. 第二、三、四對腦神經
- B. 第二、四、六對腦神經
- C. 第三、四、六對腦神經
- D. 第二、三、六對腦神經

題目核對自考選部醫學六正式試題。

2. 作答對照

- 使用者答案：A
- 考選部原始答案：C
- 考選部最終更正答案：C
- 是否有多答案接受或一律給分：否

原始答案及最終更正答案均為C；本次更正檔仍僅更正Q3，並將Q23、Q66一律給分。

3. 核心考點

本題測試海綿竇內容物與視神經的解剖定位。

海綿竇相關神經包括：

- 外側壁：CN III、CN IV、V1、V2。
- 竇腔內、靠近內頸動脈：CN VI。
- **CN II不在海綿竇內**，而是經視神經管進入眼眶。

因此，選項中完全屬於海綿竇相關腦神經的組合是：

> CN III + CN IV + CN VI。

4. 各選項逐一解析

A. CN II、III、IV——錯誤

CN III與CN IV位於海綿竇外側壁，但CN II不在海綿竇內。

CN II由視網膜出發，經視神經管進入顱內；它與海綿竇相鄰的視交叉、鞍區及眶尖病變可能在大型腫瘤中一起受累，但不能因此把CN II列為海綿竇內容物。

B. CN II、IV、VI——錯誤

CN IV與CN VI均與海綿竇密切相關，但CN II仍是錯誤項。

其中CN VI並非位於外側壁，而是直接行經竇腔、鄰近海綿竇段內頸動脈，因此海綿竇病變時特別容易受影響。

C. CN III、IV、VI——正確

三條眼球運動神經皆與海綿竇有關：

- CN III：控制多數眼外肌、提上瞼肌及瞳孔副交感功能。
- CN IV：支配上斜肌。
- CN VI：支配外直肌。

廣泛海綿竇病變可造成眼肌麻痺、複視、眼瞼下垂及瞳孔異常。完整解剖內容其實還包括V1、V2及內頸動脈周圍交感神經叢。NCBI海綿竇解剖綜述

D. CN II、III、VI——錯誤

CN III與CN VI正確，但CN II不在海綿竇，因此整組錯誤。

若題目改成眶尖症候群或腫瘤已延伸至視神經管，CN II才可能與其他眼球運動神經一起受累；那不是本題所問的標準海綿竇內容物。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇A表示可能已記得CN III、IV經過海綿竇，但將鄰近鞍區、眶尖的CN II也納入，並漏掉真正行經竇腔的CN VI。

這可能是把三個相鄰但不同的通道混在一起：

- 視神經管：CN II、眼動脈。
- 海綿竇：CN III、IV、V1、V2、VI及內頸動脈。
- 上眶裂：CN III、IV、V1、VI。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 次標籤：解剖定位
- 次標籤：相鄰顱底通道混淆
- 次標籤：視神經管 / 海綿竇 / 上眶裂

7. 下次判斷規則

> 海綿竇先抓「眼球會動的三條神經」III、IV、VI；CN II走視神經管，不要因為都通往眼眶就把它加進來。

8. 投資報酬率

高

- 海綿竇內容物是耳鼻喉科、眼科、神經科共同高頻題。
- 可延伸至海綿竇血栓、頸動脈海綿竇瘻、Tolosa–Hunt syndrome及顱底腫瘤。
- 值得連同視神經管、上眶裂、圓孔及卵圓孔一起重建空間圖。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**C。
- **現代臨床實務：**鼻咽癌向顱底及海綿竇延伸時，除III、IV、VI外，也可能侵犯V1、V2或交感神經；實際症狀取決於腫瘤侵犯範圍，而非固定只侵犯三條眼球運動神經。2024海綿竇解剖研究
- **爭議或限制：**題目措辭容易被理解為「鼻咽癌所有可能侵犯的腦神經」。若依完整解剖，V1、V2也應列入；但在四個選項中，只有C沒有錯放CN II，因此答案明確。

醫學（六）Q21

對話詳解原文

1. 題目

下列哪兩個半規管之夾角是接近相互垂直的？

- A. 右後半規管和右上半規管
- B. 右水平半規管和左水平半規管
- C. 右後半規管和左上半規管
- D. 右上半規管和左後半規管

2. 作答對照

- 使用者答案：D
- 考選部原始答案：A
- 考選部最終更正答案：A
- 是否有多答案接受或一律給分：否

原始及最終更正答案均為A。

3. 核心考點

每側耳朵有三個半規管：

- 上半規管，又稱前半規管。
- 後半規管。
- 水平半規管，又稱外側半規管。

同一側的三個半規管分處近似互相垂直的三個平面，以偵測三維旋轉加速度。因此，同側右上半規管與右後半規管接近垂直。

但左右兩耳會形成三組功能性共面配對：

- 左、右水平半規管。
- 左前 / 上半規管 + 右後半規管：LARP。
- 右前 / 上半規管 + 左後半規管：RALP。

「共面配對」並不是「互相垂直」。

4. 各選項逐一解析

A. 右後半規管和右上半規管——正確

這是同一側的兩條垂直半規管，其平面接近相互垂直。

它們與同側水平半規管共同構成三個近似正交的旋轉感測平面。題目使用「接近」很重要：真人解剖並不是數學上完全精確的90度。

B. 右水平半規管和左水平半規管——錯誤

左右水平半規管是一組功能性配對，兩者近似位於同一平面，以push–pull方式共同偵測水平旋轉。

因此兩者是近似共面，而非互相垂直。

C. 右後半規管和左上半規管——錯誤

這是LARP功能平面：

> Left Anterior / Superior + Right Posterior。

兩者是對側的共面配對。頭部在這個斜向平面旋轉時，兩側神經輸出呈一側興奮、另一側抑制，而不是把兩者當作互相垂直的感測軸。

D. 右上半規管和左後半規管——錯誤

這正是使用者選項，也是RALP功能平面：

> Right Anterior / Superior + Left Posterior。

這兩條半規管近似共面，並非相互垂直。前庭植入與前庭眼反射研究也依水平、LARP、RALP三組共面管道描述三維旋轉。JCI前庭系統示意與研究

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇D很可能不是完全不熟悉半規管，而是記得「右上半規管與左後半規管是一組」，卻把這種關係誤認為互相垂直。

實際上：

- 同側三管：彼此近似正交。
- 對側功能配對：彼此近似共面。

也就是記得配對成員，卻把題目要求的空間關係讀反。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 次標籤：空間解剖
- 次標籤：共面與垂直混淆
- 次標籤：關係詞極性

- 次標籤：LARP / RALP

7. 下次判斷規則

同側三管互相垂直；跨側配對彼此共面。看到RALP或LARP，立刻排除「相互垂直」。

8. 投資報酬率

中高

- 半規管空間關係可延伸至前庭眼反射、頭部脈衝測試及BPPV。
- LARP / RALP是國考常用的空間陷阱。
- 不必背精確角度，但必須牢記「同側正交、對側共面」。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**A。
- **現代臨床實務：**六條半規管並非完全理想化的90度或完全共面，個體間存在可測量的角度差異；臨床仍以近似正交及三組共面功能配對作為頭部脈衝測試與前庭眼反射判讀模型。人體半規管三維定向研究
- **爭議或限制：**題目使用「接近相互垂直」已保留解剖變異，因此沒有明顯爭議。

醫學（六）Q24

對話詳解原文

1. 題目

有關環狀軟骨（cricoid cartilage），下列敘述何者錯誤？

- A. 環狀軟骨是呼吸道結構中唯一整圈的軟骨
- B. 連結於環狀軟骨後上方兩側的後環杓肌（posterior cricoarytenoid muscle）是關閉聲帶（vocal fold）的肌肉
- C. 環狀軟骨上方是甲狀軟骨，連結處所形成的環甲膜（cricothyroid membrane）是皮膚離呼吸道最近之處
- D. 杓狀軟骨（arytenoid cartilage）位於環狀軟骨後上方兩側，藉由一個滑液關節（synovial joint）連結

題目核對自考選部醫學六正式試題。

2. 作答對照

- 使用者答案：A
- 考選部原始答案：B
- 考選部最終更正答案：B
- 是否有多答案接受或一律給分：否

原始答案及最終更正答案均為B。

3. 核心考點

本題表面問環狀軟骨，真正的決勝點是喉內肌功能：

> 後環杓肌是唯一能外展聲帶、打開聲門的肌肉。

它不是關閉聲帶的肌肉。聲帶內收主要由外側環杓肌與杓間肌完成。

4. 各選項逐一解析

A. 環狀軟骨是呼吸道唯一整圈軟骨——正確

環狀軟骨位於甲狀軟骨下方、第一氣管環上方，外形近似印章戒指：

- 前方是較窄的弓部。
- 後方是較寬高的板部。
- 整體形成完整360度軟骨環。

氣管軟骨雖稱為「氣管環」，實際上是後方缺口的C形軟骨，由氣管肌及膜性壁補足，因此不是真正完整的一圈。環狀軟骨確實是呼吸道中唯一完整環狀軟骨。喉與氣管手術解剖綜述

B. 後環杓肌負責關閉聲帶——錯誤，為本題答案

後環杓肌起於環狀軟骨後方板部，止於杓狀軟骨的肌突。收縮時使杓狀軟骨向外旋轉，讓聲帶外展、聲門打開。

它的高頻定位是：

> Posterior cricoarytenoid = 唯一的聲帶外展肌。

雙側喉返神經受損導致此肌失去功能時，兩側聲帶可能停在近中線位置，引起喘鳴與嚴重呼吸道阻塞。
NCBI呼吸道解剖

負責聲帶內收、關閉聲門的主要肌肉為：

- 外側環杓肌：內旋杓狀軟骨，內收聲帶。
- 橫杓肌與斜杓肌：使兩側杓狀軟骨靠近，關閉後聲門。

C. 環甲膜是皮膚至呼吸道最接近的位置——國考判定正確

環甲膜位於：

- 上方：甲狀軟骨。
- 下方：環狀軟骨。

正中部位相對表淺、血管較少，且可直接進入聲門下呼吸道，因此是緊急環甲膜切開術的進入點。

但執行時仍須注意：

- 切口應保持正中。
- 避免環甲動脈及甲狀腺相關血管。
- 幼童解剖空間較小，傳統外科環甲膜切開通常不是首選。

D. 杓狀軟骨以滑液關節連接環狀軟骨——正確

成對杓狀軟骨位於環狀軟骨後方板部的上緣，藉環杓關節連接。這是滑液關節，允許杓狀軟骨進行旋轉與滑動，藉此調整聲帶位置及張力。

環杓關節固定或脫位時，也可能造成聲帶活動異常，臨床上需與喉返神經麻痺鑑別。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇A可能是把「氣管環」的名稱理解成真正完整的軟骨圈，因而懷疑環狀軟骨並非唯一完整環。

同時可能沒有抓到B中的功能方向反轉：

- posterior cricoarytenoid：打開聲門。
- lateral cricoarytenoid：關閉聲門。

因此本題不是純粹不知道環狀軟骨，而是結構名稱與肌肉動作方向沒有牢固連結。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 次標籤：解剖功能
- 次標籤：外展 / 內收方向
- 次標籤：唯一 / 錯誤等極性字眼
- 次標籤：氣管環名稱誤導

7. 下次判斷規則

> **後環杓肌是唯一開門者：posterior opens；外側環杓肌才負責關門。**

8. 投資報酬率

高

- 後環杓肌是唯一聲帶外展肌，屬高頻國考記憶點。
- 可延伸至喉返神經損傷、雙側聲帶麻痺、喘鳴及困難呼吸道。
- 建議與所有喉內肌、神經支配及環甲膜切開一次整理。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**B。
- **現代臨床實務：**後環杓肌確為唯一聲帶外展肌，沒有實質爭議。臨床發現聲帶不動時，尚須區分神經麻痺、環杓關節固定 / 脫位及腫瘤機械性限制。
- **爭議或限制：**C的「皮膚離呼吸道最近」是教科書式簡化；肥胖、頸部腫瘤、解剖變異及兒童患者可能使定位與進入變得困難，但不影響本題答案。

醫學（六）Q26

對話詳解原文

1. 題目

針對口咽癌的檢體，驗出下列何項生物標誌時，表示該腫瘤與人類乳突病毒相關？

- A. p16
- B. p21
- C. p53
- D. Rb

2. 作答對照

- 使用者答案：B
- 考選部原始答案：A
- 考選部最終更正答案：A
- 是否有多答案接受或一律給分：否

考選部原始及更正答案均為A。

3. 核心考點

高風險型HPV相關口咽鱗狀細胞癌的經典替代性標誌是：

p16免疫組織化學染色呈瀰漫、強烈陽性。

機轉為HPV的E7蛋白使Rb路徑失活，解除細胞週期抑制後，細胞對p16產生代償性過度表現。

因此國考看到「HPV相關口咽癌 + 生物標誌」，直接選p16。

4. 各選項逐一解析

A. p16——正確

p16是CDKN2A基因產物，可抑制CDK4/6，使Rb維持抑制細胞週期的狀態。

在HPV相關腫瘤中：

1. HPV E7使Rb功能失活。
2. E2F活性釋放，細胞週期持續推進。
3. 負回饋造成p16大量累積。
4. 因此p16強烈、瀰漫染色可作為轉錄活躍高風險HPV的替代標誌。

2025年更新的CAP指引仍建議，新診斷的口咽鱗狀細胞癌應接受高風險HPV評估；對口咽組織標本，p16免疫染色仍是主要替代性檢測方法。CAP 2025 HPV檢測指引

傳統陽性判準為至少70%腫瘤細胞呈中度至強烈的核與細胞質染色；不能把少量、局部p16染色直接當作HPV陽性。

B. p21——錯誤

p21也是細胞週期抑制蛋白，主要受p53調控，可抑制cyclin-CDK複合體。

但p21不是判定HPV相關口咽癌的標準替代標誌。它可能因DNA損傷、p53狀態及其他細胞壓力而改變，缺乏p16在口咽癌中的特定診斷角色。

C. p53——錯誤

高風險HPV的E6蛋白可促進p53降解，但臨床上不能以「p53陽性」作為HPV相關口咽癌的標誌。

反而在HPV非相關、尤其抽菸相關的頭頸癌中，TP53突變較常見，免疫染色可能呈異常過度表現或完全缺失。p53染色模式不能取代p16或HPV專一性檢測。

D. Rb——錯誤

Rb確實位於HPV致癌機轉的核心：E7會使Rb路徑失活。但一般不以Rb染色作為口咽癌是否與HPV相關的標準篩檢指標。

簡單區分：

- 被HPV E7干擾的路徑：Rb。
- 最常拿來做臨床替代標誌：p16。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇p21可能是將兩個名稱相近、都具有CDK抑制作用的蛋白混淆：

- p16：HPV相關口咽癌的經典替代標誌。
- p21：主要屬於p53下游的細胞週期抑制蛋白。

這比較像相近分子標誌沒有建立疾病專屬連結，而不是完全不知道HPV的致癌機轉。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 二選一失誤
- 次標籤：生物標誌混淆
- 次標籤：p16 / p21名稱混淆
- 次標籤：HPV–E6–p53與HPV–E7–Rb路徑

7. 下次判斷規則

口咽癌問HPV先選p16；E7打掉Rb，p16因此反彈升高。

8. 投資報酬率

高

- p16與HPV相關口咽癌是耳鼻喉科、病理科及腫瘤科高頻題。
- 可延伸至AJCC分期、預後差異及頸部不明原發癌評估。
- 十月應保留完整的E6–p53、E7–Rb–p16路徑，而不只孤立背答案。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**A，p16。
- **現代臨床實務：**p16是實用而敏感的替代標誌，但不等於直接檢出HPV。某些p16陽性腫瘤實際沒有轉錄活躍的HPV；特定情境需以HPV DNA/RNA原位雜交或核酸檢測確認。CAP 2025更新說明
- **適用範圍：**p16作為HPV替代標誌最適用於口咽鱗狀細胞癌。2025 CAP指引不建議把相同邏輯例行套用到口腔、喉、下咽或鼻咽癌；鼻竇鱗癌則偏向HPV專一性檢測。
- **爭議或限制：**題目只寫「口咽癌」而未限定鱗狀細胞癌，措辭略寬；但國考顯然指HPV相關口咽鱗癌，答案仍為p16。

醫學（六）Q29

對話詳解原文

1. 題目

下列何者與子宮外孕 methotrexate 藥物治療失敗最有關？

- A. 多胎次（multigravida）
- B. 2.5 cm大小的子宮外孕
- C. 之前有子宮外孕病史
- D. 血清β-人類絨毛膜刺激激素（β-hCG）值為7,500 mIU/mL

題目核對自考選部醫學六正式試題。

2. 作答對照

- 使用者答案：B
- 考選部原始答案：D
- 考選部最終更正答案：D
- 是否有多答案接受或一律給分：否

原始答案及最終更正答案均為D。

3. 核心考點

本題測試未破裂輸卵管子宮外孕使用methotrexate時，哪些條件預示治療成功率較低。

重要失敗預測因子包括：

- 初始β-hCG較高，尤其超過5,000 mIU/mL。
- 可見胚胎心跳。
- 腫塊較大，常以3.5～4 cm為重要界線。
- β-hCG快速上升。
- 大量腹腔積血或臨床懷疑破裂。
- 無法可靠追蹤。

四個選項中，β-hCG 7,500 mIU/mL最明確跨過高失敗風險範圍。

4. 各選項逐一解析

A. 多胎次——錯誤

多胎次本身不是methotrexate治療失敗的主要預測因子。

生育史可能與子宮外孕風險背景有關，但治療已開始後，成功與否主要由：

- 滋養層活性，即β-hCG。
- 胚胎心跳。
- 腫塊大小。
- 是否破裂及病人穩定度。

因此不能因為患者懷孕次數多，就推定methotrexate較容易失敗。

B. 子宮外孕腫塊2.5 cm——不是最佳答案

腫塊越大，確實通常越不利於藥物治療，但2.5 cm仍低於許多指引使用的3.5 cm界線。

若病人：

- 血流動力穩定。
- 無明顯疼痛。
- 沒有胚胎心跳。
- β-hCG不高。
- 能密切追蹤。

2.5 cm本身通常仍屬適合考慮methotrexate的範圍。選項B提供了方向正確但程度不夠嚴重的風險線索。

C. 曾有子宮外孕——錯誤

既往子宮外孕會提高未來再次發生子宮外孕的風險，但這是「發病風險」，不等同於本次methotrexate的「治療失敗風險」。

本題考的是確診後的治療反應，不能把復發危險因子直接套成藥物失敗預測因子。

D. β-hCG 7,500 mIU/mL——正確

較高的初始β-hCG代表較大的滋養層細胞量及較高活性，是最一致的methotrexate失敗預測因子之一。

系統性回顧顯示，初始β-hCG超過5,000 mIU/mL後，單劑methotrexate失敗風險明顯增加。β-hCG界值系統性回顧

NICE指引的分層更直接：

- β-hCG低於1,500 IU/L：符合其他條件時可提供methotrexate。
- 1,500 ~ 5,000 IU/L：可在手術與methotrexate間選擇。
- 5,000 IU/L以上：通常優先提供手術治療。

因此7,500 mIU/mL是本題最強的失敗風險線索。NICE輸卵管子宮外孕處置指引

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇B可能表示已記得「子宮外孕腫塊越大，methotrexate越容易失敗」，但沒有檢查2.5 cm是否真的已達高風險程度。

相較之下，β-hCG 7,500已明顯超過常用的5,000界線。這是典型的：

> 方向正確的弱線索，壓過了具有明確數值門檻的強線索。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 次標籤：數值門檻
- 次標籤：風險因子強度排序
- 次標籤：發病風險與治療失敗風險

7. 下次判斷規則

> 子宮外孕用MTX，先看β-hCG：**超過5,000成功率明顯下降；2.5 cm本身還不算大**。

8. 投資報酬率

高

- 子宮外孕治療選擇是婦產科高頻題。
- 可延伸至期待療法、methotrexate適應症及緊急手術條件。
- 數值門檻少而實用，值得在十月完整保留。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**D。
- **現代臨床實務：**β-hCG 5,000不是絕對生物學分界；部分穩定患者仍可能經個別評估接受單劑、多劑或局部methotrexate，但必須理解成功率下降並具備隨時手術的條件。
- **治療後監測：**通常比較第4與第7天β-hCG；若下降未達15%、持平或上升，需評估追加methotrexate或手術。即使β-hCG下降，破裂風險在完全轉陰前仍未消失。
- **爭議或限制：**題目沒有提供疼痛、胚胎心跳及血流動力狀態，不能據此直接決定真實患者一定接受手術；但若只問最可能導致MTX失敗的選項，D明確最佳。

醫學（六）Q32

對話詳解原文

1. 題目

有關肩難產的新生兒合併症，下列敘述何者錯誤？

- A. Hypoxic ischemic encephalopathy（HIE）
- B. Cardiac arrest
- C. Brachial plexus injury
- D. Caput succedaneum

2. 作答對照

- 使用者答案：B
- 考選部原始答案：D
- 考選部最終更正答案：D
- 是否有多答案接受或一律給分：否

考選部原始及最終答案均為D。

3. 核心考點

肩難產發生於胎頭娩出後，胎兒前肩卡在恥骨聯合後方，導致頭至身體娩出的時間延長。

新生兒併發症可分為：

- **機械性傷害：**臂神經叢損傷、鎖骨或肱骨骨折。
- **缺氧性傷害：**酸血症、HIE、心跳停止甚至死亡。

Caput succedaneum則是胎頭先露部因產道壓力形成的頭皮水腫，不是肩難產本身的典型併發症。

4. 各選項逐一解析

A. HIE——正確，確實可能發生

肩膀卡住後，胎兒胸廓無法正常擴張，臍帶亦可能受到壓迫。若頭至身體娩出時間延長，可能造成缺氧、酸血症及HIE。

2024年大型研究仍確認肩難產可能造成新生兒窒息、HIE及死亡。2024肩難產母嬰併發症研究

不過肩難產時間與HIE並非絕對一對一；胎兒在事件前是否已有缺氧、臍帶受壓程度及復甦速度也會影響結局。

B. Cardiac arrest——正確，雖罕見但可能發生

嚴重、持續的缺氧與酸血症可以進展為新生兒心搏過緩、循環衰竭及心跳停止。

因此cardiac arrest不是最常見的合併症，但它是嚴重肩難產可能造成的終末缺氧表現。不能因為結果極端或罕見，就判定不可能發生。

C. Brachial plexus injury——正確

臂神經叢損傷是肩難產最具代表性的胎兒機械性傷害。

常見為上幹C5–C6受損，即Erb palsy，表現為：

- 肩部內收、內旋。
- 手肘伸直。
- 前臂旋前。
- 手部抓握可能相對保留。

較嚴重時可涉及整個C5–T1，甚至合併Horner syndrome。多數損傷會改善，但神經根撕脫等嚴重傷害可能留下永久障礙。ACOG肩難產實務公報

D. Caput succedaneum——錯誤，為本題答案

Caput succedaneum是胎兒頭皮皮下組織因產道壓力造成的水腫：

- 位於頭皮先露部。
- 可跨越顱骨縫。
- 通常出生時已存在。
- 多在數日內自行消退。

它比較反映胎頭在子宮頸或產道受到壓迫，可能與長時間產程或器械助產共存。肩難產的定義則是**胎頭已娩出後肩膀受阻**，所以caput不是肩難產所造成的特異性新生兒併發症。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇B可能是認為cardiac arrest太嚴重、太少見，不像肩難產的標準併發症；相對地，caput看起來像困難生產可能造成的外傷。

但題目問的是「能否成為合併症」，不是「最常見」：

- Cardiac arrest罕見，但可由嚴重缺氧直接導致。
- Caput可能與困難產程共存，但不是肩膀卡住後直接造成的傷害。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 次標籤：直接因果與共存現象
- 次標籤：罕見不等於不可能

- 次標籤：事件時間軸
- 次標籤：最常見與可能發生混淆

7. 下次判斷規則

肩難產發生在「頭出來以後」：會傷肩臂、會缺氧；胎頭先露部的caput不是肩膀卡住所造成。

8. 投資報酬率

高

- 肩難產的辨識、處置及併發症是產科急症高頻題。
- 可延伸至McRoberts maneuver、恥骨上加壓、禁止宮底加壓及臂神經叢傷害。
- 透過「事件發生時間軸」判斷傷害來源，可處理多種產傷題。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**D。
- **現代臨床實務：**HIE、心跳停止及死亡都屬少見但嚴重的缺氧結局；臂神經叢損傷及鎖骨 / 肱骨骨折則是較典型的機械性傷害。RCOG肩難產指引
- **處置重點：**確認肩難產後應立即呼援，依序採取McRoberts、恥骨上加壓、內旋轉或娩出後臂等處置；避免宮底加壓及過度牽拉胎頭。
- **爭議或限制：**caput可能與造成肩難產的長產程、胎兒過大或器械助產同時存在，因此不能說肩難產病例絕不會看到caput；但它不是肩難產的直接、典型合併症，D仍是唯一最佳答案。

醫學（六）Q35

對話詳解原文

1. 題目

29歲女性妊娠32週，主訴僵直性下腹疼痛，自外院轉診至醫學中心緊急剖腹產，手術中情況如圖所示，該病人最可能的診斷為何？

- A. Placental abruption
- B. Placenta previa with bleeding
- C. Vasa previa
- D. Uterine inversion

題目與術中影像核對自考選部醫學六正式試題。圖中可見子宮表面藍紫色、斑駁狀出血浸潤，符合 Couvelaire uterus（子宮胎盤卒中）。

2. 作答對照

- 使用者答案：D
- 考選部原始答案：A
- 考選部最終更正答案：A
- 是否有多答案接受或一律給分：否

原始答案及最終更正答案均為A；本次更正檔仍只涉及Q3，並將Q23、Q66一律給分。

3. 核心考點

本題把三類線索疊在一起：

- **症狀：**持續、僵直性下腹痛。
- **時間：**妊娠32週，胎兒尚未娩出。
- **術中影像：**血液由胎盤後方浸潤子宮肌層及漿膜，使子宮呈藍紫色斑駁外觀，即 Couvelaire uterus。

這是嚴重胎盤早期剝離的經典表現。胎盤早剝可能以隱性出血呈現，因此外出血量少不能排除；持續腹痛、子宮壓痛或高張、胎兒窘迫更具辨識力。RCOG產前出血指引

4. 各選項逐一解析

A. Placental abruption——正確

胎盤早期剝離是胎盤在胎兒娩出前，自正常著床位置部分或完全分離。

典型線索包括：

- 疼痛性陰道出血，但出血可以隱藏在胎盤後方。

- 持續腹痛、子宮壓痛。
- 子宮高張或呈板狀僵硬。
- 胎兒窘迫或死亡。
- 嚴重時發生瀰漫性血管內凝血。

胎盤後方大量出血若滲入肌層並達漿膜面，就會形成圖中的 Couvelaire uterus。這項診斷主要由剖腹產時直接觀察確認。Couvelaire uterus病例與病理說明

B. Placenta previa with bleeding——錯誤

前置胎盤的典型表現是：

- 妊娠後半期無痛性、鮮紅色陰道出血。
- 子宮通常柔軟、無明顯壓痛。
- 診斷主要依經陰道超音波確認胎盤與內子宮頸口的位置。

它不符合本題的持續僵直性腹痛，也不能解釋子宮漿膜面廣泛血液浸潤。

C. Vasa previa——錯誤

前置血管破裂通常發生於破水時，特點是：

- 無痛性陰道出血。
- 出血來源為胎兒血液。
- 胎心迅速出現心搏過緩或正弦波形。
- 母親的血壓與血紅素可與出血外觀不成比例地穩定。

它不會使母體子宮呈板狀僵硬，也不會造成 Couvelaire uterus。

D. Uterine inversion——錯誤

子宮內翻多為胎兒及胎盤娩出後的第三產程急症，常與：

- 胎盤尚未剝離時過度牽拉臍帶。
- 宮底受壓。
- 胎盤植入異常或子宮弛緩。

有關。臨床可見宮底凹陷或子宮由子宮頸、陰道突出，伴隨產後大出血及程度不成比例的休克。

本題患者仍在妊娠32週、因腹痛接受剖腹產，影像呈現的是子宮壁出血浸潤，而不是宮底向內翻轉。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇D可能是看到術中子宮外觀異常，先將其歸為「子宮形態急症」，但沒有把兩個排除力最強的線索放在前面：

1. 子宮內翻幾乎是胎兒娩出後的產後事件。

2. 胎盤早剝則發生在胎兒娩出前，並以疼痛、子宮僵硬和胎兒窘迫為核心。

這也可能表示 Couvelaire uterus 的藍紫色影像尚未建立專屬疾病連結。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 次標籤：影像辨識
- 次標籤：年齡或時間軸線索
- 次標籤：疼痛性與無痛性產前出血
- 次標籤：胎盤早剝 / 子宮內翻
- 次標籤：Couvelaire uterus

7. 下次判斷規則

> **胎兒娩出前：痛 + 硬子宮 = 先想胎盤早剝；剖腹產見藍紫斑駁子宮就是Couvelaire uterus。子宮內翻則是產後事件。**

8. 投資報酬率

高

- 胎盤早剝、前置胎盤及前置血管的鑑別是產科高頻題。
- 可延伸至胎兒窘迫、DIC、產前出血及緊急生產決策。
- Couvelaire uterus影像辨識成本低、得分效益高，值得保留。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**A，placental abruption。
- **現代臨床實務：**胎盤早剝主要是臨床診斷；超音波陰性不能排除。處置須依母體循環、出血及凝血狀態、胎心與孕週決定，不能只靠術中顏色。
- **Couvelaire uterus處置：**子宮呈出血浸潤不等於必須切除。若胎盤娩出後子宮能收縮並控制出血，通常可保留；只有持續嚴重出血或無法控制的子宮弛緩才可能需要子宮切除。
- **限制：**題目未提供胎心、陰道出血與凝血數據，但症狀、時間軸及術中影像已足以支持A。

醫學（六）Q37

對話詳解原文

1. 題目

關於子癇前症的危險因子，下列何者風險最低？

- A. 孕婦初次妊娠
- B. 抽菸孕婦
- C. 子癇前症病史孕婦
- D. 高齡孕婦（大於35歲）

2. 作答對照

- 使用者答案：A
- 考選部原始答案：B
- 考選部最終更正答案：B
- 是否有多答案接受或一律給分：否

考選部原始及最終更正答案均為B。

3. 核心考點

本題測試子癇前症危險因子的強度分層，以及一項反直覺的流行病學現象：

- **曾有子癇前症：**高風險因子。
- **初次妊娠：**中度危險因子。
- **年齡≥35歲：**中度危險因子。
- **妊娠中吸菸：**觀察研究中與較低的子癇前症發生率相關，因此四項中「風險最低」。

ACOG / SMFM目前仍將既往子癇前症列為高風險，而把初次妊娠及年齡≥35歲列為中度風險。
ACOG / SMFM高齡妊娠共識

4. 各選項逐一解析

A. 初次妊娠——不是最低

Nulliparity是公認的子癇前症中度危險因子。

可能涉及母體首次接觸胎盤及父系抗原時，母胎免疫耐受與螺旋動脈重塑尚未建立。它不是最高風險，但仍明確高於沒有相關危險因子的孕婦。

因此，雖然A不像既往子癇前症那麼強，仍不能選為四項中的最低。

B. 抽菸孕婦——國考答案

多項觀察研究顯示，妊娠中吸菸與子癲前症風險下降相關；一項統合分析估計風險約下降三分之一。吸菸與子癲前症統合分析

可能機轉包括一氧化碳或菸草相關物質對血管生成因子、胎盤血流與發炎反應的影響。但這只是流行病學關聯，近年研究也指出可能受到混雜、選擇偏差及競爭性妊娠結局影響。2023偏差機制分析

因此國考選B，但臨床上絕不能將吸菸當作預防子癲前症的方法。

C. 曾有子癲前症——高風險

既往子癲前症，尤其曾合併：

- 早發型疾病。
- 胎兒生長受限。
- 早產。
- 胎死或其他不良妊娠結果。

是下一次妊娠再發的重要危險因子，也屬低劑量aspirin預防的高風險條件。

它明顯不是風險最低者。

D. 年齡大於35歲——中度風險

高齡妊娠與子癲前症風險上升相關，而且風險隨年齡連續增加，40歲以上通常更明顯。

年齡≥35歲本身通常列為中度危險因子；若再合併另一個中度因子，便可能符合低劑量aspirin預防條件。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇A可能是認為初次妊娠只是人口學背景，不像高齡、既往病史或抽菸那樣具有明顯病理風險。

另一個可能是以一般心血管邏輯推論：

> 吸菸損傷血管內皮，因此一定會增加子癲前症。

這個方向對吸菸的整體健康危害沒有錯，但本題問的是子癲前症這個特定結局；國考測的是吸菸與其呈反向關聯的特殊流行病學記憶點。

6. 失分類型

- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 次標籤：危險因子強度
- 次標籤：反直覺流行病學
- 次標籤：最低等極性字眼

- 次標籤：疾病特定風險與整體危害

7. 下次判斷規則

子癲前症：既往病史最高；初產與≥35歲都是風險；吸菸呈反常的較低觀察風險，但絕不是臨床保護措施。

8. 投資報酬率

中高

- 子癲前症危險因子及aspirin預防條件是高頻考點。
- 可延伸至高風險與中度風險分層。
- 吸菸的反向關聯屬國考常見陷阱，記住即可，不值得過度追究精細機轉。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**B。
- **現代臨床實務：**即使部分研究顯示子癲前症較少，吸菸仍會增加胎盤早剝、前置胎盤、胎兒生長受限、早產、死產及嬰兒死亡等風險，所有孕婦仍應接受戒菸支持。WHO妊娠戒菸資料
- **預防重點：**既往子癲前症屬高風險；初次妊娠及年齡≥35歲屬中度風險。是否使用低劑量aspirin應依完整風險組合判斷。
- **爭議或限制：**吸菸與較低子癲前症風險主要來自觀察資料，可能存在偏差，不能寫成確立的因果保護作用。

醫學（六）Q40

對話詳解原文

1. 題目

下列何者是上皮性（epithelial）的良性卵巢腫瘤？

- A. Mucinous cystadenoma
- B. Theca lutein
- C. Dysgerminoma
- D. Benign cystic teratoma

題目核對自考選部醫學六正式試題。

2. 作答對照

- 使用者答案：B
- 考選部原始答案：A
- 考選部最終更正答案：A
- 是否有多答案接受或一律給分：否

原始答案及最終更正答案均為A；更正檔仍只更正Q3，Q23、Q66一律給分。

3. 核心考點

本題測試卵巢腫瘤的「細胞來源分類」，不能只看名稱中是否出現 cyst、epithelium 或卵巢細胞名稱。

國考需要掌握三大類：

- **上皮性：**serous、mucinous、endometrioid、clear cell、Brenner。
- **生殖細胞：**mature teratoma、dysgerminoma、yolk sac tumor、immature teratoma。
- **性索 - 間質：**granulosa cell tumor、thecoma、fibroma、Sertoli-Leydig cell tumor。

因此本題只有 mucinous cystadenoma 同時符合「上皮性」與「良性」。WHO分類也把 mucinous cystadenoma列於卵巢上皮性腫瘤，而dysgerminoma及mature teratoma列於生殖細胞腫瘤。
WHO / IARC女性生殖系統腫瘤分類

4. 各選項逐一解析

A. Mucinous cystadenoma——正確

黏液性囊腺瘤是良性上皮性卵巢腫瘤，典型特徵包括：

- 常為大型、多房性囊腫。
- 內襯黏液分泌型柱狀上皮。
- 多為單側。

- 無間質侵犯、明顯細胞異型或複雜增生。

名稱拆解也可協助分類：

> cyst + adenoma = 形成腺體 / 囊腔的良性上皮性腫瘤。

但實際病理必須充分取樣，以排除局部borderline或invasive成分。

B. Theca lutein——錯誤

題目措辭不完整，通常是指 **theca lutein cyst**。

它是受到高濃度hCG刺激形成的功能性 / 腫瘤樣囊腫，常見於：

- 葡萄胎等妊娠滋養細胞疾病。
- 多胎妊娠。
- 排卵誘導或卵巢過度刺激。
- 其他hCG顯著升高狀況。

常呈雙側、多發、卵巢明顯增大；它不是上皮性卵巢腫瘤。

即使把選項理解為與theca cell相關的thecoma，也屬性索 - 間質腫瘤，仍不能選B。

C. Dysgerminoma——錯誤

Dysgerminoma是惡性生殖細胞腫瘤，相當於男性的seminoma，常見於年輕女性。

重要延伸點：

- 多為實質性腫瘤。
- LDH可能升高。
- 對化學治療及放射線敏感。
- 早期患者常可採保留生育能力手術。

它同時不符合「上皮性」及「良性」兩項條件。

D. Benign cystic teratoma——錯誤

Benign cystic teratoma即mature cystic teratoma / dermoid cyst，是良性生殖細胞腫瘤。

其中可能包含皮膚、毛髮、皮脂腺、牙齒、骨骼或神經組織；雖然腫瘤內可以出現「上皮組織」，分類仍依腫瘤起源判定為生殖細胞腫瘤。

這是常見陷阱：

> 腫瘤內含有上皮，不等於它是上皮性卵巢腫瘤。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇B可能是看到theca這個卵巢固有細胞名稱，因而把它理解成「由卵巢表面或內部組織長出的良性腫瘤」。

但卵巢腫瘤分類必須再細分：

- 表面 / 輸卵管型上皮來源 → 上皮性。
- 卵母細胞來源 → 生殖細胞。
- 顆粒細胞、莢膜細胞等支持組織 → 性索 - 間質。
- 生理性濾泡或黃體反應 → 功能性囊腫 / 腫瘤樣病變。

這題的失分重點是分類樹沒有完整展開，而非單獨忘記mucinous cystadenoma。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 二選一失誤
- 次標籤：組織來源分類
- 次標籤：上皮性 / 生殖細胞 / 性索間質
- 次標籤：腫瘤與功能性囊腫
- 輕度爭議或低效度題：B的名稱不完整

7. 下次判斷規則

> **卵巢上皮性先找serous / mucinous / endometrioid / clear cell；teratoma與dysgerminoma是生殖細胞，theca相關則往性索間質或功能性囊腫放。**

8. 投資報酬率

高

- 卵巢腫瘤來源、良惡性及年齡分布是婦產科高頻考點。
- 可延伸至腫瘤標記、影像外觀及保留生育手術。
- 十月值得以一張三欄分類表完整重建。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**A。
- **現代臨床實務：**影像只能估計腫瘤來源及風險，最終分類仍依病理組織及充分取樣；尤其大型黏液性腫瘤內可能同時存在良性、borderline與惡性區域。
- **theca lutein cyst：**多數在hCG刺激消退後可自行縮小，無併發症時通常採保守追蹤；不能因卵巢巨大就直接當成腫瘤手術。
- **爭議或限制：**B應完整寫作theca lutein cyst；但無論採功能性囊腫或theca來源腫瘤解讀，都不是上皮性腫瘤，因此不影響答案。

醫學（六）Q42

對話詳解原文

1. 題目

子宮鏡手術中發現如圖所示，何者為最可能之診斷？

- A. 子宮中膈
- B. 子宮內膜息肉
- C. 雙角子宮
- D. 子宮肌腺瘤

官方圖像呈現一個突入子宮腔、表面平滑而偏淡粉色的局部腫塊，表面可見血管紋理，外觀符合子宮內膜息肉。題目與圖像核對自考選部醫學六正式試題。

2. 作答對照

- 使用者答案：A
- 考選部原始答案：B
- 考選部最終更正答案：B
- 是否有多答案接受或一律給分：否

考選部原始及最終更正答案均為B。

3. 核心考點

子宮鏡影像要先判斷異常是：

- **局部突起病灶：**息肉、黏膜下肌瘤。
- **連續分隔結構：**子宮中膈。
- **整體子宮形態異常：**雙角子宮。
- **子宮肌層疾病：**子宮肌腺症 / 肌腺瘤。

圖中病灶是輪廓圓鈍、表面平滑且有血管的局部腔內突出物，而不是由宮底向下延伸、將子宮腔分成兩半的中膈，因此選B。

4. 各選項逐一解析

A. 子宮中膈——錯誤

子宮中膈是Müllerian管融合後，中間組織吸收不完全所致。

子宮鏡下通常可見：

- 宮底正中有縱向組織向下延伸。
- 子宮腔被分成左右兩個半腔。

- 兩側輸卵管開口可能分處中膈兩旁。
- 外形偏線性、縱向或三角形，而不是圓鈍的局部腫塊。

本題影像沒有顯示一條連續分隔整個宮腔的組織，因此不支持A。

B. 子宮內膜息肉——正確

子宮內膜息肉是局部內膜腺體、間質及血管增生，可呈有蒂或廣基型。

子宮鏡常見：

- 圓形、卵圓形或稍長條狀腔內腫塊。
- 表面平滑，顏色與周圍內膜相近或稍淡。
- 表面可見細長血管。
- 有蒂者會隨灌流液輕微擺動。
- 與子宮壁連接範圍通常小於病灶主體。

本題圖像就是一個邊界清楚的局部平滑腫塊，符合B。子宮鏡可直接觀察並同時切除病灶，是評估及治療宮腔病灶的重要方法。ACOG子宮鏡臨床意見

C. 雙角子宮——錯誤

雙角子宮是子宮上段融合不全，具有外部宮底凹陷及不同程度的雙角結構。

子宮鏡可能看到兩個方向分離的宮腔，但有一項重要限制：

> 子宮鏡只能看到內部輪廓，不能判斷外側宮底是否有深凹陷。

因此區分中膈子宮與雙角子宮通常需要3D經陰道超音波或MRI，必要時合併腹腔鏡。本題影像是局部腔內腫塊，也沒有呈現兩個分離的宮腔，故不支持C。

D. 子宮肌腺瘤——錯誤

子宮肌腺症主要位於子宮肌層，常造成：

- 子宮肌層不均勻增厚。
- 球狀子宮。
- 經痛、經血過多。
- 超音波或MRI出現junctional zone異常及肌層小囊腔。

子宮鏡下可能只有不規則內膜、異常血管或小型出血性腺體開口，未必出現明確腔內腫塊。局限性adenomyoma偶爾會向腔內突出，但本題平滑、有血管的內膜性腫塊仍較符合息肉。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇A可能是將畫面中央偏淡、向子宮腔突出的組織視為「中間的一道隔板」。

真正需要比較的是病灶幾何形狀：

- **息肉：**局部、圓鈍、腫塊狀，病灶旁仍有連續腔隙。

- **中膈：**由宮底連續向下延伸，呈縱向分隔，形成左右兩個半腔。

也就是影像中注意到「中央突出」，但沒有再判斷它究竟是局部腫塊還是連續分隔結構。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 次標籤：影像辨識
- 次標籤：幾何輪廓
- 次標籤：局部腫塊 / 連續中膈
- 次標籤：宮腔內與肌層病灶

7. 下次判斷規則

> **子宮鏡見圓鈍、平滑、有血管的局部腫塊，先想內膜息肉；由宮底一路向下、把宮腔分成左右兩半，才叫中膈。**

8. 投資報酬率

高

- 子宮內膜息肉是常見宮腔病灶，影像辨識成本低。
- 可延伸至黏膜下肌瘤、中膈、不孕及異常子宮出血。
- 本題也直接對應目前已重複出現的影像判讀失分模式。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**B，子宮內膜息肉。
- **現代臨床實務：**子宮鏡外觀高度支持息肉，但不能只憑外觀排除非典型增生或惡性病變；切除後仍需送病理。2024年指引同樣強調完整切除並取得病理標本。2024子宮內膜息肉指引
- **處置差異：**症狀性息肉、停經後出血、較高惡性風險或部分不孕患者通常考慮子宮鏡切除；年輕、低風險、無症狀的小息肉可依情況追蹤，並非所有息肉都必須立即手術。
- **爭議或限制：**單張靜態圖不能顯示病灶是否隨灌流液擺動，也沒有病人年齡與出血症狀；但其局部、平滑腔內腫塊外觀足以使B成為唯一最佳答案。

醫學（六）Q45

對話詳解原文

1. 題目

有關婦科腹腔鏡手術的準備，下列何者最不適當？

- A. 常用的是頭低腳高的姿勢
- B. 肚臍是最常用的打氣進入點
- C. 腹部的壓力一般設在8～10 mmHg
- D. 置入套管時，腹部的壓力可設在25～30 mmHg

題目核對自考選部醫學六正式試題。

2. 作答對照

- 使用者答案：D
- 考選部原始答案：C
- 考選部最終更正答案：C
- 是否有多答案接受或一律給分：否

原始答案與最終更正答案均為C；更正檔仍只更正Q3，Q23、Q66一律給分。

3. 核心考點

本題真正測試的是兩個不同階段的氣腹壓力：

1. **初始進入、置入第一支trocar時：**可短暫提高至20～30 mmHg，使腹壁被撐開、增加腹壁與腹腔臟器間的距離。
2. **完成進入後的手術維持壓力：**通常降至約12～15 mmHg，並採能維持足夠視野的最低壓力。

因此：

> 25～30 mmHg可以是「短暫進入壓力」，卻不是整場手術的維持壓力；8～10 mmHg可以作為低壓策略，卻不是傳統上所有一般成人腹腔鏡的標準設定。

4. 各選項逐一解析

A. 常用頭低腳高姿勢——正確

婦科骨盆腔腹腔鏡常使用Trendelenburg position，利用重力讓小腸及網膜向頭側移動，以暴露：

- 子宮。
- 卵巢及輸卵管。
- 膀胱子宮陷凹。
- 直腸子宮陷凹及骨盆側壁。

但頭低腳高加上氣腹會：

- 增加橫膈上移及呼吸道壓力。
- 降低肺順應性。
- 增加靜脈回流、顱內壓及眼內壓。
- 增加顏面及上呼吸道水腫。

因此「常用」正確，但角度及時間仍須依病人心肺狀況調整。

B. 肚臍是最常用的打氣進入點——正確

臍部通常是建立氣腹及放置第一支trocar最常使用的位置，理由包括：

- 腹壁較薄。
- 缺少厚實肌肉層。
- 可取得良好中央視野。
- 傷口較不明顯。

若懷疑臍下沾黏、曾接受多次腹部手術、子宮或腫瘤過大，則可改採：

- Palmer’ s point。
- Lee-Huang point。
- 開放式Hasson entry。
- 光學trocar等方式。

所以B是一般原則，不代表每位患者都必須從臍部進入。

C. 腹部壓力一般設在8～10 mmHg——最不適當，為本題答案

成人腹腔鏡傳統維持壓力多約12～15 mmHg；實際上應使用能提供足夠手術視野的最低壓力。

8～10 mmHg屬於low-pressure pneumoperitoneum，可在適當患者、良好肌肉鬆弛及手術視野允許時使用，可能減少：

- 術後肩痛。
- 心肺生理干擾。
- 靜脈回流與腎灌流影響。

但低壓可能使骨盆腔操作空間不足。因此把8～10 mmHg寫成婦科腹腔鏡「一般設定」並不符合本題採用的傳統標準。

D. 置入套管時可設25～30 mmHg——正確，但只限短暫階段

高壓進入法的目的，是在置入第一支trocar前：

- 充分抬起腹壁。
- 增加腹壁與大血管、腸道的距離。
- 降低腹壁受壓下陷造成的穿刺風險。

SOGC婦科腹腔鏡進入指引指出，可在置入trocar前將腹腔壓短暫提高至20～30 mmHg；健康患者短時間高壓通常不會造成顯著心肺傷害。SOGC婦科腹腔鏡進入指引

trocar安全進入後，壓力應立即降回約12～15 mmHg，而不是維持25～30 mmHg完成手術。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇D很可能是看到25～30 mmHg明顯高於常見的12～15 mmHg，便直接判斷為危險。

但本題的關鍵限定詞是：

「置入套管時」

同一數值在不同階段的意義不同：

- 短暫用於trocar進入：可以接受。
- 長時間作為手術維持壓力：不適當。

這與Q29相似，都是看到一個看似異常的數字後，沒有先核對它所屬的操作階段及適用條件。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 次標籤：數值門檻
- 次標籤：操作階段
- 次標籤：短暫壓力 / 維持壓力
- 次標籤：適應條件

7. 下次判斷規則

腹腔鏡「進門先撐開」可短暫20～30 mmHg；trocar進去後立即降至約12～15 mmHg。先分進入壓與維持壓，再判數字。

8. 投資報酬率

高

- 腹腔鏡氣腹、進入技術及trocar傷害是婦產科與外科共同考點。
- 可延伸至Veress needle、Hasson technique、Palmer’ s point及氣腹生理效應。
- 數字不多，但必須與操作階段綁定記憶。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**C。
- **現代臨床實務：**維持壓力不是固定只能12～15 mmHg；目前強調在視野允許下使用最低有效壓力，部分手術可維持8～10 mmHg。
- **高壓進入：**25～30 mmHg只能短暫使用，確認trocar進入後應立刻下降；心肺疾病、肥胖、妊娠或其他高風險患者須個別調整。
- **爭議或限制：**C若寫成「所有情況都不能使用8～10 mmHg」會是錯的；它之所以成為答案，是因「一般設在」的概括不符合傳統成人手術設定。循證指引也承認壓力須依病人生理與手術視野調整。微創手術氣腹壓力指引

醫學（六）Q48

對話詳解原文

1. 題目

關於子宮肌瘤的敘述，下列何者最正確？

- A. 25～29歲女性無論是否接受過子宮肌瘤切除手術，子宮肌瘤發生機率都高於40～44歲女性
- B. 10年期間曾經生育過之女性，新診斷之子宮肌瘤的機率較未生育者低
- C. 子宮肌瘤切除手術之前使用過GnRH-a來減少肌瘤體積者，術後再發生子宮肌瘤的機會比術前未使用GnRH-a者來得低
- D. 以超音波追蹤比較曾接受腹腔鏡子宮肌瘤切除術和開腹子宮肌瘤切除之病患，腹腔鏡子宮肌瘤切除術後子宮肌瘤的再發生率較低

2. 作答對照

- 使用者答案：C
- 考選部原始答案：B
- 考選部最終更正答案：B
- 是否有多答案接受或一律給分：否

考選部原始及最終更正答案均為B。

3. 核心考點

本題混合三種不同概念：

1. **第一次發生 / 被診斷的風險：**年齡、種族、家族史、肥胖、初經年齡、是否生育。
2. **藥物的短期術前效果：**GnRH agonist可暫時縮小肌瘤、改善貧血。
3. **肌瘤切除後的長期復發：**與年齡、殘留小肌瘤、肌瘤數量、追蹤時間及術後懷孕等有關。

唯一穩定正確的敘述是：

> 曾經生育與較低的新發子宮肌瘤風險相關。

4. 各選項逐一解析

A. 25～29歲發生率高於40～44歲——錯誤

子宮肌瘤的發生率與盛行率通常隨生育年齡增加，在40歲前後達到高峰，停經後因雌激素及黃體素降低，多數肌瘤才逐漸縮小。

大型世代研究顯示，40～44歲女性的新診斷率高於25～29歲女性；近期澳洲22年追蹤資料同樣顯示發生率在40～44歲最高。2024年長期世代研究

因此A把年齡方向完全顛倒。至於是否曾接受肌瘤切除，則是另一個「術後復發」問題，不能改變整體年齡流行病學的基本方向。

B. 曾經生育者新診斷機率較低——正確

Parity與較低的子宮肌瘤發生率相關，而且活產次數增加時，風險通常進一步下降。

可能機轉包括：

- 妊娠期間停止排卵及月經週期。
- 產後子宮退縮及肌層重塑。
- 部分小肌瘤在妊娠後縮小或消失。
- 與生殖荷爾蒙累積暴露的差異有關。

Nurses' Health Study II追蹤超過11萬名女性，也發現parity、較晚生育及距離最近一次生育時間較短，皆與較低肌瘤發生率相關。生殖特徵與子宮肌瘤前瞻性研究

但這是族群層級的相關性，不代表生過小孩便不會長肌瘤。

C. 術前GnRH-a可降低術後復發——錯誤

GnRH agonist可暫時造成低性腺激素狀態，短期效果包括：

- 縮小子宮及肌瘤體積。
- 減少出血。
- 改善缺鐵性貧血。
- 某些情況下降低術中失血或改善切口選擇。

但它沒有根除肌瘤的始源細胞，也沒有確立的長期防復發效果。

反而可能發生：

- 小肌瘤縮小後，手術時較難被看見或觸及。
- 停藥後荷爾蒙恢復，殘留病灶重新增大。
- 肌瘤變軟、剝離層次較不清楚，增加手術辨識困難。

系統性回顧認為術前GnRH-a對術後復發的影響資料有限且不一致，不能宣稱它降低復發。GnRH-a術前治療系統性回顧

D. 腹腔鏡術後復發率較開腹低——錯誤

這不是穩定成立的結論。

一項以超音波或MRI追蹤6個月至8年的研究發現：

- 腹腔鏡肌瘤切除後8年累積復發率：76.2%。
- 開腹肌瘤切除後8年累積復發率：63.4%。

研究者推測，開腹手術可用手觸診並較完整移除細小肌層內肌瘤；腹腔鏡可能留下當時未被辨識的小病灶。腹腔鏡與開腹肌瘤切除復發研究

不過其他研究也曾得到兩者相近的結果，因此不能把「腹腔鏡復發率較低」當成普遍原則。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇C可能是依下列直覺推論：

> GnRH-a會縮小肌瘤 → 手術比較容易、切得比較乾淨 → 復發率應該下降。

問題在於「短期體積縮小」只是替代指標，並不等於「長期復發減少」。小病灶反而可能因縮小而在手術時被遺漏。

這是把一個合理的短期藥理效果，直接外推成尚未被證實的長期臨床結果。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 次標籤：發病與復發
- 次標籤：短期替代指標 / 長期臨床結果
- 次標籤：GnRH agonist
- 次標籤：流行病學方向
- 次標籤：研究結果判讀

7. 下次判斷規則

> **肌瘤：年齡增加風險上升、曾生育風險下降；GnRH-a只做短期縮小與改善貧血，不等於防復發。**

8. 投資報酬率

中高

- 子宮肌瘤的危險因子、藥物用途及手術選擇常考。
- 可延伸至生育保存、術前貧血、復發及各種手術方式。
- 精確復發百分比不必死背，但「短期縮小不等於降低復發」值得保留。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**B。
- **現代臨床實務：**生育與較低肌瘤風險相關，但不能作為預防肌瘤的醫療建議；個別風險仍受年齡、遺傳、種族、BMI及其他因素影響。NICHD肌瘤危險因子
- **GnRH-a：**適合選擇性用於短期術前縮小、改善貧血或協助手術規劃；長期使用受骨質流失及低雌激素副作用限制。

- **手術方式：**腹腔鏡通常具有較少失血、較短住院及較快恢復等優勢，但復發率受選案、肌瘤數量、追蹤方式及殘留病灶影響，不能僅靠手術途徑預測。
- **爭議或限制：**D所涉及的腹腔鏡與開腹復發比較，研究結果並不完全一致；但「腹腔鏡較低」缺乏穩定支持，而B的流行病學方向較明確，故國考答案仍為B。

醫學（六）Q50

對話詳解原文

1. 題目

子宮內膜癌最常見復發位置為：

- A. 肺部
- B. 腹腔
- C. 淋巴腺
- D. 陰道

題目核對自考選部醫學六正式試題。

2. 作答對照

- 使用者答案：B
- 考選部原始答案：D
- 考選部最終更正答案：D
- 是否有多答案接受或一律給分：否

原始答案與最終更正答案均為D；更正檔仍僅更正Q3、Q23、Q66一律給分。

3. 核心考點

本題採傳統婦癌考點：

> 子宮內膜癌術後最具代表性、最常見的局部或孤立復發位置是陰道穹窿，尤其陰道頂端。

多數子宮內膜癌因停經後出血而在早期確診，接受全子宮切除後，局部復發容易出現在原子宮頸及子宮所在位置下方的陰道殘端。

但「最常見復發位置」若未限定期別、組織型及局部或遠端復發，現代資料的答案可能不同：局部晚期、高級別或特殊組織型患者常以骨盆外或多處遠端復發為主。

4. 各選項逐一解析

A. 肺部——不是本題答案

肺是子宮內膜癌常見的遠端轉移位置之一，尤其見於：

- 高級別腫瘤。
- 深肌層侵犯。
- 淋巴血管侵犯。
- 晚期或多處復發。
- 漿液性癌、癌肉瘤等高風險組織型。

因此肺部不是不會復發，而是在傳統「早期子宮內膜癌術後最常見局部復發位置」的題型中，不優先於陰道穹窿。

B. 腹腔——錯誤

腹膜、網膜及腹腔內復發較常見於：

- 漿液性子宮內膜癌。
- 癌肉瘤。
- 高級別或晚期疾病。
- 原先已有子宮外散布的患者。

使用者選擇B，可能是把子宮內膜癌套入卵巢癌典型的腹膜播散模式，或優先想到高風險子宮內膜癌的遠端復發。

一般早期、低級別endometrioid carcinoma切除後，陰道殘端仍是最具代表性的孤立復發部位。

C. 淋巴腺——不是最佳答案

骨盆或主動脈旁淋巴結是重要的區域復發位置，風險受到下列因素影響：

- 腫瘤分級。
- 肌層侵犯深度。
- 淋巴血管侵犯。
- 子宮頸間質侵犯。
- 分子亞型及是否接受輔助治療。

淋巴結復發具有臨床重要性，但在本題傳統分類下，不是最常見的局部復發答案。

D. 陰道——正確

陰道復發通常發生於陰道穹窿或頂端，可能表現為：

- 陰道出血或帶血分泌物。
- 骨盆不適。
- 理學檢查發現陰道頂端結節或腫塊。
- 少數患者無症狀，在追蹤檢查時發現。

一項stage I子宮內膜癌研究顯示，孤立性陰道復發雖只占全體患者約2%，但仍是早期患者最典型的局部復發型態，而且多數位於陰道頂端。Stage I子宮內膜癌復發型態研究

未曾接受骨盆放射治療的孤立陰道復發，常可使用外照射合併近接治療取得良好局部控制。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇腹腔，可能是將「婦科癌症常見腹膜播散」的印象套用到所有子宮內膜癌，沒有先限定國考預設情境：

- 多數子宮內膜癌為早期確診。
- 原發治療通常包括子宮切除。
- 題目問的是教科書式最常見復發部位。
- 這時先想到陰道穹窿，而不是高風險癌的腹腔或遠端復發。

6. 失分類型

- 國考記憶點
- 核心臨床知識缺口
- 二選一失誤
- 次標籤：最常見極性字眼
- 次標籤：局部復發 / 遠端復發
- 次標籤：早期 / 高風險疾病情境
- 次標籤：婦癌播散模式混用

7. 下次判斷規則

> **早期子宮內膜癌切除後，問最典型復發位置先選陰道穹窿；高級別或晚期疾病才優先警覺腹腔、肺及多處遠端復發。**

8. 投資報酬率

中高

- 婦癌的復發與轉移位置是常見國考題。
- 可延伸至術後追蹤、陰道近接治療及復發治療。
- 不必死背各部位百分比，但要區分早期局部復發與高風險遠端復發。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**D，陰道。
- **現代臨床實務：**復發型態高度依賴FIGO期別、組織型、分子分類及曾接受的輔助治療。局部晚期患者最常見者可能是遠端復發，不能把D套用至所有族群。ASTRO子宮內膜癌放射治療指引
- **追蹤重點：**應詢問陰道出血、疼痛、咳嗽、體重下降等症狀並進行骨盆檢查；影像通常依症狀及復發風險選擇，而非所有低風險患者固定密集掃描。
- **爭議或限制：**題目未限定「早期、術後、局部或孤立復發」，措辭過度簡化。D是傳統國考答案，但不是跨越所有風險群都成立的普遍定律。

醫學（六）Q51

對話詳解原文

1. 題目

關於 complete hydatidiform mole，下列敘述何者錯誤？

- A. 相對於正常妊娠週數，80%呈現懷孕子宮過大
- B. 染色體以雙倍體（diploid）出現
- C. molar chromosomes全部來自於父親
- D. 相較於partial mole更容易進展成侵襲性癌症

2. 作答對照

- 使用者答案：B
- 考選部原始答案：A
- 考選部最終更正答案：A
- 是否有多答案接受或一律給分：否

考選部原始及最終更正答案均為A。

3. 核心考點

完全性葡萄胎的典型遺傳機轉是：

1. 一顆沒有功能性母系核基因的空卵。
2. 由一顆精子受精後複製，或由兩顆精子受精。
3. 最後仍形成完整的兩套染色體，因此是**雙倍體**。
4. 核染色體幾乎完全來自父系，稱為androgenetic diploidy。

最常見核型為46,XX，其次為46,XY。重點是：

> **只有父系來源，不代表只有一套染色體。單親來源與倍數是兩個不同概念。**

4. 各選項逐一解析

A. 80%出現子宮大於妊娠週數——錯誤，為本題答案

子宮大於預期孕週確實是完全性葡萄胎的傳統表現，原因包括：

- 絨毛廣泛水腫及滋養層增生。
- hCG顯著升高。
- 可能合併雙側theca lutein cysts。

但「80%」明顯過高。現代患者常在第一孕期接受超音波並提早診斷，尚未發展出極度子宮增大、甲狀腺亢進或早發子癇前症等完整古典表現。FIGO相關綜述也指出，隨早期超音波普及，子宮大於孕週等古典表徵現在已較少見。FIGO妊娠滋養細胞疾病更新

因此可以記「可能大於孕週」，但不能記成固定80%。

B. 染色體為雙倍體——正確

完全性葡萄胎通常為：

- 46,XX：約占九成。
- 46,XY：較少見。
- 46,YY：無法存活。

最常見機轉是一顆23,X精子進入空卵後自行複製，形成兩套完全相同的父系染色體。另一種是兩顆精子同時受精，形成46,XX或46,XY。

NCI資料同樣將完全性葡萄胎定義為空卵受精後形成的雙倍體，而部分性葡萄胎通常是三倍體。NCI妊娠滋養細胞疾病資料

C. 葡萄胎核染色體全部來自父親——典型情況正確

經典完全性葡萄胎屬androgenetic conception：

- 核染色體來自父系。
- 沒有正常母系核基因組。
- 因缺少母系表現的基因，胚胎無法正常形成。
- 胎盤滋養層則過度增生。

病理上常利用p57免疫染色協助鑑別：

- 完全性葡萄胎：通常p57陰性。
- 部分性葡萄胎及非葡萄胎流產：通常p57陽性。

需要注意，細胞的粒線體DNA仍來自卵細胞，且極少數家族性、雙親來源的完全性葡萄胎可與NLRP7或KHDC3L等母系效應基因異常有關。因此C是標準核染色體描述，不是毫無例外的宇宙定律。

D. 較partial mole容易進展成侵襲性病變——正確

完全性葡萄胎發生postmolar gestational trophoblastic neoplasia的機率明顯高於部分性葡萄胎。

NCI資料估計：

- 完全性葡萄胎進展為侵襲性葡萄胎：約15%～25%。
- 部分性葡萄胎惡性轉化：低於5%。

所以D的方向正確。NCI GTD分類與風險

不過「侵襲性癌症」用詞不精確：invasive mole屬妊娠滋養細胞腫瘤，具有局部侵犯能力，但病理分類上不等同於一般所稱的carcinoma；choriocarcinoma則是另一個明確惡性實體。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇B可能是把：

> 全部染色體來自父親

推成：

> 只有父親的一套染色體，所以應該是單倍體。

但完全性葡萄胎通常是父系染色體複製或兩顆精子共同提供兩套染色體，因此同時具備：

- 單一親本來源：androgenetic。
- 兩套染色體：diploid。

這是「來源」與「數量」兩個分類軸混在一起所造成的錯誤。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 次標籤：遺傳機轉
- 次標籤：親本來源 / 染色體倍數
- 次標籤：完全性 / 部分性葡萄胎
- 次標籤：古典表現與現代盛行頻率
- 輕度爭議或低效度題：D使用「侵襲性癌症」不夠精確

7. 下次判斷規則

> **完全性葡萄胎 = 空卵 + 父系雙倍體46,XX為主 + 無胎兒 + p57陰性 + GTN風險較高；父系專屬不等於單倍體。**

8. 投資報酬率

高

- 完全性與部分性葡萄胎比較是婦產科及病理科高頻題。
- 可延伸至核型、p57、超音波、hCG及惡性後續風險。
- 建議十月以一張比較表完整重讀，而不是分散背單一敘述。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**A。

- **現代臨床實務：**完全性葡萄胎可以出現子宮大於孕週，但早期超音波使極端古典表現愈來愈少，固定寫成80%不合理。
- **診斷實務：**早期葡萄胎不一定呈典型snowstorm；需結合超音波、病理、p57免疫染色及必要時分子分型。
- **治療後：**子宮內容物清除後仍須連續監測定量hCG，因症狀消失或超音波清空不能排除postmolar GTN。
- **爭議或限制：**C忽略極少數雙親來源完全性葡萄胎；D把侵襲性葡萄胎稱作「癌症」也不夠精確，但A的80%仍是四項中最明確錯誤者。

醫學（六）Q53

對話詳解原文

1. 題目

關於子宮頸癌的放射線治療，下列敘述何者錯誤？

- A. 傳統2D放射線治療中的「A點」位置，在子宮頸外口上2公分、子宮頸管外3公分
- B.「A點」的放射劑量通常達到7,000至8,000 cGy
- C. 術後放射線治療對於骨盆淋巴轉移的病人可以減少骨盆復發率
- D. 放射線治療合併化學治療可以增強其療效

題目核對自考選部醫學六正式試題。

2. 作答對照

- 使用者答案：B
- 考選部原始答案：A
- 考選部最終更正答案：A
- 是否有多答案接受或一律給分：否

原始答案及最終更正答案均為A；更正檔仍只更正Q3，Q23、Q66一律給分。

3. 核心考點

本題決勝點是傳統Manchester system的A點定義：

> 從子宮頸外口沿子宮腔內管向上2公分，再向外側垂直2公分。

因此是「上2、外2」，不是「上2、外3」。

A點原本是以解剖座標近似子宮動脈與輸尿管交會附近、子宮旁組織耐受限制區域，用於傳統二維腔內近接治療的處方與劑量報告。

4. 各選項逐一解析

A. 外口上2公分、子宮頸管外3公分——錯誤，為本題答案

正確位置應為：

- 沿子宮腔內管自外口向頭側2公分。
- 再向左右側垂直2公分。

「外3公分」才是錯誤所在。ASTRO的教學資料仍將歷史A點標示為「外口上2公分、tandem外2公分」；B點則位於A點再向外約3公分的位置。ASTRO子宮頸癌近接治療資料

這很可能是把：

- A點的「向外2公分」

- A點到B點的「再向外3公分」

混在一起。

B. A點總劑量通常達7,000～8,000 cGy——國考判定正確

7,000～8,000 cGy即70～80 Gy，這裡指的是外照射加近接治療的累積總劑量概念，不是一次照射給予70～80 Gy。

傳統治療會將：

- 骨盆外照射。
- 腔內近接治療。

累積至A點約70～80 Gy，依腫瘤大小、期別與分次方式調整。

現代治療常改用EQD2比較不同分次，局部晚期子宮頸癌的腫瘤高風險臨床靶體積HR-CTV D90常以至少約80～85 Gy為目標。因此B在傳統國考架構中並不算太高。

C. 骨盆淋巴結轉移者，術後放射治療可降低骨盆復發——正確但不完整

骨盆淋巴結陽性屬根除性手術後的高風險病理因子。骨盆放射治療可降低局部及區域復發。

現代標準通常不只是單獨放射治療，而是考慮含cisplatin的同步放化療，尤其合併：

- 骨盆淋巴結轉移。
- 手術切緣陽性。
- 子宮旁組織侵犯。

因此C的方向正確，但若把它寫成完整治療建議，應補上同步化療。

D. 放射線合併化學治療可增強療效——正確

Cisplatin具有放射增敏作用。同步放化療可：

- 增加DNA損傷。
- 抑制放射損傷修復。
- 改善局部控制。
- 治療潛在微小遠端病灶。

ASTRO指引強烈建議局部晚期子宮頸癌接受外照射、同步含鉑化療及近接治療；近接治療不是可任意省略的附加項目。ASTRO子宮頸癌放射治療指引

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇B可能是看到7,000～8,000 cGy後，將其理解成：

- 單次給予的劑量，或
- 單獨外照射的劑量，

因而覺得數值過高。

但本題談的是外照射加近接治療的累積總劑量。相反地，A的錯誤只藏在一個公分差異中：

- 正確：上2、外2。
- 題目：上2、外3。

這再次呈現「數值沒有先綁定測量定義與累積方式」的失分模式。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 次標籤：數值門檻
- 次標籤：解剖座標
- 次標籤：單次劑量 / 累積總劑量
- 次標籤：A點 / B點混淆
- 次標籤：錯誤極性字眼

7. 下次判斷規則

> **子宮頸癌傳統A點 = 外口上2、tandem外2；70～80 Gy看的是外照射加近接治療總量，不是單次劑量。**

8. 投資報酬率

中高

- A點座標屬傳統國考記憶點。
- 可延伸至A點、B點、膀胱與直腸劑量及近接治療。
- 現代實務已轉向影像導引體積處方，因此不值得深背大量二維座標，但「上2、外2」成本很低，應保留。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**A。
- **現代臨床實務：**MRI或CT影像導引近接治療已逐漸取代單純以A點處方；現在重視HR-CTV D90以及膀胱、直腸、乙狀結腸等器官的D2cc。
- **總治療時間：**外照射與近接治療應避免不必要延遲，因總療程拖長會降低局部控制。
- **術後淋巴結陽性：**通常應評估同步含鉑放化療，而不只是單獨骨盆照射。
- **爭議或限制：**B的70～80 Gy是歷史性概括，現代劑量會依EQD2、腫瘤體積與器官限制個別規劃；但不影響A的座標錯誤。

醫學（六）Q55

對話詳解原文

1. 題目

關於更年期症候群之血管動力變化（vasomotor symptoms）引起之相關熱潮紅（hot flashes）等症狀，下列敘述何者錯誤？

- A. 停經前後發生症狀的時間可以長達十年
- B. 肥胖的女性因為體脂肪較高，所以症狀較正常體重的更年期婦女輕微
- C. 全身性投予荷爾蒙是最有效的治療
- D. 瑜珈、針灸、戒菸和冷氣有助於減輕症狀

2. 作答對照

- 使用者答案：C
- 考選部原始答案：B
- 考選部最終更正答案：B
- 是否有多答案接受或一律給分：否

考選部原始及最終更正答案均為B。

3. 核心考點

本題測試三件事：

1. 熱潮紅可能持續多年，不只一兩年。
2. 肥胖不會因脂肪芳香化產生較多雌激素，就穩定地減輕症狀。
3. 若只比較療效，全身性更年期荷爾蒙治療仍是血管舒縮症狀最有效的治療。

必須區分：

> 「最有效」不等於「每個人都適合使用」。

4. 各選項逐一解析

A. 症狀可長達十年——正確

SWAN大型縱向研究顯示，頻繁血管舒縮症狀的中位總持續時間約7.4年；若症狀在停經過渡早期就開始，中位持續時間可超過11年。SWAN血管舒縮症狀研究

因此「可以長達十年」合理。部分患者甚至可持續至停經後很久，不能再使用「通常只忍兩三年就會結束」的舊印象。

B. 肥胖女性症狀較輕——錯誤，為本題答案

這個說法來自舊式直覺：

脂肪組織可將雄性素芳香化為雌酮，所以肥胖女性應有較多雌激素、熱潮紅較輕。

但實際觀察並不支持這種簡單推論。更年期過渡期的肥胖，尤其腹部肥胖，通常與較頻繁或較嚴重的熱潮紅、盜汗相關。

可能機轉包括：

- 皮下脂肪增加隔熱效果，使散熱較困難。
- 中樞體溫調節區縮窄。
- 發炎與代謝異常。
- 睡眠呼吸障礙及情緒症狀交互放大主觀負擔。

2026年The Menopause Society公布的SWAN相關研究亦指出，腹部肥胖與較嚴重的熱潮紅及夜間盜汗相關。The Menopause Society研究摘要

C. 全身性荷爾蒙是最有效治療——正確

對沒有禁忌症、症狀明顯的患者，全身性更年期荷爾蒙治療仍是降低熱潮紅頻率與嚴重度最有效的方法。The Menopause Society 2022荷爾蒙治療聲明

基本原則：

- 有子宮：通常須使用雌激素加適當黃體素，以保護子宮內膜。
- 已切除子宮：多數情況可使用單獨雌激素。
- 年齡小於60歲或距最終月經未滿10年、且無禁忌症者，效益風險比通常較佳。
- 使用最低有效劑量，並定期重新評估。

因此不能因荷爾蒙治療存在風險，就否定它在適當患者中的療效排名。

D. 瑜珈、針灸、戒菸及冷氣有助減輕症狀——國考判定正確，但現代證據有明顯限制

其中各項不能視為同等證據：

- **戒菸：**吸菸與較嚴重、較持久的VMS相關，戒菸對整體健康明確有益，但直接治療熱潮紅的效果未必強。
- **冷氣、分層穿衣、風扇：**可改善發作當下的不適，但未必降低VMS本身的發生頻率。
- **瑜珈：**可能改善睡眠、壓力與生活品質，但對熱潮紅頻率的證據不一致。
- **針灸：**部分患者主觀改善，但與sham acupuncture比較時效果有限且研究異質性高。

2023年The Menopause Society並未把瑜珈、針灸或單純降溫技巧列為具有充分證據的VMS治療。因此D較適合解讀成「舒適度或整體健康可能改善」，不能當成現代高證據等級治療建議。2023非荷爾蒙治療立場聲明

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇C可能是受到荷爾蒙治療的乳癌、血栓或心血管風險印象影響，因而把：

> 不是每位患者都適用

誤判成：

> 它不是療效最強的治療。

但這是兩個不同問題：

- **療效問題：**全身性荷爾蒙最有效。
- **適用性問題：**必須依年齡、距停經時間、子宮狀態、癌症與血栓風險個別評估。

相反地，B用一條看似合理的芳香化機轉，推導出與實際流行病學不符的結論。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 爭議或低效度題
- 次標籤：療效 / 適用性混淆
- 次標籤：機轉推論 / 臨床結果
- 次標籤：肥胖與熱潮紅
- 次標籤：錯誤極性字眼

7. 下次判斷規則

> **熱潮紅可拖超過十年；肥胖通常更嚴重；只問「最有效」就選全身性荷爾蒙，但再另行檢查禁忌症與是否需黃體素。**

8. 投資報酬率

高

- 更年期VMS治療是婦產科及一般內科常考題。
- 可延伸至荷爾蒙適應症、禁忌症、子宮內膜保護及非荷爾蒙治療。
- 「最有效」與「最安全 / 最適合」的區分可跨科套用至大量治療題。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**B。
- **現代臨床實務：**全身性荷爾蒙仍是最有效治療，但應個別評估；具有雌激素敏感性癌症、未明原因陰道出血、活動性或高風險血栓等情況時，通常改採非荷爾蒙方案。
- **具證據的非荷爾蒙選項：**包括部分SSRIs / SNRIs、gabapentin、fezolinetant及特定情況下的oxybutynin；選擇取決於共病與副作用。

- **D項爭議：**現代立場聲明不建議把瑜珈、針灸或降溫措施宣稱為已證實可降低VMS的治療。這使本題在現代證據下可能同時有B與D的問題；國考仍以B計分，不擅自更改官方答案。

醫學（六）Q58

對話詳解原文

1. 題目

下列何者是外傷性腦傷之原發性損傷（primary injury）？

- A. 瀰漫性軸突損傷（diffuse axonal injury）
- B. 顱內壓上升（increased intracranial pressure）
- C. 腫塊效應（mass effect）
- D. 腦水腫（brain edema）

題目核對自考選部醫學六正式試題。

2. 作答對照

- 使用者答案：B
- 考選部原始答案：A
- 考選部最終更正答案：A
- 是否有多答案接受或一律給分：否

原始答案及最終更正答案均為A；更正檔仍只更正Q3，Q23、Q66一律給分。

3. 核心考點

外傷性腦傷依發生時間及機轉分成：

- **原發性損傷：**外力作用當下直接造成的組織破壞，事後無法真正逆轉。
- **次發性損傷：**數分鐘至數日內，由水腫、缺血、缺氧、低血壓、發炎、癲癇或顱內壓升高等連鎖反應造成，可透過急救與重症照護減少。

瀰漫性軸突損傷來自旋轉加速或減速造成的軸突剪切，是典型原發性損傷。

4. 各選項逐一解析

A. 瀰漫性軸突損傷——正確

DAI發生於撞擊當下的角加速度及旋轉力，使不同密度的腦組織產生相對位移，造成軸突拉伸、剪切與斷裂。

常見位置包括：

- 灰白質交界。
- 胼胝體。
- 腦幹背外側。
- 嚴重時多處分布。

臨床可表現為撞擊後立即昏迷，而頭部CT未必有能解釋意識程度的大型血腫；MRI susceptibility及diffusion影像通常較敏感。

雖然軸突後續會發生離子失衡、細胞骨架破壞及延遲性斷裂，但起始的機械性剪切發生於受傷瞬間，所以分類為原發性損傷。

B. 顱內壓上升——錯誤

顱內壓升高通常是下列病變累積後的結果：

- 腦水腫。
- 顱內血腫擴大。
- 腦脊髓液循環受阻。
- 靜脈回流不良。
- 腦血容量增加。

它會進一步降低腦灌流壓：

$$CPP = MAP - ICP$$

若ICP持續升高，可能造成腦缺血、腦疝及新的神經損傷，所以屬重要的次發性損傷機轉。

Brain Trauma Foundation建議嚴重TBI合併異常CT的可救治患者進行ICP監測，目的正是及早控制可介入的次發性傷害。Brain Trauma Foundation嚴重TBI指引

C. 腫塊效應——錯誤

「腫塊效應」不是特定的原發性組織傷害，而是血腫、挫傷、水腫或腫脹對周圍組織造成壓迫的結果，可能表現為：

- 腦溝消失。
- 腦室受壓。
- 中線偏移。
- 基底池消失。
- 腦疝。

需要精確區分：

- 撞擊當下形成的硬膜外血腫、硬膜下血腫或腦挫傷可列入原發性病灶。
- 這些病灶後續造成的「mass effect」則是次發性生理後果。

D. 腦水腫——錯誤

TBI後腦水腫可包含：

- 血管性水腫：血腦障壁受損。
- 細胞毒性水腫：缺血與能量失敗造成細胞內鈉水累積。

腦水腫通常在受傷後逐漸形成，進一步升高ICP、降低腦灌流，因此是典型次發性傷害。2025年TBI管理綜述同樣將腦水腫、顱內壓升高及缺血列為原發機械性損傷後的次發反應。TBI管理與指引綜述

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇B可能是因為ICP升高是嚴重TBI最核心、最急迫的問題，因而把「臨床上最重要的損傷」誤認為「原發性損傷」。

但分類依據不是嚴重度，而是時間與因果位置：

- 外力直接打出來的病灶 = 原發。
- 原發病灶後續引起的惡化鏈 = 次發。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 題幹理解 / 推理失誤
- 國考記憶點
- 次標籤：原發 / 次發損傷
- 次標籤：事件時間軸
- 次標籤：直接病灶 / 生理後果
- 次標籤：重要性與分類混淆

7. 下次判斷規則

> **撞擊瞬間直接剪切或撕裂的是原發傷；之後才形成的水腫、ICP升高、缺血與腦疝都是次發傷。**

8. 投資報酬率

高

- 原發與次發腦傷是急診、神外、麻醉及復健共同高頻題。
- 可延伸至DAI、顱內血腫、腦灌流壓及TBI急救目標。
- 這個時間軸模型能一次處理多題，不只值得背單一答案。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**A。
- **現代臨床實務：**到院前無法逆轉原發性軸突剪切，治療重點是避免低血氧、低血壓、發燒、癲癇、低鈉及顱內高壓等次發打擊。
- **影像限制：**CT正常或只有少量出血不能排除DAI；意識障礙與CT不成比例時需考慮MRI。
- **分類限制：**真實病理不是完全二分。DAI由瞬間機械傷害開始，之後仍會進行次發性軸突退化；國考依起始事件將其歸為原發損傷。

醫學（六）Q60

對話詳解原文

1. 題目

下列脊髓脊膜膨出（myelomeningocele）的併發症中，何者最少見？

- A. 神經性膀胱問題
- B. 水腦症
- C. 脊柱側彎
- D. 阿諾德 - 希阿里畸形（Arnold-Chiari malformation）

2. 作答對照

- 使用者答案：D
- 考選部原始答案：C
- 考選部最終更正答案：C
- 是否有多答案接受或一律給分：否

考選部原始及最終更正答案均為C。

3. 核心考點

Myelomeningocele不是只有局部脊髓缺損，而是一組高度相關的神經、泌尿與骨骼問題：

- 神經性膀胱：幾乎普遍存在。
- Chiari II malformation：與myelomeningocele高度綁定。
- 水腦症：非常常見，許多患者需要CSF分流。
- 脊柱側彎：也常見，但受病灶高度、行走能力與年齡影響，整體頻率低於前三者。

因此四項中最少見的是C。

4. 各選項逐一解析

A. 神經性膀胱——非常常見

脊髓與薦髓排尿神經路徑受損，可能造成：

- 膀胱順應性降低。
- 逼尿肌過度活化或無力。
- 逼尿肌 - 括約肌協調不良。
- 尿滯留、尿失禁。
- 膀胱輸尿管逆流及腎臟損傷。

幾乎所有myelomeningocele患者都可能有不同程度的神經性膀胱，不能只靠「有沒有尿失禁」判斷；需要尿路超音波、腎功能及選擇性尿動力學追蹤。Chiari II與myelomeningocele臨床綜述

B. 水腦症——非常常見

Chiari II造成後腦結構向下移位，可能阻礙第四腦室出口及腦脊髓液循環。不同研究族群中，水腦症約見於50%～90%的myelomeningocele患者。

監測重點包括：

- 頭圍增加速度。
- 囟門張力。
- 嘔吐、嗜睡及眼球下視。
- 腦室大小。
- 已置放分流器者是否發生阻塞或感染。

部分患者需要腦室腹腔分流，或在選定情況接受第三腦室造口合併脈絡叢燒灼。AAPM&R myelomeningocele資料

C. 脊柱側彎——四項中最少見，為本題答案

脊柱側彎可能來自：

- 椎體先天畸形。
- 軀幹肌力不平衡。
- 骨盆傾斜。
- 高位神經病灶。
- tethered cord或syringomyelia。
- 成長期曲線進展。

但它並非每位患者都有，盛行率隨病灶高度和判定標準變動很大；整體資料約三分之一，也有高位病灶族群報告更高比例。

因此它仍值得長期監測，但在本題四個選項中，低於近乎普遍的神經性膀胱、Chiari II及高度常見的水腦症。Spina bifida併發症綜述

D. Arnold-Chiari malformation——非常常見

此處指的是**Chiari II malformation**，不是一般成人偶然發現的Chiari I。

Chiari II典型包括：

- 小腦蚓部、延髓及第四腦室向枕骨大孔下移。
- 後顱窩較小。
- 常合併水腦症。
- 與開放性myelomeningocele高度相關。

解剖影像上的Chiari II可出現在約80%～90%以上的myelomeningocele患者，但真正出現吞嚥障礙、喘鳴、呼吸中止或上肢無力等腦幹症狀者少得多。Myelomeningocele泌尿與Chiari II綜述

所以不能因為「有症狀的Chiari很少見」，就判定解剖畸形本身少見。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇D可能是依一般人口印象判斷：

> Arnold-Chiari是罕見先天畸形，所以應是最少見。

但題目問的是myelomeningocele患者，而不是一般人口。這個疾病情境會徹底改變先驗機率：

- 一般人口：Chiari II罕見。
- Myelomeningocele患者：Chiari II是高度典型伴隨畸形。

另一個可能是把「有影像學Chiari II」與「出現症狀、需要後顱窩減壓」混為一談。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 次標籤：疾病情境下的條件機率
- 次標籤：Chiari I / Chiari II
- 次標籤：影像存在 / 症狀性疾病
- 次標籤：最少見極性字眼

7. 下次判斷規則

> **看到myelomeningocele就綁定「Chiari II + 水腦 + 神經性膀胱」；脊柱側彎雖常見，仍是這四項中相對較少者。**

8. 投資報酬率

高

- Myelomeningocele的多系統併發症是復健、兒科、神外與泌尿科共同考點。
- 可延伸至病灶高度、行走預後、腦室分流、神經性膀胱及腎臟保護。
- 「一般罕見疾病在特定症候群中可能接近必然」是重要的跨科推理規則。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**C，脊柱側彎。

- **現代臨床實務：**各併發症比例取決於病灶高度、胎兒期或出生後修補、年齡與定義，不能把單一百分比套用到所有患者。
- **Chiari II：**影像異常很常見，但只有症狀性腦幹壓迫或進行性神經功能異常才需要特定介入；處置症狀前也須先排除水腦症及分流器失效。
- **神經性膀胱：**症狀輕微不代表低壓安全膀胱，長期目標是保護上泌尿道與腎功能。
- **爭議或限制：**題目只寫Arnold-Chiari而未標明type II，措辭不夠精確；但在myelomeningocele情境中應理解為Chiari II，因此不影響官方答案。

醫學（六）Q61

對話詳解原文

1. 題目

一位外傷性腦傷病患做復健治療時，為了評估他的記憶力及認知功能損傷情況，最常用的工具為下列何者？

- A. 改良阿修氏量表（Modified Ashworth scale）
- B. 布氏階段（Brunnstrom stage）評估表
- C. 瑞秋洛斯阿米哥斯量表（Rancho Los Amigos levels）
- D. 功能獨立性測量（functional independence measure）

題目核對自考選部醫學六正式試題。

2. 作答對照

- 使用者答案：A
- 考選部原始答案：C
- 考選部最終更正答案：C
- 是否有多答案接受或一律給分：否

原始答案及最終更正答案均為 C；更正檔仍僅更正 Q3、Q23、Q66一律給分。

3. 核心考點

本題要求把不同復健評估工具配對到正確的評估構面：

- Modified Ashworth Scale：肌張力 / 痙攣。
- Brunnstrom stage：中風後動作與協同模式恢復階段。
- Rancho Los Amigos Levels：腦傷後認知與行為恢復階段。
- FIM：整體日常功能獨立程度及照護需求。

因此，外傷性腦傷後要分級認知、行為及反應狀態，四項中應選 Rancho Los Amigos Levels。

4. 各選項逐一解析

A. Modified Ashworth Scale——錯誤

Modified Ashworth Scale藉由檢查者快速被動活動關節，依感受到的阻力評估肌張力增加程度，主要用於：

- 中風。
- 腦傷。
- 脊髓損傷。

- 腦性麻痺。
- 多發性硬化症等中樞神經病變的痙攣。

它評估的是「被動活動阻力」，不是記憶力、定向感或認知恢復。量表也有速度控制不足、無法完全區分神經性痙攣與肌肉攣縮等限制。Shirley Ryan AbilityLab：Modified Ashworth Scale

B. Brunnstrom stage——錯誤

Brunnstrom stage主要描述中風後偏癱肢體的動作恢復歷程，例如：

- 初期弛緩。
- 痙攣及共同運動模式出現。
- 痙攣達高峰。
- 開始脫離共同運動。
- 出現更獨立的關節動作。
- 接近正常協調。

它是動作控制及痙攣恢復階段，不是外傷性腦傷的認知分級工具。

C. Rancho Los Amigos Levels——正確

Rancho Los Amigos Levels of Cognitive Functioning Scale專門描述腦傷患者認知、行為及與環境互動能力的恢復情況。

修訂版通常分為10級，包括：

- I：無反應。
- II：一般性反應。
- III：局部性反應。
- IV：混亂、躁動。
- V：混亂、不適當。
- VI：混亂但適當。
- VII：自動化、適當。
- VIII：有目的、適當。
- IX：有目的、適當，但需待命協助。
- X：有目的、適當，達修正後獨立。

它能提供團隊共通語言，用於安排治療強度、設定復健目標及向家屬說明恢復階段。Rancho Los Amigos官方衛教資料、復健量表資料庫

D. Functional Independence Measure——不是最佳答案

FIM包含18個項目：

- 13個動作項目，如進食、穿衣、移位、行走。

- 5個認知項目，如理解、表達、社交互動、問題解決及記憶。

所以FIM確實包含認知內容，但主要目的在量化：

- 完成日常活動需要多少協助。
- 整體功能障礙程度。
- 照護負擔與復健結果。

它不像Rancho量表那樣，專門描述腦傷後認知與行為恢復階段。題目若問「整體功能獨立程度」，D才會更適合。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇A可能是知道Modified Ashworth Scale常用於腦傷及神經復健，但把：

> 適用的疾病族群

誤當成：

> 實際評估的功能構面。

同一名外傷性腦傷患者可能同時接受Ashworth、Rancho及FIM評估，但各量表回答的問題不同。本題要先抓「記憶力及認知功能」，再選量表，而不是只看「外傷性腦傷」。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 次標籤：評估工具與評估構面配對
- 次標籤：認知 / 痙攣 / 動作恢復 / 功能獨立
- 次標籤：適用族群與量表用途混淆

7. 下次判斷規則

> **腦傷認知分級找Rancho；痙攣找Ashworth；中風動作階段找Brunnstrom；整體照護依賴度找FIM。**

8. 投資報酬率

高

- 復健量表配對是高頻國考題。
- 可延伸至中風、腦傷、脊髓損傷及住院復健。
- 建議把「量表—評估構面—適用疾病」整理成一張表，而不是只背量表名稱。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**C，Rancho Los Amigos Levels。
- **現代臨床實務：**Rancho是認知及行為恢復的整體分級，不是精細的記憶測驗。若要判定注意力、執行功能、語言、學習與記憶的個別缺損，仍需MoCA、失憶期評估及正式神經心理測驗。
- **爭議或限制：**題目把「評估記憶力及認知損傷」寫得較廣。FIM也有記憶及其他認知項目，但其核心是功能獨立與照護負擔；在所列選項中，C仍是最具腦傷認知分級專一性的答案。

醫學（六）Q62

對話詳解原文

1. 題目

有關急性傷害疼痛處理，下列敘述何者錯誤？

- A. 所謂 PRICE，其中 I 是冰敷（ice）
- B. 所謂 POLICE，其中 OL 是適度負荷（optimal loading）
- C. 所謂 PEACE，其中 A 是避免使用抗發炎治療模式（avoid anti-inflammatory modalities）
- D. 所謂 LOVE，其中 E 是抬高（elevation）

2. 作答對照

- 使用者答案：C
- 考選部原始答案：D
- 考選部最終更正答案：D
- 是否有多答案接受或一律給分：否

考選部原始及最終更正答案均為D。

3. 核心考點

本題測試四組急性軟組織傷害口訣的字母內容：

- **PRICE：**Protection、Rest、Ice、Compression、Elevation。
- **POLICE：**Protection、Optimal Loading、Ice、Compression、Elevation。
- **PEACE：**Protection、Elevation、Avoid anti-inflammatory modalities、Compression、Education。
- **LOVE：**Load、Optimism、Vascularisation、Exercise。

因此LOVE的E是Exercise，不是Elevation；D錯誤。

4. 各選項逐一解析

A. PRICE的I是Ice——正確

PRICE是在RICE之前加入Protection：

- P：Protection。
- R：Rest。
- I：Ice。
- C：Compression。

- E：Elevation。

冰敷主要用於短期止痛；對腫脹控制及組織修復速度的實際效益則沒有口訣表面上那麼確定。

B. POLICE的OL是Optimal Loading——正確

POLICE以Optimal Loading取代完全休息，強調：

- 在不增加傷害的範圍內逐步承重或活動。
- 依疼痛、腫脹、組織受傷程度及功能反應調整。
- 避免長期完全不動所造成的肌力下降、僵硬及功能退化。

「Optimal」不是越早、越多越好，而是具有保護、個別化及漸進性的負荷。

C. PEACE的A是Avoid anti-inflammatory modalities——依口訣正確

PEACE中的A確實代表避免抗發炎處置。提出者的理由是發炎反應參與組織修復，過度抑制可能干擾長期癒合。

因此，以口訣本身判斷，C沒有寫錯。British Journal of Sports Medicine：PEACE and LOVE原始文章

但這不應被解讀成所有患者一律禁止NSAIDs、冰敷或其他止痛措施；這部分在現代臨床仍有證據限制，應依受傷組織、疼痛程度、出血風險及共病個別化。

D. LOVE的E是Elevation——錯誤，為本題答案

LOVE代表：

- L：Load。
- O：Optimism。
- V：Vascularisation。
- E：Exercise。

Elevation屬於PRICE、POLICE及PEACE的E，不是LOVE的E。

LOVE主要描述急性期後的積極復健方向：

- 逐步重新負荷。
- 處理災難化思考及對活動的恐懼。
- 進行不加劇症狀的有氧活動。
- 以運動恢復活動度、肌力、本體感覺及功能。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇C可能是因為「避免抗發炎治療」與常見急性疼痛處理直覺衝突，因而認為PEACE不可能主張此事。

另一方面，Elevation在PRICE、POLICE及PEACE中反覆出現，可能使它被順勢套入LOVE，忽略LOVE已轉向急性期後的主動復健，所以E應是Exercise。

這題的失分機制偏向：

> 以臨床直覺判斷口訣是否合理，卻沒有先逐字展開縮寫。

6. 失分類型

- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 次標籤：相近縮寫混淆
- 次標籤：急性期 / 恢復期
- 次標籤：Elevation / Exercise
- 輕度爭議或低效度題：PEACE中的避免抗發炎處置並非普遍適用的強制臨床規則

7. 下次判斷規則

> **PRICE、POLICE、PEACE都可見Elevation；LOVE進入主動恢復期，E一定是Exercise。**

8. 投資報酬率

中高

- 復健科及運動醫學常考各縮寫的差異。
- 可延伸至急性期保護、漸進負荷及功能恢復。
- 精細背誦成本不高，但應同時理解由「休息」轉向「適度負荷與運動」的演變。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**D。
- **現代臨床實務：**處置核心是排除骨折、脫臼、神經血管傷害及其他紅旗，再依組織與嚴重度安排保護、止痛及漸進負荷。口訣不能取代診斷與個別化復健。
- **抗發炎處置：**PEACE提出避免抗發炎治療，但這是一套專家提出的管理框架，不代表已由高品質人體試驗證實所有急性軟組織傷害均應完全避免NSAIDs或冰敷。
- **爭議或限制：**C在口訣定義上毫無疑問正確；臨床上是否採取該建議則應依疼痛需求、出血與腎胃風險，以及骨、肌腱或韌帶癒合考量個別判斷。D在縮寫定義上明確錯誤，故不影響國考答案。

醫學（六）Q70

對話詳解原文

1. 題目

下列何者不常使用於治療乳癌病人之淋巴水腫？

- A. 淋巴引流（manual lymphatic drainage）
- B. 循環治療（intermittent pneumatic compression）
- C. 減壓治療（decompression therapy）
- D. 壓力臂套的使用

題目核對自考選部醫學六正式試題。

2. 作答對照

- 使用者答案：A
- 考選部原始答案：C
- 考選部最終更正答案：C
- 是否有多答案接受或一律給分：否

原始答案與最終更正答案均為C；更正檔仍僅更正Q3，Q23、Q66一律給分。

3. 核心考點

乳癌相關淋巴水腫的保守治療核心是完整 / 複合性消腫治療：

> Complete / Complex Decongestive Therapy，CDT

主要組成包括：

- 壓迫治療。
- 運動。
- 皮膚照護。
- 衛教與自我管理。
- 視需要加入手法治療，包括淋巴引流。

間歇性氣壓壓迫也可作為輔助治療。

題目陷阱是：

- **Decongestive therapy = 消腫治療，是標準用語。**
- **Decompression therapy = 減壓治療，不是乳癌淋巴水腫的常規治療名稱。**

因此答案為C。

4. 各選項逐一解析

A. Manual lymphatic drainage——會使用，不是答案

手法淋巴引流以輕柔、特定方向的按摩手法，嘗試將組織液導向功能較完整的淋巴區域，常整合於CDT。

它可能改善：

- 腫脹或緊繃感。
- 疼痛及沉重感。
- 部分患者的生活品質。
- 組織柔軟度及自我照護能力。

但現代證據需要精確表述：MLD並非每位患者都能在壓迫治療之外獲得明顯的額外體積下降。其效果會受疾病分期、纖維化程度及是否合併壓迫影響。

所以A確實是臨床會使用的治療，但不能誇大成單獨治療的必然核心。2024年CDT專家共識

B. Intermittent pneumatic compression——會使用

間歇性氣壓壓迫利用具有多個氣囊的袖套依序加壓，促進液體由遠端向近端移動。

常見定位是：

- 作為壓迫衣、運動及其他CDT措施的輔助。
- 適用於部分保守治療效果不足或居家自我處置困難者。
- 不能完全取代日常壓迫衣與自我管理。

使用時需注意壓力、套筒覆蓋範圍及近端液體堆積；若有未治療的蜂窩性組織炎、急性深部靜脈栓塞或嚴重失代償性心衰竭，應先重新評估。乳癌相關淋巴水腫介入措施臨床指引

C. Decompression therapy——不常使用，為本題答案

「Decompression therapy」通常指解除神經、脊髓、關節或其他受壓結構的處置，並不是乳癌相關淋巴水腫的標準治療名稱。

本題極可能利用相近字詞設陷阱：

- Decompression：解除壓迫。
- Decongestion：降低組織液堆積、消腫。

淋巴水腫使用的是**decongestive therapy**，不是decompression therapy。

D. 壓力臂套——常用，而且是長期控制核心

合適尺寸與壓力等級的壓力臂套可：

- 限制組織液重新累積。
- 改善肌肉收縮時的淋巴及靜脈回流。
- 維持密集消腫治療後的成果。

- 減少日間腫脹波動。

但壓力臂套必須適當量測及定期重新評估。過緊、折疊或尺寸不合可能造成疼痛、皮膚壓傷、麻木或局部止血帶效應。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇A可能是知道近期研究對「MLD能否額外減少肢體體積」存有保留，因此把：

> 額外療效不一定顯著

誤推成：

> 臨床不常使用。

但題目只問是否常用，不是問何者具有最強的獨立療效。

另一個關鍵可能是沒有辨認C中的字詞陷阱：標準療法是**decongestive therapy**，選項卻寫成**decompression therapy**。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 次標籤：相近治療名稱混淆
- 次標籤：decongestive / decompression
- 次標籤：常用性 / 增量療效
- 次標籤：核心治療與輔助治療

7. 下次判斷規則

> **淋巴水腫的標準詞是CDT「消腫」治療（decongestive），不是「減壓」治療（decompression）；壓迫是核心，MLD與氣壓泵可作輔助。**

8. 投資報酬率

高

- 乳癌術後淋巴水腫是復健科、外科及腫瘤照護常見考點。
- 可延伸至CDT組成、壓迫衣、蜂窩性組織炎與運動處方。
- 相近英文名詞只要精確區分一次，日後容易穩定得分。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**C。
- **現代臨床實務：**壓迫、運動、皮膚照護、衛教及自我管理是長期控制基礎；MLD和氣壓泵是否加入，需依分期、症狀及患者能力決定。
- **MLD證據限制：**MLD常被納入CDT，但在已有合適壓迫治療時，額外降低肢體體積的幅度未必明顯；仍可能對症狀或特定患者有益。
- **進階治療：**保守治療不足者可評估淋巴靜脈吻合、血管化淋巴結移植或抽脂等手術，但須依液體型或纖維脂肪型病變、淋巴影像及團隊經驗選案。

醫學（六）Q72

對話詳解原文

1. 題目

54歲女性病人左肩疼痛約2個月，經左肩關節X光及左肩超音波檢查如附圖，最可能之診斷為何？

- A. 肩旋轉環帶破裂（rotator cuff tear）
- B. 肩旋轉環帶鈣化性肌腱變性（calcific tendinosis）
- C. 肩部退化性關節炎（degenerative arthritis）
- D. 肩旋轉環帶外生骨疣（exostosis）

官方影像可見肩旋轉肌袖區域的鈣化沉積，符合鈣化性肌腱病變。題目與影像核對自考選部醫學六正式試題。

2. 作答對照

- 使用者答案：D
- 考選部原始答案：B
- 考選部最終更正答案：B
- 是否有多答案接受或一律給分：否

考選部原始與最終更正答案均為B。

3. 核心考點

鈣化性旋轉肌袖肌腱病變是羥磷灰石鈣沉積於肌腱內，以棘上肌最常見。

影像辨識重點：

- X光：肱骨頭周圍、通常在大結節附近出現緻密或雲霧狀鈣化。
- 超音波：肌腱內高回音鈣化灶，可伴不同程度後方聲影。
- 鈣化灶位於軟組織 / 肌腱，不與骨皮質及骨髓腔連續。

最後一點可將它與真正的外生骨疣區分。

4. 各選項逐一解析

A. Rotator cuff tear——不是最佳答案

旋轉肌袖破裂的超音波特徵可能包括：

- 肌腱纖維連續性中斷。
- 局部低回音或無回音缺損。
- 肌腱變薄或回縮。

- 肱骨頭表面裸露。
- 動態檢查異常。

X光通常不能直接顯示肌腱裂口；慢性大型破裂可能出現肱骨頭上移或肩峰下間距縮小，但不是本題的主要影像特徵。

本題顯著異常是鈣化沉積，而非清楚的肌腱缺損。

B. Calcific tendinosis——正確

這是羥磷灰石結晶沉積於旋轉肌袖肌腱內所致，最常侵犯棘上肌。

臨床可能表現為：

- 突發劇烈疼痛，尤其吸收期。
- 較慢性的肩痛與活動受限。
- 夜間疼痛。
- 類似肩峰下夾擠的症狀。
- 偶然在無症狀患者影像中發現。

X光上的鈣化通常呈無骨小樑的均質或雲霧狀密度；超音波則能定位鈣化位於哪條肌腱，並評估周圍滑囊炎及旋轉肌袖狀態。肩部鈣化性肌腱病變影像綜述

C. Degenerative arthritis——錯誤

肩關節退化性關節炎的X光重點為：

- 關節間隙變窄。
- 邊緣骨刺。
- 軟骨下骨硬化。
- 軟骨下囊腫。
- 肱骨頭或盂的形狀改變。

這些是關節面與骨骼的退化變化，不是肌腱內孤立鈣化灶。

超音波可評估關節積液、滑膜及肌腱，但不是判斷盂肱關節退化程度的主要單一工具。

D. Exostosis——錯誤

外生骨疣是真正從骨骼長出的骨性突起，影像上應能看出：

- 與原有骨皮質連續。
- 成熟病灶通常也與髓腔連續。
- 具有骨小樑或成熟骨性結構。

鈣化性肌腱病的鈣化灶則位於肌腱軟組織內，通常呈無骨小樑的緻密或雲霧狀陰影，沒有和肱骨皮質及髓腔相連。

因此不能因影像中出現白色高密度，就直接判定為「骨頭長出來」。

5. 為何容易誤選

可能的失分機制，由作答結果合理推測：

選擇D可能是看到X光上的高密度白色病灶，便將所有鈣化或骨化影像歸為外生骨疣。

真正需要先判斷的是：

1. 病灶位於肌腱軟組織內，還是從骨皮質長出？
2. 是否具有皮質及髓腔連續性？
3. 超音波是否把高回音病灶定位在旋轉肌袖肌腱中？

這是「材質看起來像鈣或骨」之後，沒有再完成病灶來源定位。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 次標籤：影像辨識
- 次標籤：病灶位置與來源
- 次標籤：肌腱鈣化 / 骨性突起
- 次標籤：皮質與髓腔連續性
- 次標籤：X光與超音波整合

7. 下次判斷規則

> **肩部白色病灶先看是否接著骨皮質：肌腱內無骨連續性的鈣化灶 = calcific tendinopathy；與皮質、髓腔連續才想exostosis。**

8. 投資報酬率

高

- 鈣化性肌腱病是常見肩痛影像題。
- 可延伸至旋轉肌袖撕裂、退化性關節炎及肩峰下滑囊炎。
- 「先定位，再判材質」也能改善其他骨骼肌肉影像題的正確率。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**B，肩旋轉肌袖鈣化性肌腱病變。
- **現代臨床實務：**較精確用語是calcific tendinopathy；「tendinosis」只強調退化，未完全涵蓋鈣化形成與吸收的動態過程。

- **治療：**多數先採活動調整、止痛及復健；持續有症狀者可依情況考慮震波、超音波導引穿刺沖洗 / barbotage及選擇性滑囊內類固醇，難治者才考慮手術。
- **影像限制：**影像有鈣化不等於疼痛一定由它造成；仍須結合壓痛、活動方向、肌力、誘發測試及其他病變。
- **爭議或限制：**單張靜態影像不能完整顯示動態夾擠或肌腱連續性，但X光與超音波共同定位肌腱內鈣化，已足以使B成為最佳答案。

醫學（六）Q77

對話詳解原文

1. 題目

67歲病人，下背痛兩個月，止痛藥治療無效，由家人帶至急診求診，經病史詢問及身體檢查發現，懷疑為馬尾症候群（cauda equina syndrome），下列敘述何者最不適當？

- A. 下肢會有不等程度運動與感覺喪失
- B. 不常見有尿滯留
- C. 單側或雙側的坐骨神經痛
- D. 在會陰部有感覺異常

題目核對自考選部醫學六正式試題。

2. 作答對照

- 使用者答案：A
- 考選部原始答案：B
- 考選部最終更正答案：B
- 多答案接受或一律給分：否

原始答案及最終更正答案均為B；更正檔仍僅更正Q3，Q23、Q66一律給分。

3. 核心考點

馬尾症候群最重要的不是一般下背痛，而是骶神經根受壓造成的紅旗症狀：

- 新發排尿障礙，尤其尿滯留。
- 鞍區 / 會陰部感覺異常。
- 排便或性功能障礙。
- 單側或雙側坐骨神經痛。
- 不等程度的下肢感覺、運動或反射異常。

尿滯留並非「不常見」，而是最具代表性的核心症狀之一；AANS甚至將其列為最常見症狀。AANS馬尾症候群資料

4. 各選項解析

A. 下肢有不等程度運動與感覺喪失——適當

馬尾由多條腰薦神經根構成，受壓的位置及程度不同，可造成不對稱或不同程度的：

- 肌力下降。
- 感覺缺損。

- 腱反射降低。
- 神經根性疼痛。

但下肢神經缺損並不是每位早期患者都完整出現，也不是診斷定義必備條件；不能因為表現存在變異，就判斷此敘述錯誤。

B. 不常見有尿滯留——最不適當，為本題答案

馬尾壓迫會破壞S2–S4神經根控制的膀胱感覺及逼尿肌功能。可能依序出現：

- 排尿感覺改變。
- 尿意降低。
- 尿流變弱。
- 必須用力才能排尿。
- 無痛性尿滯留。
- 膀胱過度充盈後的溢流性尿失禁。

因此尿失禁不一定代表膀胱能正常排空，有時正是尿滯留後的overflow incontinence。急診指引也把尿滯留與鞍區麻木列為初步評估的關鍵資訊。Emergency Care BC臨床指引

C. 單側或雙側坐骨神經痛——適當

大塊中央椎間盤突出可能壓迫多條神經根，典型上可產生雙側坐骨神經痛；但壓迫不對稱或病程較早時，也可能只有單側症狀。

雙側症狀警示性較強，但不能以「只有單側」排除馬尾症候群。

D. 會陰部感覺異常——適當

鞍區感覺異常涵蓋：

- 會陰。
- 肛門周圍。
- 生殖器。
- 臀部內側及坐在馬鞍時接觸的區域。

可表現為麻木、感覺遲鈍或感覺方式改變，不一定是完全無感。這是高度重要的馬尾症候群紅旗。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測，你可能注意到馬尾症候群的下肢神經缺損變異很大，因而認為A寫得過度肯定。

問題在於，B不是單純「不夠典型」，而是把核心紅旗的頻率方向顛倒：

> 下肢缺損可以不完整；新發膀胱功能障礙卻必須主動追問，不能視為罕見。

這屬於對有變異的敘述過度挑剔，卻沒有先排除明顯違反典型輪廓的選項。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 次標籤：神經急症紅旗
- 次標籤：尿滯留 / 溢流性尿失禁
- 次標籤：典型症候群輪廓
- 次標籤：變異表現與錯誤敘述

7. 數秒判斷規則

下背痛 + 鞍區感覺改變 + 新發排尿困難，先當馬尾症候群；尿滯留是核心紅旗，不是罕見表現。

8. 投資報酬率

極高

- 馬尾症候群是急診、神經科、骨科及復健科共同高頻急症。
- 錯過可能造成永久膀胱、腸道、性功能及下肢神經缺損。
- 「尿滯留也可能表現成溢流性失禁」是低成本、高辨識力規則。

9. 證據與臨床差異

- **國考答案：**B。
- **現代實務：**疑似病例須緊急安排腰薦椎MRI及脊椎外科會診；不能等待所有傳統症狀同時出現。
- **膀胱掃描：**排尿後餘尿量有助於風險判斷，但低於200 mL仍不能單獨排除；臨床懷疑高時仍需影像。
- **限制：**尿滯留多見於較完整或較晚期的CES；早期可能只有排尿感覺或尿流改變，因此問診不能只問「有沒有失禁」。

醫學（六）Q80

對話詳解原文

1. 題目

35歲女性，先生為獨子，已有二女，目前病人正接受試管嬰兒治療，想在胚胎植入前先作胚胎切片，確認染色體是否正常。下列敘述何者最適當？

- A. 醫師不能幫她作胚胎切片，因為她可能會因此刻意選擇植入胚胎的性別
- B. 醫師應幫她作胚胎切片，因為這是病患的權利
- C. 醫師能幫她作胚胎切片，但不能告訴她胚胎性別
- D. 醫師能幫她作胚胎切片，但須向衛生福利部通報

2. 作答對照

- 使用者答案：C
- 考選部原始答案：B
- 考選部最終更正答案：B
- 多答案接受或一律給分：否

考選部原始及最終更正答案均為B。

3. 核心考點

本題意圖區分兩件事：

1. 為評估染色體套數而進行胚胎切片及PGT-A。
2. 利用結果進行非醫療性胚胎性別選擇。

依國考命題邏輯，不能僅因患者家庭背景「可能」具有性別偏好，就拒絕她接受染色體檢測及相關諮詢的權利，因此選B。

但B的「醫師應幫她作」寫得過度絕對。病人擁有知情、自主決定及獲得合宜醫療評估的權利，不等於有權要求醫師提供任何檢查，也不代表可以利用PGT-A進行違法的非醫療性性別選擇。

4. 各選項解析

A. 因可能選擇性別而完全拒絕切片——國考判定不適當

患者陳述的目的為確認染色體是否正常。僅憑「先生是獨子、已有二女」推測她一定會濫用結果，尚不足以否定檢測。

較合宜的作法是：

- 釐清檢測目的。
- 說明PGT-A效益及限制。

- 說明台灣禁止非醫療性胚胎性別選擇。
- 在知情同意中預先規範結果內容及胚胎選擇方式。

若患者明確要求違法性別選擇，醫療機構當然不能配合；但A把「可能濫用」直接轉換成「不能做任何切片」，範圍過大。

B. 應提供胚胎切片，因為是病人權利——國考答案，但措辭過度

國考將本題放在病人自主權架構下：患者可以接受合宜的生殖醫療資訊、評估及選擇，醫師不能單憑推測其動機而拒絕。

不過現代實務必須修正為：

> 病人有權接受充分諮詢並參與決策；是否執行PGT-A，仍須依適應性、效益、風險、費用、實驗室能力及法規共同決定。

ASRM 2024年意見指出，PGT-A作為所有IVF患者的例行篩檢，尚未證實能普遍改善整體生殖結果；近期隨機試驗中，具有可用囊胚患者的整體妊娠結果與傳統IVF相近。ASRM PGT-A委員會意見

C. 可以切片，但一律不能告知胚胎性別——不是國考答案

這個選項看似同時允許染色體檢測並防止性別選擇，因此具有相當吸引力，也是你的作答。

但國考不採C，可能基於：

- 「不得選擇胚胎性別」不必然等於所有制度下一律不得揭露任何性染色體資訊。
- 結果揭露範圍應在檢測前透過知情同意及機構政策處理。
- 不能以事後隱瞞資訊，取代事前釐清檢測目的及合法的胚胎選擇規則。

在國際倫理框架中，胚胎性別是否揭露及是否納入移植排序，確實可由機構政策及知情同意規範；並非全球一致的「絕對不得告知」。ASRM偶然發現胚胎性別之倫理意見

D. 必須因胚胎切片另向衛福部通報——不是最佳答案

《人工生殖法》第27條確實規定人工生殖機構須向主管機關通報施術、捐贈、銷毀及年度統計等資料。

但這不代表每次因PGT進行胚胎切片，都以題目所暗示的方式另作專案通報。D把一般人工生殖機構的法定資料管理義務，誤寫成此次胚胎切片的決定性條件。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測，你很可能已抓到題目的倫理衝突：

- 應允許醫療性的染色體檢測。
- 又不能協助非醫療性選擇胎兒性別。

因此選擇了看似能兼顧兩者的C。這個推理在現代實務上並不荒謬；真正的問題是國考採取的是「不得僅依推測動機剝奪患者自主權」的框架，並把B視為唯一答案。

本題失分不宜直接歸因為核心知識不足，因為選項沒有清楚區分：

- 接受諮詢的權利。
- 要求非必要檢查的權利。

- 性染色體資訊的揭露。
- 非醫療性性別選擇。
- 台灣法規與一般醫學倫理。

6. 失分類型

- 醫學倫理 / 病人自主權
- 法規與倫理框架
- 二選一失誤
- 次標籤：檢測與結果用途
- 次標籤：自主權不是無限醫療請求權
- 次標籤：PGT-A與非醫療性性別選擇
- **中度爭議 / 低效度題**

此題不宜直接納入穩定失分模式，因為B措辭過度絕對，而C在某些法規及機構政策框架下具有合理性。

7. 數秒判斷規則

> **先分「做染色體檢測」與「用結果選性別」：前者可經諮詢決定，後者在台灣除性聯遺傳病外禁止；國考遇到僅以猜測動機拒絕檢測，優先考慮病人自主。**

8. 投資報酬率

中

- PGT-A、知情同意與胚胎性別選擇可能再次出現在醫學倫理題。
- 值得掌握原則，不值得死背B的絕對語氣。
- 應保留「國考答案」與「台灣法規 / 現代臨床」兩套層次。

9. 證據與臨床差異

- **國考答案：**B。
- **台灣現行法規：**《人工生殖法》第16條禁止選擇胚胎性別，因遺傳疾病者例外；違反者可處新臺幣20萬至100萬元罰鍰。全國法規資料庫《人工生殖法》
- **PGT-A效度：**胚胎切片檢測的是滋養外胚層少量細胞，結果可能受嵌合、取樣與檢測誤差影響，並不能保證胚胎或胎兒完全正常。
- **臨床決策：**35歲本身可作為討論PGT-A的因素，但不是「患者要求便必須做」的絕對適應症；應說明費用、可能無結果、嵌合胚胎、可移植胚胎數減少及產前檢查仍有必要。
- **題目限制：**B把自主權寫成醫師必須執行檢查，C又把結果揭露規則寫成絕對命令，兩者都未精確呈現實務，因此屬低效度題；計分仍應依考選部B作答。

醫學（五）Q1

對話詳解原文

1. 題目

50歲女性因急性膽囊炎接受緊急傳統剖腹式膽囊切除術（open cholecystectomy）。術後第一天發燒至39.5°C，右上腹傷口十分疼痛，微微發紅並有分泌物流出，故將分泌物做革蘭氏染色。下列哪個結果最能代表傷口感染是由梭狀芽孢桿菌屬（Clostridium）造成？

- A. 革蘭氏陽性桿菌
- B. 革蘭氏陽性球菌
- C. 革蘭氏陰性桿菌
- D. 革蘭氏陰性球菌

題目核對自考選部醫學五正式試題。

2. 作答對照

- 使用者答案：本次執行取得的最新進度未包含原始選項；先前掃描已確認不是A，故列為真正錯題
- 考選部原始答案：A
- 考選部最終更正答案：A
- 多答案接受或一律給分：否

原始答案及最終更正答案均為A。

醫學五更正檔僅涉及Q9、Q16、Q17、Q35、Q69，不影響本題。

3. 核心考點

Clostridium的國考基本分類是：

> 厭氧、產芽孢、革蘭氏陽性桿菌。

若是Clostridium perfringens造成的氣性壞疽 / 梭菌性肌壞死，抹片可能看到粗大、箱形的革蘭氏陽性桿菌；但實際染色也可能因菌齡、組織環境或染色條件呈現gram-variable。

本題只能從四種基本形態中選擇，答案仍明確為A。

4. 各選項解析

A. 革蘭氏陽性桿菌——正確

Clostridium屬於革蘭氏陽性桿菌，代表菌體具有較厚的肽聚醣層，典型革蘭氏染色呈紫色桿狀。

常考代表菌包括：

- C. perfringens：氣性壞疽、食物中毒。
- C. tetani：破傷風。

- C. botulinum：肉毒桿菌中毒。
- C. difficile：抗生素相關腸炎。
- C. septicum：自發性肌壞死，須注意結腸腫瘤或血液惡性疾病。

題幹的術後24小時內高燒、傷口劇痛及分泌物，也必須警覺進展快速的壞死性軟組織感染。

B. 革蘭氏陽性球菌——錯誤

常見代表為：

- Staphylococcus aureus：成串。
- Streptococcus、Enterococcus：成鏈或成對。

這些確實都是手術傷口感染的重要病原，但其形態是球菌，不能代表Clostridium。

C. 革蘭氏陰性桿菌——錯誤

常見於腹腔或膽道感染的革蘭氏陰性桿菌包括：

- Escherichia coli。
- Klebsiella。
- Enterobacter。
- Pseudomonas。
- Bacteroides等厭氧菌。

因本題以膽囊手術為背景，選C具有臨床上的迷惑性；但題目不是問「最常見膽道病原」，而是直接問Clostridium的革蘭氏形態。

D. 革蘭氏陰性球菌——錯誤

代表病原主要是：

- Neisseria gonorrhoeae。
- Neisseria meningitidis。
- Moraxella catarrhalis。

不符合Clostridium，也不是此類術後傷口感染的典型形態。

5. 可能的失分機制

因原始個人選項未出現在本次可讀進度中，不能把失分機制綁定某個錯誤選項。

可由題目結果合理推測的最低限度是：可能被「膽囊手術常見腸道革蘭氏陰性菌」的臨床背景帶走，沒有先依題目明確指定的菌名回答基本形態。

本題要先分清楚：

> 問「最可能病原」才整合手術部位；問「Clostridium長什麼樣」就直接回答革蘭氏陽性桿菌。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 次標籤：微生物基本分類
- 次標籤：病原形態 / 感染部位
- 次標籤：革蘭氏陽性桿菌
- 次標籤：題目直接指定病原

7. 數秒判斷規則

> **Clostridium = 厭氧、產芽孢、革蘭氏陽性桿菌；題目已點名菌屬時，不要被手術部位常見菌帶走。**

8. 投資報酬率

高

- 微生物形態是跨感染科、外科及急診的基礎題。
- 可連結氣性壞疽、破傷風、肉毒桿菌及困難梭菌。
- 只需建立一個穩定分類即可避免重複失分。

9. 證據與臨床差異

- **國考答案：**A。
- **臨床診斷：**革蘭氏陽性桿菌只能提供初步支持，不能單憑染色確診Clostridium；仍需厭氧培養、組織檢體及臨床判斷。
- **緊急處置：**若懷疑梭菌性肌壞死，不能等待培養。IDSA建議立即外科探查與清創，病原未明前給廣效抗生素；確認梭菌後使用penicillin加clindamycin。IDSA皮膚軟組織感染指引
- **染色限制：**Clostridium在臨床檢體中可能呈gram-variable，芽孢也未必清楚可見；但四個選項中仍只有A符合標準分類。

醫學（五）Q4

對話詳解原文

1. 題目

對於腹腔內纖維瘤（desmoid fibromatosis）的治療，下列敘述何者錯誤？

- A. 傳統上，切除腫瘤和大範圍正常組織是標準治療方法
- B. 由於極少轉移，於手術切除後，大多不會局部復發
- C. 放射治療主要用作無法完整手術切除後的輔助治療
- D. 全身性治療方案包括抗荷爾蒙療法、NSAID、低劑量化療、TKI和全劑量化療

2. 作答對照

- 使用者答案：本次執行取得的最新進度未包含原始選項；先前掃描已確認不是B，故列為真正錯題
- 考選部原始答案：B
- 考選部最終更正答案：B
- 多答案接受或一律給分：否

考選部原始及最終答案均為B。

3. 核心考點

Desmoid-type fibromatosis具有一項很容易被誤判的生物學特性：

> 幾乎不發生遠端轉移，卻可局部浸潤並在切除後復發。

因此「不轉移」不能推成「不復發」。

腹腔內desmoid常發生於腸繫膜，也可能與APC突變、家族性腺瘤性息肉症及Gardner syndrome相關。雖然病理上沒有典型惡性腫瘤的轉移能力，仍可能侵犯腸道、血管或輸尿管，造成阻塞、缺血及其他嚴重併發症。

4. 各選項解析

A. 傳統上採腫瘤及廣泛正常組織切除——歷史上正確

過去治療策略類似軟組織肉瘤，追求廣泛切除及陰性切緣，因此題目加上「傳統上」後，可視為正確的歷史敘述。

但這已不是現代所有desmoid的預設處置。原因包括：

- 自然病程不可預測。
- 部分腫瘤會長期穩定甚至自行縮小。
- 廣泛手術可能造成重大功能缺損。
- 即使取得陰性切緣仍可能復發。

• 腹腔內病灶手術可能需要大範圍腸切除。

B. 因不轉移，術後大多不會局部復發——錯誤，為本題答案

Desmoid幾乎沒有轉移能力，但其名稱中的「aggressive fibromatosis」正是在強調局部侵襲性。

局部復發風險受多項因素影響：

• 解剖位置。

• 年齡。

• 腫瘤大小。

• CTNNB1突變類型。

• 是否為FAP相關病灶。

• 切緣及手術造成的生物學刺激。

• 追蹤時間。

因此「極少轉移」與「很少復發」並不存在必然關係。

C. 放療主要作為無法完整切除後的輔助治療——國考採舊式框架判定正確

傳統治療中，對無法完整切除、切緣陽性或復發病灶，確實可能考慮放射治療。

但現代實務不再把「切不乾淨便常規追加放療」視為簡單固定流程。需考慮：

• 病灶是否持續進展或有症狀。

• 放療部位及周圍器官。

• 患者年齡。

• 次發惡性腫瘤、纖維化及器官損傷風險。

• 是否已有較合適的全身治療或局部消融選項。

尤其腹腔內病灶鄰近腸道，放療限制更多。

D. 全身性治療包括多類藥物——依傳統教材可判定正確

歷史上曾使用：

• Tamoxifen等抗荷爾蒙治療。

• Sulindac等NSAID。

• Methotrexate加vinblastine / vinorelbine等低劑量化療。

• Doxorubicin等較強化療。

• Sorafenib、pazopanib等TKI。

但抗雌激素與NSAID的療效證據有限，已不宜和具隨機試驗支持的現代療法放在同一證據層級。

現代新增的重要藥物是γ-secretase inhibitor nirogacestat；美國FDA於2023年核准其用於需要全身治療的進展型成人desmoid tumor。FDA核准資料

5. 可能的失分機制

由於本次無法取得原始個人選項，只能作最低限度推測：

- 可能把「不會轉移」視為良性且術後容易根治。
- 也可能依現代實務認為A或C已經過時，因此選了其一。

後者尤其值得注意：如果當時選A，這不代表你的現代臨床判斷完全錯誤，而是題目用「傳統上」保住了舊敘述，再要求選出明顯錯誤的B。

6. 失分類型

- 國考記憶點
- 腫瘤生物學概念
- 次標籤：轉移 / 局部侵襲 / 復發
- 次標籤：歷史治療與現代指引
- 次標籤：desmoid / FAP
- **高度時代差異、低效度題**

7. 數秒判斷規則

> **Desmoid不轉移，但很會局部侵犯與復發；看到「不轉移所以不復發」直接判錯。**

8. 投資報酬率

中高

- 「不轉移但局部侵襲」是desmoid最核心、最容易得分的辨識點。
- 可延伸至FAP、Gardner syndrome及CTNNB1/APC路徑。
- 舊式手術、放療與藥物清單不值得逐字死背；應掌握現代分層。

9. 證據與臨床差異

- **國考答案：**B。
- **現代第一步：**多數新診斷、無立即器官風險的患者先採主動監測，而非立刻廣泛切除。
- **腹腔內病灶：**若持續進展且需要治療，通常優先考慮全身治療；手術須評估腸道、腸繫膜及血管犧牲造成的重大傷害。
- **多專科決策：**2024全球共識更新強調依症狀、位置、進展、治療傷害與患者偏好，由desmoid轉診中心及多專科團隊選擇方案。2024 Desmoid Tumor Working Group更新
- **題目限制：**B無疑錯誤，但A、C、D均帶有舊治療年代的痕跡；若以2026實務逐字審查，本題不只一個選項需要修正。因此本題不宜過度用來推斷個人失分模式。

醫學（五）Q8

對話詳解原文

1. 題目

一位來到急診的病人被診斷為 Stanford Type B 主動脈剝離，並無神經學症狀、腹腔內器官缺血或下肢缺血等症狀，對這位病人最主要的治療方式為何？

- A. 緊急手術治療
- B. 主動脈支架血管置放術
- C. 積極的降血壓藥物治療
- D. 心包膜穿刺引流

題目核對自考選部醫學（五）正式試題。

2. 作答對照

- 使用者作答：B
- 考選部原始答案：C
- 最終更正答案：C
- 多答案接受或一律給分：否

原始答案與最終更正答案均為C。

3. 核心考點

Stanford Type B代表剝離未涉及升主動脈。第一步還要再分：

- **Uncomplicated：**沒有破裂、器官灌流不良、肢體缺血、持續或反覆疼痛、難以控制的高血壓等併發症。
- **Complicated：**出現破裂、malperfusion、休克、持續疼痛、控制不良的高血壓或快速擴張等情況。

題幹刻意列出沒有神經症狀、腹腔器官缺血及下肢缺血，目的就是把病例導向**無併發症的急性Type B剝離**。主要治療是加護監測與積極anti-impulse therapy，而不是立即TEVAR。

4. 各選項解析

A. 緊急手術治療——錯誤

開放手術通常保留給：

- 不適合血管內治療的破裂或複雜型病灶。
- 特定解剖條件。
- 結締組織疾病或其他需個別處理的情境。

無併發症Type B剝離直接接受緊急開放手術，早期風險通常高於先採藥物治療。

B. 主動脈支架血管置放術——不是本題首要治療

TEVAR是複雜型Type B剝離的重要治療，適用情形包括：

- 破裂或即將破裂。
- 腸系膜、腎臟、脊髓或肢體灌流不良。
- 持續或反覆疼痛。
- 藥物下仍無法控制的高血壓。
- 病灶持續擴張。

部分「無併發症但具有高風險解剖特徵」的患者，現代實務可能考慮亞急性期預防性TEVAR；但題目只提供典型無併發症情境，因此不能把支架當成最主要的初始治療。

C. 積極降血壓藥物治療——正確

治療目標是降低血壓、心率及左心室收縮力量，減少主動脈壁剪力：

- 通常先給靜脈β阻斷劑，如esmolol或labetalol。
- 目標一般為心率約60–80次 / 分。
- 收縮壓降至低於120 mmHg，或維持器官灌流所容許的最低值。
- 若β阻斷後血壓仍高，再加入nicardipine、clevidipine等血管擴張劑。
- 同時止痛、監測器官灌流並安排序列影像追蹤。

2022 ACC/AHA、2024 ESC及2026 ESVS指引均維持：**無併發症急性Type B剝離以最佳藥物 / anti-impulse治療為標準起點。**ACC/AHA主動脈疾病指引、2024 ESC主動脈疾病指引、2026 ESVS降主動脈疾病指引

D. 心包膜穿刺引流——錯誤

心包填塞較典型見於Type A剝離破入心包腔。單純Type B剝離通常不以心包填塞呈現。

即使剝離合併心包填塞，快速、大量引流也可能突然升高血壓、增加主動脈出血；通常只在循環崩潰且無法立即手術時，考慮受控制的小量引流作為橋接，而不是本題的常規處置。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選擇B可能是把「主動脈剝離」直接連結到血管內支架，卻沒有將題幹連續出現的陰性線索轉成排除規則：

> 無神經症狀 + 無腹腔器官缺血 + 無下肢缺血
> → 尚無malperfusion
> → uncomplicated Type B
> → 先藥物治療。

這不是不知道TEVAR的用途，而是沒有先完成「是否複雜型」的分流。

6. 失分類型

- 題幹理解 / 推理失誤
- 治療優先序
- 嚴重度與併發症分層
- 陰性線索未轉成排除規則
- 過度治療
- 國考高頻核心知識

7. 數秒判斷規則

> **Type A通常手術；Type B先找破裂、缺血、持續痛與壓不下來。全部沒有 = 先降心率、降血壓。**

8. 投資報酬率

高。

Stanford分型、complicated / uncomplicated判斷與anti-impulse therapy是急診、心臟科及心臟血管外科共同高頻題，亦可延伸至TEVAR適應症及血壓用藥順序。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**C，積極降血壓藥物治療。
- **現代實務：**答案方向仍正確，但藥物治療不只是「降血壓」，而是同步控制心率、心肌收縮力、疼痛及器官灌流。
- **差異重點：**現代指引對高風險但尚未產生明顯併發症的Type B患者，可能討論選擇性TEVAR；不能因此把所有Type B都直接送支架。

醫學（五）Q11

對話詳解原文

1. 題目

關於高解析度食道壓力測試（high-resolution manometry motility study），下列何者最接近胃食道逆流的病人？

- A. 規律向遠端傳遞的蠕動波，食道胃接合處 / 下食道括約肌壓力屏障相對較弱
- B. 遠端食道與接合處壓力較高、收縮或流出受阻型態
- C. 缺乏正常順序傳遞的蠕動，呈同步加壓或近乎無有效蠕動的型態
- D. 高振幅、重複或多峰的強力收縮型態

本題A至D均為壓力地形圖；上述文字是依官方圖像主要形態所作的描述，不取代原圖。原圖見考選部正式試題第3至4頁。

2. 作答對照

- 使用者作答：B
- 考選部原始答案：A
- 最終更正答案：A
- 多答案接受或一律給分：否

原始及最終更正答案均為A。

3. 核心考點

GERD的壓力測試重點不是尋找「最鮮豔、壓力最高或最異常」的圖，而是尋找**抗逆流屏障較弱**的型態，例如：

- 下食道括約肌 / 食道胃接合處壓力偏低。
- EGJ結構或功能失衡。
- Ineffective esophageal motility。
- 清除逆流物的蠕動功能下降。

相反地，高壓、痙攣或接合處鬆弛不良比較支持阻塞性或痙攣性運動障礙，不是典型GERD機轉。

4. 各選項解析

A. 規律蠕動但抗逆流壓力屏障較弱——正確

官方A圖仍可見大致有順序、向遠端傳遞的蠕動，但食道胃接合處的壓力屏障相對較弱，最接近容易發生胃內容物逆流的生理條件。

GERD患者的HRM可能完全正常；若有異常，常見的是低壓LES、EGJ屏障受損或無效蠕動，而不是某一個GERD專屬的壓力圖形。

B. 較高壓或流出受阻型態——錯誤

這是使用者選擇。圖形中的遠端食道 / 接合處壓力比A明顯，不符合「括約肌屏障鬆弱」的直觀機轉。

這類高壓或鬆弛不良型態更應考慮：

- EGJ outflow obstruction。
- Achalasia相關型態。
- 其他收縮異常。

確切分類仍需依integrated relaxation pressure、遠端潛伏期、DCI及標準吞嚥程序判定，不能只靠單張縮圖命名。

C. 無有效順序蠕動或同步加壓型態——錯誤

這種圖首先提示重大食道運動障礙，而不是單純GERD。

嚴重無效或缺如收縮確實會降低食道酸清除能力並與逆流共存；但若題目問「最接近GERD」，仍應先選具有較弱抗逆流屏障、而非顯著主要運動障礙的A。

D. 高振幅、多峰或痙攣性收縮——錯誤

強力、重複或過早收縮較接近：

- Hypercontractile esophagus。
- Distal esophageal spasm。
- 其他痙攣性運動異常。

這些疾病常以吞嚥困難或胸痛表現。收縮愈強並不代表愈容易逆流；GERD的核心反而是屏障失效及清除功能不足。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選擇B可能是把「圖像看起來最異常、壓力顏色最強」當成GERD病變，而沒有先問這項檢查呈現的是哪種功能：

- GERD：抗逆流屏障偏弱。
- B圖：壓力偏高或流出不順。

也可能把「HRM異常」直接等同於「逆流較嚴重」。但HRM測量的是壓力與運動，並不直接測量胃酸逆流事件。

6. 失分類型

- 圖像判讀
- 壓力地形圖形態

- 評估工具與所測構念混淆
- 結構 / 壓力與疾病機轉未連結
- 主要運動障礙與GERD混淆
- 二選一失誤

7. 數秒判斷規則

GERD找「門太鬆、清不掉」，不是找壓力最高的圖；高壓或鬆弛不良先想阻塞 / 痙攣。

8. 投資報酬率

中高。

HRM圖形細節較專門，但「低壓LES與GERD、IRP升高與流出受阻、過早收縮與痙攣、無蠕動與重大運動障礙」是可重複使用的分類骨架。

9. 證據與國考、現代臨床差異

- **國考答案：**A。
- **Chicago Classification v4.0：**HRM主要用於標準化分類食道運動障礙；診斷須結合症狀、標準吞嚥程序及必要的支持性檢查，不能只看單張彩色圖。Chicago Classification v4.0
- **現代GERD診斷：**HRM本身不是GERD的確診工具。它主要用來排除achalasia等運動障礙、定位pH導管，並在抗逆流手術前評估蠕動功能。ACG食道生理檢查指引、ACG胃食道逆流指引
- **確診差異：**未經證實的GERD通常需依內視鏡及動態酸鹼值 / 阻抗監測建立客觀證據；低壓LES或無效蠕動只是支持性線索。Lyon Consensus 2.0

醫學（五）Q12

對話詳解原文

1. 題目

關於橫膈肌損傷修補的敘述，下列何者錯誤？

- A. 鈍性橫膈肌損傷的修補通常經由腹部切開進入探查，以處理相關的內臟損傷
- B. 經腹部探查後，受傷的橫膈膜可使用粗的不可吸收縫線進行縫補
- C. 對於所有類型的橫膈肌損傷，胸腔鏡手術應為首選的介入治療方式，以減少不必要的傷害
- D. 大面積撕裂脫落的橫膈膜缺損，可使用人工或生物網片（mesh）進行修補

題目核對自考選部醫學（五）正式試題。

2. 作答對照

- 使用者作答：B
- 考選部原始答案：C
- 最終更正答案：C
- 多答案接受或一律給分：否

原始答案及最終更正答案均為C。

3. 核心考點

橫膈肌損傷沒有「所有病例一律使用同一進入路徑」的原則。手術途徑取決於：

- 急性或延遲診斷。
- 鈍傷或穿刺傷。
- 血流動力是否穩定。
- 是否懷疑合併腹腔臟器損傷。
- 是否已有胸腔內沾黏或臟器嵌頓。
- 缺損大小及能否無張力直接縫合。

急性創傷尤其是鈍傷，常合併脾臟、肝臟、腸道等腹腔損傷，因此通常優先由腹部探查。胸腔鏡可用於適當、穩定且經選擇的患者，但不可能是「所有類型」的首選。

4. 各選項解析

A. 鈍傷通常經腹部進入——正確

鈍性橫膈肌破裂通常代表高能量創傷，可能同時存在：

- 肝脾損傷。

- 腸道或腸繫膜損傷。
- 骨盆、胸腹部其他創傷。
- 腹腔出血。

因此急性期採腹部途徑，可以同時檢查並處理腹腔臟器。EAST指引對血流動力穩定的急性橫膈肌損傷，也條件性建議腹部途徑優於胸部途徑。EAST創傷性橫膈肌損傷指引

若患者不穩定，則更應依主要出血來源迅速選擇剖腹或剖胸，不能為了微創而延誤止血。

B. 粗不可吸收縫線修補——正確

多數能直接關閉的缺損可使用粗的不可吸收或長效縫線，以：

- Interrupted sutures。
- Horizontal mattress sutures。
- Figure-of-eight sutures。

進行修補。

使用不可吸收縫線是因橫膈膜持續承受呼吸運動及腹胸腔壓力差，需要長期維持抗張強度。因此B雖然寫得較傳統，基本方向正確。

C. 所有類型均以胸腔鏡為首選——錯誤，為本題答案

問題出在兩個絕對化詞語：

> **所有類型 + 應為首選。**

胸腔鏡較可能適用於：

- 血流動力穩定。
- 腹腔臟器損傷可能性低。
- 延遲性橫膈疝、胸腔內沾黏需要處理。
- 病灶位置適合胸腔鏡觀察與修補。
- 團隊具有相應經驗。

但下列情境不能把胸腔鏡當成固定首選：

- 急性鈍傷合併腹內出血。
- 疑似多重腹腔臟器損傷。
- 血流動力不穩定。
- 需快速、廣泛探查。
- 無法以微創方式安全復位或修補。

即使在穩定的穿透傷患者，EAST也主要支持經選擇後使用腹腔鏡，而非宣稱胸腔鏡適用於全部損傷。

D. 大面積缺損可使用網片——正確

若缺損太大，直接縫合會產生過高張力，可能使用：

- 合成網片。
- 生物性網片。
- 可吸收或複合材料。

選擇須考慮污染程度、組織品質、缺損大小與感染風險。2023 WSES立場文件也支持複雜的大型缺損使用網片強化，但材料仍須個別化。WSES複雜橫膈疝處置文件

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選擇B可能是對「粗的不可吸收縫線」有所疑慮，認為這種材料或措辭太傳統、可能傷害橫膈肌。

但本題真正具有最高排除力的是C的絕對化敘述。手術入路必須依傷勢及時間點決定，不可能由單一胸腔鏡處理所有病例。

這延續目前已多次出現的模式：

> 注意到一個看似不尋常的技術細節，卻沒有先處理「所有、一定、首選」等高風險限定詞。

6. 失分類型

- 題幹理解 / 推理失誤
- 絕對化敘述
- 手術途徑選擇
- 適用條件未分層
- 微創手術適應症
- 二選一失誤

7. 數秒判斷規則

> **急性橫膈傷先問還要不要探查腹腔；多重腹傷走腹部。看到「所有損傷都先胸腔鏡」直接高度懷疑。**

8. 投資報酬率

中高。

精確縫法不是最常考，但「急性走腹部、延遲疝可能走胸部、微創需穩定且經選擇、大缺損可用mesh」可涵蓋多數橫膈創傷題。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**C。
- **現代實務：**同樣不支持單一固定路徑；腹腔鏡與胸腔鏡的應用比傳統更廣，但必須依損傷位置、合併傷及生命徵象選擇。
- **網片差異：**大型缺損可用網片，但污染創傷中使用永久性合成網片須審慎，不能只憑缺損大就忽略感染風險。

- **指引限制：**創傷性橫膈損傷的比較研究品質普遍不高，EAST多項建議屬條件性建議；這更進一步證明C的「所有病例首選」不合理。

醫學（五）Q18

對話詳解原文

1. 題目

下列何者不是器官移植後晚期感染的風險因子？

- A. 免疫抑制劑的長期使用
- B. 受贈者既存的病毒感染
- C. 處在裝修中的工作環境
- D. 經常輸血

2. 作答對照

- 使用者作答：C
- 考選部原始答案：D
- 最終更正答案：D
- 多答案接受或一律給分：否

原始及最終更正答案均為D，沒有特殊計分。

3. 核心考點

器官移植後感染的傳統時間軸：

1. **第一個月：**手術、導管、傷口、院內菌與供體來源感染。
2. **第1～6個月：**免疫抑制最明顯，CMV及各種伺機性感染突出。
3. **6個月以後：**

- 多數穩定患者以社區感染為主。
- 若持續高度免疫抑制、反覆排斥治療或移植物功能不佳，仍有伺機性感染。
- 潛伏病毒可能再活化。
- 環境黴菌暴露仍然重要。

因此「晚期」並不表示患者已不再害怕Aspergillus或病毒再活化。

4. 各選項解析

A. 長期使用免疫抑制劑——是風險因子

感染風險實際取決於「net state of immunosuppression」，包括：

- 藥物種類、劑量及持續時間。
- 是否使用高劑量類固醇。

- 是否接受抗胸腺細胞球蛋白等淋巴球耗竭治療。
- 白血球或淋巴球低下。
- 移植物功能。
- 合併CMV等感染。

長期、強度較高的免疫抑制會使患者在移植半年後仍可能發生Pneumocystis、Nocardia、Cryptococcus、Aspergillus、CMV等感染。

B. 受贈者既存病毒感染——是風險因子

既存感染可能在免疫抑制後再活化，例如：

- CMV。
- EBV。
- HBV、HCV。
- HSV、VZV。
- BK polyomavirus。

2025年第四版國際CMV共識仍強調移植前供受者CMV血清狀態及移植後預防、病毒量監測的重要性；潛伏感染可以在免疫抑制下重新活化，且可能於預防性抗病毒藥停止後才出現晚發疾病。第四版國際CMV共識指引

C. 處在裝修中的工作環境——是風險因子

施工、拆除、鑽孔及天花板工程會使灰塵中的黴菌孢子大量氣溶膠化，尤其是Aspergillus。

器官移植受贈者若仍處於明顯免疫抑制狀態，長期在裝修環境工作可能增加：

- 侵襲性肺麴菌症。
- 鼻竇或中樞神經黴菌感染。
- 其他環境性黴菌感染。

AST安全生活指引明確建議移植患者對居家裝修及高粉塵環境採取預防措施；不是只有移植早期住院期間才需要注意。AST移植後安全生活指引

2026 IDSA更新也再次顯示，實體器官移植後的侵襲性Aspergillus風險高度依器官種類及個人免疫狀態而異，不能把所有患者一律預防用藥，但高風險者須採針對性策略。2026 IDSA移植後侵襲性麴菌症預防指引

D. 經常輸血——國考判定不是典型晚期風險因子

輸血確實不是完全沒有感染風險，可能涉及：

- 極低機率的輸血傳播病毒或細菌。
- CMV陰性患者接受不適當血品。
- 特定地區的HEV、West Nile virus等新興感染。
- 輸血相關免疫調節。

但在現代血品篩檢、白血球減除及適當選擇血品下，「經常輸血」並不是器官移植後晚期感染的標準核心風險因子，也沒有像A至C那樣直接指向持續免疫抑制、病毒再活化或環境黴菌暴露。

因此四項中D是考選部要求的唯一最佳答案。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選擇C可能是把「裝修環境」理解為一般職業背景，沒有將施工粉塵連結到Aspergillus等環境黴菌。

同時，「經常輸血會傳染疾病」是合理的一般醫療印象，可能因此被保留下來。但題目不是問任何理論上的感染可能性，而是問：

> 哪一項不是移植後晚期感染的典型風險因子？

在這個限定下，持續免疫抑制、潛伏病毒與黴菌暴露的直接性都高於經常輸血。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 移植感染時間軸
- 環境暴露辨識
- 風險因子強度排序
- 一般感染印象與疾病專屬風險混淆
- Aspergillus / 施工粉塵連結
- 二選一失誤

7. 數秒判斷規則

> **移植後晚期仍怕「壓得久、病毒醒、黴菌吸進去」；輸血不是零風險，但不是標準晚期風險主軸。**

8. 投資報酬率

高。

移植後感染的時間軸是外科、內科及感染科共同高頻考點，可延伸至：

- 不同時期的病原鑑別。
- CMV、EBV及BK virus。
- Pneumocystis與黴菌預防。
- 排斥治療後的感染風險重新分層。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**D。

- **現代實務：**感染並不嚴格依月數切割。預防藥物可能把CMV或Pneumocystis的發病時間推遲；反覆排斥治療也可能使患者在多年後重新進入高風險期。
- **裝修環境：**是否必須完全離開工作場所，要依粉塵控制、隔離區、HEPA過濾、個人防護及免疫抑制程度評估；並非看到裝修就必然感染。
- **輸血限制：**D只能解讀成「不是典型晚期風險因子」，不能寫成輸血絕不傳播感染。特定病毒、細菌污染及免疫低下患者的血品選擇仍需重視。
- **題目限制：**沒有說明移植器官、距離移植多久及免疫抑制強度；真實患者的感染風險必須個別化，但四選一仍以D最佳。

醫學（五）Q19

對話詳解原文

1. 題目

下列有關器官移植排斥的描述，何者正確？

- A. 人類白血球抗原（HLA）是編碼人類主要組織相容性複合體（MHC）的基因，它位在第6對染色體短臂上，與免疫系統功能有關
- B. MHC主要分為兩大類，其中class I HLA與$CD4^+$ T細胞結合後活化T細胞
- C. T細胞經由異種辨識（allorecognition）及細胞內訊息傳遞，產生IL-6並活化T細胞
- D. Calcineurin inhibitor可藉由抑制allorecognition途徑，阻斷T細胞活化而抑制排斥

題目核對自考選部醫學（五）正式試題。

2. 作答對照

- 使用者作答：D
- 考選部原始答案：A
- 最終更正答案：A
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始答案與最終更正答案一致。

3. 核心考點

本題要分清楚三個層次：

1. **抗原呈現：**

- MHC class I → $CD8^+$ T細胞
- MHC class II → $CD4^+$ T細胞

2. **同種異體辨識（allorecognition）：**

- 直接途徑
- 間接途徑
- 半直接途徑

3. **辨識後的細胞內訊息：**

- TCR辨識抗原之後啟動calcineurin–NFAT路徑
- 促進IL-2等細胞激素轉錄及T細胞增殖
- Calcineurin inhibitor作用在這個**辨識後的下游訊息層**

4. 各選項解析

A. HLA位於第6對染色體短臂——正確

人類MHC系統稱為HLA，核心區域位於第6號染色體短臂6p21附近，編碼參與抗原呈現及免疫調控的分子。

文字若精確表達，應說「HLA基因編碼人類MHC分子」，而不是把HLA與MHC寫成完全不同的兩套東西；但本選項所指的位置與免疫功能均正確，因此是國考答案。

B. Class I HLA與$CD4^+$ T細胞結合——錯誤

基本配對為：

- MHC class I呈現細胞內來源抗原給$CD8^+$細胞毒性T細胞。
- MHC class II呈現細胞外來源抗原給$CD4^+$輔助型T細胞。

所以B把CD4與CD8對調。

C. Allorecognition後以IL-6作為典型T細胞活化訊號——錯誤

移植免疫的傳統主軸是：

> Alloantigen辨識 → TCR與共刺激訊號 → calcineurin / NFAT → IL-2轉錄 → T細胞增殖。

IL-6確實參與發炎、T細胞分化與移植免疫，現代研究也不會說它毫無作用；但它不是這類國考題描述T細胞經典自分泌活化時應填入的代表性介白素，應以IL-2為核心。

此外，allorecognition較正確的中文是「**同種異體辨識**」，官方題目寫成「異種辨識」並不理想。

D. CNI直接抑制allorecognition——錯誤

Tacrolimus及cyclosporine確實抑制T細胞活化、降低移植排斥，因此這個選項很有吸引力。

錯誤在於作用層次：

- Allorecognition：T細胞辨識供者抗原 / MHC。
- CNI：在辨識發生後，抑制calcineurin，使NFAT無法正常進入細胞核，進而降低IL-2等細胞激素轉錄。

因此CNI主要阻斷的是**辨識後的細胞內訊息傳遞**，不能精確寫成直接抑制allorecognition本身。
Tacrolimus的官方藥品資料也將作用描述為FKBP-12結合、calcineurin抑制及NFAT訊息受阻。
DailyMed：Prograf作用機轉

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選D可能是抓到「CNI能抑制T細胞活化及移植排斥」這個正確終點，卻把正確的臨床效果反推成錯誤的直接作用標的。

也就是將：

> 抗原辨識 → 細胞內訊息 → 細胞激素轉錄 → T細胞增殖

壓縮成同一層，沒有區分「辨識」與「辨識後訊息傳遞」。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 次標籤：MHC I / II配對
- 次標籤：直接作用標的與最終效果
- 次標籤：allorecognition / calcineurin–NFAT
- 次標籤：IL-2 / IL-6

7. 數秒判斷規則

> **I配CD8、II配CD4；CNI是在辨識後封鎖calcineurin–NFAT–IL-2，不是把供者抗原辨識本身關掉。HLA在6p。**

8. 投資報酬率

高

這套架構可同時處理移植排斥、免疫抑制藥物、T細胞活化及MHC配對題，值得用一條訊息鏈牢記。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**A。
- **現代臨床實務：**Allorecognition包含直接、間接及半直接途徑；排斥也不只有T細胞，抗體、B細胞、補體及先天免疫同樣重要。移植T細胞allorecognition綜述
- **藥理差異：**CNI確實抑制排斥反應，但其標的是辨識後的calcineurin訊息。實務上還須依移植器官、排斥風險、血中濃度、腎毒性、神經毒性及感染風險調整治療。
- **題目限制：**A的語句略簡化；C的「異種辨識」翻譯及只聚焦IL-6也不精確，但不影響A為唯一最佳答案。

醫學（五）Q26

對話詳解原文

1. 題目

先天性黑色素痣（congenital melanocytic nevi, CMN）直徑超過多少公分，惡性變化之可能最高？

- A. < 1.5公分
- B. 1.5 ~ 10公分
- C. 11 ~ 20公分
- D. > 20公分

2. 作答對照

- 使用者作答：B
- 考選部原始答案：D
- 最終更正答案：D
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始答案與最終更正答案均為D。

3. 核心考點

CMN通常以**預估成年後最大直徑**分層：

- 小型： < 1.5 cm
- 中型：1.5 ~ < 20 cm
- 大型 / 巨型：≥20 cm
  部分新分類再把超過40 cm者獨立稱為巨型。

病灶越大，黑色素瘤及神經皮膚黑色素細胞增生相關風險越高。因此四個選項中，> 20 cm風險最高。

4. 各選項解析

A. < 1.5 cm——錯誤

屬小型CMN。小型病灶仍須留意不對稱增大、快速變化、潰瘍、出血或新生硬結，但整體惡性風險遠低於大型 / 巨型CMN。

B. 1.5 ~ 10 cm——錯誤

這是使用者選項，屬中型範圍的一部分。中型CMN並非完全沒有黑色素瘤風險，但題目問的是「可能最高」，不能只選已開始具風險、卻不是最高的組別。

C. 11 ~ 20 cm——錯誤

仍屬中型或接近大型門檻的病灶。風險可能高於更小的CMN，但尚未跨過本題採用的20 cm大型 / 巨型門檻。

D. > 20 cm——正確

預估成年直徑超過20 cm通常歸入大型或巨型CMN，是四個選項中惡性變化風險最高者。

風險還會受以下因素影響：

- 尺寸特別巨大，例如超過40 cm。
- 軀幹後方或沿中軸分布。
- 大量衛星痣。
- 合併神經皮膚黑色素細胞增生症。
- 病灶內出現快速增長、疼痛、潰瘍或性質改變的結節。

系統性回顧也顯示，CMN的黑色素瘤風險具有尺寸相關性，而大型 / 巨型病灶是最重要的高風險群。
2023年系統性回顧

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選B可能表示知道「CMN尺寸增加會提高惡性風險」，但沒有將題目的最高級字眼「可能最高」轉換成：

> 直接選尺寸最大的分層，並檢查是否跨過20 cm門檻。

另一種可能是只記得1.5 cm是小型與中型的分界，卻沒有保留20 cm這個與大型高風險病灶更相關的界線。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 次標籤：數值門檻
- 次標籤：最高級字眼
- 次標籤：尺寸與條件風險分層
- 次標籤：預估成人尺寸

7. 數秒判斷規則

> **CMN看到「惡性風險最高」就找大型 / 巨型：預估成年直徑超過20 cm。**

8. 投資報酬率

高

只需保留1.5 cm與20 cm兩個界線，即可處理分類、惡性風險及追蹤強度題，記憶成本低。

9. 證據與臨床差異

- **國考計分答案：**D， > 20 cm。
- **現代臨床實務：**目前通常依「預估成年尺寸」而非單看出生當下的實測直徑分類；題目沒有交代這一點，屬教科書式簡化。
- **風險估計：**新資料認為過去部分大型CMN的惡性風險可能被高估，但大型病灶仍是明確較高風險群；2025年綜述估計大型CMN的黑色素瘤絕對風險約1.25%～10%，研究間差異很大。2025年CMN風險綜述
- **處置差異：**預防性切除不保證消除黑色素瘤風險，因為深部、殘留或中樞神經系統的黑色素細胞仍可能發生病變。治療須綜合腫瘤風險、外觀與心理影響、手術負擔及功能部位，而不是看到 > 20 cm便自動全切。2024年CMN管理更新

醫學（五）Q27

對話詳解原文

1. 題目

關於 Guyon canal syndrome 的敘述，下列何者錯誤？

- A. Guyon canal由hook of the hamate、pisiform、piso-hamate ligament、palmar carpal ligament構成
- B. 可能造成正中神經壓迫
- C. 理學檢查可能出現Tinel sign
- D. 壓迫原因可能是ganglion、giant cell tumor、ulnar artery thrombosis

題目核對自考選部醫學（五）正式試題。

2. 作答對照

- 使用者作答：D
- 考選部原始答案：B
- 最終更正答案：B
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始答案與最終更正答案一致。

3. 核心考點

Guyon canal又稱ulnar tunnel，位於手腕掌側尺側，主要通過：

- 尺神經及其分支。
- 尺動脈。

因此Guyon canal syndrome是**腕部尺神經壓迫症候群**，不是正中神經壓迫。

快速分流：

- 正中神經 + 腕隧道 → carpal tunnel syndrome。
- 尺神經 + Guyon canal → ulnar tunnel syndrome。
- 尺神經 + 肘部 → cubital tunnel syndrome。

4. 各選項解析

A. Guyon canal的構造——正確

經典邊界包括：

- 尺側：pisiform。

- 橈側：hook of hamate。
- 頂部：palmar carpal ligament。
- 底部：pisohamate ligament與屈肌支持帶的一部分。

不同解剖資料對頂部、底部的細部分層可能略有差異，但A列出的骨性及韌帶結構皆屬Guyon canal的重要邊界，國考判定正確。

B. 可能造成正中神經壓迫——錯誤，為本題答案

Guyon canal內受壓的是**尺神經**。臨床可能出現：

- 小指及無名指尺側麻木。
- 骨間肌無力。
- 握力或捏力下降。
- Froment sign。
- Wartenberg sign。
- 小魚際或骨間肌萎縮。

正中神經則主要通過carpal tunnel；腕隧道症候群多影響拇指、食指、中指及無名指橈側感覺，並可能造成魚際肌無力。

AAOS同樣將ulnar tunnel syndrome定義為尺神經在腕部Guyon canal受壓。AAOS尺神經隧道症候群說明

C. 可能出現Tinel sign——正確

敲擊Guyon canal上方若引發尺神經分布區的麻刺感，可視為Tinel sign陽性。

但Tinel sign不是單獨確診工具，仍須合併：

- 感覺分布。
- 骨間肌及拇收肌力量。
- Froment、Wartenberg sign。
- 神經傳導及肌電圖。
- 超音波、MRI或CT尋找腫塊、骨折或血管病灶。

特別值得注意的是，背側尺側手部感覺可能保留，因為dorsal ulnar cutaneous branch通常在進入Guyon canal前便已分出。

D. Ganglion、巨細胞瘤及尺動脈栓塞均可能造成壓迫——正確

Guyon canal壓迫的原因包括：

- Ganglion cyst，最常見的占位性原因。
- Hook of hamate骨折。
- 重複壓迫，例如自行車手的handlebar palsy。

- 異常肌肉、纖維帶或其他腫瘤。
- Giant cell tumor of tendon sheath。
- Ulnar artery thrombosis或aneurysm，例如hypothenar hammer syndrome。

美國手外科學會資料也將ganglion、hook of hamate骨折、其他腫塊及尺動脈血栓列為重要病因。
ASSH尺神經壓迫章節

所以D中的病因雖然頻率不同，並沒有錯。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選D可能是因為該選項同時混合囊腫、腫瘤與血管血栓，看起來不像一組典型答案；尤其giant cell tumor及ulnar artery thrombosis較少見，容易被當成干擾項。

但題目只問「可能」，不是「最常見」。真正排除力最高的是神經定位：

> Guyon canal = 尺神經；正中神經根本不在這個隧道內。

這也是「罕見不等於不可能」與「先做結構定位，再比較病因頻率」的組合陷阱。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 題幹理解 / 推理失誤
- 解剖定位
- 尺神經 / 正中神經混淆
- Guyon canal / carpal tunnel混淆
- 罕見病因被誤判為不可能
- 二選一失誤

7. 數秒判斷規則

> **Guyon = 尺神經；carpal tunnel = 正中神經。題目只說「可能」時，不要因病因罕見就刪除。**

8. 投資報酬率

高。

這個定位可直接延伸至：

- Carpal、cubital及Guyon三種隧道症候群。
- 尺神經不同部位受傷的感覺與運動分布。
- Handlebar palsy及hypothenar hammer syndrome。
- Froment、Wartenberg與Tinel sign。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**B。
- **現代臨床實務：**Guyon canal依尺神經分支受壓位置可再分成三區，分別呈現混合型、純運動型或純感覺型症狀；不能要求所有患者都有完整尺神經麻痺。
- **診斷差異：**需同時排除肘部尺神經病變、C8–T1神經根病變、下幹臂神經叢病變及多發性周邊神經病變。
- **治療差異：**移除反覆壓力、調整自行車握姿及短期固定可用於輕症；若有腫塊、血管病變、進行性無力或保守治療失敗，才依病因考慮手術減壓或血管處置。
- **題目限制：**A對隧道頂部及底部的描述較簡化，但B的神經定位明確錯誤，不影響唯一最佳答案。

醫學（五）Q28

對話詳解原文

1. 題目

使用2.5% calcium gluconate gel治療一般氫氟酸（hydrofluoric acid）導致的傷口時，建議在疼痛緩解前，間隔多久需塗抹藥一次？

- A. 15分鐘
- B. 30分鐘
- C. 60分鐘
- D. 90分鐘

2. 作答對照

- 使用者作答：B
- 考選部原始答案：A
- 最終更正答案：A
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始與最終更正答案均為A。

3. 核心考點

氫氟酸的危險性不只來自酸性腐蝕。Fluoride ion可深入組織並結合鈣、鎂，造成：

- 深層組織壞死。
- 低血鈣。
- 低血鎂。
- 高血鉀。
- QT延長、心律不整甚至心跳停止。

局部皮膚暴露在完成去污後，可使用2.5% calcium gluconate gel持續按摩，並在疼痛緩解前頻繁補充。國考採用的標準間隔是：

> **每15分鐘重新塗抹一次。**

4. 各選項解析

A. 15分鐘——正確

氫氟酸可持續向深層組織滲透，因此處置節奏必須密集。

常見職業暴露指引建議：

1. 立即移除受污染衣物。

2. 迅速以大量水沖洗。

3. 戴防護手套，塗上2.5% calcium gluconate gel並持續按摩。

4. 每15分鐘重新塗抹，直到醫療人員接手或疼痛緩解。

Weill Cornell的氫氟酸暴露指引即明確建議每15分鐘補擦一次。氫氟酸暴露處置指引

B. 30分鐘——錯誤

這是使用者作答。部分臨床文件會以「持續按摩」或「每10～15分鐘重複」描述，而非所有文件都採完全相同的計時方式；但30分鐘才重新補擦，已比本題採用的緊急處置節奏慢。

30～60分鐘在其他處置脈絡中可能出現，例如局部疼痛未改善時，評估是否需要注射calcium gluconate；不能把這段觀察時間誤當成gel的補擦間隔。

C. 60分鐘——錯誤

氫氟酸傷害可能在表面變化不明顯時持續深入。等待一小時才補藥，可能延誤fluoride ion中和。

低濃度HF暴露甚至可能數小時後才出現疼痛，因此「現在不太痛」不能作為延長處置間隔的理由。

D. 90分鐘——錯誤

同樣過久，不符合HF暴露的急救原則。氫氟酸灼傷屬於需要立即去污、密集局部治療及迅速就醫的化學暴露。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選B可能是記得calcium gluconate gel需要反覆塗抹，但將間隔記成較常見的一般外用藥節奏，或把「30～60分鐘未緩解則升級治療」混成「每30分鐘補擦」。

本題真正的提示是：

> **氫氟酸 + 疼痛尚未緩解。**

這代表fluoride仍可能持續作用，處置節奏應偏向最短的15分鐘，而不是一般傷口用藥間隔。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 數值門檻
- 處置間隔
- 高危化學暴露
- 疼痛作為治療終點
- 補擦間隔與升級治療時間混淆
- 二選一失誤

7. 數秒判斷規則

HF會向深處鑽、抓走鈣鎂：沖洗後calcium gluconate gel持續按摩，每15分鐘補擦，痛不退就升級處置。

8. 投資報酬率

高。

除15分鐘外，更值得掌握的是：

- HF造成低血鈣與致命性心律不整。
- 低濃度暴露可以延遲疼痛。
- Calcium gluconate gel適用於皮膚，不能直接塗入眼睛。
- 疼痛持續表示治療可能不足。
- 指尖、指甲下、濃度高或面積大的暴露需更積極處置。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**A，15分鐘。
- **現代實務：**各機構可能寫成持續按摩、每10～15分鐘補擦，或持續至疼痛緩解；因此15分鐘是合理的考試標準值，但不是唯一存在的文字版本。
- **疼痛用途：**疼痛改善是局部治療反應的重要指標，不宜以局部麻醉掩蓋後再據此判斷療效。
- **升級處置：**若30～60分鐘內疼痛未明顯改善，或為高濃度、深部、指尖 / 甲下及大面積灼傷，須評估局部注射、區域性或動脈內calcium gluconate等專科處置。CDC / ATSDR也強調持續治療至疼痛緩解，並監測鈣、鎂、鉀與心電圖。CDC / ATSDR氫氟酸醫療處置指引
- **急症差異：**Gel不能取代立即去污及就醫。即使皮膚面積不大，眼睛、吸入、吞食、指尖暴露或出現全身症狀都需要快速醫療評估。
- **題目限制：**未提供HF濃度、暴露面積及位置；因此只能回答局部gel的國考標準間隔，不能據此決定完整臨床處置。

醫學（五）Q30

對話詳解原文

1. 題目

70歲女性患者至門診，主訴左腳疼痛到無法走路有一週，過去病史有長期抽菸和三高，檢視患者左腳如圖所示，患側量測之 ankle-brachial index（ABI）：0.3，下一步的檢查或治療，何者不適當？

- A. 診斷性動脈攝影（angiography）
- B. 口服阿斯匹靈（Aspirin）
- C. 口服抗凝血劑（Warfarin）
- D. 討論血管再暢通（revascularization）的策略：血管腔內治療（endovascular therapy）或繞道手術治療（bypass surgery）

題目核對自考選部醫學（五）正式試題。

2. 作答對照

- 使用者作答：B
- 考選部原始答案：C
- 最終更正答案：C
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始答案與最終更正答案均為C。

3. 核心考點

ABI 0.3代表嚴重下肢動脈灌流不足。患者又有：

- 高齡。
- 長期抽菸。
- 高血壓、高血脂、糖尿病等「三高」背景。
- 足部疼痛嚴重到無法行走。
- 官方影像所呈現的缺血性足部變化。

因此須迅速評估嚴重PAD、慢性肢體威脅性缺血或急性加重的可能性，並同步進行：

1. 血管解剖評估。
2. 抗血小板及心血管危險因子治療。
3. 討論血管重建。

但「病情越嚴重」不等於應直接使用warfarin。沒有心房顫動、靜脈血栓、機械瓣等其他適應症時，全強度口服抗凝血治療不應單純用來治療動脈粥樣硬化性PAD。

4. 各選項解析

A. 診斷性動脈攝影——適當

ABI已證實嚴重缺血，但ABI只能量化灌流障礙，不能完整顯示：

- 病灶位於主髂、股腿或膝下動脈。
- 阻塞長度。
- 遠端流出道狀況。
- 是否適合血管腔內治療或繞道手術。

若已考慮血管重建，須以CTA、MRA、duplex或導管動脈攝影建立解剖圖譜。傳統國考把診斷性動脈攝影列為合理下一步。

現代實務未必所有患者都先做侵入性導管攝影；穩定者常先以duplex或CTA規劃，但若準備同步進行腔內治療，導管攝影仍很合理。

B. 口服Aspirin——適當

Aspirin是抗血小板藥，不是用來立即「打通」已阻塞的血管，而是降低症狀性PAD患者的：

- 心肌梗塞。
- 缺血性中風。
- 心血管死亡。
- 部分重大肢體事件。

2024 ACC / AHA PAD指引對症狀性PAD建議單一抗血小板治療，可使用aspirin或clopidogrel。
2024 ACC / AHA下肢PAD指引摘要

病人需要血管重建並不會使aspirin變成不適當；藥物治療與重建處理的是不同層次。

C. 口服Warfarin——不適當，為本題答案

Warfarin抑制維生素K依賴性凝血因子，主要用於特定血栓栓塞疾病。它不是一般動脈粥樣硬化性PAD的標準單獨治療。

2024 ACC / AHA指引明確指出：PAD患者若沒有心房顫動等其他適應症，不應使用全強度口服抗凝血治療來降低心血管或重大肢體事件，屬Class III不建議。ACC官方指引重點

需要區分：

- **Warfarin全強度抗凝：**本題情境下不適當。
- **低劑量rivaroxaban 2.5 mg bid + 低劑量aspirin：**特定症狀性PAD或血管重建後患者，在出血風險可接受時可考慮。
- **急性肢體缺血的立即抗凝：**通常使用靜脈未分段heparin，而不是先開口服warfarin等待生效。

D. 討論血管腔內治療或繞道手術——適當

嚴重疼痛、ABI 0.3及足部缺血變化提示肢體可能受到威脅。血管重建可：

- 改善缺血性靜止痛。

- 促進傷口癒合。
- 降低組織壞死及截肢風險。
- 保存可使用的肢體。

2024指引對慢性肢體威脅性缺血建議進行重建，以降低組織喪失、改善疼痛及保存肢體。腔內治療或繞道手術的選擇須依病灶解剖、可用靜脈、手術風險及患者偏好決定。ACC PAD重建建議

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選B可能是認為病情已非常嚴重，aspirin「太弱」，因此不像合適的治療。

問題是把治療強度與藥物機轉混在一起：

- Aspirin雖不能立即恢復血流，但仍是症狀性PAD的基礎治療。
- Warfarin看似「更強的血液稀釋劑」，卻不代表更適合動脈粥樣硬化性PAD。

嚴重缺血的正確升級方向是緊急血管評估及重建，不是把抗血小板任意升級成全強度口服抗凝。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 藥物類別混淆
- 抗血小板 / 抗凝血混淆
- 病情嚴重度與治療機轉混淆
- 急性處置 / 長期預防混淆

7. 數秒判斷規則

> **症狀性PAD保留抗血小板；嚴重缺血要做血管影像並討論重建。沒有AF、VTE或其他適應症，不因ABI很低就改開warfarin。**

8. 投資報酬率

高。

可同時處理：

- ABI分級。
- PAD與慢性肢體威脅性缺血。
- 抗血小板與抗凝血差別。
- 何時評估血管重建。

- 急性肢體缺血的緊急處置。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**C，口服warfarin。
- **現代實務：**仍支持症狀性PAD使用抗血小板，且不支持無其他適應症的全強度口服抗凝。
- **現代新增策略：**低劑量rivaroxaban加aspirin是雙路徑抑制，不能與全劑量warfarin混為一談。
- **時間軸限制：**慢性肢體威脅性缺血的典型定義通常要求缺血性靜止痛或組織喪失持續較長時間；題目只寫一週，因此真實病例還須緊急排除急性或急性加重的肢體缺血。
- **影像選擇：**不一定每人都直接接受侵入性攝影，可依腎功能、病灶及重建計畫選擇duplex、CTA、MRA或導管攝影。

醫學（五）Q31

對話詳解原文

1. 題目

有關慢性下肢潰瘍，下列敘述何者最適當？

- A. 不論動脈或靜脈型通常都是很痛的
- B. 靜脈潰瘍很少發生在足部
- C. 動脈潰瘍很少發生在腿部
- D. 腿部潰瘍對糖尿病患者的影響低於其他患者族群

2. 作答對照

- 使用者作答：A
- 考選部原始答案：B
- 最終更正答案：B
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始答案及最終更正答案均為B。

3. 核心考點

動脈性與靜脈性潰瘍應先以**位置及周圍組織表現**區分，疼痛只能作為輔助：

特徵	動脈性潰瘍	靜脈性潰瘍
常見位置	足趾、足部、外踝或壓力點，也可在小腿	踝至小腿中段的gaiter area，常靠近內踝
外觀	深、界線清楚、punched-out、壞死	較淺、不規則、滲液及肉芽組織
周圍皮膚	冰冷、蒼白、缺毛、脈搏弱	水腫、色素沉著、濕疹、脂性皮膚硬化
疼痛	常明顯，抬高加重、下垂改善	疼痛程度可變，未必「通常很痛」
核心治療	恢復灌流	排除顯著動脈病變後施行壓迫治療

4. 各選項解析

A. 動脈或靜脈型通常都很痛——錯誤

動脈性潰瘍通常疼痛明顯，尤其抬高患肢或夜間平躺時加劇。

靜脈性潰瘍可以痛，感染、嚴重水腫或皮膚炎也可能使疼痛相當顯著；但其疼痛程度變異很大，不能概括成「通常都是很痛的」。

此外，糖尿病周邊神經病變可能使嚴重足部潰瘍反而疼痛不明顯，因此「痛不痛」不能單獨決定病因或嚴重度。

B. 靜脈潰瘍很少發生在足部——最適當

典型靜脈性潰瘍位於：

- 小腿下三分之一。
- 內踝附近。
- 踝部至小腿中段的gaiter area。

足趾或遠端足部潰瘍較應優先考慮：

- 動脈缺血。
- 糖尿病神經病變及壓力傷害。
- 混合性血管病變。
- 血管炎或其他病因。

NICE資料同樣把典型靜脈性潰瘍定位在踝至小腿中段的gaiter area。NICE靜脈性腿部潰瘍資料

「很少」不是「絕不可能」；嚴重靜脈疾病、混合性病變或非典型病例仍可能累及接近足部的位置。

C. 動脈潰瘍很少發生在腿部——不適當

動脈性潰瘍最經典的位置確實是：

- 足趾末端。
- 足背。
- 足跟。
- 外踝。
- 其他骨性突出或壓力點。

但嚴重動脈灌流不足也可以造成下腿潰瘍，不能籠統說「很少發生在腿部」。實務上「leg ulcer」本來就可能包含動脈、靜脈或混合性病因，必須檢查脈搏、ABI / TBI及血管影像。

D. 糖尿病患者受到的影響較低——錯誤

糖尿病可能合併：

- 周邊神經病變。
- PAD及動脈鈣化。
- 足部壓力分布異常。
- 感染風險增加。
- 傷口癒合不良。

- 截肢風險升高。

因此影響並不低。疼痛可能因神經病變而減少，但「比較不痛」不等於疾病影響比較小。

IWGDF指引要求糖尿病足部潰瘍同時評估神經病變、缺血、感染與傷口深度，正反映這是一個高風險族群。IWGDF 2023糖尿病足指引

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選A可能是以「潰瘍 = 組織受損 = 應該很痛」作為整體判斷，沒有先使用病灶位置與病理機轉。

本題的關鍵不是潰瘍能否疼痛，而是「通常」：

- 動脈性潰瘍常痛。
- 靜脈性潰瘍的疼痛變異較大。
- 糖尿病神經病變甚至可使嚴重潰瘍不痛。

相較之下，靜脈潰瘍集中在gaiter area、少在足部，是較穩定的典型分布。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 典型病灶位置
- 動脈性 / 靜脈性潰瘍混淆
- 疼痛程度過度概括
- 「通常 / 很少」等機率字眼
- 糖尿病神經病變可能掩蓋疼痛

7. 數秒判斷規則

> **靜脈看gaiter area與內踝；動脈看足趾、足部與壓力點。潰瘍痛不痛有例外，位置通常比疼痛更可靠。**

8. 投資報酬率

高。

這張鑑別架構可延伸至：

- 慢性下肢傷口。
- PAD及糖尿病足。
- 壓迫治療的適應症與禁忌。

- ABI / TBI判讀。
- 傷口感染及截肢風險評估。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**B。
- **現代實務：**病灶位置很有用，但不能僅憑位置確診；動脈、靜脈、神經病變常同時存在。
- **壓迫治療：**疑似靜脈潰瘍也應先評估動脈灌流；顯著PAD時不能直接套用標準高壓壓迫。
- **糖尿病患者：**ABI可能因動脈中層鈣化而假性偏高，必要時改看趾肱指數、趾壓、經皮氧分壓及動脈波形。
- **題目限制：**「靜脈潰瘍很少發生在足部」是典型分布的考試化表達，不等於足部病灶可以完全排除靜脈成分。

醫學（五）Q33

對話詳解原文

1. 題目

下列有關於乳糜胸的敘述，何者最不適當？

- A. 其乳糜主要成分為脂肪
- B. 最常見之原因為腫瘤侵犯造成
- C. 初始以支持性治療為原則，若失敗應儘速手術治療
- D. 手術治療以經胸結紮胸管為較常見之方式

題目核對自考選部醫學（五）正式試題。

2. 作答對照

- 使用者作答：A
- 考選部原始答案：B
- 最終更正答案：B
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始答案與最終更正答案一致。

3. 核心考點

本題的關鍵是「最常見」所涵蓋的母群體：

- 若只談**非創傷性乳糜胸**，惡性腫瘤確實是最常見原因，尤其是淋巴瘤。
- 若談**所有乳糜胸**，現代病例中醫源性 / 術後胸管損傷占有重要甚至最主要地位，因此不能不加限定地說腫瘤侵犯是整體最常見原因。
- 乳糜含大量由腸道吸收的乳糜微粒與三酸甘油酯，所以國考接受「主要成分為脂肪」；但實際上也含淋巴球、蛋白質、電解質及免疫球蛋白。

因此B的問題不是腫瘤不會造成乳糜胸，而是把「非創傷性病例中的最常見」擴張成所有病例的最常見。

4. 各選項解析

A. 乳糜主要成分為脂肪——國考判定適當

乳糜是腸道吸收長鏈脂肪酸後形成的富含乳糜微粒淋巴液，通常具有：

- 高三酸甘油酯。
- 可檢出chylomicrons。
- 以淋巴球為主的細胞成分。

- 蛋白質、脂溶性維生素與電解質。

臨床診斷不能只看胸水是否呈乳白色；較具確定性的證據是胸水檢出chylomicrons。胸水三酸甘油酯大於110 mg/dL則高度支持乳糜胸。

A把複雜成分簡化成「主要為脂肪」，並不十分精密，但符合本題採用的教科書表述。

B. 最常見原因為腫瘤侵犯——最不適當，為本題答案

腫瘤是**非創傷性乳糜胸**最常見原因，其中以淋巴瘤最典型；機轉可能是直接侵犯、壓迫胸管或阻礙淋巴回流。

但是所有乳糜胸還包括：

- 胸腔與心臟手術造成的醫源性胸管損傷。
- 胸部創傷。
- 中央靜脈血栓或高靜脈壓。
- 先天性淋巴管異常。
- 感染與其他少見病因。

現代醫療環境中，胸腔手術後的醫源性乳糜胸非常重要。故若沒有「非創傷性」限定，B的概括不成立。StatPearls乳糜胸綜述

C. 支持性治療失敗後儘速手術——國考判定適當，但現代策略較多元

初始保守治療通常包括：

- 引流有症狀或大量的胸水。
- 低脂、以中鏈三酸甘油酯為主的飲食。
- 高流量時考慮禁食與全靜脈營養。
- 補充水分、電解質、蛋白質及營養。
- Octreotide或somatostatin。
- 治療原發病因。

若持續高流量、營養與免疫狀況惡化，或保守治療無效，需儘早升級介入；傳統選項所指的下一步是手術。

不過現代實務不一定直接開刀，也可考慮淋巴管攝影與胸管栓塞。治療時點須依每日流量、持續時間、原發病因及病人體力個別化。2024乳糜胸綜合性回顧

D. 經胸結紮胸管是常見手術方式——國考判定適當

胸管結紮是保守治療失敗後的傳統標準手術。現多以胸腔鏡方式進行，常在橫膈上方、食道與主動脈之間辨認並結紮胸管；因胸管解剖存在變異，有時會對可疑組織進行整束結紮。

目前也可能使用：

- 經皮胸管栓塞。
- 胸膜固定術。

- 胸膜腹腔分流。
- 針對腫瘤或靜脈阻塞的病因治療。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選A可能是注意到乳糜並非只有脂肪，還含有淋巴球、蛋白質及電解質，因此認為「主要成分為脂肪」過度簡化。

這項質疑在生理學上合理，但本題更關鍵的錯誤在B的範圍外推：

> 「腫瘤是非創傷性乳糜胸最常見原因」不等於「腫瘤是所有乳糜胸最常見原因」。

這與既有模式一致：沒有先確認「最常見」的母群體是全部病例還是特定亞型。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 整體病因與非創傷性亞型混淆
- 條件機率範圍外推
- 生理成分的精確描述與國考簡化語句衝突

7. 數秒判斷規則

> **乳糜胸問病因先分母群體：全部病例重視術後 / 創傷；非創傷性才是惡性腫瘤、尤其淋巴瘤最常見。**

8. 投資報酬率

高。

可以一併掌握：

- 乳糜胸與偽乳糜胸鑑別。
- 胸水chylomicrons及三酸甘油酯判讀。
- 胸管解剖與手術傷害。
- 低脂 / MCT、TPN、octreotide。
- 胸管結紮與胸管栓塞的治療層級。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**B。
- **現代臨床實務：**病因分布會因研究族群而異；腫瘤是非創傷性乳糜胸首要原因，但術後醫源性乳糜胸在現代整體病例中非常重要。

- **治療差異：**保守治療失敗後不必然直接開胸手術；影像導引胸管栓塞已成為部分中心的重要替代方案。
- **題目限制：**A對乳糜組成有所簡化，C的「儘速手術」也忽略流量與微創介入選項；但四個選項中，B未限定母群體所造成的錯誤最明確。

醫學（五）Q37

對話詳解原文

1. 題目

有關Caroli's疾病的敘述，下列何者最適當？

- A. 肝內膽管先天性導管板（ductal plate）畸形所造成，其特徵是肝內膽管連續性囊性擴張
- B. 通常發生於肝硬化病人，並與囊性腎病有關
- C. 大部分發生於年輕人，男性和女性無差異
- D. 治療以肝臟切除術為主

2. 作答對照

- 使用者作答：A
- 考選部原始答案：C
- 最終更正答案：C
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始與最終更正答案均為C。

3. 核心考點

Caroli disease是罕見的先天性導管板畸形，典型表現是：

- 大型肝內膽管呈**節段性、非阻塞性、囊狀或梭狀擴張**。
- 擴張的膽管與膽道系統相通。
- 容易造成膽汁鬱積、肝內結石、反覆膽管炎及膽管癌。
- 通常在兒童、青少年或年輕成人期被發現。
- 男女發生率大致相同。

必須再區分：

- **單純Caroli disease：**主要為大型肝內膽管囊狀擴張。
- **Caroli syndrome：**合併先天性肝纖維化及門脈高壓，並較常伴隨常染色體隱性多囊腎病。

4. 各選項解析

A. 導管板畸形造成「連續性囊性擴張」——錯誤

前半句正確：Caroli disease確實屬先天性導管板畸形。

錯誤落在後半句的「連續性囊性擴張」。經典形態是大型肝內膽管呈**節段性、囊狀或梭狀的非阻塞性擴張**，不是整段膽管均勻連續地囊性擴張。

影像可見：

- Central dot sign：門靜脈分支與肝動脈分支位於擴張膽管中央。
- Saccular或fusiform intrahepatic duct dilatation。
- 肝內結石與膽管炎。

因此A是一個「前半句正確、後半句使整項失效」的組合選項。AASLD Caroli disease影像與病理說明

B. 通常發生於肝硬化病人並與囊性腎病有關——錯誤

Caroli disease是先天性膽管發育異常，不是通常由既有肝硬化所引起。

囊性腎病的關聯確實存在，但更典型地出現在：

- Caroli syndrome。
- 先天性肝纖維化。
- PKHD1相關常染色體隱性多囊腎病。

所以B把一個可能的相關疾病，接在錯誤的發病背景上。患者可因反覆膽管炎或先天性肝纖維化逐漸產生肝臟併發症，但不能倒置成「通常發生於肝硬化病人」。

C. 多發生於年輕人，男女無差異——正確

Caroli disease是先天性疾病，臨床表現通常在兒童、青少年或年輕成人期出現，常見症狀包括：

- 反覆發燒、右上腹痛及黃疸。
- 反覆細菌性膽管炎。
- 肝內膽管結石。
- 肝膿瘍。
- 門脈高壓，尤其Caroli syndrome。

沒有穩定的明顯性別差異，因此C是四項中最適當的完整敘述。Caroli disease臨床綜述

D. 治療以肝切除為主——錯誤

治療取決於病變範圍：

- **局限於單一肝葉或肝段：**肝切除可能達到長期控制甚至治癒。
- **瀰漫性雙葉病變：**不能單靠局部切除處理。
- **反覆難治膽管炎、門脈高壓、肝功能惡化或瀰漫病變：**可能需要肝臟移植。
- **急性膽管炎或結石：**抗生素、內視鏡或介入性膽道引流及結石處理。
- **膽汁鬱積：**部分患者使用ursodeoxycholic acid。

因此「肝切除為主」只適用於局限型病例，不能概括所有Caroli disease。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選A可能是認出「先天性導管板畸形」這個高度專屬的正確關鍵詞，因此在讀完前半句後便停止核對。

但複合敘述必須每一部分都正確：

- 導管板畸形：正確。
- 連續性囊性擴張：不夠精確；應為節段性、非阻塞性囊狀或梭狀擴張。

這是典型的「專屬關鍵詞命中後，未再檢查同一選項的第二個命題」。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 複合敘述只驗證前半句
- 導管板畸形
- 連續性 / 節段性擴張混淆
- Caroli disease / Caroli syndrome混淆
- 局限型與瀰漫型治療混淆

7. 數秒判斷規則

> **Caroli = 年輕人、男女相近、肝內膽管節段性囊狀擴張；局限型可切肝，瀰漫型嚴重時考慮移植。**
> **選項有兩個子句時，兩句都要驗證。**

8. 投資報酬率

高。

可延伸至：

- 導管板畸形疾病譜。
- Caroli disease與Caroli syndrome。
- 先天性肝纖維化及ARPKD。
- Central dot sign。
- 反覆膽管炎、肝內結石與膽管癌。
- 局部切除與肝移植的適用範圍。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**C。

- **現代臨床實務：**診斷依MRCP、CT或其他膽道影像確認擴張膽管與膽道相通；並需排除原發性硬化性膽管炎、復發性化膿性膽管炎及阻塞後膽管擴張。
- **治療差異：**沒有單一治療適用所有患者。局限型適合肝切除，瀰漫型則以感染控制、膽道介入及必要時肝移植為核心。
- **疾病譜差異：**腎囊性疾病、先天性肝纖維化和門脈高壓更偏向Caroli syndrome，不能與單純Caroli disease完全混用。
- **題目限制：**A的「連續性」容易被誤解為「擴張膽管與膽道相通」。國考意圖應是區分連續性與典型節段性擴張；C的爭議最少。

醫學（五）Q38

對話詳解原文

1. 題目

關於胰臟惡性腫瘤的手術，下列敘述何者最適當？

- A. 手術中若發現肝臟轉移、肝門（hilum）淋巴有侵犯，若可清除宜繼續手術，因為胰臟癌預後不好
- B. 胰臟癌的Whipple procedure，併發症以膽汁滲漏最常見
- C. 胰臟神經內分泌腫瘤若轉移只限於肝臟，仍可進行肝臟移植
- D. 目前對於邊緣性切除手術（borderline resection）仍傾向先手術再化學治療，甚至放射線治療，來提高廓清率

題目核對自考選部醫學（五）正式試題。

2. 作答對照

- 使用者作答：D
- 考選部原始答案：C
- 最終更正答案：C
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始答案與最終更正答案均為C。

3. 核心考點

本題故意把兩種生物學行為截然不同的胰臟惡性腫瘤混在一起：

- **胰管腺癌（PDAC）：**一旦有肝轉移，通常屬轉移性疾病，不做以根治為目的的胰臟切除；borderline resectable疾病則傾向先接受induction / neoadjuvant treatment。
- **分化良好的胰臟神經內分泌腫瘤（pNET）：**生長可能相對緩慢；若轉移侷限於肝臟，部分患者可接受肝切除、局部治療，極少數嚴格篩選者甚至可考慮肝移植。

因此：

> 「罕見」不等於「不能做」。C不是說所有pNET肝轉移都應移植，而是說在高度選擇的肝限性病例中仍然存在這個選項。

4. 各選項解析

A. 發現肝轉移後仍繼續胰臟癌根治手術——錯誤

對典型PDAC而言，術中確認肝轉移已代表遠端轉移。即使肉眼上能移除少數肝病灶，通常也反映已有全身性微小轉移，繼續Whipple或其他大範圍胰臟切除：

- 難以取得真正根治。

- 手術併發症可能延誤全身治療。
- 沒有常規證據支持因「預後本來就差」而擴大手術。

肝門淋巴結侵犯也提示較進展的疾病；但本選項只要有肝臟轉移，便已足以否定常規根治性切除。

現代確有少量研究探索「寡轉移PDAC」在全身治療反應極佳後的轉換手術，但仍屬高度選擇或臨床研究情境，不能作為一般原則。

B. Whipple最常見併發症是膽汁滲漏——錯誤

胰十二指腸切除後的重要併發症包括：

- 術後胰瘻（postoperative pancreatic fistula）。
- 延遲性胃排空。
- 術後出血。
- 腹腔內膿瘍或感染。
- 傷口感染。
- 膽汁滲漏。

其中膽汁滲漏不是最典型、最常見的決勝答案。臨床上更核心的是胰腸吻合處的胰瘻，風險受胰臟質地柔軟、胰管細小、失血及病理種類等因素影響。

C. pNET肝限性轉移仍可接受肝移植——正確

肝移植只適用於極少數患者，常見選擇條件包括：

- 分化良好的G1或G2 NET。
- 原發腫瘤已完整切除。
- 沒有肝外轉移。
- 肝轉移無法完整切除。
- 腫瘤負荷有限，常以少於肝容積50%為參考。
- 經治療或觀察至少6個月仍穩定。
- Ki-67較低，顯示生物學行為緩慢。
- 年齡與整體器官功能適合移植。

2024年EASL肝移植指引仍認為：原發腫瘤已切除、經一段穩定期、不可切除且侷限於肝臟的G1–G2神經內分泌腫瘤轉移，可在有經驗中心考慮肝移植，但建議強度仍弱、證據層級有限。EASL肝移植指引

因此C的精確意思是：

> 肝移植「可以成為選項」，不是標準套用於所有pNET肝轉移患者。

D. Borderline resectable胰臟癌先開刀再化療——錯誤

Borderline resectable PDAC通常與重要血管接觸，直接手術發生R1切除的機率較高。

目前較合理的策略是：

1. 先給induction / neoadjuvant chemotherapy，例如mFOLFIRINOX或其他合適方案。
2. 視情況加入放射治療。
3. 重新以影像、CA 19-9、體能狀態與有無進展評估。
4. 沒有遠端進展且可望完整切除者，再安排手術。

2025年Pan-Asian adapted ESMO指引明確指出，borderline resectable pancreatic cancer因R1風險高，應考慮induction treatment；不能進入試驗時，也建議induction therapy優先於直接手術。
2025 Pan-Asian ESMO胰臟癌指引

必須注意：對明確「可切除」PDAC，是否全面採新輔助治療仍有區域差異；但這不適用於本選項所問的borderline resectable疾病。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選D可能是把「手術是唯一可能根治胰臟癌的方法」延伸為：

> 只要仍有邊緣可切除性，就應先把腫瘤切掉，再用術後治療補強。

但borderline resectable的問題正是直接手術較容易：

- 切緣陽性。
- 很快出現遠端進展。
- 因手術併發症而無法完成全身治療。

另一方面，C看起來像把「已經轉移的癌症」拿去移植，直覺上非常激進；但pNET不是PDAC，少數肝限性、低級別、長期穩定病例確實可能符合移植條件。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- PDAC與pNET生物學混淆
- 罕見但可行被誤判為不可能
- Borderline resectable治療順序
- 新輔助 / 誘導治療與術後輔助治療混淆
- 腫瘤亞型與手術適應症分類

7. 數秒判斷規則

PDAC肝轉移通常不做根治性胰切；borderline resectable先做induction treatment。pNET若低級別、肝限性且長期穩定，極少數仍可考慮肝移植。

8. 投資報酬率

高。

可同步整理：

- 可切除、borderline resectable、局部晚期與轉移性PDAC。
- Neoadjuvant、induction與adjuvant therapy的時序。
- Whipple主要併發症。
- pNET肝轉移的切除、栓塞、消融、PRRT與移植。
- 「可以考慮」與「標準治療」的證據層級。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**C。
- **現代臨床實務：**肝移植只適用於極少數嚴格篩選的低級別、肝限性NET，不應把「只轉移到肝臟」當成充分條件。
- **Borderline resectable PDAC：**現代指引支持先接受induction therapy，再重新評估手術；D的順序顛倒。
- **PDAC寡轉移手術：**少數高量中心正在研究轉換手術，但尚不能推翻「肝轉移通常不進行根治性胰切」的一般原則。
- **題目限制：**C沒有寫出grade、Ki-67、原發腫瘤是否切除及穩定期等條件，過度簡化；但它使用「仍可」而非「應常規進行」，所以仍是唯一可成立的選項。

醫學（五）Q39

對話詳解原文

1. 題目

為了降低肝硬化病人接受肝癌切除手術後產生併發症，下列何者不是必要之術前準備？

- A. 術前預防性抗生素
- B. 經皮穿肝膽汁引流（percutaneous transhepatic biliary drainage, PTBD）
- C. 補充適當的靜脈輸液
- D. 補充足夠的營養

2. 作答對照

- 使用者作答：D
- 考選部原始答案：B
- 最終更正答案：B
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始及最終更正答案均為B。

3. 核心考點

肝硬化患者接受HCC切除前，重點是降低：

- 術後肝衰竭。
- 感染。
- 腎損傷。
- 出血。
- 腹水及失代償。
- 傷口癒合不良。

因此術前應評估並優化營養、容量狀態、感染風險及肝儲備。

PTBD處理的是**膽道阻塞或顯著膽汁鬱積**，不是用來一般性改善肝硬化患者的肝功能。典型HCC沒有膽道阻塞時，常規PTBD不但沒有必要，還可能增加出血、感染、膽汁滲漏及腫瘤播散風險。

4. 各選項解析

A. 術前預防性抗生素——必要

肝切除屬重大腹部手術。肝硬化患者又可能有：

- 免疫功能失調。

- 低白蛋白血症。
- 腹水。
- 糖尿病或營養不良。
- 較高感染與傷口併發症風險。

因此應依手術規範在切皮前適當時間給予預防性抗生素；長時間手術或大量失血時可依藥物半衰期補打。

但「預防性」不代表術後常規持續多日。沒有感染或膽道支架等特殊條件時，延長抗生素反而增加抗藥性、Clostridioides difficile感染及其他副作用。

B. 常規PTBD——不是必要，為本題答案

PTBD的合理適應症包括：

- 惡性膽道阻塞。
- 嚴重膽汁鬱積。
- 急性膽管炎需要引流。
- 內視鏡引流失敗或無法進行。
- 部分肝門膽管癌接受大範圍肝切除前，需要選擇性引流預定保留肝葉。

典型肝硬化合併HCC若沒有阻塞性黃疸，PTBD不能：

- 改善門脈高壓。
- 增加future liver remnant。
- 逆轉肝硬化。
- 預防一般性的術後肝衰竭。

而且肝硬化可能伴隨凝血異常、血小板低下及腹水，使穿刺相關出血與感染風險更值得注意。

2022 ERAS肝臟手術指引把術前膽道引流限定於膽汁鬱積肝臟；並非所有肝切除患者的常規措施。
ERAS Society肝臟手術指引

C. 補充適當的靜脈輸液——必要，但強調適量

肝硬化患者可能因：

- 禁食。
- 利尿劑。
- 腹水與有效循環容積不足。
- 出血。
- 感染。
- 腎功能脆弱。

而需要適當補充液體並矯正電解質。

不過「適當」不等於大量灌液。過量輸液可能造成：

- 腹水及周邊水腫惡化。
- 肺水腫。
- 靜脈壓升高與手術出血增加。
- 稀釋性低鈉。
- 術後肝腎功能惡化。

現代肝切除採個別化、目標導向的液體治療；術中切肝階段常希望降低中心靜脈壓以減少失血，切除完成後再恢復適當灌流。

D. 補充足夠營養——必要

肝硬化患者常有：

- 蛋白質熱量營養不良。
- Sarcopenia。
- 低白蛋白血症。
- 肝醣儲存不足。
- 較長時間空腹後容易進入分解代謝。

營養不良與感染、腹水、傷口癒合不良、住院延長及死亡風險有關，因此術前需要：

1. 營養風險篩檢。
2. 足夠熱量與蛋白質。
3. 優先使用口服或腸道營養。
4. 明顯營養不良者，視手術急迫性進行7–14天營養優化。

ERAS肝臟手術指引將所有肝臟手術患者的術前營養評估列為必要；營養不良患者應接受術前腸道營養補充。ERAS術前營養建議

所以D不是錯誤選項。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選D可能是認為：

> 肝癌手術最重要的是處理手術、感染與循環；營養只是一般照護，未必稱得上必要的術前準備。

但對肝硬化患者，營養不良和sarcopenia是非常實際的術後風險來源。

相對地，PTBD的名稱帶有「肝」「膽汁引流」，容易讓人直覺認為先降低肝膽系統壓力可以保護肝臟；然而PTBD只有在膽道阻塞或膽汁鬱積存在時才有治療標的。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 題幹理解 / 推理失誤
- 二選一失誤
- 常規準備與選擇性介入混淆
- 適應症判斷
- PTBD與HCC術前準備混淆
- 營養風險低估
- 有效循環容積與總體液量混淆

7. 數秒判斷規則

> **看到PTBD先問：有沒有膽道阻塞、膽管炎或明顯膽汁鬱積？沒有就不是一般HCC切除前準備。肝硬化手術前反而要主動顧營養、感染與適當容量。**

8. 投資報酬率

高。

可延伸至：

- HCC肝切除條件。
- Child-Pugh、MELD、門脈高壓與future liver remnant。
- 術後肝衰竭風險。
- 肝硬化營養與sarcopenia。
- PTBD、ERBD的真正適應症。
- 低中心靜脈壓與目標導向輸液。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**B，PTBD。
- **現代臨床實務：**術前膽道引流不是全面禁止；若有明顯膽汁鬱積、膽管炎或特定膽道腫瘤，可能十分必要。但單純肝硬化合併HCC並無常規適應症。
- **輸液差異：**不是所有肝硬化患者都應在術前大量輸液；應矯正真正的低血容量，同時避免過度負荷。
- **營養差異：**並非只看血清albumin；還應評估體重減輕、飲食量、肌肉量及sarcopenia。
- **抗生素差異：**重點是適時、適藥、適當追加，而非無限延長療程。
- **手術前最重要的額外評估：**現代實務還必須確認腫瘤範圍、肝功能、臨床顯著門脈高壓及足夠的future liver remnant。AASLD建議肝硬化患者接受切除時，應有良好代償、無臨床顯著門脈高

壓及足夠的剩餘肝容量。2023 AASLD HCC指引

醫學（五）Q40

對話詳解原文

1. 題目

三級副甲狀腺功能亢進症（tertiary hyperparathyroidism）較可能發生於下列何種情況？

- A. 原發性副甲狀腺功能亢進症成功治療後
- B. 低血鈣症發生後
- C. 因慢性腎衰竭進行腎移植後
- D. 甲狀腺切除術後

題目核對自考選部醫學（五）正式試題。

2. 作答對照

- 使用者作答：A
- 考選部原始答案：C
- 最終更正答案：C
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始答案與最終更正答案一致。

3. 核心考點

三類副甲狀腺功能亢進應以病理時間軸理解：

1. **原發性：**副甲狀腺本身出問題，常見腺瘤；PTH高、血鈣高。
2. **次發性：**腺體仍在回應外界刺激；慢性腎病因高磷、低calcitriol及低鈣，持續刺激PTH。
3. **三級：**長期次發性刺激使腺體增生並自主化；即使腎移植移除了原始刺激，PTH仍持續分泌，常伴高血鈣。

因此「慢性腎衰竭多年，腎移植後仍持續PTH過高」是最典型情境。

4. 各選項解析

A. 原發性副甲狀腺功能亢進成功治療後——錯誤

成功切除致病腺瘤或過度分泌腺體後，原發性副甲狀腺功能亢進理應改善。

術後若發生低血鈣，較可能是：

- 暫時性副甲狀腺功能低下。
- Hungry bone syndrome。
- 剩餘腺體恢復較慢。

這不是原發性疾病進展成三級副甲狀腺功能亢進的典型路徑。

B. 低血鈣發生後——不足以構成三級

低血鈣會刺激PTH分泌，屬正常生理回饋；若低血鈣持續，可能造成**次發性**副甲狀腺功能亢進。

只有長期刺激導致腺體結節性增生、自主分泌，而且原始刺激解除後仍不停止，才進入三級。因此單純「發生低血鈣」不夠。

C. 慢性腎衰竭接受腎移植後——正確

慢性腎衰竭會造成：

- 磷排泄下降。
- Calcitriol生成下降。
- 腸道鈣吸收下降。
- 長期次發性副甲狀腺功能亢進。
- 副甲狀腺瀰漫性或結節性增生。

成功腎移植後，腎功能與鈣磷環境雖改善，部分已自主化的腺體仍持續分泌PTH，形成持續性 / 三級副甲狀腺功能亢進，常出現高血鈣。

近期研究仍將其描述為腎移植後重要併發症；未治療的高血鈣性三級副甲狀腺功能亢進與移植腎及全身結局不良相關。2024腎移植後三級副甲狀腺功能亢進研究

D. 甲狀腺切除術後——錯誤

甲狀腺手術可能因副甲狀腺被移除、血流受損或暫時失去功能，造成：

- PTH降低。
- 低血鈣。
- 手足麻木、痙攣。
- Chvostek或Trousseau sign。

典型方向是**副甲狀腺功能低下**，不是三級功能亢進。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選A可能是把「三級」理解成原發性疾病治療後出現的後續階段。

但primary、secondary、tertiary並不是依治療前後編號，而是依分泌機轉分類：

- Primary：腺體自行過度分泌。
- Secondary：仍受外界刺激驅動。
- Tertiary：長期secondary後變成自主分泌。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 原發性 / 次發性 / 三級分類混淆
- 病理機轉時間軸
- 刺激性分泌與自主性分泌混淆
- 二選一失誤

7. 數秒判斷規則

腎衰竭先secondary；刺激太久腺體自主化，腎移植後PTH仍高、血鈣反而高，就是tertiary。

8. 投資報酬率

高。

可同步處理：

- CKD–mineral and bone disorder。
- 原發性、次發性與三級副甲狀腺功能亢進。
- 腎移植後高血鈣。
- Cinacalcet與副甲狀腺切除術。
- Hungry bone syndrome。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**C。
- **現代實務：**三級副甲狀腺功能亢進不一定只能在腎移植後才「開始」；自主化可能在長期透析期間已形成，腎移植後只是仍持續存在。
- **診斷限制：**移植後PTH一時偏高不一定全部屬三級；需結合持續時間、血鈣、血磷、腎功能及原先腎性骨病判斷。
- **治療：**Cinacalcet可降低血鈣和PTH；嚴重、持續、有症狀或藥物控制不佳者可考慮副甲狀腺切除，後者是較具根治性的治療。

醫學（五）Q45

對話詳解原文

1. 題目

45歲女性右側乳房有一硬塊，報告顯示腫瘤可能為乳腺小葉癌（invasive lobular carcinoma），此類腫瘤常見的特別影像表現為何？

- A. 清晰邊緣和單一腫塊
- B. 擴散性分布，邊緣模糊
- C. 高回聲且伴隨血流訊號增加
- D. 腫塊內鈣化均勻分布

2. 作答對照

- 使用者作答：C
- 考選部原始答案：B
- 最終更正答案：B
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始與最終更正答案均為B。

3. 核心考點

侵襲性小葉癌常因E-cadherin功能喪失，使腫瘤細胞以鬆散、單列方式沿乳腺間質浸潤，不容易形成界線清楚的球狀腫塊。

典型影像傾向：

- 擴散性或浸潤性分布。
- 邊緣模糊或呈放射狀。
- 結構扭曲、局部不對稱。
- 超音波呈不規則低回聲病灶及後方聲影。
- 病灶範圍可能被乳房攝影和超音波低估。

4. 各選項解析

A. 清晰邊緣和單一腫塊——錯誤

界線清楚、圓形或橢圓形單一腫塊較像：

- 纖維腺瘤。
- 囊腫。
- 部分邊界較清楚的惡性腫瘤。

小葉癌雖偶爾可以形成明確腫塊，但其最具特色的表現是浸潤範圍不清、容易多灶或多中心，而非清楚單一病灶。

B. 擴散性分布、邊緣模糊——正確

小葉癌可呈現：

- Spiculated或ill-defined mass。
- 不對稱密度。
- Architectural distortion。
- 缺乏明確腫塊的擴散性浸潤。

影像回顧研究將放射狀或邊緣不清的腫塊，以及界線不明的不對稱密度，列為常見乳房攝影表現。小葉癌多模態影像回顧

C. 高回聲並伴血流增加——錯誤

小葉癌在超音波上最典型的是：

- **低回聲**，不是高回聲。
- 不規則或角狀、邊緣模糊。
- 後方聲影。
- 有時只有聲影或組織扭曲，未形成明確腫塊。

都卜勒血流可以增加，也可能不明顯，不能作為小葉癌的專屬特徵。選項同時把主要回聲方向寫反。

D. 腫塊內均勻鈣化——錯誤

微鈣化是DCIS及部分侵襲性乳管癌常見的提示方式；小葉癌較少以鈣化為主要表現。

即使存在鈣化，也沒有「腫塊內均勻分布」這項典型特徵。這種描述無法解釋小葉癌的擴散性浸潤生長。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選C可能是以一般惡性腫瘤印象判斷：

> 惡性腫瘤血管新生較旺盛，所以應有血流增加。

血流增加確實可能出現，但不是本題詢問的「小葉癌特殊影像」。更具鑑別力的是其生長方式造成的：

- 邊緣模糊。
- 擴散浸潤。
- 結構扭曲。
- 病灶範圍容易被低估。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 影像辨識
- 病理生長方式與影像未連結
- 一般惡性特徵壓過疾病專屬特徵
- 回聲方向混淆
- 影像鑑別力排序
- 二選一失誤

7. 數秒判斷規則

> **Lobular不像一顆球，而像偷偷散開：邊緣模糊、擴散浸潤、結構扭曲；超音波通常是低回聲加聲影。**

8. 投資報酬率

高。

可延伸至：

- Invasive lobular與ductal carcinoma比較。
- E-cadherin缺失。
- 多灶性、多中心性及雙側病灶。
- 乳房攝影、超音波與MRI的角色。
- 影像病灶範圍被低估的手術規劃問題。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**B。
- **現代實務：**小葉癌影像變化多端，也可能呈現清楚腫塊或影像陰性；B是最具代表性的典型模式，不是每例必然如此。
- **MRI角色：**確診後若需釐清病灶範圍、多灶 / 多中心或對側疾病，MRI通常比乳房攝影與超音波更敏感，但可能增加偽陽性及額外切片。ACR侵襲性乳癌影像準則
- **病理確認：**影像不能單獨確診小葉癌，仍須粗針切片；E-cadherin缺失可協助病理分類。乳癌病理與E-cadherin說明

醫學（五）Q48

對話詳解原文

1. 題目

門診有一位國中男生，14歲，主訴為左側陰囊腫大，經診所醫師轉診，懷疑為睪丸腫瘤。下列處置何者錯誤？

- A. 理學檢查必須仔細，排除睪丸受傷、陰囊水腫或腹股溝疝氣
- B. 若為惡性腫瘤，標準術式為根除性睪丸切除（radical inguinal orchiectomy），包括鼠蹊部整條精索
- C. 腫瘤指數是日後追蹤治療效果的指標，最重要的是癌胚抗原（CEA）以及攝護腺特定抗原（PSA）
- D. 如果懷疑是惡性睪丸腫瘤，必須在手術前完成所有影像學檢查，作為期別診斷

題目核對自考選部醫學（五）正式試題。

2. 作答對照

- 使用者作答：D
- 考選部原始答案：C
- 最終更正答案：C
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始答案與最終更正答案一致。

3. 核心考點

疑似睪丸生殖細胞腫瘤的三個專屬記憶點：

1. **腫瘤指標：AFP、β-hCG、LDH。**
2. **手術路徑：經鼠蹊根除性睪丸切除及精索高位結紮。**
3. **禁止常規經陰囊切片或切除**，以免破壞淋巴引流、增加局部復發並影響分期。

CEA偏向腸胃道等腫瘤，PSA屬攝護腺標誌，兩者都不是睪丸生殖細胞腫瘤的主要指標。

4. 各選項解析

A. 仔細理學檢查並排除其他病因——適當

陰囊腫大需先區分：

- 睪丸實質腫瘤。
- 副睪炎或睪丸炎。
- 睪丸扭轉。
- 外傷及血腫。

- 陰囊水腫、陰囊積水。
- 腹股溝疝氣。
- 精索靜脈曲張。

接著以陰囊超音波判斷病灶位於睪丸內或睪丸外。睪丸內實質性腫塊的惡性機率遠高於睪丸外病灶。

B. 經鼠蹊根除性睪丸切除——國考判定適當

高度懷疑惡性睪丸腫瘤時，標準處置是：

- 鼠蹊部切口。
- 控制並高位結紮精索。
- 整顆睪丸連同相關精索結構取出。
- 避免切開陰囊皮膚及常規穿刺腫瘤。

這同時具有確定病理、局部治療及分期功能。

14歲位於兒童與青春期交界；若是小型、不確定、指標陰性病灶，現代實務可能在專科中心考慮保留睪丸手術及術中冰凍切片。但對明顯疑似惡性、青春期後生殖細胞腫瘤，根除性鼠蹊睪丸切除仍是標準。

C. CEA及PSA是最重要腫瘤指標——錯誤，為本題答案

睪丸生殖細胞腫瘤的主要指標為：

- **AFP：**nonseminomatous germ cell tumor常升高；純seminoma不應造成AFP升高。
- **β-hCG：**choriocarcinoma及部分nonseminoma明顯升高；部分seminoma也可能輕度升高。
- **LDH：**專一性較低，但可反映腫瘤負荷及預後。

指標應在睪丸切除前抽取，術後依半衰期重複追蹤，用於：

- 分期及預後分組。
- 評估治療反應。
- 辨識術後仍有殘存疾病。
- 監測復發。

EAU現行指引同樣要求在睪丸切除前後測量AFP、β-hCG及LDH。EAU睪丸癌診斷指引

CEA與PSA不屬於這套標準：

- CEA：較常用於大腸癌等腺癌的追蹤。
- PSA：攝護腺上皮相關標誌，在14歲患者更完全不合情境。

D. 術前完成影像分期——國考判定適當，但措辭過度絕對

疑似睪丸惡性腫瘤通常需要：

- 陰囊超音波。
- 胸、腹、骨盆橫斷面影像，通常為含顯影劑CT。

- 術前AFP、β-hCG及LDH。
- 依症狀及高風險表現決定是否增加腦部或骨骼影像。

因此國考接受D，重點是術前建立分期基準。

但現代指引沒有要求每位患者都必須在睪丸切除前完成「所有」可能影像。EAU指出：若指標升高或臨床懷疑轉移，術前胸腹骨盆影像是標準；若是小型或性質不確定病灶，完整分期影像可延至病理證實惡性後進行。EAU分期影像建議

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選D很可能是抓到「必須」「所有影像」「手術前」三個過度絕對的字眼。這項質疑在現代臨床上確實合理。

問題是C存在更明確、幾乎無爭議的錯誤：

> 睪丸癌 = AFP、β-hCG、LDH；絕不是CEA + PSA。

這題應先排除疾病專屬標誌完全錯置的選項，再處理D的臨床措辭爭議。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 國考記憶點
- 腫瘤標誌疾病配對
- AFP / β-hCG / LDH
- CEA / PSA干擾
- 明確錯誤與可爭議措辭的優先排序
- 絕對字眼陷阱
- 二選一失誤

7. 數秒判斷規則

> **睪丸腫瘤先背三個：AFP、β-hCG、LDH；手術走鼠蹊高位結紮。看到CEA + PSA可直接刪除。**

8. 投資報酬率

高。

可延伸至：

- Seminoma與nonseminoma的指標差異。
- 鼠蹊切除與禁止陰囊切片。
- 指標半衰期及Stage IS。
- 睪丸癌淋巴轉移至後腹膜的路徑。

- 生育保存及精子冷凍。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**C。
- **現代實務：**AFP、β-hCG、LDH仍是標準指標，與國考完全一致。
- **影像差異：**D的「所有影像都必須在術前完成」過度絕對；小型不確定病灶可待病理證實後再完成分期。
- **年齡差異：**14歲患者需考慮青春期狀態及兒童腫瘤譜；不能把所有成人睪丸癌策略毫無調整地套用。
- **重要限制：**正常腫瘤指標不能排除睪丸癌，尤其純seminoma可能三項均正常。

醫學（五）Q55

對話詳解原文

1. 題目

對於遠端胃癌病人接受部分胃切除手術（gastrectomy）及D2淋巴結清除手術步驟的描述，下列何者錯誤？

- A. 需結紮右及左胃網膜動脈、上腸繫膜動脈、左胃動脈、右胃動脈
- B. 切除範圍包括胃幽門及胃竇，取決於腫瘤位置及手術安全距離
- C. 殘留胃重建方式為胃 - 十二指腸吻合或胃 - 空腸吻合
- D. D2淋巴結清除須清除胃小彎、胃大彎、門靜脈、總肝動脈、脾臟附近淋巴結，而且需要清除至少15顆淋巴結

2. 作答對照

- 使用者作答：D
- 考選部原始答案：A
- 最終更正答案：A
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始及最終更正答案均為A。

3. 核心考點

本題最強的排除點不是背完整D2 station，而是辨識一項災難性解剖錯誤：

> **遠端胃切除不會結紮上腸繫膜動脈（SMA）。**

SMA是中腸主要血流來源，供應大部分小腸及右側結腸。若把SMA主幹結紮，可能導致廣泛腸缺血，絕非胃癌切除的常規步驟。

4. 各選項解析

A. 包含結紮上腸繫膜動脈——錯誤，為本題答案

遠端胃切除可能依腫瘤範圍處理：

- 右胃動脈。
- 右胃網膜動脈。
- 左胃動脈。
- 大彎側在預定切線附近的左胃網膜血管分支。

但**不會結紮SMA主幹**。

SMA供應：

- 十二指腸遠端。
- 空腸、迴腸。
- 盲腸、升結腸。
- 橫結腸近端。

胃的主要動脈供應則來自celiac trunk系統，包括左胃、脾及總肝動脈相關分支。A把中腸主幹血管混進胃癌手術，是決定性錯誤。

B. 切除幽門及胃竇，範圍取決於位置與安全距離——適當

遠端胃切除通常包括：

- 胃竇。
- 幽門。
- 遠端胃體的適當範圍。

實際切除線取決於：

- 腫瘤位置。
- 肉眼型態與浸潤範圍。
- 能否取得R0切緣。
- 病理類型。
- 剩餘胃是否足以重建。

若無法取得安全近端切緣，可能需要改為全胃切除。

C. 胃 - 十二指腸或胃 - 空腸吻合——適當

遠端胃切除後常見重建包括：

- **Billroth I：**胃 - 十二指腸吻合。
- **Billroth II：**胃 - 空腸吻合。
- **Roux-en-Y胃 - 空腸吻合。**

選擇取決於剩餘胃與十二指腸能否無張力吻合、逆流風險、病人狀況及術者策略。

D. D2清除範圍及至少15顆淋巴結——國考判定適當，但描述不精確

D2不是以「門靜脈旁、脾臟附近」這種模糊地圖定義，而是依淋巴結station及胃切除方式界定。

依2025年第7版日本胃癌治療指引，遠端胃切除的D2範圍為D1加上：

- No. 8a：總肝動脈前上方。
- No. 9：腹腔動脈周圍。
- No. 11p：近端脾動脈。
- No. 12a：肝十二指腸韌帶內、肝動脈旁。

完整範圍還包含D1的No. 1、3、4sb、4d、5、6、7。日本胃癌治療指引2025

因此D有幾項現代限制：

- 遠端胃癌D2並非例行清除脾門No.10。
- 「門靜脈附近」不是精確station描述。
- 淋巴結顆數主要是分期充分性的品質指標，不是D2的解剖定義。
- 現代TNM通常希望至少檢查16顆區域淋巴結；題目的「至少15顆」較接近舊式或概括表達。

D確實寫得不漂亮，但A中的SMA結紮是更直接且危險的錯誤，故官方選A。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選D可能是注意到：

- 脾臟附近並非所有遠端胃癌都需清除。
- 「門靜脈附近」描述過度模糊。
- 淋巴結數量門檻可能應是16而非15。

這些質疑相當合理，顯示你可能對D2清除的精確內容有所警覺。

但本題應先做一次「大血管生理檢查」：

> SMA若被結紮，整段中腸會缺血；這不可能是遠端胃切除的常規步驟。

也就是對D的精細爭議，壓過了A中更高層級的解剖災難。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 解剖定位
- Celiac trunk與SMA供血範圍混淆
- 胃癌手術血管處理
- D2淋巴結station
- 精細爭議壓過決定性錯誤
- 二選一失誤
- 輕度低效度題：D的描述不夠精確

7. 數秒判斷規則

> **胃是celiac territory；SMA是中腸命脈。胃切除選項只要寫結紮SMA主幹，直接判錯。**

8. 投資報酬率

高。

可延伸至：

- 腹腔動脈三大分支。
- 胃部動脈弓。
- SMA供應範圍。
- Billroth I、II及Roux-en-Y。
- 胃癌D1 / D2淋巴結station。
- R0切除與安全切緣。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**A。
- **現代實務：**結紮SMA仍明確錯誤，沒有實質爭議。
- **D2定義：**應依station而不是含糊的「某血管或脾臟附近」描述；遠端胃切除的D2為D1加No.8a、9、11p及12a。
- **脾門清除：**No.10或預防性脾切除不是遠端胃癌的常規D2內容。
- **淋巴結數量：**足夠送檢數量有助準確N分期，但清除幾顆與是否完成正確解剖station是兩個不同概念。
- **手術策略：**D2通常適用於具根治可能的cT2–T4或cT1N+胃癌；患者狀況、腫瘤期別及手術中心經驗仍須納入考量。

醫學（五）Q56

對話詳解原文

1. 題目

有關骨代謝疾病的敘述，下列何者最適當？

- A. 棕色腫瘤（brown tumor）是一種骨代謝異常疾病，經由局部病灶腫瘤採樣即可確認診斷
- B. Gaucher氏病（Gaucher disease）是家族性疾病，會造成肝臟、脾臟腫大及骨壞死（bone infarct）
- C. 佩吉特骨病（Paget disease）在病灶處的骨母細胞（osteoblast）會出現包涵體（inclusion bodies），因此推測與病毒感染有關
- D. 佩吉特骨病好發於年輕族群，X光攝影可能出現骨生成或蝕骨現象

題目核對自考選部醫學（五）正式試題。

2. 作答對照

- 使用者作答：D
- 考選部原始答案：B
- 最終更正答案：B
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始答案與最終更正答案一致。

3. 核心考點

三種疾病要依機轉分類：

- **Brown tumor：**嚴重副甲狀腺功能亢進造成的反應性骨病灶，不是真正腫瘤。
- **Gaucher disease：**遺傳性溶小體儲積病，可造成肝脾腫大及骨梗塞、骨壞死。
- **Paget disease of bone：**高骨轉換、結構紊亂的局部性骨重塑疾病，主要發生於中老年人。

B完整符合Gaucher disease；D雖然後半句正確，但「好發於年輕族群」使整項錯誤。

4. 各選項解析

A. Brown tumor靠局部採樣即可確診——錯誤

Brown tumor是長期高PTH造成的局部骨吸收、纖維化、出血及巨細胞反應，不是真正腫瘤。

病理可能看到：

- 多核巨細胞。
- 纖維血管性間質。
- 出血與含鐵血黃素沉積。

- 骨小樑吸收。

但這些變化也可能出現在巨細胞瘤、動脈瘤性骨囊腫及其他巨細胞性病灶，因此**單靠局部切片未必能確診**。還必須核對：

- 血鈣、血磷。
- ALP。
- PTH。
- 腎功能。
- 是否存在原發性或次發性副甲狀腺功能亢進。

Brown tumor屬嚴重hyperparathyroidism的骨骼表現；評估巨細胞性病灶時，骨代謝數據和PTH不可省略。骨炎性纖維囊腫與brown tumor說明

B. Gaucher disease造成肝脾腫大及骨壞死——正確

Gaucher disease多由雙等位基因 **GBA1** 致病變異造成，導致β-glucocerebrosidase功能不足，使脂質堆積於巨噬細胞。

典型表現包括：

- 肝脾腫大。
- 貧血、血小板低下。
- 骨痛或bone crisis。
- Erlenmeyer flask deformity。
- 骨髓浸潤。
- 骨梗塞、骨壞死。
- 骨質減少及病理性骨折。

GeneReviews同樣將hepatosplenomegaly、osteonecrosis以及局部溶骨或硬化性病灶列為第一型Gaucher disease的重要表現。Gaucher disease GeneReviews

因此B是唯一完整正確的敘述。

C. Paget病的osteoblast出現病毒樣包涵體——錯誤

Paget disease曾在病灶的**破骨細胞osteoclast**中發現類似paramyxovirus的核內包涵體，而不是osteoblast。

此外，病毒假說至今並未確立為完整病因。現代理解較偏向：

- 遺傳易感性，例如SQSTM1相關變異。
- 破骨細胞功能失調。
- 可能的環境因素。
- 病毒是否具有因果作用仍有爭議。

所以C同時寫錯細胞種類，並把尚未確立的病毒假說說得過度肯定。Paget disease病理與病因回顧

D. Paget病好發年輕人——錯誤

Paget disease確實可能依病程呈現：

- 早期osteolytic phase。
- Mixed lytic–blastic phase。
- 晚期sclerotic / burned-out phase。

影像可見cotton-wool skull、picture-frame vertebra、皮質增厚、骨擴大及長骨彎曲。

但它主要發生於**中老年人**，很少在中年前發病；「好發於年輕族群」明確錯誤。2019循證指引也將其定位為主要影響較年長成人的局部高骨轉換疾病。Paget disease循證指引

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選D可能是認出Paget disease可同時具有osteolytic與osteoblastic影像，因此接受了後半句，卻沒有重新核對前半句的年齡。

這和先前「複合選項只驗證其中一個正確子句」的模式相似：

- 混合蝕骨 / 造骨變化：正確。
- 好發年輕族群：錯誤。

同時可能未建立Gaucher disease的骨骼表現連結，把它只記成「肝脾腫大的儲積病」，而忽略骨梗塞及osteonecrosis也很典型。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 相近骨代謝疾病分類
- 複合敘述未逐句核對
- 遺傳性儲積病
- Brown tumor與真正骨腫瘤混淆
- Osteoblast / osteoclast混淆
- Paget disease年齡分布
- 二選一失誤

7. 數秒判斷規則

> **Gaucher = 家族性儲積病 + 肝脾大 + 骨梗塞；brown tumor要回頭找PTH，不能只靠切片；Paget看老人與混合型骨重塑。**

8. 投資報酬率

高。

可延伸至：

- Gaucher disease的GBA1、酵素替代及substrate reduction therapy。
- Brown tumor與巨細胞瘤鑑別。
- 原發性及腎性副甲狀腺功能亢進。
- Paget disease的ALP、影像及zoledronic acid治療。
- 複合選項逐句驗證。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**B。
- **現代臨床：**Gaucher disease須以酵素活性及分子遺傳檢測確認，不能只靠肝脾腫大或骨病變。
- **Brown tumor：**病理切片可協助排除惡性病變，但需結合PTH與鈣磷代謝才可建立病因診斷。
- **Paget disease：**病毒樣包涵體出現在osteoclast，且病毒因果假說尚未確立。
- **治療差異：**Paget disease不是看到ALP升高就一律治療；通常以骨痛或可能發生併發症的活動性病灶為主要治療對象。

醫學（五）Q59

對話詳解原文

1. 題目

關於肩關節盂肱關節（glenohumeral joint）的解剖結構，下列敘述何者最適當？

- A. 盂肱韌帶是界線分明的帶狀韌帶，其膠原纖維呈平行排列
- B. 肩胛骨與胸廓之間存在一個真正的滑液關節（synovial joint）
- C. 鎖骨是上肢與中軸骨骼之間唯一的骨性連接
- D. 肩盂窩的關節面積約為肱骨頭的二分之一，提供了良好的穩定性

2. 作答對照

- 使用者作答：D
- 考選部原始答案：C
- 最終更正答案：C
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始及最終更正答案均為C。

3. 核心考點

肩部同時具備極大活動度與較低先天骨性穩定性：

- 上肢骨骼藉**鎖骨與胸骨形成的胸鎖關節**連接中軸骨骼。
- Scapulothoracic articulation是功能性滑動介面，不是真正滑液關節。
- Glenoid淺而小，無法像髖臼一樣靠骨性包覆維持穩定。
- 肩關節穩定主要依賴盂唇、關節囊、盂肱韌帶、旋轉肌袖及肩胛周圍肌肉。

因此C最適當。

4. 各選項解析

A. 盂肱韌帶是界線分明、平行纖維的帶狀韌帶——錯誤

Superior、middle及inferior glenohumeral ligaments主要是**關節囊局部增厚**，解剖形態具有相當變異，並非每一條都像獨立繩索般界線分明。

尤其：

- MGHL可能細小、分叉，甚至缺如。
- IGHL形成前束、後束及腋下囊袋的複合體。
- 膠原纖維與關節囊彼此交織，不宜概括成整齊平行排列。

解剖回顧把盂肱韌帶描述為前下方關節囊的增厚結構，而非完全獨立的典型帶狀韌帶。盂肱關節解剖與不穩定性回顧

B. 肩胛胸廓間是真正滑液關節——錯誤

Scapulothoracic articulation沒有典型滑液關節應具備的：

- 相對關節軟骨面。
- 關節囊。
- 滑液腔。
- 真正骨與骨直接關節面。

它是肩胛骨沿胸壁滑動的**功能性關節介面**，中間隔著subscapularis、serratus anterior及滑囊等軟組織。

因此雖然肩胛胸廓運動對肩部功能極重要，仍不能稱為真正synovial joint。

C. 鎖骨是上肢與中軸骨骼唯一骨性連接——正確

上肢骨骼的骨性連接路徑為：

肱骨 → 肩胛骨 → 肩鎖關節 → 鎖骨 → 胸鎖關節 → 胸骨。

胸鎖關節是上肢 / 肩帶與中軸骨骼之間唯一真正的骨性關節連接。AAOS也把鎖骨描述為連接手臂與軀幹的骨骼。AAOS鎖骨解剖

精確來說，真正完成這項連接的是**鎖骨及其胸鎖關節**；國考以「鎖骨是唯一骨性連接」表達此概念。

D. Glenoid約為肱骨頭二分之一並提供良好骨性穩定——錯誤

Glenoid相對於肱骨頭：

- 面積較小。
- 曲率較淺。
- 骨性包覆有限。
- 以犧牲穩定度換取大活動範圍。

不同測量方法的數值略有差異，但一般描述是glenoid關節面僅涵蓋肱骨頭約四分之一至三分之一，而非穩定包覆二分之一。

盂唇雖可加深關節窩，仍不能使肩關節取得像髖關節般的骨性穩定。因此D的「提供良好穩定性」方向也完全相反。肩關節必須依賴旋轉肌袖的concavity compression、盂唇、關節囊及韌帶共同維持穩定。盂肱關節穩定機轉

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選D可能是把「肩盂與肱骨頭高度吻合」或「盂唇能加深肩盂」延伸為肩盂本身已覆蓋肱骨頭約一半，並能提供良好穩定性。

但肩關節的核心設計正好相反：

> **淺而小的肩盂換取活動度；穩定性主要由軟組織及肌肉補足。**

另一可能是沒有把「上肢與中軸骨骼唯一連接」直接連到胸鎖關節，因此低估C的專屬性。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 解剖結構—功能關係
- 胸鎖關節定位
- Scapulothoracic假關節 / 功能性關節
- 骨性穩定與動態穩定混淆
- Glenoid覆蓋比例
- 活動度與穩定度取捨
- 二選一失誤

7. 數秒判斷規則

> **上肢接中軸只走胸鎖關節；肩盂又小又淺，所以肩關節靠盂唇、關節囊與rotator cuff穩定，不靠深骨窩。**

8. 投資報酬率

高。

可延伸至：

- 胸鎖、肩鎖、肩胛胸廓及盂肱關節。
- 靜態與動態肩關節穩定器。
- Bankart、SLAP及HAGL lesion。
- IGHL在外展外旋時防止前方脫位。
- Rotator cuff的concavity-compression作用。
- 肩盂骨缺損與復發性脫位。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**C。
- **現代解剖：**仍一致；胸鎖關節是上肢與中軸骨骼的唯一真正骨性關節連接。
- **措辭限制：**與其說「鎖骨」本身是連接，更精確應寫成「鎖骨經胸鎖關節連接中軸骨骼」。
- **盂肱韌帶：**是關節囊增厚，但不同個體及不同韌帶的形態變異很大；A的絕對描述不成立。
- **穩定性差異：**肩盂骨性包覆小並不代表正常肩膀必然不穩；正常人可藉盂唇、負壓、韌帶與肌肉維持精確動態穩定。

- **臨床延伸：**前下盂骨缺損、Bankart lesion或rotator cuff功能失調都可能破壞這套平衡。

醫學（五）Q63

對話詳解原文

1. 題目

關於股骨頭骨壞死（osteonecrosis of the femoral head），下列敘述何者最適當？

- A. 早期的病變先發生在股骨頭的前外上部區域的關節軟骨，然後擴及深層的鈣化軟骨層
- B. 股骨頭塌陷前的早期骨壞死，建議進行人工關節置換，以改善症狀
- C. 有新月徵（crescent sign）時，不適合接受保守性治療，如雙磷酸鹽類、statins、高壓氧和體外震波療法等
- D. 股骨頭塌陷後較適合接受核心減壓和結構性骨移植，增加血液供應，再生骨軟骨

題目核對自考選部醫學（五）正式試題。

2. 作答對照

- 使用者作答：A
- 考選部原始答案：C
- 最終更正答案：C
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始答案與最終更正答案一致。

3. 核心考點

這題的主軸是「股骨頭是否已發生結構性失敗」：

- Pre-collapse：仍可能採取核心減壓等保髖治療。
- Crescent sign：代表軟骨下骨折，已進入ARCO stage 3。
- 明顯塌陷、退化性關節炎：保髖效果下降，較常考慮人工髖關節置換。

因此看到crescent sign，就不能再把它視為單純早期、結構完整的病灶。

4. 各選項解析

A. 病變由關節軟骨開始——錯誤

股骨頭骨壞死的主要初始病灶是缺血造成的：

- 骨髓細胞死亡。
- 骨細胞死亡。
- 壞死骨無法正常重塑。
- 軟骨下骨逐漸失去承重能力。

關節軟骨可由滑液獲得營養，早期可能仍保持相對完整；疾病不是由前外上方的關節軟骨一路向深層擴散。

壞死區通常位於股骨頭承重區，常以前外上方最具臨床重要性，但這不等於病變從關節軟骨起始。

B. 塌陷前即進行人工關節置換——錯誤

Pre-collapse病灶，尤其年輕患者、病灶範圍不大時，治療目標通常是保留原生關節，可能考慮：

- 核心減壓。
- 核心減壓合併骨移植或細胞治療。
- 特定病例的截骨或血管化骨移植。
- 風險因子控制及密切影像追蹤。

核心減壓主要用於ARCO stage I、II等尚未塌陷的階段，而不是塌陷後才做。核心減壓適應症研究

C. 出現crescent sign後不適合題列保守療法——官方正確

Crescent sign是軟骨下骨折形成的透亮線，表示結構已開始失敗；ARCO共識也把它連結至後續股骨頭塌陷。ARCO病理共識

題目所列的雙磷酸鹽、高壓氧及體外震波等非手術療法，研究主要集中於較早期病灶；一旦已有軟骨下骨折，單靠這些療法阻止進展的可靠性不足。因此四個選項中以C最適當。

D. 塌陷後才適合核心減壓及結構性骨移植——錯誤

核心減壓最主要的治療窗口是塌陷前。

塌陷後的處置取決於：

- 塌陷程度。
- 壞死區大小與位置。
- 軟骨及髖臼是否已退化。
- 年齡、症狀與活動需求。
- 是否仍有技術上可行的保髖方案。

部分極早期、小範圍塌陷病例仍可能嘗試較複雜的保髖手術，但不能概括成「塌陷後較適合核心減壓」。明顯塌陷或退化性變化通常更傾向人工髖關節置換。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測，選A可能是：

- 記得壞死區常位於前外上方承重區。
- 把病灶的常見位置誤接成「由關節軟骨開始」。
- 沒有把crescent sign立即轉換成軟骨下骨折及結構性失敗。

真正需要優先抓的是：

> Crescent sign = 軟骨下骨折 = 已跨過單純pre-collapse階段。

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- 病理起始位置混淆
- 疾病分期與治療時機
- Crescent sign意義
- 軟骨與軟骨下骨混淆
- 題幹條件未轉換
- 二選一失誤

7. 數秒判斷規則

> **股骨頭壞死先壞骨、不是先壞軟骨；crescent sign是軟骨下骨折。減壓趁未塌陷，明顯塌陷再想置換。**

8. 投資報酬率

高。可延伸至：

- Ficat與ARCO分期。
- 類固醇、酒精、潛水夫病及鐮刀型紅血球疾病。
- MRI雙線徵。
- 病灶大小與Kerboul angle。
- 保髖治療與人工關節的時機。

9. 國考答案與現代臨床差異

- 國考答案：C。
- 現代分期：crescent sign確實代表軟骨下骨折，核心概念一致。
- 措辭限制：C的「不適合」過度絕對；實務仍須考慮塌陷幅度、病灶大小、年齡及患者需求。
- 藥物證據：雙磷酸鹽等療法的研究結果不一致，尚不能當作可靠逆轉結構性失敗的標準方案。
- 手術差異：極少數早期、小幅塌陷患者仍可能接受保髖手術，但單純核心減壓的成功率通常已下降。

醫學（五）Q66

對話詳解原文

1. 題目

一位60歲男性的腹部電腦斷層檢查，發現左側腎臟有一個5.5公分的囊腫，其邊緣不規則（shaggy margins），且有實心結節（solid nodules）。依據Bosniak囊腫分類，此一囊腫屬於下列哪一種類？

- A. 第一類
- B. 第二類
- C. 第三類
- D. 第四類

2. 作答對照

- 使用者作答：C
- 考選部原始答案：D
- 最終更正答案：D
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始及最終更正答案均為D。

3. 核心考點

Bosniak III與IV的快速分界：

- III：增厚、不規則的壁或分隔，但沒有明確增強性結節。
- IV：具有增強性實心結節或軟組織成分。

本題的「solid nodules」是決定性關鍵，因此官方選Bosniak IV。

4. 各選項解析

A. Bosniak I——錯誤

典型單純囊腫：

- 薄而平滑的壁。
- 均質液體內容。
- 無分隔、鈣化或結節。
- 無顯影增強。

與本題的不規則邊緣及實心結節完全不符。

B. Bosniak II——錯誤

可有少數薄分隔或細小鈣化，但仍屬低風險病灶，不應具有明確實心結節。

若病灶複雜程度需要影像追蹤，傳統分類另有Bosniak IIF；本題未列出，但其特徵也不到實心結節。

C. Bosniak III——錯誤

Bosniak III可有：

- 增厚或不規則的壁。
- 增厚或不規則的分隔。
- 可測得的顯影增強。

但關鍵是沒有符合Bosniak IV定義的增強性結節。

因此若題幹只有「shaggy margins」，C可能值得考慮；一旦另有solid nodules，分類應上升至IV。

D. Bosniak IV——正確

Bosniak v2019把增強性凸出結構分為：

- 與囊壁呈銳角：任何大小的結節均可列為IV。
- 與囊壁呈鈍角：高度至少4 mm才定義為結節。

也就是說，真正高權重的分類特徵是「增強性結節」，而不只是囊壁不規則。Bosniak v2019原始更新論文

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測，選C可能是：

- 抓到「不規則邊緣」與Bosniak III的連結。
- 沒有讓後面的solid nodules覆蓋前面的較低權重特徵。
- 把III理解成「所有複雜囊腫」，而沒有以結節區分III與IV。

這是典型的影像特徵權重問題：

> **不規則壁可以是III；增強性結節直接把分類推向IV。**

6. 失分類型

- 核心臨床知識缺口
- Bosniak III / IV分類
- 影像關鍵形態未優先使用
- 不規則壁與實心結節混淆
- 腫瘤分類層級
- 高權重特徵未覆蓋低權重特徵
- 二選一失誤

7. 數秒判斷規則

Bosniak III看厚壁、厚分隔與不規則；看到增強性實心結節，直接升IV。

8. 投資報酬率

高。可延伸至：

- Bosniak I、II、IIF、III、IV完整分類。
- CT與MRI的顯影判讀。
- 複雜腎囊腫與囊性腎細胞癌。
- 追蹤、主動監測及部分腎切除的選擇。

9. 國考答案與現代臨床差異

- 國考答案：D。
- 現代分類：增強性結節仍是Bosniak IV的核心特徵。
- 題目缺口：題幹只寫solid nodules，沒有明確說明結節是否顯影增強；嚴格套用Bosniak v2019時，必須確認enhancement，不能只憑「實心」兩字分類。
- 處置差異：Bosniak IV不等於所有患者立即接受根除性腎切除。2023年CUA指引建議，≤2 cm病灶可優先考慮主動監測；2–4 cm可監測或手術；>4 cm則通常以手術切除為優先。本題5.5 cm，若確認為IV且患者適合手術，通常傾向切除，能保留腎元時優先考慮部分腎切除。CUA 2023複雜腎囊腫指引

醫學（五）Q68

對話詳解原文

1. 題目

關於男性外陰部動脈血流來源，下列敘述何者錯誤？

- A. 內髂（internal iliac）動脈分支上膀胱（superior vesical）動脈，供應輸精管（vas deferens）
- B. 內髂（internal iliac）動脈分支臍（umbilical）動脈，供應提睪肌（cremaster）
- C. 外髂（external iliac）動脈分支下腹壁（inferior epigastric）動脈，供應提睪肌
- D. 主動脈（aorta）分支睪丸（testicular）動脈，供應睪丸

題目核對自考選部醫學（五）正式試題。

2. 作答對照

- 使用者作答：C
- 考選部原始答案：B
- 最終更正答案：B
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始答案與最終更正答案一致。

3. 核心考點

睪丸及精索具有三組主要動脈來源：

- **睪丸動脈：**腹主動脈。
- **輸精管動脈：**通常來自上膀胱動脈，少數來自下膀胱動脈；屬內髂系統。
- **提睪肌動脈：**下腹壁動脈；屬外髂系統。

因此B把臍動脈錯配給提睪肌；C反而是正確敘述。

4. 各選項解析

A. 上膀胱動脈供應輸精管——正確

輸精管動脈又稱deferential artery：

- 通常由上膀胱動脈發出。
- 上膀胱動脈通常源自臍動脈近端仍開放的部分。
- 沿輸精管走行。
- 可與睪丸動脈及提睪肌動脈形成吻合。

部分個體可由下膀胱動脈等其他內髂分支發出，但不影響A作為標準解剖敘述。

B. 臍動脈供應提睾肌——錯誤，為本題答案

臍動脈近端可發出上膀胱動脈，間接連結到輸精管動脈系統；它不是提睾肌動脈的標準來源。

提睾肌真正需要配對的是：

> 外髂動脈 → 下腹壁動脈 → 提睾肌動脈。

B可能是把「臍動脈—上膀胱動脈—輸精管」路徑錯接到提睾肌。

C. 下腹壁動脈供應提睾肌——正確

提睾肌動脈又稱external spermatic artery，通常由下腹壁動脈發出，伴隨精索通過腹股溝管，供應：

- 提睾肌。
- 精索被膜。
- 部分睾丸及副睾周圍組織。

解剖文獻也明確記載，提睾肌動脈經下腹壁動脈源自外髂系統。陰囊與睾丸血管解剖回顧

因此你所選的C本身是正確敘述；問題在於題目問的是「何者錯誤」。

D. 腹主動脈發出睾丸動脈——正確

睾丸動脈通常直接起自腹主動脈，約在腎動脈稍下方，經後腹膜下降後進入腹股溝管及精索。

這個高位起源可由胚胎時期睾丸自後腹壁下降理解：血管起點保留在腹主動脈，而不是隨睾丸下降至骨盆。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測，這題不像單純不會解剖：

- C確實是正確的解剖路徑。
- 你可能辨識出「提睾肌動脈來自下腹壁動脈」，便直接選C。
- 但題幹要求找的是「錯誤」敘述。

若當時是懷疑C中「外髂動脈分支下腹壁動脈」的層級表達，仍應再檢查B：

> 臍動脈與提睾肌之間沒有標準直接供血配對。

6. 失分類型

- 題幹正反向未轉換
- 「何者錯誤」漏看
- 血管來源配對
- 內髂與外髂系統
- 複合解剖路徑
- 正確知識套入錯誤作答方向

7. 數秒判斷規則

睪丸找腹主動脈，輸精管找膀胱動脈，提睪肌找下腹壁動脈；選答案前再看題幹問對還是問錯。

8. 投資報酬率

高。可同時延伸至：

- 睪丸扭轉後的血流評估。
- 隱睪手術及Fowler–Stephens procedure。
- 腹股溝疝修補時的精索血管保護。
- 睪丸動脈、輸精管動脈與提睪肌動脈的吻合。
- 內髂與外髂動脈分支。

9. 最新證據與國考 / 現代臨床差異

- 國考答案：B。
- 現代解剖：核心配對沒有改變，C仍是標準正確敘述。
- 個體差異：輸精管動脈的來源可有變異，不一定全部由上膀胱動脈發出；A是最常見的標準化表達。
- 手術意義：睪丸具有多重吻合血流，但不代表其中任一條血管均可任意犧牲；實際風險取決於手術位置、既往手術及側枝循環是否完整。睪丸動脈與側枝循環回顧

醫學（五）Q71

對話詳解原文

1. 題目

一名28歲男性出現右側精索靜脈曲張，醫師懷疑其靜脈回流途徑受阻。下列何者為右側睪丸的正常靜脈回流血管？

- A. 下腔靜脈（inferior vena cava）
- B. 右腎靜脈（right renal vein）
- C. 右外髂靜脈（right external iliac vein）
- D. 右下腹壁靜脈（right inferior epigastric vein）

2. 作答對照

- 使用者作答：C
- 考選部原始答案：A
- 最終更正答案：A
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始及最終更正答案均為A。

3. 核心考點

睪丸靜脈具有重要的左右不對稱：

- **右睪丸靜脈 → 下腔靜脈。**
- **左睪丸靜脈 → 左腎靜脈。**

這也解釋為何精索靜脈曲張遠較常發生於左側。

4. 各選項解析

A. 下腔靜脈——正確

睪丸內的小靜脈匯入蔓狀靜脈叢（pampiniform plexus），向上逐漸合併成睪丸靜脈。

右睪丸靜脈通常：

- 在後腹膜中上行。
- 於右腎靜脈下方。
- 直接注入下腔靜脈的前外側。

近期解剖研究中，右側內精索靜脈直接注入下腔靜脈仍是最常見型態。右側內精索靜脈解剖研究

B. 右腎靜脈——不是通常路徑

左睪丸靜脈注入左腎靜脈；右側通常不經右腎靜脈。

確實存在右睪丸靜脈注入右腎靜脈的解剖變異，資料估計約占少數個體，但題目問的是正常典型回流，因此仍選A。腎靜脈解剖與變異

C. 右外髂靜脈——錯誤

外髂靜脈主要接收下肢及前腹壁的靜脈回流，不是睪丸主要靜脈的正常終點。

精索及陰囊還存在：

- 提睪肌靜脈。
- 輸精管靜脈。
- 陰囊前後靜脈。
- 與腹壁、骨盆靜脈的側枝交通。

因此部分血液可以透過側枝進入髂靜脈系統，但不能把這些側枝當成右睪丸靜脈的標準主幹回流。

D. 右下腹壁靜脈——錯誤

下腹壁靜脈是前腹壁靜脈，最後進入外髂靜脈。它可能與提睪肌周圍靜脈存在交通，但不是睪丸主靜脈的正常終點。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測，選C可能是：

- 把睪丸已下降到陰囊的位置，直覺連到鄰近的外髂系統。
- 把提睪肌、陰囊或精索側枝靜脈當成睪丸主靜脈。
- 沒有以胚胎起源理解睪丸血管仍回到後腹膜高位。

這和睪丸動脈源自腹主動脈是同一套胚胎邏輯：

> 睪丸雖然下降至陰囊，主要動靜脈仍沿後腹膜回到高位大血管。

6. 失分類型

- 核心解剖知識缺口
- 左右不對稱路徑
- 主幹回流與側枝回流混淆
- 外髂靜脈錯置
- 胚胎下降與血管來源未連結
- 解剖結構—功能關係
- 二選一失誤

7. 數秒判斷規則

右睪丸靜脈直入IVC；左睪丸靜脈先進左腎靜脈。記成「右直、左轉」。

8. 投資報酬率

高。可延伸至：

- 左側精索靜脈曲張較常見的原因。
- Nutcracker syndrome。
- 腎細胞癌腫瘤栓與性腺靜脈回流。
- 後腹膜手術及性腺靜脈栓塞。
- 突發右側精索靜脈曲張的評估。

9. 最新指引支持與國考 / 現代臨床差異

- 國考答案：A。
- 現代解剖：仍一致；右睪丸靜脈通常直接進入下腔靜脈，左側進入左腎靜脈。
- 解剖變異：少數右睪丸靜脈可注入右腎靜脈、重複睪丸靜脈或其他側枝，不能把「通常路徑」寫成無例外。
- 臨床傳統：過去常認為所有孤立右側精索靜脈曲張都要進行腹部影像，以排除腎癌或後腹膜腫塊。
- 現代指引：AUA / ASRM不建議僅因小型或中型的孤立右側精索靜脈曲張便常規進行腹部影像；若為新發、巨大、平躺不消退或不可復位，才應依臨床判斷評估腹膜後或下腔靜脈病變。AUA / ASRM男性不孕症指引

醫學（五）Q72

對話詳解原文

1. 題目

35歲男性跌倒後左肩劇痛、無法活動。軸位電腦斷層影像如題本所示。下列何者最適當？

- A. 這是最常見的盂肱關節脫位
- B. 這類患者較容易傷到前側肩盂，而不是後側肩盂
- C. 治療前肩關節無法外旋
- D. 大多數患者需要緊急手術

題目及影像核對自考選部醫學（五）正式試題。

2. 作答對照

- 使用者作答：A
- 考選部原始答案：C
- 最終更正答案：C
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始答案與最終更正答案一致。

3. 核心考點

軸位CT顯示肱骨頭位於肩盂後方，屬於**後方肩關節脫位**。

典型表現：

- 上臂固定於內收、內旋。
- 肩關節外旋明顯受限或完全無法外旋。
- 可能合併後側盂唇 / 肩盂損傷。
- 肱骨頭前內側可出現reverse Hill-Sachs lesion。

因此C最適當。

4. 各選項解析

A. 最常見的肩關節脫位——錯誤

最常見的是**前方脫位**，約占絕大多數肩關節脫位；後方脫位相對少見，也較容易漏診。

本題不能只套用「肩關節脫位最常是前方」的盛行率知識，而要先依CT判斷這名患者實際是哪個方向。

B. 較易傷到前側肩盂——錯誤

後方脫位主要可能造成：

- 後側盂唇撕裂，即reverse Bankart lesion。
- 後側肩盂骨折或缺損。
- 肱骨頭前內側壓迫性缺損，即reverse Hill-Sachs lesion。

所以把前側肩盂列為主要受傷位置，方向相反。

C. 治療前無法外旋——正確

後方脫位時，肱骨頭被鎖在肩盂後方，患肢通常維持內收、內旋；被動外旋會受到機械性阻擋。

臨床上，「無法外旋」是區分後方脫位的重要體徵。後方脫位也常因正位X光不明顯而漏診，腋下片、scapular-Y view或CT可協助確認。後方肩關節脫位臨床整理

D. 大多數需要緊急手術——錯誤

急性、單純且可復位的後方脫位，通常先在適當鎮靜或麻醉下進行**緊急閉鎖復位**，不等於大多數都需開刀。

較可能需要手術者包括：

- 閉鎖復位失敗或鎖定型脫位。
- 合併顯著骨折。
- 大範圍reverse Hill-Sachs缺損。
- 復位後仍不穩定。
- 延遲診斷的慢性脫位。

治療選擇須依脫位時間、骨缺損比例及穩定性決定；急性病例通常仍先嘗試閉鎖復位。後方肩關節脫位治療回顧

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選A可能是記得「前方肩關節脫位最常見」，卻沒有先利用題目提供的軸位CT判斷個案方向。

也可能在軸位影像上未先定位肩盂，因而沒有看出：

> 肱骨頭位於肩盂後方 = 後方脫位。

這屬於一般盛行率印象壓過個案高權重影像證據。

6. 失分類型

- 影像方向定位
- 高權重影像特徵未優先使用
- 一般盛行率與個案診斷混淆
- 前方 / 後方肩關節脫位
- Reverse Bankart與reverse Hill-Sachs

- 結構位置與活動限制未連結

7. 數秒判斷規則

軸位CT先找肩盂：肱骨頭在肩盂後面就是後脫位；患肢鎖在內旋，所以外旋不出去。

8. 投資報酬率

高。

可延伸至：

- 前方與後方肩關節脫位影像。
- Hill-Sachs與reverse Hill-Sachs。
- Bankart與reverse Bankart。
- 癲癇、電擊與後方脫位。
- 骨缺損大小對手術選擇的影響。
- 容易漏診的肩部創傷。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**C。
- **現代臨床：**後方脫位造成固定內旋及外旋受阻，與國考一致。
- **影像策略：**若普通正位片無法解釋明顯活動受限，應補腋下片、Y-view或CT。
- **治療措辭：**需要緊急處理不等於需要緊急手術；多數急性、無複雜骨折病例先嘗試閉鎖復位。
- **手術決策：**還要考慮reverse Hill-Sachs缺損比例、脫位持續時間及復位後穩定性，不能只依「後方脫位」四字決定。

醫學（五）Q75

對話詳解原文

1. 題目

關於外傷的敘述，下列何者最不適當？

- A. 最常造成外傷的機轉是鈍傷
- B. 頭皮、臉部傷口因表皮細菌較多，較容易細菌感染
- C. 殘留於傷口內的鐵片，大多數可在X光影像中看出
- D. 下肢傷口比上肢傷口容易感染

2. 作答對照

- 使用者作答：A
- 考選部原始答案：B
- 最終更正答案：B
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始及最終更正答案均為B。

3. 核心考點

傷口感染風險不能只看表皮菌量，還要考慮：

- 局部血流灌注。
- 傷口位置。
- 污染程度。
- 組織破壞與異物。
- 傷口長度。
- 糖尿病及免疫狀態。

頭皮與臉部血流豐富，臨床感染率通常較低；下肢傷口則是較明確的感染高風險位置。

4. 各選項解析

A. 鈍傷是最常見外傷機轉——國考判定適當

在一般創傷流行病學中，跌倒、碰撞及交通事故造成的鈍傷占主要比例，穿刺傷、槍傷等穿透傷相對較少。

A的「外傷」缺乏特定族群、地區及照護場域，措辭確實寬泛；但作為一般國考概括敘述仍可接受，不是四項中最明確的錯誤。

B. 頭皮及臉部較容易感染——錯誤，為本題答案

頭皮及臉部可能具有正常菌叢，但不能直接推出臨床感染率較高。

頭頸部組織血流豐富，通常具有：

- 較好的免疫細胞及抗生素輸送。
- 較佳的氧合與修復能力。
- 相較下肢更低的創傷性傷口感染風險。

前瞻性多中心研究顯示，下肢位置、糖尿病、污染及較長傷口會提高感染風險；頭頸部傷口的感染率反而較低。創傷性撕裂傷感染風險研究

C. 鐵片多可由X光發現——適當

金屬通常具有高放射密度，多數可在普通X光中看見。

但仍可能受以下因素影響：

- 異物非常細小。
- 與骨骼或其他高密度結構重疊。
- 攝影角度不佳。
- 異物位置太深或接近關節。

必要時可追加不同角度X光、超音波或CT。金屬、玻璃及石材通常是放射不透性異物；木材與部分塑膠較容易在X光中漏掉。軟組織異物影像回顧

D. 下肢傷口較容易感染——適當

下肢傷口感染風險較高，可能與下列因素有關：

- 相對較差的局部灌流。
- 靜脈或淋巴回流問題。
- 水腫。
- 污染機會較高。
- 糖尿病及周邊動脈疾病較容易在下肢表現。
- 傷口承受活動張力。

因此D比B更符合臨床傷口感染風險分布。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選A可能是注意到「最常造成外傷」缺乏分母與適用範圍，因此質疑其過度概括。這項語意質疑並非毫無道理。

但B存在更直接的因果錯誤：

> 表皮細菌較多，不等於傷口感染率一定較高。

頭皮與臉部的良好血流會明顯改變臨床結果。答題時應先找出與已知感染風險方向直接相反的選項，再處理A這類範圍不精確的措辭。

6. 失分類型

- 危險因子與臨床結果混淆
- 細菌定殖與感染混淆
- 傷口位置風險
- 局部血流與感染
- 可爭議措辭壓過決定性錯誤
- 選項成立強度排序
- 二選一失誤

7. 數秒判斷規則

臉和頭皮血流旺，感染通常較低；下肢血流與回流較差，感染較高。菌多不等於一定較會感染。

8. 投資報酬率

高。

可延伸至：

- 傷口感染高風險因子。
- 是否需要預防性抗生素。
- 異物的X光、超音波及CT選擇。
- 臉部傷口縫合時限。
- 咬傷、穿刺傷及開放性骨折。
- 糖尿病與周邊血管疾病的傷口風險。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**B。
- **現代臨床：**頭頸部撕裂傷感染率通常較低、下肢較高，核心方向一致。
- **重要區分：**皮膚菌叢、傷口定殖及真正侵入性感染是不同概念。
- **A項限制：**「外傷」範圍太廣；不同國家、年齡與創傷中心的機轉分布不同，但一般整體創傷仍以鈍傷為主。
- **抗生素策略：**不能只因傷口位於下肢便一律使用抗生素；仍須結合污染、組織損傷、異物、宿主狀況及是否為咬傷等因素判斷。

醫學（五）Q76

本次補寫版 2026-10-07

主題：安全帶傷與Chance骨折的腹部合併傷

本次補寫版，2026年10月7日完成。原始詳解尚未回收；以下依正式試題、原始答案、最終更正及所列醫學來源重建。

題目與答案對照

一位48歲司機有繫安全帶，在高速公路發生車禍，身體檢查發現病人意識清楚，血壓126/82 mmHg，心跳86/min，腹部有一帶狀瘀傷，X光發現第一腰椎有Chance fracture，則病人那個器官最可能受到傷害？

- A. 降主動脈
- B. 胃
- C. 脾臟
- D. 十二指腸

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
C	D	D	無；本題未列於更正備註

參考來源：考選部正式試題；考選部原始答案；考選部最終更正檔。

個人作答取自本對話已保存的80題作答序列；以上三份官方檔案均於本次補寫重新核對。

核心考點

腹部安全帶痕＋胸腰椎Chance骨折，要優先警覺安全帶相關的空腔臟器及腸繫膜損傷。Chance骨折是屈曲牽張型傷害；身體繞安全帶支點彎曲時，腹內結構也會承受壓迫與剪力。

四個選項中，十二指腸是最符合此機轉的答案。它部分位於後腹膜、相對固定，可因壓迫與剪力出現挫傷、壁內血腫或穿孔。血壓及心跳暫時穩定，不足以排除這類傷害。

各選項解析

A．降主動脈——不是本題最典型配對

高速減速確實可能造成主動脈損傷，但通常須結合胸部機轉、影像與其他線索。本題更具辨識力的腹部安全帶痕與Chance骨折，指向腸道／腸繫膜相關傷害。

B．胃——可能受傷，但相對不是最佳答案

強烈腹部鈍傷可造成胃破裂，尤其在胃擴張的情形；然而胃不是這組安全帶與Chance骨折線索最典型的國考配對。

C．脾臟——常見鈍傷器官，仍不是本題最佳

脾臟是腹部鈍傷常見受傷器官，也可以合併於安全帶傷。不能因它普遍常見，就蓋過本題特殊機轉所提示的空腔臟器風險。

本題並非宣稱安全帶痕患者不會脾傷；只是四個選項中要以D作為最佳答案。

D．十二指腸——正確

十二指腸可被壓向脊柱並承受剪力；合併Chance骨折時要特別警覺。後腹膜損傷的初期腹膜刺激徵象可能不突出，症狀與影像可能隨時間演變。

WSES腸道創傷指引把安全帶痕視為需要提高腸道損傷警覺的重要線索；評估不能只停在一組正常生命徵象。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是優先套用「腹部鈍傷常見脾損傷」，沒有把安全帶痕與L1 Chance骨折整合成一個特殊傷害機轉。

這是複習用的可能解釋，不能據此確認你作答當時的實際思路。

失分類型

- 一般盛行率與個案機轉
- 空腔臟器與實質器官
- 正常生命徵象不能排除延遲表現

數秒判斷規則

> **安全帶痕加Chance骨折，要查腸道與腸繫膜；本題四選一抓十二指腸，不能只背最常見脾傷。**

投資報酬率

高。可延伸至腹部鈍傷、後腹膜傷害、腸道穿孔及創傷影像與觀察。

國考答案與現代臨床差異

- 國考D是這四個選項的機轉配對；不能延伸成十二指腸在所有安全帶傷系列中都一定是最常受傷器官。
- 真實個案要評估整段腸道、腸繫膜及其他腹內器官，不只找十二指腸。
- 對初始影像不確定但疑慮持續者，須依創傷團隊評估安排連續腹部檢查、觀察及必要的再影像；不能因第一次結果或生命徵象正常就宣告無傷。

補寫所用來源

- WSES 2022 腸道創傷指引
- Chance骨折臨床整理

醫學（四）Q2

對話詳解原文

1. 題目

貧血病人血液抹片發現有很多spherocytes，最不可能是下列何種疾病？

- A. ABO血型不合引起的溶血性貧血
- B. 自體免疫性溶血性貧血
- C. 遺傳性球形紅血球症
- D. G6PD缺乏症引起的溶血性貧血

題目核對自考選部醫學（四）正式試題。

2. 作答對照

- 使用者作答：A
- 考選部原始答案：D
- 最終更正答案：D
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始答案與最終更正答案一致。

3. 核心考點

大量spherocytes主要來自兩類機轉：

1. **紅血球膜骨架缺陷**

- 遺傳性球形紅血球症。

2. **抗體包覆後被脾臟巨噬細胞部分吞噬膜**

- 自體免疫性溶血性貧血。
- ABO不合等免疫性溶血。

G6PD缺乏是**氧化性傷害**，血液抹片的代表形態是：

- Heinz bodies：需超活體染色。
- Bite cells。
- Blister cells。
- Eccentrocytes。

因此「很多spherocytes」最不支持D。

4. 各選項解析

A. ABO血型不合——可能出現spherocytes

ABO不合造成抗體介導的溶血；尤其新生兒ABO溶血病，可見大量microspherocytes。

機轉是抗體附著紅血球後，脾臟巨噬細胞移除部分細胞膜，使表面積 / 體積比下降，紅血球逐漸變圓。

值得注意的是，新生兒ABO溶血的DAT不一定陽性；即使DAT陰性，血片仍可能看到microspherocytes。新生兒ABO溶血與血片表現

B. 自體免疫性溶血性貧血——典型出現spherocytes

以warm AIHA為例：

- IgG包覆紅血球。
- 脾臟巨噬細胞部分吞噬紅血球膜。
- 紅血球失去膜面積後成為spherocyte。
- 最終在脾臟發生血管外溶血。

典型檢查包括：

- Reticulocytosis。
- 間接膽紅素及LDH上升。
- Haptoglobin下降。
- DAT通常陽性。
- 血片可見spherocytes。

2025年ASH回顧仍把血片spherocytes列為AIHA的重要線索，並用其與以schistocytes為主的微血管病性溶血鑑別。ASH自體免疫性溶血性貧血回顧

C. 遺傳性球形紅血球症——最典型

常見膜骨架蛋白異常包括：

- Spectrin。
- Ankyrin。
- Band 3。
- Protein 4.2。

膜逐漸流失後，紅血球變成：

- 無中央蒼白區。
- 直徑偏小。
- MCHC可能升高。
- 滲透脆性增加。
- 通過脾臟時容易被滯留及破壞。

診斷除血片外，常搭配DAT及EMA binding test；HS通常DAT陰性，可藉此與免疫性溶血鑑別。遺傳性球形紅血球症病理與診斷

D. G6PD缺乏症——最不可能，為本題答案

G6PD不足使紅血球無法產生足夠NADPH及還原型glutathione，遇到感染、蠶豆或氧化性藥物後，血紅素變性形成Heinz bodies。

脾臟將Heinz body連同鄰近細胞膜咬掉後，形成bite cells；也常見blister cells。因此D與「大量spherocytes」的典型配對最弱。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選A可能是把spherocyte過度限定為：

- 遺傳性膜缺陷；或
- 自體免疫性溶血。

因而忽略ABO不合本身也是抗體介導的膜流失，尤其新生兒ABO溶血可出現microspherocytes。

相反地，G6PD缺乏應先連到：

> **氧化傷害 → Heinz body → bite / blister cell。**

6. 失分類型

- 紅血球形態分類
- 膜缺陷與酵素缺陷混淆
- 免疫性與氧化性溶血
- ABO不合的血片表現
- Spherocyte / bite cell / blister cell
- 病理機轉未優先使用
- 核心臨床知識缺口

7. 數秒判斷規則

> **球形細胞想膜被削掉：HS、AIHA、ABO；G6PD則背Heinz body被咬成bite cell。**

8. 投資報酬率

高。

可延伸至：

- 血管內與血管外溶血。
- DAT陽性及陰性溶血的鑑別。
- HS的EMA binding test。

- G6PD急性期酵素檢測偽陰性。
- Bite cell、schistocyte、target cell等血片配對。
- 新生兒ABO與Rh溶血差異。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**D。
- **現代血液學：**典型配對完全一致；G6PD以bite、blister cells及Heinz bodies為主。
- **形態限制：**單一形態不是絕對專屬。嚴重氧化性溶血經脾臟pitting後，也可能產生少數類球形細胞；題目用「很多spherocytes」及「最不可能」使D仍是最佳答案。
- **檢測限制：**急性G6PD溶血期間，高齡且酵素最低的紅血球已被清除，剩下網狀紅血球酵素活性較高，檢測可能暫時正常；高度懷疑時需在恢復期複驗。
- **HS與AIHA鑑別：**血片相似時，DAT及EMA binding比單靠形態可靠。

醫學（四）Q3

對話詳解原文

1. 題目

關於兒童第1型糖尿病及第2型糖尿病，下列敘述何者最適當？

- A. 第1型糖尿病病童比第2型糖尿病病童有較高比例的糖尿病家族史
- B. 第1型糖尿病病童在40歲後或肥胖後會轉變成第2型糖尿病
- C. 第1型糖尿病及第2型糖尿病病童均需要接受飲食控制及維持良好的運動習慣
- D. 兒童第1型糖尿病為先天性，而兒童第2型糖尿病是飲食異常及肥胖造成

2. 作答對照

- 使用者作答：A
- 考選部原始答案：C
- 最終更正答案：C
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始及最終更正答案均為C。

3. 核心考點

第1型與第2型糖尿病病理不同：

- **第1型：**自體免疫性β細胞破壞，造成絕對胰島素缺乏。
- **第2型：**胰島素阻抗合併逐漸發生的β細胞功能衰退。

但兩者均需要：

- 個人化營養治療。
- 規律運動。
- 體重與心血管風險管理。
- 糖尿病教育。
- 心理及家庭支持。

因此C是唯一完整正確的敘述。

4. 各選項解析

A. 第1型有較高比例家族史——錯誤

第1型糖尿病確實具有遺傳易感性，尤其與HLA相關；但多數新診斷兒童沒有第一等親的第1型糖尿病病史。

青年第2型糖尿病的家族聚集通常更明顯，常合併：

- 父母或手足有第2型糖尿病。
- 肥胖。
- Acanthosis nigricans。
- 高血壓或血脂異常。
- 高風險族群背景。

所以A把兩型糖尿病的家族史比例方向倒置。

B. 第1型會轉變成第2型——錯誤

第1型糖尿病不會因年齡增加或肥胖而「變成」第2型。

第1型患者日後可能同時出現：

- 肥胖。
- 胰島素阻抗。
- 高胰島素需求。
- 第2型糖尿病常見的代謝特徵。

這有時稱為double diabetes或mixed features，但原本的自體免疫性β細胞破壞仍然存在，不能描述成疾病轉型。

C. 兩型均需營養及運動管理——正確

第1型糖尿病的飲食管理重點並不是單純限制熱量，而是：

- 健康均衡飲食。
- 碳水化合物計算。
- 胰島素劑量與攝食量匹配。
- 運動前後調整胰島素及補充碳水化合物。
- 預防低血糖。

第2型則更強調：

- 減少高熱量及含糖飲料。
- 改善飲食品質。
- 增加身體活動。
- 改善體重及胰島素敏感性。

ADA 2026建議所有糖尿病兒童及青少年進行年齡適當的營養教育，並以每日至少60分鐘中高強度活動為一般目標。ADA 2026兒童與青少年糖尿病照護標準

D. 第1型先天、第2型由飲食及肥胖造成——錯誤

第1型不是「出生時就有」的先天性疾病；它通常在出生後因遺傳易感性與免疫 / 環境因素交互作用，逐步產生自體免疫性β細胞破壞。

第2型也不能簡化成「吃錯、變胖所造成」：

- 具有強烈遺傳背景。
- 不同族群風險不同。
- 青春期生理性胰島素阻抗會增加風險。
- 睡眠、社經環境、藥物及內分泌因素也可能參與。
- 並非每位肥胖兒童都會得到第2型糖尿病。

ISPAD 2024仍將營養及運動列為治療核心，但強調青年第2型糖尿病是多因子疾病，不能歸咎於個人意志或單一飲食因素。ISPAD 2024兒童第2型糖尿病指引

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選A可能是記得第1型糖尿病具有HLA及自體免疫遺傳背景，因此推論它比第2型更常具有糖尿病家族史。

問題在於：

- 有遺傳性，不等於臨床上家族史比例一定更高。
- 第2型糖尿病的家族聚集通常更強。
- C問的是兩型都成立的共同照護原則，不需先決定哪一型病理更典型。

6. 失分類型

- 第1型 / 第2型糖尿病分類
- 遺傳易感性與家族史比例混淆
- 疾病病因與共同治療原則混淆
- 自體免疫與胰島素阻抗
- 肥胖與疾病分類
- 複合選項判讀
- 核心臨床知識缺口

7. 數秒判斷規則

> **T1是自體免疫缺胰島素，T2是阻抗加分泌衰退；兩型都要飲食、運動和教育。家族史通常T2更強，T1不會胖一胖變T2。**

8. 投資報酬率

高。

可延伸至：

- T1DM與T2DM的兒童鑑別。
- Islet autoantibodies與C-peptide。
- DKA及ketosis-prone T2DM。
- Acanthosis nigricans。
- MODY及單基因糖尿病。
- 第1型糖尿病運動時的低血糖預防。
- 青年第2型糖尿病的metformin、GLP-1 RA及胰島素適應症。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**C。
- **現代指引：**營養、運動、教育及心理支持仍是兩型兒童糖尿病的共同照護核心。
- **「飲食控制」措辭：**現代較偏好「個人化營養治療」，避免被理解成一律節食；第1型兒童仍需足夠熱量以支持生長發育。
- **分類現實：**肥胖不能直接排除第1型；體型正常也不能完全排除第2型。必要時應結合自體抗體、C-peptide及臨床病程。
- **混合表現：**第1型患者可同時有胰島素阻抗，但不代表疾病轉變為第2型。
- **去污名化：**青年第2型糖尿病是遺傳、環境及代謝共同作用的結果，不宜只歸因於飲食失控。

醫學（四）Q4

對話詳解原文

1. 題目

關於急性細支氣管炎（acute bronchiolitis）之敘述，下列何者最適當？

- A. 病理機轉為細支氣管平滑肌收縮導致呼吸費力
- B. 聽診時可聽見wheezing及crackles
- C. 最重要的致病原為流行性感冒病毒
- D. 最主要的治療方式為吸入性抗病毒藥物

題目核對自考選部醫學（四）正式試題。

2. 作答對照

- 使用者作答：C
- 考選部原始答案：B
- 最終更正答案：B
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始答案與最終更正答案一致。

3. 核心考點

急性細支氣管炎主要是嬰幼兒的病毒性下呼吸道感染，病理核心為：

- 細支氣管上皮細胞壞死。
- 黏膜水腫。
- 分泌物及細胞碎屑造成小氣道阻塞。
- 呼氣期空氣滯留，嚴重時可有肺不張。

臨床聽診可以同時出現：

- Wheezing：小氣道狹窄。
- Fine crackles：細支氣管分泌物及遠端小氣道反覆開啟。

因此B最適當。

4. 各選項解析

A. 主要由平滑肌收縮造成——錯誤

這比較接近氣喘的核心生理機轉。

細支氣管炎主要是病毒感染造成小氣道：

- 發炎。
- 水腫。
- 上皮脫落。
- 黏液及細胞碎屑阻塞。

雖然氣道張力可能參與，但不是以可逆性平滑肌收縮為主要問題，因此常規給予albuterol等支氣管擴張劑通常無明確效益。

B. 可聽到wheezing與crackles——正確

典型病程是先有：

- 流鼻水。
- 鼻塞。
- 輕微發燒。
- 咳嗽。

之後出現：

- Tachypnea。
- 胸壁凹陷。
- Wheezing。
- Crackles。
- 餵食困難；年幼嬰兒可能呼吸暫停。

NICE及2025年澳洲—紐西蘭指引均把wheeze、crackles或兩者並存列為臨床診斷的重要聽診表現。NICE細支氣管炎指引、Australasian Bronchiolitis Guideline 2025

C. 最重要病原為influenza virus——錯誤

最重要且最常見的病原是**呼吸道融合病毒（RSV）**。

其他可能病原包括：

- Rhinovirus。
- Human metapneumovirus。
- Parainfluenza virus。
- Adenovirus。
- Influenza virus。
- Coronavirus。

所以influenza可以造成細支氣管炎，但不是最主要病原。AAP的臨床整理仍將RSV列為最常見致病原。AAP Pediatric Care Online

D. 主要治療是吸入性抗病毒藥——錯誤

治療核心是**支持性照護**：

- 維持足夠氧合。
- 鼻腔分泌物處理。
- 維持水分與餵食。
- 必要時鼻胃管或靜脈補液。
- 嚴重病例使用high-flow nasal cannula、CPAP或呼吸器。

不建議常規使用：

- 支氣管擴張劑。
- 類固醇。
- 抗生素。
- 胸部物理治療。
- 吸入性抗病毒藥。

Aerosolized ribavirin僅在極少數特殊重症或嚴重免疫低下患者個別考慮，並非一般細支氣管炎的主要治療。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選C可能是把「冬季病毒性呼吸道感染的重要病原」直接連到influenza，沒有先依年齡與疾病層級分類：

- Influenza：可造成全身症狀、上呼吸道或肺炎。
- RSV：嬰幼兒細支氣管炎最典型病原。

也可能沒有把「wheeze與crackles可同時存在」視為細支氣管炎的典型組合。

6. 失分類型

- 病原與疾病配對
- RSV與influenza混淆
- 上下呼吸道疾病分類
- 小氣道病理機轉
- Wheezing / crackles聽診判讀
- 支持性治療與特效治療混淆
- 核心臨床知識缺口

7. 數秒判斷規則

嬰兒流鼻水後喘鳴 + crackles = bronchiolitis；病原先選RSV，機轉是水腫黏液堵塞，治療以氧氣與補液支持。

8. 投資報酬率

高。

可延伸至：

- Bronchiolitis與氣喘鑑別。
- RSV預防的nirsevimab及母體疫苗。
- 氧氣及high-flow nasal cannula適應症。
- 不建議常規使用的藥物。
- 年幼嬰兒呼吸暫停風險。
- 何時住院及何時進加護病房。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**B。
- **現代臨床：**wheezing與crackles均為典型聽診表現，完全一致。
- **病原差異：**RSV仍是最重要病原，但臨床通常不需為單純病例常規確認病毒種類，因結果多半不改變治療。
- **支氣管擴張劑：**目前仍不建議常規試用；若年齡較大、反覆喘鳴或有明顯氣喘表型，診斷本身可能已不是典型首次細支氣管炎。
- **2025指引例外：**對重症加護病例，合併epinephrine與dexamethasone可在特定情境考慮，但證據確定性有限，不能外推為一般治療。
- **抗病毒藥：**預防策略進展很快，但已感染後的標準治療仍以支持療法為主。

醫學（四）Q5

對話詳解原文

1. 題目

關於痙攣性雙側麻痺（spastic diplegia）的描述，下列何者最不適當？

- A. 是所有腦性麻痺中最常見之型態
- B. 肢體障礙通常上肢比下肢嚴重
- C. 早產兒的腦室旁白質軟化症是常見致病因
- D. 要注意兒童的動作發展，尤其是爬行動作

2. 作答對照

- 使用者作答：A
- 考選部原始答案：B
- 最終更正答案：B
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始及最終更正答案均為B。

3. 核心考點

Diplegia的核心定義就是：

> **雙側肢體受影響，但下肢明顯重於上肢。**

典型表現包括：

- 下肢spasticity。
- Hip adduction與內旋。
- Scissoring gait。
- Toe walking或crouch gait。
- 上肢功能相對保留。
- 早產及periventricular white matter injury / PVL病史。

因此B把上下肢嚴重度完全寫反，是最明確錯誤。

4. 各選項解析

A. 是最常見型態——國考判定可接受，但措辭不夠精確

傳統教科書常把spastic diplegia列為最常見或極常見的腦性麻痺臨床型態，尤其與早產存活兒的periventricular white matter injury密切相關。

但現代分類較常使用：

- Spastic unilateral CP。
- Spastic bilateral CP。
- Dyskinetic CP。
- Ataxic CP。

再搭配GMFCS描述功能，而不只使用diplegia、hemiplegia、quadriplegia。不同族群中究竟哪一個傳統亞型「最常見」也會不同。

所以A不是漂亮的現代敘述，但B在定義層級就直接錯誤，仍應選B。

B. 上肢比下肢嚴重——錯誤，為本題答案

Spastic diplegia的下肢受累大於上肢；上肢可能：

- 完全正常。
- 只有輕微精細動作問題。
- 在快速動作時顯示輕度異常。

若上肢與下肢均嚴重受影響，或上肢更嚴重，就不符合典型diplegia分布。CanChild同樣將diplegia定義為腿部受累大於手臂。CanChild腦性麻痺功能分類說明

C. 早產兒PVL是常見病因——正確

早產兒腦室旁白質特別脆弱，可能因：

- 缺血及灌流不穩。
- 發炎。
- 未成熟寡樹突膠細胞受損。
- 腦室內出血相關損傷。

造成PVL或較廣義的periventricular white matter injury。

下肢皮質脊髓束纖維在腦室旁走行較接近，因此容易出現下肢重於上肢的痙攣性雙側麻痺。NICE也將PVL列為評估腦性麻痺病因時的重要白質損傷型態。NICE腦性麻痺評估與管理指引

D. 注意爬行等動作發展——適當，但現代評估不只看爬行

可能出現的早期警訊包括：

- 翻身、坐立或爬行延遲。
- 以雙上肢拖動身體、下肢較少交替。
- Bunny hopping。
- 下肢僵硬或交叉。
- 扶站時踮腳。
- 動作發展不對稱或停滯。

但現代早期偵測不應只等到爬行異常。高風險嬰兒可使用：

- General Movements Assessment。
- Hammersmith Infant Neurological Examination。
- 標準化運動發展量表。
- 腦部MRI。

AACPDM強調應在明確功能障礙出現前積極辨識高風險兒童，不建議採取「等等看」策略。
AACPDM腦性麻痺早期偵測路徑

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選A可能是注意到：

- 現代腦性麻痺分類不再強調diplegia。
- 「所有腦性麻痺中最常見」的絕對措辭可能依族群而異。

這個質疑合理，但B有更直接的定義性錯誤：

> **Diplegia = 腿比手嚴重；B卻寫成手比腿嚴重。**

這再次出現「精細措辭爭議壓過決定性錯誤」的模式。

6. 失分類型

- 腦性麻痺肢體分布
- Diplegia定義
- 上下肢嚴重度方向顛倒
- 早產與PVL
- 解剖結構—功能關係
- 現代分類與傳統術語
- 可爭議措辭壓過明確錯誤
- 二選一失誤

7. 數秒判斷規則

> **Diplegia先看兩條腿：下肢重、上肢輕；早產 + PVL最典型。看到「上肢比下肢嚴重」直接刪。**

8. 投資報酬率

高。

可延伸至：

- Spastic unilateral / bilateral CP。

- PVL與早產兒腦傷。
- GMFCS。
- General Movements Assessment與HINE。
- Scissoring、equinus及crouch gait。
- 髖關節監測。
- Botulinum toxin、矯具、選擇性背根切斷術及骨科手術。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**B。
- **現代臨床：**雙側痙攣型腦性麻痺仍以下肢受累較重為核心，與國考一致。
- **A項限制：**現代流行病學通常先說spastic CP是最常見大類；spastic diplegia是否為所有傳統亞型中最常見，依定義與族群而異。
- **術語更新：**現代較常用spastic bilateral CP加GMFCS功能分級，而不完全依diplegia等舊式地形術語。
- **病因表達：**PVL是重要影像—病理關聯，但並非看到PVL就必然發展成spastic diplegia。
- **早期診斷：**不應等到爬行或走路異常才評估；高風險早產兒可更早以標準化神經及動作工具追蹤。

醫學（四）Q6

對話詳解原文

1. 題目

有一個寶寶在1歲10個月時因川崎氏症而接受高劑量（2 g/kg）免疫球蛋白注射，今日滿2歲3個月。若想要注射日本腦炎活性減毒疫苗，下列建議何者最為適當？

- A. 今日可以注射
- B. 今日不可以注射，建議下個月再注射
- C. 今日不可以注射，建議再過3個月就可以注射
- D. 今日不可以注射，建議再過6個月就可以注射

題目核對自考選部醫學（四）正式試題。

2. 作答對照

- 使用者作答：C
- 考選部原始答案：D
- 最終更正答案：D
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始答案與最終更正答案一致。

3. 核心考點

高劑量靜脈注射免疫球蛋白可能以被動抗體中和活性疫苗病毒，使疫苗免疫反應不足。

臺灣接種指引規定：

> 接受高劑量IVIG（≥1 g/kg）後，MMR、水痘及活性減毒日本腦炎疫苗須間隔11個月。

本題已經過：

- 1歲10個月 → 2歲3個月 = 5個月。
- 還需等待：11 - 5 = 6個月。

因此選D。

4. 各選項解析

A. 今日接種——錯誤

距離2 g/kg IVIG僅5個月，尚未達11個月。此時接種並非主要擔心安全性，而是被動抗體可能干擾疫苗病毒複製，導致免疫效力不足。

B. 下個月接種——錯誤

再等1個月後，總間隔只有6個月，仍不足11個月。

「6個月」較容易與輸血或部分血液製品後的接種間隔混淆，不能直接套用於川崎病使用的2 g/kg高劑量IVIG。

C. 再過3個月——錯誤

再過3個月，總間隔為8個月，仍不足11個月。

這也是使用者所選答案；問題不是完全沒有考慮延後，而是低估了高劑量IVIG需要的完整等待期。

D. 再過6個月——正確

目前已過5個月，再等6個月後恰為11個月，符合臺灣現行接種間隔指引。

疾管署的專業接種表明確將MMR、水痘及活性減毒JE疫苗列入高劑量IVIG後須延後11個月的疫苗。
臺灣疾管署各項預防接種間隔表

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選C可能是知道高劑量IVIG後不能立即接種活性疫苗，但：

- 將等待期記成8個月；或
- 只計算「還要等多久」，未先算出目前已過5個月；或
- 把不同血液製品的3、6、11個月間隔混在一起。

6. 失分類型

- 疫苗與免疫球蛋白交互作用
- 活性與非活性疫苗分類
- 不同血液製品等待期混淆
- 年齡差換算
- 題幹時間軸未完整轉換
- 國考記憶點

7. 數秒判斷規則

高劑量IVIG後，MMR / 水痘 / 活性JE背11個月；題目已過5個月，所以再等6個月。

8. 投資報酬率

高。

可延伸至：

- 一般IMIG、輸血與高劑量IVIG的不同間隔。
- 活性疫苗與非活性疫苗。
- 活性疫苗彼此未同日接種時的間隔。

- 川崎病IVIG後的疫苗安排。
- 過早接種時是否需重新接種。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**D。
- **臺灣現行指引：**仍是高劑量IVIG後間隔11個月再接種MMR、水痘或活性減毒JE疫苗，與國考一致。
- **機轉重點：**主要是避免被動抗體降低疫苗效力，不是因活性JE疫苗必然造成嚴重不良反應。
- **不可過度延伸：**並非所有疫苗都須等待11個月；非活性疫苗通常不受同等程度影響，部分活性疫苗亦有不同規則。
- **實務處理：**若曾在建議間隔前誤接種，是否重打及重打時點應依疫苗種類、接種指引與實際血液製品重新評估。

醫學（四）Q7

對話詳解原文

1. 題目

下列何種狀況最容易造成Apgar score的偽陰性？

- A. 母親被給予magnesium sulfate過後出生的新生兒
- B. 新生兒先天性肌肉病變（congenital myopathy）
- C. 胎兒的血液中catecholamine過高者
- D. 早產兒

2. 作答對照

- 使用者作答：A
- 考選部原始答案：C
- 最終更正答案：C
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始及最終更正答案均為C。

3. 核心考點

若把「低Apgar」視為篩檢胎兒缺氧 / 酸血症的陽性結果：

- **偽陽性：**沒有真正窒息，卻因其他因素得到低分。
- **偽陰性：**確有缺氧或酸血症，出生後卻仍顯得有活力、Apgar不低。

高catecholamine是胎兒面對缺氧與生產壓力的重要代償反應，可能暫時維持：

- 心率與血壓。
- 呼吸驅動。
- 肌張力及反射反應。
- 周邊循環與出生轉換。

因此酸血症胎兒仍可能具有尚可的Apgar，形成偽陰性。

4. 各選項解析

A. 母親使用magnesium sulfate——較容易造成偽陽性

胎盤暴露於較高濃度magnesium後，新生兒可能出現：

- 暫時性肌張力低下。
- 反射下降。

- 呼吸抑制或活力較差。

即使沒有嚴重缺氧，Apgar的tone、reflex或respiration項目也可能偏低。因此比較像「無窒息但分數低」的偽陽性，而非偽陰性。

B. 先天性肌肉病變——較容易造成偽陽性

先天性肌病可能使新生兒：

- 肌張力低。
- 自主動作少。
- 哭聲弱。
- 呼吸肌無力。
- 反射反應下降。

這些表現會降低Apgar，但不能直接證明胎兒窒息，同樣屬於使分數非特異性偏低的因素。

C. Catecholamine過高——正確，最可能造成偽陰性

胎兒缺氧時，交感—腎上腺反應可使catecholamine上升，短暫支持心血管功能及出生後活力。

因此可能出現：

> 臍動脈酸血症存在，但Apgar仍不差。

人體研究顯示，Apgar主要反映新生兒當下活力，並不足以單獨判定胎兒是否存在酸血症或窒息。胎兒catecholamine與Apgar研究

D. 早產——較容易造成偽陽性

早產兒即使沒有嚴重窒息，也可能因生理成熟度不足而出現：

- 肌張力較低。
- 反射較弱。
- 呼吸不規則。
- 膚色較不易迅速轉紅。

所以早產會使Apgar偏低，但這不一定代表缺氧性腦病變。

ACOG與AAP亦指出，Apgar會受妊娠週數、母體藥物、復甦處置及心肺、神經疾病影響，不能單獨作為窒息證據。ACOG / AAP Apgar Score說明

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選A可能是正確想到magnesium sulfate會使新生兒活力與肌張力下降，卻把「分數被壓低」誤稱為偽陰性。

本題必須先定義方向：

- Magnesium、肌病、早產：沒窒息也可能低分 = 偽陽性。

- 高catecholamine：有酸血症仍可能高分 = 偽陰性。

6. 失分類型

- 評估工具與所測構念混淆
- 偽陽性 / 偽陰性方向顛倒
- Apgar與胎兒窒息混用
- 母體藥物對新生兒活力的影響
- 早產兒Apgar限制
- Catecholamine代償反應
- 替代指標與真正病理狀態混淆

7. 數秒判斷規則

> **先把低Apgar當「陽性」：鎂、肌病、早產會無窒息也低分，是偽陽性；高catecholamine能遮住酸血症，是偽陰性。**

8. 投資報酬率

高。

可延伸至：

- Apgar五項與評分方式。
- Apgar不能單獨診斷窒息。
- 臍動脈血氣與base deficit。
- 新生兒腦病變及低溫治療條件。
- 早產及母體藥物造成的評分偏差。
- 篩檢工具的偽陽性與偽陰性。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**C。
- **現代生理學：**高catecholamine可能使酸血症胎兒仍呈現較好的出生後活力，核心方向成立。
- **重要限制：**高catecholamine並不保證Apgar一定正常；嚴重或持續缺氧超過代償能力時，分數仍會下降。
- **Apgar定位：**Apgar用於描述出生後狀態及對復甦的反應，不能單獨診斷或排除缺氧窒息。
- **現代判斷：**疑似缺氧缺血性腦病變時，須合併臍帶血氣、復甦需求、神經學檢查、器官損傷及病程，不能因Apgar尚可便排除。
- **題目措辭：**「偽陰性」必須先指定被篩檢的疾病。本題默認以胎兒窒息 / 酸血症為目標，否則語意不夠完整。

醫學（四）Q8

對話詳解原文

1. 題目

依異常發生的機轉命名與定義，附圖箭頭處造成的異常，最可能屬於哪一種先天缺陷分類？

- A. 畸形（malformation）
- B. 發育不良（dysplasia）
- C. 形變（deformation）
- D. 發育中斷（disruption）

題目與影像核對自考選部醫學（四）正式試題。

2. 作答對照

- 使用者作答：B
- 考選部原始答案：D
- 最終更正答案：D
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始答案與最終更正答案一致。

3. 核心考點

這四類不是依外觀嚴重度分類，而是依「發生機轉」分類：

- **Malformation：**器官在形成過程中即發生內在錯誤。
- **Dysplasia：**某種組織的細胞組織、分化或排列異常。
- **Deformation：**原本正常形成的結構受到機械壓迫，外形或位置改變，通常沒有組織被摧毀。
- **Disruption：**原本正常發育的組織遭外在破壞，形成不規則缺損、壞死或截斷。

原題影像的箭頭顯示膜性帶狀組織牽連胎兒顱面部，並有嚴重、不對稱的組織破壞，符合羊膜帶相關的disruption。

4. 各選項解析

A. Malformation——錯誤

Malformation是胚胎形態生成本身出錯，代表結構從一開始就沒有正常形成。

典型例子包括：

- 神經管缺損。
- 唇顎裂。

- 部分先天性心臟病。
- 多指症。

重點是**內在發育程序異常**，不是正常組織形成後被膜帶破壞。

B. Dysplasia——錯誤

Dysplasia是某一類組織的細胞排列、分化或組織化異常，常影響該組織在身體多個位置的表現。

典型例子包括：

- Achondroplasia等骨骼發育不良。
- Ectodermal dysplasia。
- 部分結締組織或軟骨發育異常。

它不是單一部位遭到外力切割或破壞。影像的局部不規則缺損與膜性牽連不符合dysplasia。

C. Deformation——錯誤

Deformation是正常形成的胎兒受到機械力量，使形狀或位置異常，例如：

- 羊水過少造成肢體攣縮。
- 子宮空間受限造成clubfoot。
- 胎位或外部壓迫造成顱形、肢體姿勢異常。

它通常是「壓彎、壓扁、位置改變」，而不是直接摧毀組織。

D. Disruption——正確

Disruption是原本正常的組織遭外來因素破壞，例如：

- 羊膜帶纏繞。
- 血管中斷。
- 缺血壞死。
- 感染或物理性破壞。
- 羊膜帶造成環形束帶、肢端截斷或不規則顱顏缺損。

原題影像所示膜性帶狀牽連及不對稱組織缺損，正是這類機轉。羊膜帶造成的深溝、肢體截斷或其他組織破壞，是disruption的標準例子。先天異常機轉分類整理

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選B可能是看到嚴重而廣泛的異常，便把它理解成「組織發育不好」。

但dysplasia不是「長得很異常」的泛稱，而是特定的組織組織化異常。這題應優先辨識：

> 箭頭所示膜性帶 + 不對稱組織缺損 = 外力破壞既有組織 = disruption。

6. 失分類型

- 先天缺陷機轉分類
- Dysplasia / disruption混淆
- 組織發育異常與組織破壞混淆
- 羊膜帶序列
- 影像關鍵來源未優先使用
- 名稱直覺取代病理機轉

7. 數秒判斷規則

> **沒長好是malformation；整類組織長亂是dysplasia；正常結構被壓歪是deformation；正常組織被破壞、切斷是disruption。**

8. 投資報酬率

高。

可延伸至：

- 羊膜帶序列。
- Potter sequence及羊水過少造成的deformation。
- Malformation、sequence、syndrome與association。
- 血管中斷造成的先天缺陷。
- 骨骼dysplasia的分類。
- 產前超音波發現異常時的機轉判讀。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**D。
- **現代胚胎病理分類：**羊膜帶等外在力量破壞原本正常組織，仍屬disruption，核心一致。
- **命名限制：**臨床文獻有時會寬泛地把所有先天結構異常稱為congenital malformations，但這不等於機轉分類中的狹義malformation。
- **影像限制：**單靠一張屍檢影像未必能證明確切病因；完整判斷仍會結合胎盤、羊膜、臍帶、產前影像及病理檢查。
- **國考策略：**題幹已指定「依發生機轉」，因此應使用狹義四分類，而不是日常廣義用語。

醫學（四）Q9

對話詳解原文

1. 題目

下列關於新生兒復甦術（neonatal resuscitation program）的敘述，何者最不適當？

- A. 新生兒復甦術處置流程依循C（circulation）A（airway）B（breathing）的原則
- B. 過程中若需要監測血氧（SpO_2），應監測右上肢血氧
- C. 初始步驟後，若經適當正壓換氣後，心率仍為每分鐘50下，在考慮開始胸部按壓前，應先置放氣管內管
- D. 胸部按壓與正壓換氣比為3：1

2. 作答對照

- 使用者作答：D
- 考選部原始答案：A
- 最終更正答案：A
- 特殊計分：無；不是多答案接受或一律給分題

原始及最終更正答案均為A。

3. 核心考點

新生兒復甦與成人心搏停止最大的差異是：

新生兒心搏過緩最常源於通氣不足與缺氧，因此建立有效肺部通氣比立即胸部按壓更重要。

大致流程為：

1. 保暖、擺位、必要時清理阻塞物、擦乾及刺激。
2. 呼吸暫停、喘息或HR < 100/min時開始正壓換氣。
3. 確認胸廓起伏並完成通氣矯正；必要時建立替代氣道。
4. 有效通氣後HR仍 < 60/min，才開始胸部按壓。
5. 通常使用3次按壓配1次通氣。

所以A把流程概括成循環優先的CAB，方向錯誤。

4. 各選項解析

A. 依循CAB——錯誤，為本題答案

CAB是成人及部分兒童心搏停止流程中用來強調盡快胸部按壓的架構，不能直接套到出生時的新生兒復甦。

新生兒常見的問題是：

- 肺尚未充分擴張。
- 胎兒肺液尚未排除。
- 缺氧引起心搏過緩。
- 無效通氣導致心率持續下降。

因此優先處理的是氣道與肺部通氣，而不是先做循環按壓。

B. 監測右上肢SpO_2——正確

右手或右腕代表**導管前preductal血氧**，較能反映供應腦部及冠狀動脈的氧合狀態。

若測量下肢，結果可能受到動脈導管分流影響，不能與出生後每分鐘的preductal目標值直接互換。

2025 AHA / AAP指引仍指定感測器放置於右手或右腕。AHA 2025新生兒復甦指引

C. 胸部按壓前先建立替代氣道——國考判定適當

若有效正壓換氣後HR仍為50/min，已達準備胸部按壓的門檻。

在開始按壓前應再次確保：

- 面罩密合。
- 胸廓確實起伏。
- 氣道位置與通氣壓力適當。
- 必要時使用氣管內管或喉罩等替代氣道。

2025 AHA / AAP仍強調開始胸部按壓前必須最佳化通氣；若可行，應建立氣管內管或喉罩等替代氣道。2025 AHA / AAP完整共識文件

D. 按壓與通氣比3：1——正確

新生兒復甦通常使用：

- 每分鐘90次按壓。
- 每分鐘30次通氣。
- 合計約120個動作。
- 以「按、按、按、吹」的節奏協調進行。

因此3：1並不是錯誤選項。

5. 可能的失分機制

由作答結果合理推測：

選D可能是把其他年齡層的CPR比例套入新生兒：

- 成人單人CPR：30：2。
- 兒童雙人CPR：15：2。
- 新生兒出生時復甦：通常3：1。

也可能覺得3：1的通氣比例過高，卻沒有先回到新生兒心搏過緩的主要原因——缺氧與肺部通氣不足。

6. 失分類型

- 新生兒復甦流程
- 新生兒與成人CAB混淆
- 通氣優先與循環優先混淆
- 胸部按壓啟動條件
- 3：1比例
- Preductal血氧位置
- 不同年齡層CPR流程混用
- 核心臨床知識缺口

7. 數秒判斷規則

> **新生兒先把肺吹開：HR < 100開始PPV；有效通氣後仍 < 60才按壓；按壓與通氣3：1，血氧看右手。**

8. 投資報酬率

極高。

可延伸至：

- NRP初始評估與黃金一分鐘。
- PPV適應症。
- MR SOPA通氣矯正步驟。
- HR < 60的處置。
- Preductal SpO_2目標。
- 氣管內管與喉罩適應症。
- Epinephrine及臍靜脈導管。
- 早產兒起始氧氣濃度與體溫管理。

9. 國考答案與現代臨床差異

- **國考答案：**A。
- **現代指引：**有效通氣仍是出生時新生兒復甦的核心，不能套用成人CAB。
- **B項精確化：**應說右手或右腕，而不是泛稱整個右上肢。
- **C項更新：**現代指引要求「替代氣道」，不一定只能氣管插管；合適體型的新生兒可使用喉罩。

- **按壓條件：**必須是至少約30秒、確定胸廓起伏的有效通氣後HR仍 < 60/min，而不是一看到50/min便立即按壓。
- **比例例外：**若有充分理由認為心搏停止源於原發性心臟原因，可能考慮較高的按壓比例；一般出生時復甦仍以3：1為標準。
- **2025更新：**部分通氣頻率、監測及替代氣道建議有所更新，但本題A、B、C、D的官方判斷仍未被推翻。

醫學（四）Q11

本次補寫版 2026-10-07

主題：Williams症候群與血管狹窄的位置

本次補寫版，2026年10月7日完成。原始詳解尚未回收；以下依正式試題、原始答案、最終更正及所列醫學來源重建。

題目與答案對照

1歲大女嬰因為有心雜音，診斷為supravalvular aortic stenosis合併peripheral pulmonary stenosis。下列何種先天性症候群最需被優先考慮？

- A. Noonan syndrome
- B. William syndrome
- C. Turner syndrome
- D. CHARGE syndrome

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
D	B	B	無；本題未列於更正備註

參考來源：考選部正式試題；考選部原始答案；考選部最終更正檔。

個人作答取自本對話已保存的80題作答序列；以上三份官方檔案均於本次補寫重新核對。

核心考點

決勝線索是**主動脈瓣上狹窄 + 周邊肺動脈狹窄**，應優先聯想到Williams症候群。這是血管壁 / elastin相關的動脈病變配對，不是只看到「肺動脈狹窄」就選Noonan。

Williams症候群與7q11.23區域缺失相關，ELN基因缺失是血管表現的重要機轉。題目選項寫William syndrome，臨床標準名稱通常為Williams或Williams–Beuren syndrome。

各選項解析

A．Noonan——容易混淆，但狹窄層級不同

Noonan較典型的心臟表現包括肺動脈**瓣**狹窄及肥厚型心肌病。題幹是周邊肺動脈狹窄，還合併主動脈瓣上狹窄，整組特徵更支持Williams。

B．William / Williams——正確

GeneReviews明確列出主動脈瓣上狹窄及嬰兒期常見的周邊肺動脈狹窄。兩者並存時，本題的診斷優先順序很清楚。

其他可能表現包括特殊面容、生長與發展特徵及高血鈣等；但本題沒有要求所有典型特徵同時出現。

C．Turner——較典型是其他左心阻塞病變

Turner症候群常聯想到主動脈縮窄或二葉式主動脈瓣，並不是本題這組瓣上主動脈與周邊肺動脈狹窄的最佳配對。女嬰身分本身沒有足夠鑑別力。

D．CHARGE——可以有先天性心臟病，但線索不足

CHARGE包含眼缺損、心臟病、後鼻孔閉鎖、生長 / 發展與生殖器及耳部相關異常。它確實可以有心血管缺陷，但不能因此把所有複合先天性心臟病都歸入CHARGE。

題目沒有提供其較特異的眼、鼻、耳等線索；反而已給出Williams的經典血管配對。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選D可能是把兩處心血管異常視為CHARGE的廣義「heart defects」，但沒有進一步比較哪種症候群最符合病灶的精確位置。

這是複習用的可能解釋，不能據此確認你作答當時的實際思路。

失分類型

- 症候群與特定心臟病配對
- 瓣上與瓣膜層級
- 特異線索優先於廣義特徵

數秒判斷規則

> **主動脈瓣上加周邊肺動脈狹窄想Williams；肺動脈瓣狹窄想Noonan；主動脈縮窄想Turner。**

投資報酬率

高。可延伸至先天性心臟病、遺傳症候群及elastin相關血管病變。

國考答案與現代臨床差異

- 官方B與典型Williams表現一致；臨床仍需結合病史、完整評估及遺傳檢驗確認。
- 不能以任何單一血管狹窄，直接推導所有患者都符合Williams；本題依兩個病灶的組合做優先排序。
- GeneReviews指出Williams合併血管病變者的麻醉與鎮靜風險需特別評估，不能只處理心雜音而忽略整體血管狀況。

補寫所用來源

- GeneReviews Williams Syndrome
- Williams主動脈與肺動脈狹窄原始追蹤研究

醫學（四）Q12

本次補寫版 2026-10-07

主題：VSD嬰兒心衰竭與生長線索

本次補寫版，2026年10月7日完成。原始詳解尚未回收；以下依正式試題、原始答案、最終更正及所列醫學來源重建。

題目與答案對照

足月男嬰出生體重為3.5公斤，1個月大時被聽到第3度收縮期的心雜音，懷疑是心室中隔缺損（ventricular septal defect）。下列何種臨床表現或是檢查結果暗示已有心臟衰竭的可能？

- A. 目前體重為4公斤
- B. 平靜時的呼吸次數為每分鐘40次
- C. 平靜時的心跳次數為每分鐘120下
- D. 右側肋骨下緣可摸到約1公分的肝臟

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
B	A	A	無；本題未列於更正備註

參考來源：考選部正式試題；考選部原始答案；考選部最終更正檔。

個人作答取自本對話已保存的80題作答序列；以上三份官方檔案均於本次補寫重新核對。

核心考點

本題不能使用成人生命徵象標準判斷嬰兒。四個選項中，官方以**體重增加不足的線索**選A；呼吸40次、心跳120次及僅觸及1公分肝緣，都可以落在嬰兒可接受的情境。

大型VSD在出生後肺血管阻力下降時，左向右分流與肺血流增加，可能在約4～6週出現餵食費力、呼吸困難及體重增加不佳。生長曲線與餵食表現比單次成人化的數字判讀更重要。

各選項解析

A．1個月只增加0.5公斤——本題官方答案

從3.5到4公斤，淨增加500公克；若粗略用30日計算，約16.7公克／日。相較一般嬰兒早期快速增重的方向，題目把它當成生長／餵食受影響的線索。

但這只是粗估：初期生理性體重下降、恢復出生體重的時間、餵養量及個人曲線都會影響解讀。**單憑4公斤不能確診心衰竭，也不能說所有這樣增重的嬰兒必然不正常。**

B．呼吸40次／分——不是明確的呼吸急促

嬰兒正常或可接受的呼吸速率本來就比成人快。RCH的足月及3個月參考區間都包含40次／分；它不是這組選項中最有力的心衰竭線索。

仍需觀察凹胸、鼻翼搧動、餵食時喘、血氧及趨勢；『數值可接受』不保證整體病況正常。

C．心跳120次 / 分——可接受的嬰兒心率

這不是依成人標準就能判定的異常心搏過速。哭鬧、睡眠、發燒與測量時情境都會影響心率；單次安靜心率120不足以支持心衰竭。

D．肋下肝緣1公分——可以是正常嬰兒體徵

嬰兒肝緣本來可能在右肋緣下觸及。僅1公分不能直接等同病理性肝腫大或右心衰竭；須結合實際肝大小、質地、趨勢與其他鬱血線索。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選B可能是把成人呼吸40次 / 分的異常程度套到1個月嬰兒，或沒有先比較四個選項是否落在同齡可接受範圍。

這是複習用的可能解釋，不能據此確認你作答當時的實際思路。

失分類型

- 年齡別正常值
- 生長與餵食表現
- 暗示診斷與確立診斷區分

數秒判斷規則

> **嬰兒VSD看餵食喘、出汗與增重曲線；40次呼吸、120次心跳、1公分肝緣，不能直接當成人異常值。**

投資報酬率

極高。可延伸至嬰兒心衰竭、先天性心臟病時序及兒科生命徵象。

國考答案與現代臨床差異

- 官方A是在四個選項中找相對可疑的生長線索，不是以單次體重建立心衰竭診斷。
- 雜音響度不等於分流量或心衰竭嚴重度；評估仍需超音波及整體臨床狀態。
- 實務應追蹤體重 / 身長曲線、餵食時間、攝取量、呼吸功與灌流。RCH表格是可接受參考範圍，不能代替個別評估。

補寫所用來源

- MSD 專業版 VSD
- RCH 年齡別生命徵象
- AAP 嬰兒第一個月生長
- Merck 新生兒理學檢查

醫學（四）Q13

本次補寫版 2026-10-07

主題：前中後腸分界與腸神經嵴遷移

本次補寫版，2026年10月7日完成。原始詳解尚未回收；以下依正式試題、原始答案、最終更正及所列醫學來源重建。

題目與答案對照

有關正常腸道發展，下列敘述何者最不適當？

- A. 食道、胃及前段十二指腸是由前腸（foregut）發展而成
- B. 降結腸及上段肛管是由後腸（hindgut）發展而成
- C. 神經嵴（neural crest）細胞的遷移是由顱部至尾部
- D. 小腸及全段橫結腸是由中腸（midgut）發展而成

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
C	D	D	無；本題未列於更正備註

參考來源：考選部正式試題；考選部原始答案；考選部最終更正檔。

個人作答取自本對話已保存的80題作答序列；以上三份官方檔案均於本次補寫重新核對。

核心考點

D的決定性錯誤是**全段橫結腸**。中腸包括遠端十二指腸、空迴腸、盲腸、闌尾、升結腸及橫結腸近端2/3；橫結腸遠端1/3則屬後腸。

C描述腸神經系統主要的迷走部神經嵴細胞，由較顱側向尾側殖入腸道的方向。題目寫「神經峭」，標準術語通常為「神經嵴」。

各選項解析

A．食道、胃、近端十二指腸來自前腸——適當

前腸向尾端的界線常以十二指腸及膽道開口附近的胚胎分界理解。食道、胃及近端十二指腸屬前腸，A符合標準分類。

B．降結腸與上段肛管來自後腸——適當

後腸包括橫結腸遠端1/3、降結腸、乙狀結腸、直腸及上部肛管。下部肛管則有外胚層肛凹的來源，不能把上下肛管全部混為一類。

C．神經嵴主要遷移方向顱側至尾側——本題接受

腸神經系統主要由迷走部神經嵴細胞殖入腸道，向尾側推進，形成腸神經節。遷移 / 分化失敗可與Hirschsprung disease的遠端無神經節區域相關。

現代發育學也描述骶部神經嵴的額外貢獻；因此C是主要路徑的簡化，不能延伸為所有神經嵴細胞、所有器官都只有同一方向。

D．小腸及全段橫結腸屬中腸——錯誤，為答案

橫結腸必須分成近端2/3與遠端1/3；後者來自後腸。此外，近端十二指腸屬前腸，將『小腸』全部籠統放入中腸也不夠精確。最直接、無歧義的陷阱仍是『全段橫結腸』。

NASPGHAN教學資料直接列出中腸的近端2/3橫結腸與後腸的遠端1/3。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是記得神經嵴有複雜、多方向的遷移，而對這句概括敘述較保留；但沒有先抓住D中更明確的分界錯誤。

這是複習用的可能解釋，不能據此確認你作答當時的實際思路。

失分類型

- 胚胎來源與解剖分界
- 部分與全部的量詞
- 主要路徑與例外
- 最佳答案排序

數秒判斷規則

橫結腸近2/3屬中腸、遠1/3屬後腸；十二指腸跨前中腸分界，看到全段就先核對。

投資報酬率

高。可延伸至血管供應、腸旋轉、先天性腸道異常及Hirschsprung disease。

國考答案與現代臨床差異

- 官方D符合胚胎解剖分界。
- C的顱尾方向應限定於腸神經系統主要迷走部神經嵴路徑，不宜寫成所有神經嵴細胞的普遍定律。
- 前、中、後腸分區主要討論胚胎腸管區域；腸壁不同組織層的細胞來源還要另分內胚層、中胚層與神經嵴。

補寫所用來源

- NASPGHAN 腸道胚胎與解剖教學
- 腸神經嵴發育專題

醫學（四）Q15

本次補寫版 2026-10-07

主題：膽道閉鎖的流行病學與早期辨認

本次補寫版，2026年10月7日完成。原始詳解尚未回收；以下依正式試題、原始答案、最終更正及所列醫學來源重建。

題目與答案對照

關於膽道閉鎖（biliary atresia）的敘述，下列何者最不適當？

- A. 新生兒糞便如呈現淡黃色或灰白色，應懷疑是否有膽道閉鎖或肝內膽汁滯留的可能
- B. 西方國家膽道閉鎖的發生率，比東亞國家為高
- C. 膽道閉鎖在肝切片檢查最重要的特徵是膽管增生（bile ductular proliferation）
- D. 膽道閉鎖宜及早完成診斷，建議在60天以內完成葛西手術（Kasai procedure）

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
C	B	B	無；本題未列於更正備註

參考來源：考選部正式試題；考選部原始答案；考選部最終更正檔。

個人作答取自本對話已保存的80題作答序列；以上三份官方檔案均於本次補寫重新核對。

核心考點

B把流行病學方向寫反：膽道閉鎖發生率通常在東亞地區較高，而不是西方較高。台灣人口研究支持這個方向。

另兩個重要複習點是**淡色糞便／持續黃疸需評估膽汁鬱積**，以及**早診斷、早Kasai**。所謂膽道閉鎖，不代表肝內膽管在組織上不會有反應性增生。

各選項解析

A．淡色糞便應懷疑膽汁鬱積——方向適當

膽汁未正常進入腸道時，糞便可能變淡、灰白或近似陶土色。持續或反覆明顯變淡的糞便需要評估，不能把它一律當成餵奶造成。

淡黃色的主觀描述較寬，並非每一種黃便都異常；應結合糞便色卡、黃疸、深色尿及直接／結合型膽紅素。題意是在提示需懷疑並檢查，並不是憑顏色確診。

B．西方發生率較東亞高——錯誤，為答案

台灣15年人口研究的方向是發生率高於西方國家；各地及各時段估計會不同，但不能將整體東亞與西方的方向顛倒。

本題不必硬背單一精確發生率，先抓住區域比較即可。

C．肝切片可見膽管增生——適當

膽道阻塞可在肝切片呈現膽小管 / 膽管增生、膽汁栓塞及門脈區纖維化等反應。『閉鎖』主要指膽道的阻塞性病變，與肝內膽管增生並不矛盾。

這些組織特徵支持膽道阻塞，但不是孤立的百分之百特異診斷；早期表現與其他膽汁鬱積病也可能重疊，需由專科整合其他檢查。

D．及早診斷並在60天內Kasai——國考接受

越早處理通常越有利，60天以內是常見國考重點。然而它不是『可以放心等到第60天』的期限。

2025 AAP臨床報告把辨認時點前移至2～4週健兒訪視，並指出理想上30～45日以前手術有較佳結果。重點是盡早轉介、避免錯失時間，而非剛好壓在60日。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是把膽道「閉鎖」直覺理解成不應有任何膽管增生，未分開肝外阻塞與肝內組織的反應；也可能未先核對B的區域發生率方向。

這是複習用的可能解釋，不能據此確認你作答當時的實際思路。

失分類型

- 病名字面與病理反應
- 流行病學方向
- 診斷與手術時序
- 懷疑與確診區分

數秒判斷規則

> **灰白便、持續黃疸先查膽汁鬱積；東亞膽道閉鎖較多，肝內可膽管增生；Kasai越早越好，別等60天。**

投資報酬率

極高。可延伸至新生兒黃疸、直接膽紅素、糞便色卡及嬰兒肝膽急迫轉介。

國考答案與現代臨床差異

- 官方B合理；各地精確發生率需依研究年代與母群體辨認，不能當作永遠固定的數字。
- D的60天是傳統考試界線；2025 AAP更強調2～4週辨認及更早手術的機會。
- 肝切片有診斷價值，但不能只靠膽管增生單一特徵確診，也不能因某次糞便仍有顏色就排除。

補寫所用來源

- 2025 AAP 膽道閉鎖早期辨認臨床報告
- NASPGHAN / ESPGHAN 嬰兒膽汁鬱積指引

- 台灣膽道閉鎖人口研究

醫學（四）Q16

先前重建版

題目與答案對照

有關嬰幼兒阻塞性尿路疾病（obstructive uropathy）之影像學檢查，下列何者最不適合？

- A. 靜脈注射腎盂攝影（intravenous pyelogram）
- B. 排尿時膀胱尿道攝影術（voiding cystourethrogram）
- C. 前行性腎盂攝影（antegrade pyelogram）
- D. 核醫掃描（renal scintigraphy）

來源：考選部正式試題。

使用者作答	原始答案	最終答案	特殊計分
D	A	A	無

已重新核對原始答案與最終更正檔。

核心考點與各選項解析

重點是**每項檢查能回答什麼問題**，不能因為核醫具有輻射就直接排除。

A．IVP——最不適合，為答案

IVP將顯影劑注入靜脈，等待腎臟排泄後拍攝集尿系統。腎功能或尿流受影響時，顯影可能延遲、資訊不足，另有輻射及含碘顯影劑的負擔。Johns Hopkins：IVP

結合現代超音波與功能性檢查的分工，IVP不是此情境的常規首選。但不能把國考答案延伸為「所有嬰幼兒都禁用IVP」。

B．VCUG——有適應症，不能排除

可觀察膀胱、排尿時尿道及膀胱輸尿管逆流。疑似後尿道瓣膜的男嬰尤其需要這項檢查；EAU對疑似後尿道瓣膜建議進行VCUG。EAU：先天性下泌尿道阻塞

不過，不能推成所有孤立性腎盂擴張都必須做VCUG。

C．前行性腎盂攝影——選擇性使用，不是常規第一線

從腎盂端直接注入顯影劑，觀察往輸尿管方向的通路。其他影像不足以釐清阻塞，或已有腎造廔等特定情境，可考慮使用。

它有穿刺、出血及感染風險，但「有侵入性」不等於「對阻塞沒有診斷用途」。Johns Hopkins：前行性腎盂攝影

D．核醫掃描——可評估功能性阻塞，不是答案

此情境的重要檢查是**利尿腎圖，常用99mTc-MAG3**，評估分腎功能與引流反應。EAU將利尿腎圖列為評估尿液輸送障礙功能意義的重要工具。EAU：上泌尿道擴張與PUJ阻塞

必須區分：

- MAG3動態利尿腎圖：功能、排泄與引流。
- DMSA腎皮質掃描：主要看腎皮質與疤痕。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選D可能是不熟悉核醫對功能性阻塞的用途，也可能因輻射疑慮，或混淆DMSA與MAG3而排除。沒有當時自述，不能確認是哪一種。

- 失分類型：檢查目的、構造與功能評估、第一線與選擇性檢查區分。
- 數秒判斷規則：**「超音波看構造，VCUG看逆流 / 尿道，MAG3看功能與引流；IVP不是此情境常規首選。」**
- 投資報酬率：高，可串連腎盂擴張、UPJ阻塞、後尿道瓣膜與VUR。

最新指引與國考 / 臨床差異

本次查核的是2026版EAU指引，更新範圍包含兒童UTI及上泌尿道擴張。EAU版本說明

國考選A；現代臨床則先做腎臟膀胱超音波，再依問題選擇VCUG或利尿腎圖。**B、C、D不是每位患者都要做，也不是可以互換的檢查。**

醫學（四）Q18

先前重建版

題目與答案對照

有關兒童泌尿道感染（urinary tract infection）之危險因子（risk factors），下列何者最不適當？

- A. 泌尿系統結構異常（anatomic abnormality）
- B. 便秘（constipation）
- C. 如廁訓練時（toilet training）
- D. 割包皮男孩（circumcised male）

使用者作答	原始答案	最終答案	特殊計分
B	D	D	無

題目與答案已核對同份官方試題、原始答案及最終更正檔。

核心考點與各選項解析

先分清楚**增加風險**與**相對保護**；便秘不能只當成與泌尿系統無關的腸道問題。

A．泌尿系統結構異常——適當

造成阻塞、尿液滯留或逆流的異常，可能增加UTI或反覆感染風險，例如後尿道瓣膜、狹窄及高等級VUR。不同異常的風險並不相同。EAU：兒童UTI

B．便秘——適當

便秘與膀胱腸道功能障礙（BBD）、反覆UTI常共存。若伴隨不協調排尿、排空不全及殘尿，感染風險更值得注意；但不是每位便秘兒童都一定有殘尿。EAU：兒童下泌尿道功能障礙

EAU建議辨識並治療相關患童的BBD，也指出處理便秘可減少UTI復發。EAU：兒童UTI預防

C．如廁訓練時——國考接受，但文字需精確化

合理的臨床解讀是：訓練期間**若出現憋尿、憋便或不協調排尿**，可能增加風險。

但「正在如廁訓練」不等於已存在這些問題，更不能直接說如廁訓練會造成感染。定時、放鬆排尿及便秘處理，反而是治療的一部分。EAU：排尿行為與腸道管理

D．割包皮男孩——最不適當，為答案

相較未環切男嬰，包皮環切與較低UTI風險相關，因此方向偏向**相對保護**。EAU：兒童UTI與包皮環切

這不代表環切後不會感染，也不等於應替所有男孩常規手術；仍須評估個別基礎風險與利弊。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選B可能是尚未連結便秘、BBD與膀胱排空，因此認為便秘與UTI無關；也可能未優先辨認D的保護方向。不能僅憑選項確認當時推理。

- 失分類型：跨器官功能關聯、危險與保護因子、相關情境與直接病因區分。
- 數秒判斷規則：**「結構異常、排不乾淨、便秘 / BBD增加風險；包皮環切相對保護。先判方向，再比強弱。」**
- 投資報酬率：高，可延伸至反覆UTI、VUR、便秘與排尿行為處置。

最新指引與國考 / 臨床差異

國考答案D與2026 EAU指引方向一致，但要保留兩項限制：

1. C是概括的風險情境，不能教成「如廁訓練會造成UTI」。
2. 包皮環切的相對保護，不代表每名健康男嬰都需要手術。

累積失分模式與本次進度

本次重做不新增計數。Q18原本已納入「因果、危險因子與替代指標」；其餘模式均維持固定基準。

- 本次完成：重做Q16、Q18；新增完成 **0題**。
- 累計完成：醫學（六）32題、醫學（五）29題、醫學（四）24題，共 **85 / 138題**。
- 下一個掃描題號：醫學（四）Q38。
- 下一批真正錯題：Q41、Q42；Q38～Q40已排除。
- 新增失分模式：無。
- 建議下次工作量：2題。

目前仍無法將重做稿或本次紀錄存回Library；上述提供的是可下載檔，**原固定基準未修改，也未宣稱已同步**。

醫學（四）Q20

既有回收附件原文

題目與作答對照

下列何者為 Henoch-Schönlein purpura 最不常見的臨床表現？

- A. 關節痛（arthralgia）
- B. 腹痛（abdominal pain）
- C. 血尿或蛋白尿（hematuria or proteinuria）
- D. 嗜中性白血球低下（neutropenia）

題目來源：考選部正式試題。

- 使用者作答：**B**
- 原始答案：**D**
- 最終更正後答案：**D**
- 特殊計分：無，屬真正錯題。原始答案、最終更正檔

核心考點與各選項解析

Henoch–Schönlein purpura，現稱 **IgA血管炎（IgA vasculitis）**，典型表現要連成「皮膚、關節、腸道、腎臟」，不能只記住紫斑。

A．關節痛——典型表現

常影響下肢大關節，尤其膝、踝，可伴關節炎。因此不是最不常見項。

B．腹痛——典型表現，不應排除

腹部症狀是重要的腸道受累表現，並非罕見附帶症狀。各器官症狀出現順序可以不同，不能因尚未看到完整紫斑表現便排除。

若出現劇烈腹痛、消化道出血或腸阻塞徵象，須評估腸套疊等併發症。

C．血尿或蛋白尿——典型腎臟表現

可以只有尿液檢查異常，患者未必自覺不適。因此沒有肉眼血尿，不等於沒有腎臟受累。

上述關節、腹部及腎臟表現，均列於RCH兒童IgA血管炎指引。

D．嗜中性白血球低下——非典型，為答案

A、B、C都對應本病的主要受累器官；嗜中性白血球低下不屬於這組典型表現。這是「最不常見」的比較，不應延伸成患者絕不可能同時有嗜中性白血球低下。

可能的失分機制與失分類型

由作答結果合理推測：選B可能反映對IgA血管炎腹部表現的熟悉度不足，未將腹痛與紫斑、關節症狀、尿液異常連成同一症候群。僅憑答案，不能確認你當時是否漏看題幹或採用了哪種推理。

- 暫定失分類型：典型症候群表現辨識、腸道受累與病名未連結。
- 數秒判斷規則：**「IgA血管炎看皮、關、腸、腎；腹痛在典型組合內，嗜中性白血球低下不在。」**
- 投資報酬率：高；可延伸至兒童紫斑鑑別、急性腹痛及腎炎追蹤。

現行證據與國考 / 臨床差異

國考答案D與現行臨床認識一致；臨床更重要的是避免漏掉**無症狀或稍後出現的腎臟受累**。

KDIGO 2025建議兒童IgA血管炎自發病起監測尿液，其後至少每月一次、持續至少6個月；並不支持為預防腎炎而對沒有腎臟受累的兒童常規使用類固醇。KDIGO 2025指引

醫學（四）Q21

既有回收附件原文

題目與作答對照

5歲女童流鼻水，咳嗽一週以上，最近3～4天高燒達39.5℃，且鼻水轉變為黃綠濃稠狀，伴有頭痛，夜間咳嗽較明顯，此外無其它症狀。最可能的診斷為：

- A. 急性鼻咽炎（acute nasopharyngitis）
- B. 急性鼻竇炎（acute sinusitis）
- C. 急性支氣管炎（acute bronchiolitis）
- D. 過敏性鼻炎（allergic rhinitis）

原題C的中英文不一致：**bronchiolitis通常譯為「細支氣管炎」**；此處保留官方原文，不自行改題。
考選部正式試題

- 使用者作答：**A**
- 原始答案：**B**
- 最終更正後答案：**B**
- 特殊計分：無，屬真正錯題。原始答案、最終更正檔

核心考點

重點不是「黃綠鼻涕 = 細菌」，而是**病程、發燒程度與症狀組合**。

CDC現行兒童照護建議列出三種支持急性細菌性鼻竇炎的病程：

- 持續型：鼻涕或日間咳嗽超過10天，沒有改善。
- 惡化型：病毒性上呼吸道感染先改善，之後又發燒或呼吸道症狀加重。
- 嚴重型：≥39℃發燒合併膿性鼻涕，持續至少3天。CDC兒童門診照護建議

本題後期出現39.5℃高燒、濃稠鼻涕及頭痛，整體最支持B。但要保留兩項限制：

1. 「一週以上」**不等於已超過10天**。
2. 題幹未明說曾改善，**不能自行補成嚴格的「先好轉再惡化」**。

各選項解析

A．急性鼻咽炎——能解釋起初症狀，但不是最佳答案

一般感冒也可能出現變色鼻涕；顏色本身不能區分病毒或細菌。本題更值得注意的是後期持續高燒及頭痛，而非只看到流鼻水、咳嗽就停在普通感冒。

B．急性鼻竇炎——最適當

鼻部症狀合併頭痛，且病程後段出現數日高燒，較符合鼻竇炎的臨床情境。與其他選項相比，能解釋整體表現。

臨床若要嚴格套用「嚴重型細菌性鼻竇炎」條件，仍應確認高燒與膿性鼻涕是否同時持續至少3天；題幹沒有把每項症狀的持續時間完全分開交代。

C．急性支氣管炎 / bronchiolitis——不如B符合

依英文bronchiolitis解讀，典型患者為兩歲以下嬰幼兒，常有喘鳴、呼吸加快或呼吸費力；本題為5歲且以鼻部症狀、頭痛為主，較不符合。CDC細支氣管炎摘要

即使按中文理解成支氣管炎，單靠咳嗽也不足以使它優於鼻竇炎。

D．過敏性鼻炎——無法合理解釋整體高燒病程

過敏線索通常包括鼻眼搔癢、流淚、季節性或過敏原接觸關聯。單純過敏性鼻炎不能妥善解釋連續數日39.5℃高燒。ACEP兒童鼻竇炎臨床整理

可能的失分機制與失分類型

由作答結果合理推測：選A可能是較重視最初的流鼻水、咳嗽，未充分整合後期高燒與頭痛。也可能是不熟悉鼻竇炎的病程判準；不能直接斷言你當時「忽略」了某句話。

- 暫定失分類型：疾病時間軸、嚴重度與核心警訊整合。
- 數秒判斷規則：**「鼻竇炎看久、重、再惡化；鼻涕顏色不能單獨定案。」**
- 投資報酬率：高；可同時改善普通感冒、過敏性鼻炎與細菌性鼻竇炎的鑑別。

現行證據與國考 / 臨床差異

國考選B合理；但「急性鼻竇炎」並不自動代表已證實細菌感染。

CDC目前建議：無併發症者不常規影像檢查；僅持續型可考慮短期觀察，嚴重或惡化型則建議抗生素治療，常用第一線為amoxicillin或amoxicillin/clavulanate。CDC兒童照護建議，頁面日期2024-04-22，本次重新查核

若出現眼球突出、眼球活動疼痛、視力改變或意識異常，須考慮眼眶 / 顱內併發症，不能再當一般鼻竇炎處理。ACEP併發症辨識

醫學（四）Q22

既有回收附件原文

題目與答案對照

關於幼兒期接受癌症治療多年後，較常產生的延遲效應（late adverse effect），下列敘述何者最不適當？

- A. Anthracyclines類藥物（如doxorubicin）：高頻為主的聽力下降
- B. 頭部放療：影響執行功能、注意力、記憶力、處理速度、視力
- C. Bleomycin：肺纖維化
- D. Vincristine及vinblastine：周邊神經病變

來源：考選部醫學（四）正式試題

- 使用者作答：C
- 原始答案：A
- 最終更正答案：A
- 特殊計分：無，屬真正錯題

原始答案與最終更正檔一致；更正檔只有Q14及Q28有特殊計分。

核心考點

兒童癌症治療的代表性器官毒性配對：

- Anthracycline → 心肌病變、心衰竭。
- Platinum類藥物，尤其cisplatin → 高頻感音性聽力下降。
- Bleomycin → 肺毒性、肺纖維化。
- Vinca alkaloids → 周邊神經病變。
- 頭部放療 → 神經認知及特定視覺晚期效應。

因此A把「platinum—耳毒性」錯接到anthracycline。

各選項解析

A．Anthracycline造成高頻聽損——最不適當，為答案

Doxorubicin等anthracycline的代表性晚期毒性是劑量相關心肌病變。臨床表現可能在治療後多年甚至數十年才出現；幼年接受治療及較高累積劑量會增加風險。

高頻感音性聽力下降的經典藥物是cisplatin等platinum製劑，通常先影響高頻，再隨累積暴露波及語音頻率。NCI兒童癌症治療晚期效應PDQ

B．頭部放療影響認知與視覺——國考判定適當

頭部放療可能造成：

- 注意力及執行功能下降。
- 處理速度變慢。
- 記憶及學習困難。
- 視知覺或視動整合異常。
- 視野、白內障或視力問題，視照射區域與劑量而定。

不過「視力」不是所有頭部放療患者都常見的統一結果。現代精準放療下，明顯視力下降相對少見，主要取決於視神經、視交叉及眼球實際受量；B屬概括性敘述，但仍不如A明確錯誤。NCI神經認知與視覺晚期效應

C．Bleomycin造成肺纖維化——適當

Bleomycin可造成劑量相關肺毒性，包括：

- 間質性肺炎。
- 肺纖維化。
- 限制型肺功能障礙。
- 肺擴散能力下降。

胸部放射治療、較高累積劑量及其他肺部傷害可能加重風險。兒童療程所用劑量不一定造成嚴重臨床纖維化，但此藥物—器官配對仍正確。NCI肺部晚期效應

D．Vinca alkaloids造成周邊神經病變——適當

Vincristine、vinblastine干擾微管功能及軸突運輸，可引起：

- 遠端肌力下降。
- 感覺異常。
- 腱反射減弱。
- 步態或平衡問題。
- Vincristine相關自主神經病變，如便祕。

部分症狀在停藥後改善，但長期存活者仍可能存在未被辨識的神經肌肉功能障礙。NCI周邊神經病變資料

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是低估了bleomycin肺纖維化作為長期毒性的典型程度，或未先將高頻聽損配對至platinum類藥物。僅憑作答結果不能確定當時思路。

- 失分類型：藥物—器官毒性配對、治療晚期效應、藥物機轉分類。
- 數秒判斷規則：**「Anthracycline傷心、platinum傷耳、bleomycin傷肺、vinca傷神經。」**
- 投資報酬率：高；可延伸至腫瘤存活者監測、化療副作用及累積劑量概念。

國考與現代臨床差異

國考答案A與現代證據一致。現代照護則更強調：

- 毒性風險取決於累積劑量、年齡、合併放療與個人易感性。
- 頭部放療的認知與視覺效應取決於實際照射結構，不能一概而論。
- Proton therapy、縮小照射範圍及降低劑量可減少部分神經認知毒性。
- 晚期效應監測應依實際治療暴露史個人化，而不是只依癌症名稱安排。

醫學（四）Q24

既有回收附件原文

題目與答案對照

關於肋膜積液是滲出液（exudate）或漏出液（transudate）的鑑別診斷，下列何者最不適當？

- A. Exudate液體所含蛋白質經常 > 3.0 g/dL
- B. Transudate液體pH值經常 < 7.2
- C. Exudate液體中的LDH值經常 > 200 IU/L
- D. Transudate液體中的葡萄糖經常≧60 mg/dL
- 使用者作答：D
- 原始答案：B
- 最終更正答案：B
- 特殊計分：無，屬真正錯題

核心考點

現代分類應優先使用Light’s criteria。符合任一項便歸為exudate：

1. 肋膜液 / 血清蛋白質比值 > 0.5。
2. 肋膜液 / 血清LDH比值 > 0.6。
3. 肋膜液LDH > 血清LDH正常上限的三分之二。

若三項皆不符合，通常判為transudate。Light’s criteria整理

pH < 7.2不是transudate的常見特徵；在肺炎旁積液中，它反而提示複雜性積液或膿胸風險。

各選項解析

A．Exudate蛋白質經常 > 3.0 g/dL——可作概括，但不是標準單獨判準

Exudate由局部發炎、血管通透性上升或淋巴阻塞造成，蛋白質通常較高。因此 > 3.0 g/dL可作粗略提示。

但現代分類不應只看這個絕對值；部分exudate可能低於3.0 g/dL，部分使用利尿劑後的心衰竭積液則可能被Light’s criteria判為exudate。

B．Transudate的pH經常 < 7.2——錯誤，為答案

Transudate通常源於全身性的靜水壓或膠體滲透壓失衡，例如：

- 心衰竭。
- 肝硬化。
- 腎病症候群。

- 低白蛋白血症。

其pH並不以 < 7.2為特徵。低pH較應想到局部代謝旺盛或酸性物質累積的exudative疾病，例如：

- 複雜性肺炎旁積液或膿胸。
- 食道破裂。
- 類風濕性肋膜炎。
- 部分惡性積液。

英國胸腔醫學會指引將肋膜液pH≤7.2視為肺膜感染高風險的重要處置門檻，而非transudate分類特徵。BTS 2023肋膜疾病指引

C．Exudate的LDH經常 > 200 IU/L——可作舊式概括

Exudate因組織發炎、細胞破壞及代謝活性增加，LDH往往升高。

然而200 IU/L是固定絕對值，會受到實驗室血清LDH正常範圍影響。現代應使用：

> 肋膜液LDH / 血清LDH > 0.6，或肋膜液LDH > 血清正常上限的三分之二。

因此C方向合理，但不宜作為獨立通用標準。

D．Transudate葡萄糖經常≧60 mg/dL——國考判定適當

單純transudate的葡萄糖通常接近血糖，不常因大量白血球、細菌或腫瘤細胞消耗而明顯降低。

肋膜液低葡萄糖較支持：

- 複雜性肺炎旁積液或膿胸。
- 類風濕性肋膜炎。
- 惡性積液。
- 結核性肋膜炎。

不過D也不是Light’ s criteria的一部分；臨床判讀時還要參考同時血糖，不能只靠60 mg/dL單一門檻。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選D可能是注意到葡萄糖≥60 mg/dL不屬於Light’ s criteria，因此認為它最不適當。這項質疑具有臨床道理，但B存在更直接的方向性錯誤：pH < 7.2指向複雜性exudative疾病，而不是常見transudate。

- 失分類型：分類標準與輔助指標混淆、Light’ s criteria、絕對值與相對比值。
- 數秒判斷規則：**「Light看蛋白比、LDH比、LDH上限；pH < 7.2想感染性exudate，不想transudate。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至心衰竭積液、肺炎旁積液、膿胸及胸管引流判斷。

國考與現代臨床差異

- 國考答案B與現代臨床方向一致。

- A、C、D都是「經常如此」的概括性型態，不是正式Light’ s criteria。
- pH≤7.2主要用於評估肺炎旁積液是否複雜、是否需引流，不是區分所有transudate與exudate的主要標準。
- 心衰竭患者接受利尿劑後，Light’ s criteria可能將部分真正transudate誤判為exudate；此時可結合血清—肋膜液白蛋白梯度、蛋白梯度或NT-proBNP判讀。肋膜積液現代評估

醫學（四）Q26

既有回收附件原文

題目與答案對照

下列何種狀況最不可能造成次發性腎上腺功能不全（secondary adrenal insufficiency）？

- A. 先天性腎上腺增生症（congenital adrenal hyperplasia）
- B. 突然停掉服用超過一個月的腎上腺皮質酮（prednisolone）
- C. 前腦無裂畸形（holoprosencephaly）
- D. 腦垂體（pituitary gland）曾接受過放射線治療（radiotherapy）

來源：考選部正式試題

- 使用者作答：**B**
- 原始答案：**A**
- 最終更正答案：**A**
- 特殊計分：無，屬真正錯題

原始答案與最終更正檔一致。

核心考點

先依病灶層級分類：

- **原發性：**腎上腺皮質本身異常，如CAH。
- **次發性：**腦垂體ACTH分泌不足。
- **第三級：**下視丘CRH不足或長期外源性類固醇抑制HPA軸。
- 臨床資料也常將次發性與第三級合稱**中樞性腎上腺功能不全**。

因此A屬最明確的原發性病因，是「最不可能造成次發性」的答案。Pediatric Endotext：兒童腎上腺功能不全

各選項解析

A．先天性腎上腺增生症——答案

CAH是腎上腺類固醇生成酵素異常，病灶位於腎上腺本身，屬原發性腎上腺功能不全。ACTH通常因負回饋不足而升高，不是腦垂體ACTH不足。

B．長期prednisolone後突然停藥——可造成中樞性功能不全

長期外源性類固醇會抑制CRH與ACTH；突然停藥時，萎縮的腎上腺尚未恢復，可能發生腎上腺危象。

2024年歐洲內分泌學會與Endocrine Society指引指出，口服類固醇使用達3至4週以上且超過生理劑量，即具有HPA軸抑制風險。類固醇誘發腎上腺功能不全指引

嚴格分類時這通常稱為**第三級**，但不少臨床資料將其納入central adrenal insufficiency；這是本題的用語簡化處。

C．前腦無裂畸形——可能造成中樞性功能不全

Holoprosencephaly屬中線腦部發育異常，可能合併下視丘—腦垂體功能缺陷，包括ACTH缺乏。不是每名患者都會發生，但病理路徑合理。

D．腦垂體接受放射治療——典型次發性病因

腦垂體或鄰近區域放療可能造成延遲性ACTH缺乏；功能異常可在治療後多年才出現，因此需要長期內分泌追蹤。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選B可能是注意到類固醇停藥在嚴格分類屬「第三級」而不是「次發性」。這項判斷具有現代內分泌學依據，但國考把次發性與第三級概括為中樞性病因；四項中A仍是唯一明確發生於腎上腺本身者。

- 失分類型：原發性 / 次發性 / 第三級分類、術語邊界與最佳答案排序。
- 數秒判斷規則：**「腎上腺本身 = 原發；下視丘、腦垂體、類固醇停藥 = 中樞。看到CAH先選原發。」**
- 投資報酬率：高；可延伸至ACTH、電解質、色素沉著及腎上腺危象鑑別。

國考與現代臨床差異

- 國考答案A正確。
- 現代嚴格分類通常把長期類固醇後HPA軸抑制稱為第三級，而非狹義次發性。
- 臨床常合稱central adrenal insufficiency，因此B仍是合理的中樞性病因。
- 中樞性患者通常保留醛固酮功能；原發性疾病則較可能出現高ACTH、色素沉著及鹽皮質素異常，但須視CAH亞型而定。

醫學（四）Q30

既有回收附件原文

題目與答案對照

6歲男童，上課時常常坐不住，愛四處亂跑，無法專心學習，對老師的勸誡皆不聽從，同學們也都因此排擠他。醫師評估可能是注意力不足 / 過動症（ADHD），有關此病症，下列敘述何者最適當？

- A. 診斷必要的條件包含腦波檢查結果是正常
- B. 學齡前的孩子還太小，所以不應該有ADHD診斷
- C. 大約60～80% ADHD的兒童到青春期症狀不會持續存在
- D. 診斷上相關症狀應需持續超過6個月
- 使用者作答：**B**
- 原始答案：**D**
- 最終更正答案：**D**
- 特殊計分：無，屬真正錯題

核心考點

ADHD診斷是臨床診斷，核心條件包括：

- 症狀持續**至少6個月**。
- 數項症狀在12歲以前已出現。
- 出現在至少兩種情境，如家庭與學校。
- 確實妨礙社交、學業或其他功能。
- 排除更能解釋症狀的睡眠、情緒、學習或其他疾病。

沒有單一檢驗可以確診ADHD；應取得家長、教師及其他照顧者提供的跨情境資料。CDC ADHD診斷頁，2026年7月更新

各選項解析

A．正常腦波是必要條件——錯誤

常規腦波不是ADHD的診斷條件，也不能用正常腦波確認ADHD。只有另有發作性意識改變、疑似癲癇或其他神經學線索時，才考慮EEG。

B．學齡前不能診斷ADHD——錯誤

ADHD可以在學齡前診斷。AAP指引涵蓋4至18歲兒童及青少年，並為4歲至未滿6歲者提出專門處置建議。

學齡前診斷確實較困難，因正常幼兒也可能活動量高、注意時間短；但「較難診斷」不等於「不應診斷」。AAP ADHD臨床指引

C．60～80%到青春期不再持續——錯誤

方向大致顛倒。傳統追蹤資料常估計約60～80%的兒童到了青春期仍有症狀；不同研究會因診斷門檻及追蹤方式而得到不同數字。

過動可能隨年齡下降，但注意力不足、衝動、執行功能與功能損害仍可能持續。

D．症狀持續超過6個月——最佳答案

官方選D；其核心概念正確。不過精確診斷用語是：

> **至少持續6個月，而非必須超過6個月。**

而且持續時間並非唯一條件，仍須確認跨情境、功能損害、發病年齡及鑑別診斷。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選B可能是把「學齡前兒童診斷需格外謹慎」延伸成「不能診斷」，或認為必須入學後才能確認跨情境功能損害。僅憑答案不能確定當時的實際推理。

- 失分類型：診斷條件、時間門檻、年齡適用範圍。
- 數秒判斷規則：**「ADHD背6、12、2：至少6個月、部分症狀12歲前、至少2種情境；不靠EEG，學齡前也能診斷。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至學習障礙、焦慮、睡眠障礙及自閉症的鑑別。

國考與現代臨床差異

- 國考答案D仍是最佳答案。
- 現代標準寫「至少6個月」，不是嚴格的「超過6個月」。
- 診斷不能只依課堂行為，還須取得其他情境的資料。
- 學齡前兒童可以診斷；治療通常優先採用家長訓練及行為介入。
- ADHD沒有可作為必要條件的腦波、生物標記或單一心理測驗。
- 症狀表現會隨年齡改變，不宜把「過動減少」直接解讀成疾病完全消失。

醫學（四）Q31

既有回收附件原文

題目與答案對照

下列何者不是5歲兒童下運動神經元（lower motor neuron）受損的症狀？

- A. 肌肉無力
- B. 無 Babinski sign
- C. 肌肉不自主顫動（fasciculation）
- D. 深層肌腱反射變強

來源：考選部醫學（四）正式試題

- 使用者作答：**B**
- 原始答案：**D**
- 最終更正答案：**D**
- 特殊計分：無，屬真正錯題

原始答案與最終更正檔一致。

核心考點

下運動神經元由脊髓前角細胞或腦神經運動核開始，經神經根、周邊神經到神經肌肉接合處。受損後失去對肌肉及反射弧的直接支配，典型表現為：

- 肌肉無力。
- 肌張力降低。
- 深層肌腱反射降低或消失。
- 肌肉萎縮。
- Fasciculation。
- 足底反射屈曲或無反應，不出現典型Babinski sign。

相反地，**深層肌腱反射增強**通常指向上運動神經元病灶。NCBI下運動神經元病灶整理

各選項解析

A．肌肉無力——符合LMN病灶

上下運動神經元病灶都可能造成無力，因此無力本身不能區分兩者；必須再看肌張力、反射、萎縮、肌束顫動及病理性足底反射。

B．無Babinski sign——符合LMN病灶

Babinski sign代表刺激足底後大拇趾背屈、其他趾呈扇形張開，通常反映皮質脊髓徑等上運動神經元系統受損。

LMN病灶不會產生典型Babinski sign，因此B雖然寫的是「沒有某項徵象」，仍與LMN定位一致。

5歲兒童已超過嬰幼兒可能出現生理性伸性足底反射的階段，可按成人式定位判讀。

C．Fasciculation——符合LMN病灶

肌束顫動是運動單位失神經後產生的不規則肌纖維束收縮，常見於：

- 前角細胞疾病，例如脊髓性肌肉萎縮症。
- 運動神經元疾病。
- 神經根或周邊神經病變。

若同時出現無力、萎縮及反射下降，其定位價值更高。

D．深層肌腱反射變強——不符合，為答案

深層肌腱反射需要完整的感覺神經、脊髓突觸、運動神經與肌肉。LMN或反射弧受損時，反射通常降低。

反射增強、clonus及Babinski sign則是失去中樞抑制後的上運動神經元表現，因此D方向相反。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選B可能是注意到「無Babinski sign」並非一項陽性的症狀，而只是病理反射不存在，因此認為它不應列入LMN表現。這項語意質疑並非沒有道理，但D存在更直接的神經定位矛盾：

> **LMN切斷反射弧，反射應下降；反射增強要想UMN。**

- 失分類型：上下運動神經元定位、反射方向、陰性徵象與症狀措辭。
- 數秒判斷規則：**「LMN軟、弱、縮、跳、反射低；UMN硬、反射高、Babinski陽性。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至脊髓性肌肉萎縮、周邊神經病變、脊髓病變及急性無力鑑別。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

- 國考答案D與現代神經定位一致。
- B的「無Babinski sign」比較像檢查結果，而非患者主訴的症狀；題目用詞不夠精確，但不影響D是唯一方向相反者。
- 急性上運動神經元病灶在脊髓休克階段可能暫時呈現低張力與反射下降，不能只憑單次反射直接定案。
- 臨床應綜合反射、肌張力、萎縮、感覺分布及無力型態，不宜單靠任何一項徵象。

醫學（四）Q32

既有回收附件原文

題目與答案對照

意識改變是臨床上很重要的評估，Glasgow Coma Scale（GCS）昏迷指數≦8時，往往需要積極維持呼吸道之處理。下列關於兒童意識評估的描述，何者最不適當？

- A. GCS中，「語言表達反應」在嬰幼兒與較大兒童意識評估上有所不同
- B.「坐立難安、激動（restless, agitated）」在嬰幼兒的GCS語言項目評為3分
- C.「可定位疼痛（localizes pain）」在嬰幼兒的GCS動作項目上評為5分
- D. 長期臥床無反應的病患，開閉眼、肢體動作、腦幹反射與呼吸型態皆為Full Outline of Unresponsiveness score評估的項目
- 使用者作答：**C**
- 原始答案：**B**
- 最終更正答案：**B**
- 特殊計分：無，屬真正錯題

核心考點

兒童GCS仍評估三個構面：

- Eye：最高4分。
- Verbal：最高5分。
- Motor：最高6分。

但尚未具備成人語言能力的嬰幼兒，verbal項目必須改用哭聲、安撫反應、互動及聲音反應評估。

本題採用的兒童GCS版本中：

- Persistent irritability：3分。
- Restless / agitated：**2分**。
- Localizes pain：動作反應**5分**。

所以B把2分寫成3分，是最不適當者。

各選項解析

A．嬰幼兒與較大兒童的語言評分不同——正確

成人或能正常言語的兒童可評估是否定向、混亂或使用不適當字詞；嬰幼兒則需用：

- 咿呀聲及適齡互動。
- 是否容易安撫。

- 持續哭泣或躁動。
- 對疼痛是否僅有呻吟。

因此不能要求尚未發展語言的嬰兒回答人物、時間及地點。

B．Restless、agitated評3分——錯誤，為答案

依原題採用的版本：

- 5分：適齡聲音、微笑或正常互動。
- 4分：哭泣但可安撫。
- 3分：持續煩躁或對疼痛哭泣。
- **2分：坐立難安、激動或僅有呻吟。**
- 1分：無反應。

不同兒童GCS表格的描述文字略有差異，但題目中的restless / agitated通常放在2分級距。兒童GCS臨床量表

C．Localizes pain為動作5分——正確

動作評分骨架為：

- 6：依指令或適齡自主動作。
- **5：定位疼痛刺激。**
- 4：僅從疼痛處縮回。
- 3：異常屈曲。
- 2：異常伸展。
- 1：無反應。

「定位疼痛」代表手會朝刺激位置移動、試圖排除刺激，層級高於單純把肢體縮回，因此C正確。

D．FOUR score評估眼、動作、腦幹反射及呼吸——正確

FOUR是Full Outline of UnResponsiveness的縮寫，四個構面各0至4分：

1. Eye response。
2. Motor response。
3. Brainstem reflexes。
4. Respiration pattern。

它不需要verbal score，因此對插管、失語或無法言語的患者特別有用；還能補充GCS沒有直接評估的腦幹反射與呼吸型態。FOUR score原始驗證研究

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是把「localizes pain」與「withdraws from pain」的分數混淆，或使用另一套嬰兒動作描述而對5分有所疑慮。

關鍵是先保留固定的動作骨架：

遵從6、定位5、縮回4、屈曲3、伸展2、無反應1。

再處理嬰幼兒語言項目的特殊描述。

- 失分類型：評估工具與所測構念、兒童GCS分數級距、定位與縮回疼痛混淆。
- 數秒判斷規則：**「GCS是眼4、語5、動6；動作背6-5-4＝遵從、定位、縮回。FOUR則是眼、動、腦幹、呼吸。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至急診神經評估、插管病患、腦幹功能及病情趨勢監測。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

- 國考答案B合理；C的localizes pain＝5分正確。
- 不同兒童GCS版本的verbal描述並不完全一致，臨床紀錄最好同時寫出各構面分數及實際反應，不只記總分。
- GCS≤8代表嚴重意識障礙，應立即評估氣道保護與通氣能力，但現代臨床不主張僅因總分達8便機械式插管；還要評估保護性反射、呼吸、氧合、病程及可逆原因。
- FOUR score在插管患者具有優勢，但原始驗證主要來自成人神經重症族群；兒童臨床仍以年齡校正的GCS較普遍。
- 目前Brain Trauma Foundation仍將第三版兒童重度腦傷指引列為現行版本；意識量表是序列評估的一部分，不能取代完整神經檢查及顱內壓風險判斷。兒童重度腦傷現行指引

醫學（四）Q36

既有回收附件原文

題目與答案對照

12歲男性，下肢出現紅疹（如附圖），同時伴有腹痛及關節痛症狀。在皮膚紅疹出現前，曾發生過感冒。對於此病症相關的臨床檢查，下列何者較不需要？

- A. 皮膚切片併免疫螢光染色檢查
- B. 紅血球沉降速率
- C. 尿液檢查
- D. 血清免疫球蛋白E（IgE）

來源：考選部醫學（四）正式試題

- 使用者作答：**B**
- 原始答案：**D**
- 最終更正答案：**D**
- 特殊計分：無，屬真正錯題

原始答案與最終更正檔一致；更正檔只影響Q14與Q28。

核心考點

下肢紫斑、腹痛、關節痛，加上近期上呼吸道感染，典型指向**IgA血管炎**。

檢查應依目的排序：

1. 尿液及血壓：篩檢常無症狀的腎臟受累。
2. 皮膚切片加直接免疫螢光：診斷不典型或需排除其他血管炎時使用。
3. ESR：非專一性發炎指標，診斷價值有限，但在鑑別全身性發炎疾病時可能採驗。
4. IgE：不是IgA血管炎的標準診斷、腎臟篩檢或預後檢查，因此最不需要。

各選項解析

A．皮膚切片併免疫螢光——有條件地需要

典型病例通常可臨床診斷，不必常規切片；但若紫斑分布或外觀不典型、診斷不明，切片可顯示白血球碎裂性小血管炎，直接免疫螢光可見IgA沉積。

因此A不是每位患者都必做，但與確認疾病機轉仍有直接關聯。

B．ESR——通常不是必要檢查，但可能用於鑑別

ESR可能因發炎而升高，卻不能確診IgA血管炎，也不能可靠預測腎炎。

使用者選B具有臨床上的合理性：對典型病例，ESR確實經常不需檢驗。但與IgE相比，ESR至少仍可能在診斷不明、需評估感染或其他全身性發炎疾病時作為輔助。

C．尿液檢查——必須優先完成

腎臟受累可能只有顯微血尿或蛋白尿，患者沒有症狀。尿液檢查及血壓測量是初診與後續追蹤的核心。

RCH指引明確指出，懷疑IgA血管炎時必須進行尿液與血壓評估；典型病例通常只需尿液檢查，不需廣泛抽血。RCH兒童IgA血管炎指引

D．血清IgE——最不需要，為答案

IgE主要與立即型過敏、寄生蟲感染及部分免疫疾病相關，並非IgA血管炎的診斷依據。

IgA血管炎雖是免疫介導疾病，但疾病名稱中的IgA不能延伸成「所有免疫球蛋白都值得檢查」。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：你可能正確辨識ESR缺乏專一性，因此選B；但題目問的是四項中「較不需要」，還需比較各檢查與疾病的關聯強度。

- ESR：雖非必要，仍可輔助鑑別發炎性疾病。
- IgE：既不能確診，也不負責腎臟篩檢或風險分層，關聯更低。

失分類型

- 檢查目的與所測構念
- 必要檢查與非專一性輔助檢查排序
- IgA與IgE概念區分
- 「不是常規檢查」與「四項中最不需要」的最佳答案判斷

數秒判斷規則

> **IgA血管炎先驗尿、量血壓；切片留給不典型病例。IgE與診斷及腎炎篩檢均無直接關係。**

投資報酬率

高。可延伸至兒童紫斑鑑別、IgA血管炎腎炎、尿蛋白定量、血壓追蹤及腎臟切片適應症。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

- 國考答案D合理。
- 現代臨床中，典型病例的A與B往往也不需常規進行，因此題目辨識度並不完美。
- 尿液及血壓才是不能遺漏的檢查，因腎臟受累常無症狀。
- 2025年發表的IPNA兒童IgA腎病 / IgA血管炎腎炎建議，進一步依血尿、蛋白尿、腎功能及持續時間決定腎臟追蹤與切片，而不是依IgE判斷。IPNA臨床建議

醫學（四）Q37

既有回收附件原文

題目與答案對照

48歲男性，因為痛風服用allopurinol後，出現高燒且全身（含生殖器及口腔黏膜）水疱潰瘍，皮膚科醫師確診為Stevens–Johnson syndrome，下列敘述何者錯誤？

- A. 皮膚病理切片可見表皮層和真皮層的裂解，表皮細胞明顯壞死
- B. 皮膚組織直接免疫螢光檢查呈現表皮層和真皮層之間線狀分布的免疫堆積
- C. 常侵犯眼睛黏膜
- D. 若無感染症狀，不必常規使用抗生素，且以支持性療法為主
- 使用者作答：**D**
- 原始答案：**B**
- 最終更正答案：**B**
- 特殊計分：無，屬真正錯題

核心考點

SJS與TEN是同一疾病光譜，主要由藥物誘發的細胞毒性免疫反應造成角質細胞凋亡及表皮壞死。

典型特徵包括：

- 疼痛性紅斑、水疱與表皮剝離。
- 至少兩處黏膜受累，常見口腔、眼睛及生殖器。
- 病理可見廣泛角質細胞壞死、全層表皮壞死及表皮下分離。
- **直接免疫螢光通常陰性。**

各選項解析

A．表皮壞死及表皮—真皮分離——正確

早期可見散在角質細胞凋亡；嚴重時形成全層表皮壞死及表皮下裂隙。

題目所稱「表皮層和真皮層裂解」用詞不夠精確，但大致對應表皮—真皮交界處分離。

B．基底膜帶線狀免疫沉積——錯誤，為答案

SJS/TEN不是抗體沉積型水疱病，直接免疫螢光通常為陰性。

若看到表皮—真皮交界處線狀IgG或C3沉積，反而應考慮：

- Bullous pemphigoid。
- Mucous membrane pemphigoid。
- Epidermolysis bullosa acquisita。

- 其他自體免疫性表皮下水疱病。

皮膚切片的直接免疫螢光在此主要用來排除這些模仿疾病。SJS/TEN病理與直接免疫螢光

C．常侵犯眼睛黏膜——正確

急性期可能出現：

- 結膜炎及結膜潰瘍。
- 角膜上皮缺損。
- 偽膜及眼瞼黏連。
- 後續乾眼、角膜混濁、倒睫及視力損害。

不能等到視力下降才會診；嚴重或疑似眼部受累者應早期由眼科評估。

D．無感染時不常規使用抗生素，以支持治療為主——正確

主要處置包括：

- 立即停用可疑致病藥物。
- 補充液體、電解質、熱量及蛋白質。
- 疼痛、體溫及傷口照護。
- 眼睛、口腔、生殖泌尿及呼吸道照護。
- 監測敗血症與器官損傷。

皮膚屏障破壞雖增加感染風險，但預防性全身抗生素沒有常規效益，還可能造成抗藥性、藥物反應及菌叢改變；有感染證據時才依培養與臨床狀態治療。2024年S3指引也將多專科支持治療列為急性期照護核心。2024年SJS/TEN S3支持治療指引

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選D可能是因SJS/TEN屬危及生命的嚴重疾病，而認為單純支持治療不足，或認為廣泛表皮脫落後應預防性使用抗生素。

但「支持性治療為主」不代表消極處置；它包含高度密集的液體、傷口、感染、眼科與器官支持。B則與SJS/TEN的病理機轉直接矛盾。

失分類型

- SJS/TEN病理機轉
- 直接免疫螢光判讀
- 細胞毒性疾病與抗體沉積型水疱病混淆
- 支持治療與預防性抗生素
- 皮膚—黏膜急症鑑別

數秒判斷規則

> **SJS/TEN是表皮細胞被殺死：全層壞死、表皮下分離、DIF陰性；看到基底膜線狀免疫沉積，要轉想自體免疫水疱病。**

投資報酬率

**極高。*可延伸至SJS / TEN體表面積分類、SCORTEN、allopurinol與HLA-B58:01、藥物停用、燒傷中心照護及眼科併發症。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

- 國考答案B與現代病理學一致。
- Allopurinol是典型高風險藥物；應立即停用並永久避免再次暴露。
- 直接免疫螢光預期陰性，但其價值在排除自體免疫水疱病。
- 支持治療仍是處置根基；是否加用cyclosporine、etanercept、類固醇或其他免疫調節治療，須依病程、禁忌與當地專科團隊決定，不能取代支持照護。
- 不建議在沒有感染證據時常規給予預防性全身抗生素。SJS/TEN臨床整理

醫學（四）Q41

對話詳解原文

題目與作答對照

45歲男性，主訴近一年來在左側大腿出現一個直徑約7 mm硬實的結節（圖一），偶爾有自發性的痛感。臨床醫師用兩根手指掐捏腫瘤的邊緣，發現上述的病灶會凹陷，出現了很典型的dimple sign（圖二）。下列何者為最可能的診斷？

- A. 皮膚纖維瘤（dermatofibroma）
- B. 脂肪瘤（lipoma）
- C. 神經纖維瘤（neurofibroma）
- D. 血管瘤（hemangioma）

已核對考選部正式試題及附圖：圖一為棕色隆起結節，圖二呈現由兩側掐捏後的中央凹陷。

使用者作答	原始答案	最終更正後答案	特殊計分
C	A	A	無，屬真正錯題

依據：原始答案、最終更正檔。

核心考點

「會凹陷」還不夠，必須辨認怎麼操作才凹陷。

徵象	操作及反應	典型配對
Dimple sign	從病灶兩側掐捏，中央皮膚凹陷	皮膚纖維瘤
Buttonhole invagination	直接用手指按壓，病灶向內陷入	神經纖維瘤

兩者不是同一項檢查的不同名稱。皮膚纖維瘤、單發性神經纖維瘤

各選項解析

A．皮膚纖維瘤——正確

典型為四肢的硬實小結節，常呈棕色，有時疼痛或搔癢。病灶與表面皮膚相連，側向掐捏時出現中央凹陷。本題的大小、質地、位置及操作反應形成一致的診斷組合。DermNet臨床描述

B．脂肪瘤——不符合主要線索

脂肪瘤位於皮下，通常柔軟或有橡皮樣觸感，表面皮膚一般不與腫瘤緊密牽連。因此「硬實小結節＋側捏後皮膚凹陷」不如A典型。DermNet脂肪瘤，2024年10月審閱

C．神經纖維瘤——最值得辨別的干擾選項

神經纖維瘤可以出現按壓內陷的buttonhole現象，但本題明確描述的是**兩指掐捏邊緣**，並直接命名dimple sign，應優先配對皮膚纖維瘤。

此外，單發性神經纖維瘤不等同於已確診神經纖維瘤病。DermNet單發性神經纖維瘤

D．血管瘤——不是最佳配對

題幹與附圖的主要診斷線索是硬實結節及dimple sign，並未提供足以讓血管性病灶優於A的證據。不能因結節偶爾疼痛，就將其直接歸為血管瘤。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是記得神經纖維瘤「按下去會凹」，因而把buttonhole現象與dimple sign混在一起。也可能只是兩種腫瘤的徵象配對不熟；僅憑答案不能確認當時思路。

- 失分類型：臨床徵象與操作方式配對、dimple / buttonhole混淆。
- 數秒判斷規則：**「側捏凹陷找dermatofibroma；直接按入才聯想neurofibroma的buttonhole。」**
- 投資報酬率：高；可延伸至皮膚結節的質地、所在層次及表面皮膚牽連程度。

現行證據與國考 / 臨床差異

本題屬臨床徵象辨識，並非需要新治療指引才能決定答案的題型。2026年9月14日重新查核的現行專科資料支持A。

臨床上，dimple sign是支持線索，**不是保證良性的通行證**。若病灶近期增大、潰瘍、外觀不對稱或診斷不確定，仍應考慮切片；典型且無困擾的皮膚纖維瘤通常不必治療。DermNet診斷與處置

醫學（四）Q42

對話詳解原文

題目與作答對照

28歲的女性因每日落髮大於150根而至皮膚科就診。經詢問後發現，其3個月前開始減肥並實行嚴格的卡路里控管，體重減少約15公斤。仔細觀察頭皮並沒有發炎的現象，毳毛（vellus hair）也沒有增加。此病患落髮的原因最有可能為下列何者？

- A. 休止期落髮（telogen effluvium）
- B. 生長期落髮（anagen effluvium）
- C. 圓禿（alopecia areata）
- D. 紅斑性狼瘡（lupus erythematosus）

來源：考選部正式試題。

使用者作答	原始答案	最終更正後答案	特殊計分
C	A	A	無，屬真正錯題

依據：原始答案、最終更正檔。

核心考點

嚴格節食、快速減重，經過約三個月才出現明顯掉髮，最支持休止期落髮。

誘因使較多毛囊提早離開生長期；毛髮經過休止期後才脫落，因此誘因與掉髮之間存在延遲。英國皮膚科醫學會2025年10月資料將極端節食、顯著減重及約三個月的延遲列為典型線索。BAD休止期落髮資料

各選項解析

A．休止期落髮——正確

本題有明確誘因與相符時間差，且沒有描述發炎、瘢痕或局部圓形禿髮斑，整體最符合TE。

不能把「每天超過150根」單獨當作確診門檻；落髮計數還受洗髮頻率與蒐集方式影響，病史及頭皮檢查更重要。BAD診斷說明

B．生長期落髮——時間與誘因不如A吻合

典型機轉是生長中的毛髮基質細胞受損，例如化療或毒性暴露，毛幹快速受損、斷裂或脫落。化療後常在約2至4週發生，而不是本題節食後約三個月的延遲型態。DermNet生長期落髮

C．圓禿——正常外觀頭皮不能單獨支持它

圓禿常見界線清楚、表面光滑的圓形或橢圓形落髮斑，可有驚嘆號毛等線索；也存在瀰漫型，不能說沒有圓形禿髮斑就絕對排除。

但本題沒有提供這些特徵，反而有高度相關的減重病史與延遲時間，因此A更適當。DermNet圓禿，2024年7月更新

D．紅斑性狼瘡——缺乏支持它優於A的線索

頭皮盤狀狼瘡可有鱗屑、毛囊病變及瘢痕性落髮；狼瘡也可能造成非瘢痕性瀰漫落髮。因此「頭皮沒有發炎」不能完全排除所有狼瘡相關落髮。

本題未提供其他狼瘡線索，減重後的時間關係則更直接支持TE。DermNet皮膚狼瘡，2024年9月更新

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是把「頭皮看起來正常、卻大量掉髮」優先連到圓禿，沒有充分利用嚴格節食及約三個月的時間差。也可能是不熟悉毛髮週期；不能據此斷言當時忽略了哪一句。

- 失分類型：落髮誘因與時間軸、休止期落髮 / 圓禿鑑別。
- 數秒判斷規則：**「大量掉髮先倒查兩三個月：節食、減重或重大身體壓力，優先想TE。」**
- 投資報酬率：高；可延伸至產後、疾病後落髮，以及生長期落髮的時間差鑑別。

現行證據與國考 / 臨床差異

國考答案A與現行認識一致。BAD的2025年10月資料是專科醫學會衛教建議，**不是新發布的正式診斷指引**；不應混稱。

臨床仍需確認落髮分布、持續誘因及必要的缺鐵、甲狀腺等評估。典型TE主要處理誘因與營養問題；掉髮改善及髮量恢復需要時間，不代表每位患者都需要藥物。BAD評估與處置

「毳毛沒有增加」是輔助描述，不能單獨確診TE，也不能單靠它排除所有其他落髮疾病。

醫學（四）Q44

先前重建版

關於急性缺血性腦中風之處置，下列何者最適當？

- A. 不論到院時血壓數值，皆應控制在185/110 mmHg以下
- B. 不論到院時血糖數值，皆應控制在140～180 mg/dL
- C. 輕度中風建議短期合併抗血小板藥物clopidogrel與ticagrelor
- D. 頸動脈剝離建議使用抗凝血劑或抗血小板藥物預防再次中風

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
C	**D**	**D**	無，屬真正錯題

核心考點

這題考的是**處置的適用條件與藥物組合**。看到熟悉的血壓、血糖數字或「雙重抗血小板」，還要確認它適用於哪種患者。

A．所有患者皆控制至185/110以下——錯誤

185/110是重要的**靜脈溶栓前血壓門檻**，不能套用到所有缺血性中風。

情境	判讀重點
準備接受靜脈溶栓	血壓須降至＜185/110 mmHg
溶栓後最初24小時	維持＜180/105 mmHg
未接受溶栓或取栓，且無其他急迫降壓適應症	血壓＜220/120時，不應一律急著降至185/110以下

因此A的問題在於「不論……皆」。AHA/ASA 2026指引，血壓章節

B．所有患者血糖皆控制在140～180——錯誤

140～180 mg/dL是**持續高血糖的治療目標**，不是把所有人的血糖都調整到這個區間。

例如原本血糖100 mg/dL，不能據此主張要升到140以上；低血糖則應及時矯正。2026指引亦不建議為改善中風預後而積極使用胰島素壓到80～130，因會增加嚴重低血糖風險。AHA/ASA 2026指引更新摘要

C．Clopidogrel＋ticagrelor——錯誤，也是本題最重要的陷阱

中風短期雙抗血小板的典型組合是：

- **Aspirin＋clopidogrel**。
- 特定條件下可考慮**aspirin＋ticagrelor**。

Clopidogrel與ticagrelor同為P2Y12抑制劑；本題把兩者直接配在一起，並非指引建議的中風DAPT組合。

2026指引對未接受靜脈溶栓的特定輕度非心因性中風患者，建議早期開始aspirin + clopidogrel，通常使用21天後轉為單藥。不能只記「輕度中風用兩種抗血小板」。AHA/ASA 2026指引，抗血小板章節

D．頸動脈剝離可用抗凝血或抗血小板——正確

頸部動脈剝離可能形成血栓並造成腦栓塞，因此需要抗血栓治療預防復發。

AHA 2024科學聲明支持個別化選擇抗血小板或抗凝血治療；發生缺血性中風者通常接受約3～6個月抗血栓治療。這裡的「或」很重要，並不是常規把兩類一起使用。AHA頸部動脈剝離聲明解讀

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是記得「輕度中風可以短期DAPT」，但沒有進一步核對兩個藥名；也可能混淆了「aspirin + clopidogrel」與「aspirin + ticagrelor」。僅憑答案不能確認當時思路。

- **失分類型：**治療適用條件、具體藥物配對、同類藥物辨識。
- **數秒判斷規則：**「中風雙抗先找aspirin，再搭一個P2Y12抑制劑；185/110先問是否準備溶栓。」
- **投資報酬率：極高。**同時涵蓋急性中風血壓、血糖、次級預防及頸動脈剝離。

國考答案與現代臨床差異

官方D與現行證據方向一致，但臨床仍須依梗塞範圍、出血風險、血管影像及病灶位置選藥。頸部動脈剝離的處理不能直接套用到伴蜘蛛網膜下腔出血的顱內剝離。

另外，**NIHSS低不等於症狀不致失能**；符合條件且有致失能缺損者，仍須評估再灌流治療，不能看到「輕度」就一律只給雙抗。AHA/ASA 2026更新摘要

醫學（四）Q45

先前重建版

一位52歲女性，家族中有母親與哥哥曾因顱內動脈瘤破裂導致蜘蛛網膜下腔出血。她本身患有多囊腎病（autosomal dominant polycystic kidney disease），目前無神經症狀。接受腦部MRI時，意外發現一顆5 mm的後交通動脈（posterior communicating artery）動脈瘤。下列敘述何者最適當？

- A. 該動脈瘤5年內破裂風險極低（＜1%），無需追蹤
- B. 因動脈瘤位於後循環，5年內破裂風險約2.5%，應考慮積極評估或處理
- C. 若無高血壓或家族史，後交通動脈瘤5 mm的破裂風險與前大腦動脈／中大腦動脈類似
- D. 除非有動靜脈畸形共病，多囊腎病並非顱內動脈瘤的危險因子

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
D	**B**	**B**	無，屬真正錯題

核心考點

不能只看到「5 mm、沒有症狀」就判定不用追蹤。本題同時提供：

線索	意義
ADPKD	顱內動脈瘤的重要危險背景
母親與哥哥皆有動脈瘤破裂史	兩位一等親的強烈家族史
後交通動脈位置	風險評估須納入位置
5 mm、無症狀	不代表沒有破裂風險或不需追蹤

KDIGO 2025明確指出ADPKD與顱內動脈瘤及破裂風險增加相關，家族史也是重要評估依據。
KDIGO 2025第6章重點

A．小於1%、無需追蹤——錯誤

題幹不足以支持「個人5年風險必定＜1%」，更不能推導出無需追蹤。

即使評估後決定暫不介入，通常仍須安排影像監測及風險控制；**不立即手術與不需追蹤是兩回事**。
ESO 2022未破裂顱內動脈瘤指引

B．官方答案，但有兩項必須修正的理解

首先，**2.5%有歷史研究來源**。ISUIA 2003研究中，沒有個人既往蜘蛛網膜下腔出血、動脈瘤＜7 mm，且位於「後循環或後交通動脈」這個合併分組者，5年累積破裂率為2.5%。ISUIA原始研究

但不能照字面把B全部背成通則：

1. **風險分組不等於解剖分類。**原研究明列「後循環及後交通動脈瘤」合併分析；不能因放在同組，就把後交通動脈瘤一概稱為後循環動脈瘤。常見內頸動脈—後交通動脈交界動脈瘤在解剖分類上

屬前循環。

2. **2.5%不是這位患者的精確個人預測。**她還有ADPKD與強烈家族史，不能直接套用一般研究分組的平均值。

所以B應抓住的正確方向是：**需要積極專科評估，並考慮是否介入**，而不是「已算出她一定有2.5%風險，必須開刀」。

C．沒有高血壓或家族史，位置風險就相同——不適當

移除兩項危險因素，不會使動脈瘤位置失去意義。破裂風險還受位置、大小、形態及是否增長等影響，不能直接宣稱相同。

也不要反向記成「所有前循環都安全」；不同部位不能粗略混成一組。ESO風險評估建議

D．ADPKD須合併AVM才是危險因子——明確錯誤

ADPKD本身就是顱內動脈瘤的重要危險背景，不需先合併動靜脈畸形。

動脈瘤與AVM是不同的血管病變。KDIGO 2025對有相關家族史、且適合接受治療的ADPKD患者，建議進行顱內動脈瘤篩檢，並沒有「須合併AVM」這項前提。KDIGO 2025建議

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選D可能是尚未建立「ADPKD—顱內動脈瘤」的固定關聯，或把動脈瘤與AVM的危險背景混在一起。不能據此判定你當時是否已注意到B的用詞問題。

- **失分類型：**遺傳疾病與血管併發症配對、危險因子、群體風險與個人風險。
- **數秒判斷規則：**「ADPKD + 一等親破裂史，小動脈瘤也要評估；5 mm不能直接推出不追蹤。」
- **投資報酬率：高。**可延伸至ADPKD腎外表現、家族性動脈瘤篩檢及預防性介入判斷。

最新指引與國考 / 臨床差異

官方仍判B，沒有多答案或一律給分更正；但B的解剖措辭及風險數字需要保留上述限制。

現代臨床會由腦血管專科比較**自然破裂風險與預防性治療風險**，再結合形態、增長、病史及患者意願決定追蹤或介入。ESO 2022指引以這種風險比較為核心，並不是單憑5 mm或單一百分比決定手術。ESO指引

KDIGO 2025也支持ADPKD相關高風險者的篩檢與個別化照護；篩檢影像優先考慮不需釓顯影劑的TOF-MRA。KDIGO指引重點

醫學（四）Q48

對話詳解原文

題目與答案對照

45歲女性，最近一個月出現記憶障礙與反覆右手抽搐。MRI T2 FLAIR影像顯示顳葉高訊號變化，腦電圖（EEG）顯示局部慢波，血清抗體陽性。下列何者為最可能之病因？

- A. HSV（herpes simplex virus）腦炎
- B. 自體免疫性邊緣葉腦炎（autoimmune limbic encephalitis）
- C. 多發性硬化症（multiple sclerosis）
- D. 代謝性腦病變（metabolic encephalopathy）

來源：考選部醫學（四）正式試題

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
A	B	B	無，屬真正錯題

原始答案與最終更正檔一致。

核心考點

本題是典型的**次急性邊緣葉症候群**：

- 病程約一個月，符合小於三個月的次急性進展。
- 記憶障礙，對應海馬及邊緣系統功能。
- 反覆右手抽搐，支持左側顳葉局部癲癇。
- 顳葉T2 / FLAIR高訊號。
- EEG局部慢波，支持局部腦功能異常。
- 血清神經抗體陽性。

整體最支持B。但臨床上，顳葉病灶同時也是HSV腦炎的重要鑑別，不能僅憑血清抗體便停止感染評估。

各選項解析

A．HSV腦炎——重要鑑別，但不是本題最佳答案

HSV腦炎也可出現：

- 記憶障礙及意識改變。
- 局部癲癇。
- 顳葉FLAIR或DWI異常。

- EEG顳葉週期性放電或局部慢波。

其典型病程通常較急，常在數天內出現發燒、頭痛及快速惡化的腦病變。本題沒有提供發燒或感染前驅，反而給出一個月的次急性病程及抗體陽性，因此整體較偏向自體免疫性腦炎。

不過，影像或臨床懷疑腦炎時，仍應檢驗CSF HSV PCR，並在結果尚未明確前給予經驗性靜脈acyclovir；不能因懷疑自體免疫疾病便延誤HSV治療。自體免疫性腦炎診治共識

B．自體免疫性邊緣葉腦炎——正確

常見表現包括：

- 近期記憶形成障礙。
- 癲癇或癲癇重積。
- 精神或行為改變。
- 睡眠及自主神經異常。
- 內側顳葉MRI異常。
- EEG顳葉局部慢波或癲癇放電。

可能相關抗體包括LGI1、CASPR2、GABA-B receptor、AMPAR、GAD65及部分腫瘤神經抗體；不同抗體的臨床表型、腫瘤關聯及血清 / CSF檢驗敏感度並不相同。自體免疫性腦炎抗體與表型整理

C．多發性硬化症——不符合主要症候群

MS較典型的是視神經炎、脊髓炎、腦幹症候群或其他時間與空間多發的中樞脫髓鞘事件。它可以造成癲癇或認知症狀，但「次急性記憶障礙 + 局部癲癇 + 顳葉高訊號 + 相關抗體」更符合邊緣葉腦炎。

D．代謝性腦病變——不符合局部性

代謝性腦病變通常引起較瀰漫的意識、認知或注意力障礙，EEG常呈廣泛性慢波。除非是低血糖、高血糖等特定狀況，通常不能妥善解釋局部手部抽搐及侷限顳葉影像異常。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選A可能是正確注意到HSV具有高度辨識力的顳葉侵犯與局部癲癇，卻讓單一影像定位壓過一個月的次急性病程及神經抗體線索。

這不是完全沒有臨床道理；真正臨床處置確實必須先排除HSV。但國考問的是整體「最可能」病因，應選B。

失分類型

- 自體免疫性邊緣葉腦炎
- HSV腦炎鑑別
- 疾病時間軸
- 顳葉MRI與EEG判讀
- 單一影像特徵與整體證據權重
- 血清與CSF抗體檢驗差異

數秒判斷規則

> **數天發燒、頭痛、快速惡化的顳葉腦炎先想HSV；數週至三個月的記憶障礙、癲癇、精神症狀加神經抗體，優先想自體免疫性邊緣葉腦炎。臨床上兩者仍須同步排除。**

投資報酬率

極高。可延伸至首次癲癇、腦炎性精神症狀、LGI1相關faciobrachial dystonic seizure、低血鈉、抗NMDAR腦炎及腫瘤篩檢。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

- 國考答案B合理。
- 現行診斷架構以小於三個月的記憶、精神或癲癇症狀，結合MRI、EEG、CSF及神經抗體判斷。
- **血清抗體陽性不能單獨確診。**低效價或臨床相關性不足的抗體可能是假陽性；通常需依抗體特性同時檢驗血清與CSF。
- 嚴格的抗體陰性「確定邊緣葉腦炎」影像條件通常要求雙側內側顳葉異常；本題只寫「顳葉」，沒有交代單側或雙側。
- 應以腰椎穿刺檢查細胞數、蛋白、寡克隆帶、HSV / VZV PCR及神經抗體。感染尚未排除前通常先給acyclovir；不能直接只上免疫治療。
- 若臨床高度懷疑且感染已合理排除，不應為了等待抗體結果而延誤類固醇、IVIG或血漿置換。2021自體免疫性腦炎最佳實務建議

醫學（四）Q51

對話詳解原文

題目與答案對照

下列疾病的主要病理變化，何者不屬於tau蛋白病變（tauopathy）？

- A. 多重系統萎縮症（multiple system atrophy）
- B. 進行性上眼神經核麻痺症（progressive supranuclear palsy）
- C. 皮質基底核退化症（corticobasal degeneration）
- D. 阿茲海默病（Alzheimer disease）

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
C	A	A	無，屬真正錯題

核心考點

神經退化疾病先按主要堆積蛋白分類：

蛋白病理	代表疾病
α-synucleinopathy	MSA、Parkinson disease、DLB
4R tauopathy	PSP、CBD
3R + 4R tau並伴Aβ	Alzheimer disease
TDP-43 proteinopathy	多數ALS、部分FTD
Prion protein	CJD

因此唯一不以tau為定義性主要病理的選項是MSA。

各選項解析

A．多重系統萎縮症——不屬於tauopathy，為答案

MSA的定義性病理為：

- 少突膠細胞內的α-synuclein陽性glial cytoplasmic inclusions。
- 又稱Papp–Lantos bodies。
- 依臨床主要表現分為MSA-P與MSA-C。
- 常合併早期且明顯的自主神經功能障礙。

2022年Movement Disorder Society診斷標準仍將α-synuclein陽性神經膠細胞質包涵體視為病理確認MSA的必要核心。MDS 2022 MSA診斷標準

B．Progressive supranuclear palsy——屬於4R tauopathy

PSP的病理以四重複序列tau為主，可見：

- Globose neurofibrillary tangles。
- Tufted astrocytes。
- 基底核、黑質、丘腦下核及腦幹受累。

典型臨床表現包括垂直核上性凝視麻痺、早期跌倒、軸性僵硬及額葉執行功能障礙。

官方中文寫成「進行性上眼神經核麻痺症」並不標準，較常用名稱是**進行性核上性麻痺**；英文則沒有歧義。

C．皮質基底核退化症——屬於4R tauopathy

CBD可見：

- 神經元及膠細胞內4R tau堆積。
- Ballooned neurons。
- Astrocytic plaques。
- 皮質及白質的不對稱性病變。

這是使用者選擇的干擾項，但CBD正是經典4R tauopathy之一。PSP與CBD病理綜述

須區分：

- **Corticobasal degeneration：**病理診斷，屬4R tauopathy。
- **Corticobasal syndrome：**臨床症候群，底層病理也可能是PSP、Alzheimer disease或TDP-43疾病，不一定都是CBD。

D．阿茲海默病——具有重要tau病理

Alzheimer disease具有兩項核心病理：

- 細胞外amyloid-β斑塊。
- 細胞內過度磷酸化tau神經纖維糾結，包含3R及4R tau。

因此它雖不是「純粹只有tau」的疾病，仍可納入tauopathy範疇；本題不能因為它還有amyloid便將其排除。美國NIA：Alzheimer的amyloid與tau病理

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能表示對corticobasal degeneration的病理蛋白不熟，或將臨床上的corticobasal syndrome病因多樣性，延伸成CBD本身不屬於tauopathy。

也可能尚未建立MSA與α-synuclein的固定配對；僅憑答案不能確定當時思路。

失分類型

- 神經退化疾病—病理蛋白配對
- Tauopathy / synucleinopathy分類
- PSP / CBD / MSA鑑別
- Corticobasal syndrome與degeneration混淆
- 臨床症候群與病理診斷混淆

數秒判斷規則

> **MSA-P或MSA-C都屬α-synucleinopathy；PSP與CBD是4R tau；Alzheimer是Aβ加3R / 4R tau。**

投資報酬率

極高。可延伸至非典型巴金森症候群、REM sleep behavior disorder、自主神經衰竭、垂直凝視麻痺及alien limb的鑑別。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

- 國考答案A與現代神經病理分類一致。
- MSA可能同時出現少量或偶發tau病理，但其**定義性主要蛋白仍是α-synuclein**，不能因此稱為tauopathy。
- PSP與CBD都是4R tauopathy，但臨床表型可能互相重疊。
- Corticobasal syndrome不是CBD的同義詞；單靠臨床表現不能確定底層一定是CBD。
- Alzheimer disease同時具有Aβ與tau病理；若題目問「純粹的原發性tauopathy」，分類措辭會更複雜，但在本題四個選項中A仍是唯一明確的synucleinopathy。

醫學（四）Q52

對話詳解原文

題目與答案對照

關於本態性顫抖（essential tremor）的敘述，下列何者最不適當？

- A. 通常出現雙手對稱性的靜止性顫抖（resting tremor）
- B. 需排除甲狀腺功能亢進及藥物過量（如lithium或valproate），以確立診斷
- C. 常用的治療藥物，包括propranolol及benzodiazepines
- D. 對於藥物治療反應差的病人，可考慮使用聚焦超音波燒灼術

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
B	A	A	無，屬真正錯題

已重新核對考選部正式試題、原始答案及最終更正檔。

核心考點

本態性顫抖的核心是：

> **雙側上肢動作性顫抖，包括姿勢性及動作中顫抖，而不是通常以靜止性顫抖表現。**

現行Movement Disorder Society定義還要求：

- 雙側上肢動作性顫抖。
- 持續至少3年。
- 可合併頭部、聲音或下肢顫抖。
- 沒有足以另立診斷的肌張力不全、共濟失調或巴金森症候群徵象。MDS本態性顫抖定義

各選項解析

A．通常出現對稱性靜止性顫抖——錯誤，為答案

本態性顫抖主要在：

- 維持姿勢時，例如雙手向前伸。
- 寫字、端杯、使用餐具等動作時。
- 接近目標的動作過程中。

靜止性顫抖較典型地使人想到巴金森氏症。長期或較嚴重的本態性顫抖患者偶爾也可能有休息時顫抖，但不能因此把它寫成「通常」表現。MDS顫抖分類共識

B．排除甲狀腺亢進及致顫藥物——適當

本態性顫抖是臨床診斷，應先排除可逆或次發原因，包括：

- 甲狀腺功能亢進。
- 咖啡因或其他興奮劑。
- Lithium。
- Valproate。
- 部分抗憂鬱劑、支氣管擴張劑及免疫抑制劑。
- 酒精或鎮靜藥物戒斷。
- 增強性生理顫抖。

不是每位患者都必須進行完全相同的實驗室套組，但病史或檢查有相應線索時，甲狀腺功能及藥物清單不可忽略。

C．Propranolol及benzodiazepines可用於治療——國考判定適當

藥物證據的優先順序需再細分：

- **Propranolol與primidone：**主要第一線藥物。
- Topiramate：部分患者可考慮。
- Alprazolam或clonazepam等benzodiazepines：可能用於焦慮明顯加重顫抖或其他藥物效果不佳者，但證據及定位不如propranolol、primidone。
- Benzodiazepines須注意嗜睡、跌倒、認知影響、耐受性及依賴風險。

因此C作為「包括哪些可使用藥物」尚可接受，但若寫成benzodiazepines也是主要第一線藥物，就不夠精確。AAN本態性顫抖治療指引

D．藥物難治時可考慮聚焦超音波——適當

經適當藥物治療仍嚴重影響功能者，可評估：

- 深部腦刺激術。
- 射頻丘腦切開術。
- MRI導引聚焦超音波丘腦切開術。

聚焦超音波可減輕藥物難治型手部顫抖，但屬造成永久性病灶的治療，可能產生感覺異常、步態不穩或平衡問題，必須慎選患者。聚焦超音波隨機試驗

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選B可能是認為本態性顫抖可以直接依臨床表型確診，因此不需刻意排除甲狀腺亢進或藥物因素。

但B是在描述鑑別診斷；A則直接把疾病最核心的**動作性顫抖**寫成「通常為靜止性顫抖」，方向明確相反。

失分類型

- 本態性顫抖與巴金森氏症鑑別

- 動作性 / 姿勢性 / 靜止性顫抖分類
- 排除診斷與核心診斷條件
- 第一線與後線治療排序

數秒判斷規則

> **動作時抖想ET，休息時抖先想Parkinson；ET第一線propranolol或primidone，難治再評估DBS或聚焦超音波。**

投資報酬率

極高。可延伸至巴金森氏症、藥物性顫抖、甲狀腺亢進、肌張力不全性顫抖及小腦性顫抖的鑑別。

國考答案與現代臨床差異

- 國考答案A與現行疾病定義一致。
- 現代定義更明確要求雙側上肢動作性顫抖持續至少3年。
- Benzodiazepines不是與propranolol及primidone同等的常規第一線藥物。
- 聚焦超音波主要用於經選擇的藥物難治患者，不能僅因患者想停藥便直接使用。
- 長期ET偶爾可能合併靜止性顫抖；但這不會使A的「通常」敘述變正確。

醫學（四）Q54

對話詳解原文

題目與答案對照

50歲男性，罹患上呼吸道感染數日，兩天前起床後出現步態不穩與複視。神經學檢查發現眼球在每個方向的運動都受到限制，肢體動作不協調，並伴隨深部肌腱反射消失。下列何者是最可能的診斷？

- A. 腦幹中風（brainstem stroke）
- B. 病毒性腦炎（viral encephalitis）
- C. 米勒費雪症候群（Miller Fisher syndrome）
- D. 重症肌無力（myasthenia gravis）

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
B	C	C	無，屬真正錯題

核心考點

本題完整呈現Miller Fisher syndrome三聯徵：

1. **Ophthalmoplegia：**眼外肌麻痺。
2. **Ataxia：**共濟失調、步態不穩。
3. **Areflexia：**深部肌腱反射消失。

再加上近期上呼吸道感染，診斷指向相當明確。MFS屬Guillain–Barré syndrome光譜疾病，通常與anti-GQ1b抗體有關。2023 EAN / PNS GBS診療指引

各選項解析

A．腦幹中風——可造成複視與共濟失調，但不如C完整

腦幹中風可急性出現：

- 眼球運動障礙。
- 構音或吞嚥障礙。
- 共濟失調。
- 交叉性感覺或運動缺損。

但本題是廣泛性眼外肌麻痺加上深部肌腱反射消失，並有近期感染，較支持周邊神經的MFS。腦幹中風通常還會有長束徵象、感覺異常、單側無力或明確腦神經定位。

真實臨床若症狀突然發作，仍不能只靠三聯徵便跳過急性中風影像評估。

B．病毒性腦炎——不符合主要症候群

病毒性腦炎較常出現：

- 發燒。
- 意識或行為改變。
- 癲癇。
- 頭痛。
- 局部神經學缺損。

本題沒有意識改變或癲癇，卻有典型的眼外肌麻痺、共濟失調、反射消失組合，因此B不是最佳答案。

C．Miller Fisher syndrome——正確

MFS通常在呼吸道或腸胃道感染後急性發作。Anti-GQ1b IgG具有高度診斷支持價值，2023年EAN / PNS指引建議懷疑MFS時檢驗anti-GQ1b抗體。

輔助檢查可能包括：

- CSF蛋白升高、白血球數正常或接近正常。
- 神經傳導檢查。
- Anti-GQ1b IgG。
- 必要時腦部MRI，以排除腦幹中風或其他中樞病灶。

但疾病早期CSF蛋白或神經傳導仍可能正常，不能因單次陰性結果排除。

D．重症肌無力——眼球症狀可相似，但反射及共濟失調不符

重症肌無力可造成：

- 複視。
- 眼瞼下垂。
- 波動性、易疲勞的眼外肌或延髓肌無力。

然而：

- 深部肌腱反射通常保留。
- 感覺正常。
- 不會造成真正的共濟失調。
- 近期感染後出現areflexia更支持GBS / MFS光譜。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選B可能是看到近期上呼吸道感染與急性神經症狀，便優先聯想到感染直接侵犯中樞神經，沒有把三個神經學檢查結果整合成固定症候群。

本題的辨識關鍵不是單純「感染後神經症狀」，而是：

眼外肌麻痺 + 共濟失調 + 反射消失。

失分類型

- Miller Fisher syndrome三聯徵
- GBS變異型
- 中樞與周邊神經病灶定位
- 感染前驅與直接感染混淆
- Anti-GQ1b抗體

數秒判斷規則

感染後出現眼不動、走不穩、反射不見，就是Miller Fisher；想到anti-GQ1b。

投資報酬率

極高。可延伸至Guillain–Barré syndrome、Bickerstaff brainstem encephalitis、腦幹中風、重症肌無力及急性眼外肌麻痺的鑑別。

國考答案與現代臨床差異

- 國考答案C與現行診斷架構一致。
- MFS可以是不完整型，也可能與典型運動感覺型GBS重疊；並非每位患者一開始就同時出現全部三項表現。
- Anti-GQ1b高度支持診斷，但陰性不能完全排除。
- CSF的albuminocytologic dissociation可能在第一週尚未出現。
- MFS通常具有良好、自限性的恢復病程；單純MFS使用IVIG或血漿置換的額外效益證據有限。
- 若出現四肢無力、呼吸障礙、吞嚥障礙或自主神經不穩，應考慮GBS重疊並依嚴重GBS處理及監測。
- 意識障礙、錐體徑徵象或中樞影像異常則需考慮Bickerstaff brainstem encephalitis或其他中樞病變。

醫學（四）Q55

對話詳解原文

題目與答案對照

在皮肌炎（dermatomyositis）中，下列那一項臨床或實驗室發現最具有特異性？

- A. 近端肌肉無力
- B. 血清肌酸激酶（CK）升高
- C. 關節疼痛
- D. Gottron's 丘疹或紫羅蘭色皮疹（heliotrope rash）

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
A	D	D	無，屬真正錯題

已重新核對考選部正式試題、原始答案及最終更正檔。

核心考點

「典型表現」不等於「最具特異性」。

近端無力與CK升高可提示肌肉疾病；Gottron丘疹與heliotrope rash則更能把診斷指向皮肌炎。EULAR / ACR分類標準將這些典型皮膚病灶列為重要辨識特徵。2017 EULAR / ACR分類標準

各選項解析

A．近端肌肉無力——常見，但不夠特異

皮肌炎可造成肩帶、骨盆帶等近端肌群無力，例如抬手、起身或爬樓梯困難。但其他肌病也可能呈現相同分布；下一題的類固醇肌病就是例子。

因此A可以支持「肌病」，卻不能有效區分是哪一種肌病。Johns Hopkins皮肌炎資料

B．CK升高——反映肌肉受損，不是皮肌炎專屬

CK是肌肉損傷的重要指標，但肌肉受傷及多種肌肉疾病都可能使它升高。它不能單獨回答「是不是皮肌炎」。MedlinePlus：CK檢查

C．關節疼痛——可以出現，但辨識力低

關節痛可能伴隨皮肌炎，但許多風濕疾病及其他疾病也會出現，特異性不如D。Johns Hopkins皮肌炎資料

D．Gottron丘疹或heliotrope rash——最佳答案

- **Gottron丘疹：**典型為手指關節伸側等部位的紅紫色、可觸及丘疹，可能伴鱗屑。
- **Heliotrope rash：**眼瞼及眼周的紫紅色皮疹，常伴水腫。

這裡不只是「有紅疹」，而是特定外觀與分布的組合。EULAR / ACR皮膚特徵定義

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選A可能是熟悉「皮肌炎會造成近端無力」，但把常見、典型的表現，當成最能區分疾病的表現。僅憑答案，不能確定當時是否漏看「特異性」。

- 失分類型：典型性與特異性混淆、臨床徵象的診斷辨識力。
- 數秒判斷規則：**「近端無力找肌病；Gottron + 眼周紫紅疹更指向皮肌炎。」**
- 投資報酬率：高；可延伸至肌病鑑別、CK判讀及無肌病性皮肌炎。

現行證據與國考 / 臨床差異

國考答案D與目前疾病辨識架構一致。但有兩個臨床限制：

1. **分類標準不等於可以跳過鑑別診斷。**仍要確認皮疹外觀、分布及其他臨床資料。
2. **正常CK不能排除所有皮肌炎。**例如無肌病性皮肌炎可有典型皮膚病灶，卻沒有臨床或實驗室肌肉受累。

本次查核包含2017年分類標準與2025年4月修訂的專科衛教資料；後者不是新發布的正式診斷指引。
Myositis Association皮肌炎資料

醫學（四）Q56

對話詳解原文

題目與答案對照

76歲男性，慢性腎功能衰竭，接受腎臟移植後開始服用環孢素（cyclosporine）和類固醇。數月後出現近端肌無力，以下肢最明顯，但血清肌酸激酶（CK）正常。下列何者為最可能的診斷？

- A. 類固醇引起的肌病（steroid myopathy）
- B. 尿毒症神經病變（uremic neuropathy）
- C. 多發性肌炎（polymyositis）
- D. 重症肌無力（myasthenia gravis）惡化

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
D	A	A	無，屬真正錯題

來源同上：考選部正式試題、原始答案、最終更正檔。

核心考點

數月類固醇暴露＋近端下肢無力＋正常CK，最支持慢性類固醇肌病。

它主要是非發炎性的肌肉萎縮與功能下降，不必伴隨明顯肌細胞壞死，因此CK可以正常。類固醇肌病臨床綜述

各選項解析

A．類固醇肌病——正確

慢性型常逐漸出現骨盆帶、近端下肢無力，肌痛通常不突出。病理可見第二型肌纖維萎縮，缺乏明顯發炎；典型病例CK正常。

本題的用藥時間、無力分布與檢驗結果相互吻合。類固醇肌病臨床綜述

B．尿毒症神經病變——無力分布不如A吻合

典型為遠端、對稱性的感覺運動神經病變，下肢較明顯，常有麻木、振動覺下降及腱反射減弱。

本題強調的是近端肌無力，沒有提供上述感覺或反射異常，因此A更適當。不能只因做過移植便假設腎功能已完全正常；排除B的重點是臨床型態。尿毒症神經病變綜述

C．多發性肌炎——近端無力相符，但整體不如A

發炎性肌病也可呈近端無力，且通常伴肌酵素升高。本題的正常CK與類固醇暴露時間，更符合慢性類固醇肌病。

但不能簡化成「正常CK一律排除發炎性肌病」；仍須綜合其他證據。肌病鑑別整理

D．重症肌無力惡化——正常CK不足以支持

MG較具辨識力的是活動後加重、休息後改善的易疲勞性無力，可合併眼瞼下垂、複視或吞嚥、說話困難。Johns Hopkins重症肌無力資料

本題沒有交代既往MG病史，也未提供波動性或眼球、延髓症狀。「CK正常」只能表示未見明顯肌酵素升高，不能直接推論成MG，更不能自行補出「原有MG惡化」。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選D可能是把正常CK解讀成「不是肌肉本身的疾病」，因而優先想到神經肌肉接合處病變。但慢性類固醇肌病正是「肌肉疾病、CK仍可正常」的重要例外。

- 失分類型：用藥時間與無力型態整合、正常檢驗的排除能力、肌病與神經肌肉接合處疾病鑑別。
- 數秒判斷規則：**「長期類固醇後近端腿無力，CK正常也要想類固醇肌病。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至移植後無力、藥物副作用，以及肌炎患者治療中反而變弱的鑑別。

現行證據與國考 / 臨床差異

國考答案A合理；臨床則不能只靠這組線索直接停藥：

- 本題未提供類固醇劑量，也未完整排除其他藥物、代謝或營養原因，仍須評估。
- 「正常CK」是慢性型常見特徵，不能套用成所有急性或重症相關類固醇肌病的必要條件。臨床綜述，2023年更新
- 移植患者是否減量，須由移植團隊兼顧排斥風險。2024年ESE / Endocrine Society指引強調，長期類固醇的減量須考慮原疾病是否仍需要治療與腎上腺抑制風險，不能突然停藥。這份是**類固醇誘發腎上腺功能不全指引**，不是專門的肌病診斷指引。2024聯合指引

醫學（四）Q58

對話詳解原文

題目與答案對照

關於多發性硬化症（multiple sclerosis, MS）的敘述，下列何者最不適當？

- A. 在MS的致病過程中，T淋巴球和B淋巴球的功能調控，兩者均有失常
- B. MS的發病病程有多種形式，其中以原發持續惡化型（primary progressive type）最常見
- C. MS是一種慢性中樞神經系統自體免疫疾病，其特徵是發炎和神經退化
- D. MS的診斷標準（McDonald criteria）包括臨床、放射線、腦脊髓液檢查結果，以確定疾病在病程和病灶位置上的表現

來源：考選部醫學（四）正式試題

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
A	B	B	無，屬真正錯題

依據：原始答案、最終更正答案。

核心考點

MS最常見的起始病程是**復發緩解型（relapsing-remitting MS, RRMS）**，不是原發持續惡化型（primary progressive MS, PPMS）。

現行資料通常估計：

- 約85%患者起始為RRMS。
- 約15%患者從發病起便呈持續惡化，即PPMS。
- RRMS患者日後可能轉為次發持續惡化型（SPMS）。

因此B把少數病程型態寫成最常見，方向明確錯誤。MS Trust病程型態整理

各選項解析

A．T與B淋巴球調控均失常——適當

MS的免疫病理不是單由一種淋巴球負責：

- T細胞參與穿越血腦障壁、發炎反應及髓鞘傷害。
- B細胞可參與抗原呈現、細胞激素調控及抗體產生。
- 抗CD20治療對復發型MS有效，也支持B細胞在疾病中的重要性。

因此A屬現代MS免疫機轉的合理概括，不能因「自體免疫疾病主要想到T細胞」便排除B細胞。

B．PPMS最常見——錯誤，為答案

PPMS的特徵是從起病開始便逐漸累積神經功能障礙，沒有典型的復發—緩解病程；但它只占MS患者中的少數。

真正最常見的是RRMS，所以B是四項中最直接、最無歧義的錯誤。

C．慢性中樞神經自體免疫疾病，兼具發炎與神經退化——適當

MS主要侵犯中樞神經系統，包括腦、脊髓及視神經，可同時涉及：

- 免疫介導的發炎。
- 脫髓鞘。
- 軸突與神經元損傷。
- 隨病程累積的神經退化。

臨床上常以「免疫介導疾病」描述，因為確切起始抗原及完整致病鏈仍未完全釐清；但C作為國考敘述合理。

D．McDonald criteria整合臨床、影像與腦脊髓液——方向適當

傳統診斷核心是證明病灶具有：

- 空間多發性（dissemination in space）。
- 時間多發性（dissemination in time）。
- 並排除更合理的替代診斷。

臨床發作、MRI及腦脊髓液寡克隆帶均可能參與診斷。因此D方向正確，但屬較簡化的說法。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選A可能是對「T、B細胞兩者均有調控異常」這種概括敘述較為保留，卻沒有先排除B中更明顯的流行病學方向錯誤。僅憑作答結果，不能確認當時實際思路。

- 失分類型：疾病病程分型、盛行比例、最佳答案排序、免疫機轉。
- 數秒判斷規則：**「MS起始八成以上是RRMS；約一成多是PPMS。看到PPMS最常見，直接判錯。」**
- 投資報酬率：高；可延伸至RRMS、SPMS、PPMS及臨床孤立症候群的鑑別。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

國考答案B與現行病程分類一致。

2025年正式發表的**2024年版McDonald criteria修訂**進一步擴充診斷架構，包括視神經位置及新的MRI、腦脊髓液生物標記，並以較一致的架構處理復發型與進展型疾病。因此D雖然概念正確，已不是完整描述新版標準。2024 McDonald criteria修訂論文

臨床診斷仍不能只因MRI出現白質病灶便判定MS，必須確認病灶形態、位置、病程及替代診斷。

醫學（四）Q59

對話詳解原文

題目與答案對照

依據DSM-5-TR，關於雙極情緒障礙症（bipolar disorder）的描述，下列何者最不恰當？

- A. 生產後4週內發作的mood episode都可稱為peripartum onset subtype
- B. 1年內有4次以上的mood episode可稱為rapid cycling subtype
- C. 一般而言，第一型雙極情緒障礙症之躁期的持續時間至少要1週
- D. 一般而言，第二型雙極情緒障礙症之輕躁期的持續時間至少要1週

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
A	D	D	無，屬真正錯題

核心考點

躁期與輕躁期最重要的時間門檻：

- **躁期（manic episode）：至少1週。**
- **輕躁期（hypomanic episode）：至少連續4天。**
- 若躁期嚴重到必須住院，或出現精神病症狀，不必滿1週。
- Rapid cycling：12個月內至少4次符合標準的躁期、輕躁期或重鬱期。

因此D把輕躁期的4天錯寫成1週，是最明確的錯誤。Merck Manual雙極情緒障礙診斷整理

各選項解析

A．產後4週內發作可使用peripartum onset——國考判定適當，但措辭不精確

DSM架構中的「with peripartum onset」是**specifier（標註詞）**，不是獨立疾病亞型。它適用於符合診斷的情緒發作，且發作始於：

- 懷孕期間；或
- 分娩後4週內。

所以A想考的時間界線基本正確，但有兩點需修正：

1. 應稱specifier，不宜稱subtype。
2. 不是產後任何情緒波動都能使用；必須先符合躁期、輕躁期或重鬱期等情緒發作標準。

與D的明確時間錯誤相比，A仍不是最佳答案。NCBI：雙極障礙相關標註詞

B．一年內4次以上發作可稱rapid cycling——核心門檻正確

Rapid cycling是指過去12個月內出現至少4次：

- 躁期。
- 輕躁期。
- 重鬱期。

各次發作還應以緩解期或情緒極性轉換加以區隔。和A相同，更精確的名稱是**specifier**，不是獨立subtype。Merck Manual rapid cycling定義

C．第一型雙極障礙躁期通常至少1週——適當

Bipolar I的診斷關鍵是曾有一次躁期。躁期通常需：

- 明顯高昂、易怒或擴張性情緒及活動增加。
- 持續至少1週，且大部分時間、幾乎每天存在。
- 造成明顯功能損害。

如果嚴重到必須住院，或已有精神病症狀，即使未滿1週仍可符合躁期。

D．第二型雙極障礙輕躁期至少1週——錯誤，為答案

輕躁期的最低持續時間是**至少連續4天**，不是1週。

此外，Bipolar II須同時具有：

- 至少一次輕躁期。
- 至少一次重鬱期。
- 從未出現躁期。

輕躁期雖與原本狀態明顯不同，但不應嚴重到造成明顯社會或職業功能損害、必須住院或出現精神病症狀；若有這些情況，應改判為躁期。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選A可能是注意到「都可稱為」以及「subtype」的文字過度概括，因而判定不恰當。這項質疑具有臨床及術語上的合理性；但在單選題的最佳答案排序中，D存在更直接的數字錯誤：輕躁期是4天，不是1週。

- 失分類型：診斷時間門檻、specifier與subtype混淆、最佳答案排序。
- 數秒判斷規則：**「躁7、輕躁4、重鬱14；rapid cycling一年至少4次。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至Bipolar I / II、cyclothymia、物質誘發情緒障礙及住院門檻判讀。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

- 國考答案D與DSM-5-TR核心門檻一致。
- 躁期滿1週的規則有「因嚴重程度需住院時不限時間」的例外。
- 輕躁期不能出現精神病症狀；若出現，即按躁期處理。
- A、B使用「subtype」並不精確；peripartum onset及rapid cycling均屬specifier。

- Peripartum onset的DSM界線是懷孕期間或產後4週內；臨床上的產後情緒疾病風險期可延伸更久，不應把DSM標註詞的4週界線誤當成所有臨床風險的終點。

醫學（四）Q60

對話詳解原文

題目與答案對照

在精神狀態檢查（mental status examination, MSE）中，下列何者最能評估認知功能？

1. 病人無法記住三個單詞（例如：蘋果、快樂、腳踏車），並在五分鐘後無法正確回憶
2. 病人說話內容缺乏邏輯，句子之間沒有明顯連貫性，且表達混亂
3. 病人持續感到悲傷，對先前感興趣的活動失去興趣
4. 請病人畫11點10分的時鐘

- A. 僅①②
- B. 僅①④
- C. 僅①③④
- D. ①②③④

來源：考選部醫學（四）正式試題

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
A	B	B	無，屬真正錯題

依據：原始答案、最終更正答案。

核心考點

國考採用較狹義的MSE分欄：

敘述	主要評估構面
① 三詞延遲回憶	記憶 / 認知
② 語句缺乏邏輯與連貫性	思考形式 / 思考過程
③ 悲傷、失去興趣	情緒
④ 11點10分畫鐘	執行功能、視空間功能 / 認知

因此應選 **B，僅①④**。

各項解析

① 五分鐘後無法回憶三個單詞——屬認知功能

這是延遲回憶測試，主要評估近期記憶及新資訊的登錄、保存與提取。

臨床仍需先確認病人當初是否正確聽懂並完成即刻登錄；注意力不足、失語、聽力障礙、教育程度及語言差異，都可能影響結果。

② 語句缺乏邏輯與連貫性——國考歸為思考形式

它描述的是思考如何組織與表達，例如：

- Loose association。
- Derailment。
- Incoherence。
- Disorganized thought process。

這不同於「思考內容」，後者才包含妄想、強迫意念、自殺或殺人意念等。MSE資料通常將思考過程與認知分開記錄。NCBI精神狀態檢查整理

③ 悲傷及失去興趣——屬情緒症狀

- 持續悲傷主要描述主觀情緒。
- 對原本感興趣的活動失去興趣是anhedonia。

它們可支持重鬱症候群，但不是這一題所問的狹義認知測試。

④ 11點10分畫鐘——屬認知功能

畫鐘不只是測試「會不會畫圖」，還需要整合：

- 理解指令。
- 規劃及執行功能。
- 視空間配置。
- 數字順序與位置。
- 時針、分針概念。

11點10分也是常見的標準畫鐘指令。三詞回憶與畫鐘共同構成Mini-Cog的核心工作，因此④應納入。AAFP精神狀態檢查與畫鐘測試

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選A可能是把語句缺乏邏輯視為廣義認知異常，因而納入②；同時沒有把畫鐘辨認成執行功能及視空間功能測試。僅憑作答結果，不能確定當時實際判斷過程。

- 失分類型：評估工具與所測構念、MSE分欄、思考形式與認知功能混淆。
- 數秒判斷規則：**「三詞回憶 + 畫鐘 = 認知；話講得亂 = 思考形式；悲傷沒興趣 = 情緒。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至譫妄、失智、思覺失調症、憂鬱症及認知篩檢工具判讀。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

國考答案B符合常見精神科MSE分欄：②記錄於thought process，③記錄於mood，①④歸入cognition。

不過本題確實存在術語邊界：

- 有些臨床框架把思考過程、語言甚至行為也列入**廣義認知功能**。
- AAFP的MSE架構便把thought process列入較廣泛的cognitive portion。
- 因此②當然可能反映認知或腦功能異常，但在精神科紀錄的狹義分欄中，仍應優先歸為思考形式。

此外，三詞回憶或畫鐘異常都不能單獨確診失智；應結合注意力、功能退化、病程、教育與語言背景，必要時再使用MoCA、Mini-Cog或完整神經心理評估。

醫學（四）Q61

對話詳解原文

題目與答案對照

有關關係妄想（delusion of reference）的病人主訴，下列何者最適當？

- A. 我在想什麼他們都知道
- B. 我有超能力要拯救世界
- C. 我的行為都被別人控制
- D. 電視上播放的節目暗藏著要傳遞給我的訊息

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
C	D	D	無，屬真正錯題

核心考點

四個選項分別對應四種不同的妄想內容：

選項	妄想類型
A	思想廣播 / 思想被他人知悉
B	誇大妄想
C	控制妄想 / 被動體驗
D	關係妄想

關係妄想的核心是：

> **原本中性、與自己無關的外界事件，被賦予專門針對自己的特殊意義。**

因此電視節目暗藏給自己的訊息，是最典型的答案。

各選項解析

A．「我在想什麼他們都知道」——思想廣播

患者相信自己的內在思想能被別人得知、聽見或接收，屬於thought broadcasting。

它的重點是**思想邊界被突破**，不是把外界中性事件解讀成與自己有關。NCBI MedGen：thought broadcasting定義

B．「我有超能力要拯救世界」——誇大妄想

內容包含不符合現實的特殊能力、權力、地位或使命，屬grandiose delusion。

可出現在躁期、思覺失調症及其他精神病性疾病；妄想內容本身不能單獨決定診斷。

C．「我的行為都被別人控制」——控制妄想

患者相信自己的行為、感受、意志或衝動由外在力量操控，屬delusion of control或passivity phenomenon。

這是使用者所選答案，但它的核心是：

> **我的行為不是由我自己發動，而是被外力控制。**

與關係妄想的「外界事件特別指向我」不同。

D．「電視節目暗藏要傳遞給我的訊息」——正確

電視節目本來是面向一般觀眾的中性內容，但患者相信其中藏有專門傳給自己的暗號、警告或指示，正是典型關係妄想。

電台、新聞、網路文章、陌生人談話或路人的動作，也可能被賦予同樣的個人特殊意義。NCBI精神狀態檢查：ideas of reference

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是把「所有事情都針對我」與「別人在操控我」放在同一類外力影響妄想中，沒有依主詞與作用方向進一步分類。不能據此斷言當時實際思路。

- 失分類型：精神病理症狀分類、關係妄想與控制妄想鑑別。
- 數秒判斷規則：**「外界訊息在說我 = 關係；他們知道我想什麼 = 思想廣播；他們操控我 = 控制；我能力超凡 = 誇大。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至Schneider一級症狀、思覺失調症、躁期與妄想症的鑑別。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

國考答案D與現行精神病理定義一致。NCBI妄想分類

臨床上還需區分：

- **Idea of reference：**患者覺得某事件似乎與自己有關，但可能仍保留懷疑或修正空間。
- **Delusion of reference：**信念固定、確信程度高，即使有相反證據也難以動搖。

題幹已明確使用delusion，且D以「暗藏要傳遞給我的訊息」表現高度個人化意義，符合妄想層級。

妄想類型只描述內容，不等同診斷。真正臨床仍需評估：

- 信念確信度及可修正性。
- 文化與宗教背景。
- 情緒症狀及意識狀態。
- 物質、藥物或一般醫療原因。
- 對自身及他人的安全風險。

醫學（四）Q63

對話詳解原文

題目與答案對照

下列關於照會聯商精神醫學（consultation-liaison psychiatry）之敘述，何者最不適當？

- A. 照會聯商精神醫學認為精神疾患可影響內科疾病的預後
- B. 綜合醫院住院患者憂鬱疾患的盛行率高於社區與基層診所民眾
- C. 憂鬱同時是冠狀動脈心臟病（coronary artery disease）的危險因子與不良預後因子
- D. 罹患身體疾病患者，女性、未滿40歲等是自殺企圖的危險因子

來源：考選部醫學（四）正式試題

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
C	D	D	無，屬真正錯題

已核對原始答案及最終更正檔；更正檔只影響Q14與Q28。

核心考點

本題同時考兩件事：

1. 精神疾病與身體疾病具有雙向影響。
2. 自殺風險必須區分**非致死企圖**與**自殺死亡**，不能把人口學關聯混為一談。

官方以D為答案，預期的傳統考點是：身體疾病患者若合併高齡、男性、嚴重或慢性疾病、疼痛、失能、憂鬱、物質使用、過去企圖及社會孤立，尤其需要警覺自殺死亡風險。

但D使用「自殺企圖」一詞，使題目產生現代流行病學上的爭議，後面詳述。

各選項解析

A．精神疾患可影響內科疾病預後——適當

照會聯商精神醫學處理的是一般醫療環境中的精神、行為及身心交互問題，例如：

- 憂鬱導致服藥及復健遵從性下降。
- 譫妄增加住院時間、跌倒及死亡風險。
- 物質使用影響疾病控制。
- 焦慮或認知障礙干擾檢查、治療決策及出院安排。

因此精神評估並非只處理患者是否「心情不好」，也會影響整體醫療結果。

B．綜合醫院住院患者的憂鬱盛行率較高——方向適當

身體疾病、功能損害、疼痛、住院壓力及既有精神共病，使一般醫院住院患者較容易出現憂鬱症候群。

但臨床閱讀研究時要確認其測量的是：

- 正式重鬱症診斷。
- 憂鬱症狀篩檢陽性。
- 調適障礙或其他情緒問題。

不同定義會得到不同盛行率，不能把所有「量表高分」直接等同重鬱症。

C．憂鬱是冠心病危險因子及不良預後因子——適當

憂鬱與冠狀動脈疾病的關聯可能透過多條路徑形成，包括：

- 吸菸、活動不足及服藥遵從性較差。
- 自律神經及下視丘—腦下垂體—腎上腺軸改變。
- 發炎、血小板活化及代謝因素。
- 罹患冠心病後的功能受限及心理壓力反過來加重憂鬱。

美國心臟協會的科學聲明認定，急性冠心症後的憂鬱可視為不良預後風險因子，因此C不是本題錯誤選項。AHA科學聲明

不過「危險因子」不代表已證實單一路徑的直接因果，也不表示治療憂鬱必然等比例消除心血管事件。

D．女性、未滿40歲是身體疾病患者自殺企圖危險因子——官方判定最不適當

在嚴重或慢性身體疾病患者中，應特別關注：

- 疼痛、失能、失去獨立性。
- 憂鬱、絕望及物質使用。
- 過去自殺企圖。
- 社會孤立、經濟與照護壓力。
- 疾病嚴重度及預後。
- 高齡男性的自殺死亡風險。

美國照會聯商精神醫學學會的評估資料明確將嚴重或慢性疾病、疼痛、睡眠問題、認知損害及失能列為重要因素；CDC也列出過去企圖、憂鬱、嚴重疾病或慢性疼痛、物質使用及絕望等風險。ACLP自殺風險評估指南、CDC風險因子

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是對「憂鬱是冠心病危險因子」的因果措辭有所保留，或只記得冠心病會造成憂鬱，而沒有保留兩者的雙向關聯。

也可能是你知道女性及較年輕者在一般族群中可能有較多非致死自殺企圖，因此沒有把D判錯。這項質疑其實具有臨床合理性；僅憑答案不能確認當時思路。

- 失分類型：風險因子與因果關係、自殺企圖與自殺死亡、一般族群與身體疾病族群混用。
- 數秒判斷規則：**「心病影響身病，憂鬱也會拖累冠心病預後；自殺題先分企圖還是死亡，再看疼痛、失能、憂鬱與既往企圖。」**

- 投資報酬率：極高；可延伸至急診自殺風險評估、心肌梗塞後憂鬱、癌症與慢性疼痛照護。

國考答案與現代臨床差異

官方答案D可以理解，但題目文字不夠嚴謹：

- 女性在一般族群中常有較高的非致死企圖通報率；男性則有較高的自殺死亡率。
- 年輕者的非致死企圖不罕見；高齡者雖企圖次數可能較少，致死性通常更高。
- 因此若D嚴格限定「自殺企圖」，直接宣稱女性、未滿40歲不是危險因子並不穩妥。
- 國考想考的較可能是**身體疾病患者的自殺死亡高風險輪廓**，卻把outcome寫成「企圖」。

臨床不能依性別或年齡單獨判定安全；必須直接詢問意念、計畫、手段、意圖、過去行為、保護因子及近期壓力。

醫學（四）Q64

對話詳解原文

題目與答案對照

26歲張小姐，個性內向、怕生，從小在學校朋友就少，自大學起開始頻繁出現持續性的心悸、失眠及對未來或小事過度擔憂等症狀，也難以集中注意力，總擔心自己表現不佳，導致身心俱疲。下列有關焦慮症的診斷及治療，何者最不適當？

- A. 流病研究發現常見的焦慮症，像是廣泛性焦慮症、恐慌症，傾向有家族聚集性（familial aggregation）
- B. 社交焦慮症（social anxiety disorder）是可能的診斷之一，女性罹患此症的比例與男性差不多
- C. 在治療焦慮症上，增加腦部血清素的藥物，像是SSRI或SNRI是一線治療選擇
- D. 影像學研究顯示左背外側前額葉（left dorsolateral prefrontal cortex）可作為影像生物標記（biomarker）協助診斷焦慮症

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
B	D	D	無，屬真正錯題

核心考點

> **研究發現某腦區有群體差異，不等於已經取得可替個別患者診斷的生物標記。**

焦慮症目前仍主要依據：

- 症狀型態及誘發情境。
- 病程時間。
- 功能損害。
- 物質、藥物及身體疾病排除。
- 精神科鑑別診斷。

沒有一項左DLPFC影像檢查可供常規臨床確診焦慮症，因此D是最明確的錯誤。

各選項解析

A．焦慮症具有家族聚集性——適當

家族聚集性反映遺傳與共享環境共同作用，不代表存在單一「焦慮基因」。家族史是焦慮症的已知風險線索；NIMH目前仍持續研究遺傳、腦部生物學、家庭及環境因素。NIMH焦慮症資料

B．社交焦慮是可能診斷，男女比例差不多——可接受但需保留

她從小內向怕生、朋友少、擔心表現不佳，因此社交焦慮確實可列入鑑別。但題幹同時有持續且涵蓋未來與小事的廣泛擔憂、失眠、心悸、注意力不集中及疲憊，更應評估廣泛性焦慮症，兩者也可能共

病。

性別比例會因資料來源不同而改變：

- WHO整體資料指出焦慮症較常見於女性。
- NIH MedlinePlus則將社交焦慮描述為男女受影響相近。
- 社區研究有時呈女性較高；臨床樣本差異可能縮小。

因此B不是毫無爭議，但仍不像D那樣直接把研究候選標記提升為臨床診斷工具。WHO焦慮症資料，2026年9月15日更新、NIH MedlinePlus

C．SSRI或SNRI是一線藥物——適當

SSRI及SNRI可用於多種焦慮症的長期治療；心理治療尤其CBT同樣是核心治療。

實務上需注意：

- 初期可能短暫增加焦躁、噁心或睡眠障礙。
- 通常需數週才有明顯療效。
- 不宜突然停藥。
- 藥物選擇須依診斷、共病、交互作用及患者偏好決定。
- Benzodiazepine通常不適合作為長期常規治療。

WHO目前仍將CBT類心理介入及SSRI列為具實證的治療方式。WHO診療整理

D．左DLPFC影像可作為焦慮症診斷生物標記——錯誤，為答案

焦慮研究確實發現前額葉、杏仁核、島葉及其網路可能存在結構或功能差異；這些結果有助理解疾病機轉或研究治療反應。

但臨床生物標記必須能在**個別患者**身上穩定重現，並具足夠敏感度、特異度、外部驗證及標準化。焦慮症異質性高，影像結果還會受到年齡、藥物、共病、掃描方法及分析流程影響。

目前常規診斷流程仍是病史、臨床評估及必要的身體檢查 / 實驗室排除，沒有「照左DLPFC便能協助確診」的標準。NIH臨床診斷說明、精神疾病候選生物標記現況

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選B可能是注意到多數焦慮症整體上女性較常見，因此對「男女差不多」產生質疑。這項質疑有流行病學依據，但社交焦慮的性別差異會隨社區或臨床樣本而變化。

相較之下，D的問題更根本：它把尚在研究中的群體腦影像差異，寫成可協助臨床個別診斷的生物標記。

- 失分類型：研究關聯與臨床診斷工具、群體差異與個體判定、最佳答案排序。
- 數秒判斷規則：**「精神影像多半是研究線索；未經個體層級驗證，不能叫臨床診斷biomarker。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至憂鬱症、ADHD、思覺失調症及神經影像機器學習研究的判讀。

國考答案與現代臨床差異

- 國考答案D與現代臨床一致：目前沒有左DLPFC影像檢查可常規診斷焦慮症。
- B的「男女差不多」受研究族群影響，並非絕對定律；這個選項本身略顯粗糙。
- 題幹雖最像長期廣泛擔憂，但仍須確認症狀是否大多數日子持續至少6個月、是否難以控制，以及是否由甲狀腺疾病、心律不整、咖啡因、藥物或物質造成。
- 內向、怕生本身不是社交焦慮症；必須存在對負面評價的明顯恐懼、逃避或忍受時的強烈焦慮及功能損害。
- 腦影像在真實臨床的用途主要是有神經學警訊或懷疑器質性病變時排除其他原因，而非確認一般焦慮症。

醫學（四）Q66

對話詳解原文

題目與答案對照

阿茲海默失智症與輕度認知障礙（mild cognitive impairment）兩者診斷的基本差別（primary differentiation）是依照下列那一個特徵？

- A. APOE4 allele有無
- B. 腦脊髓液（CSF）β-amyloid濃度高低
- C. 腦影像生物標記陽性或陰性
- D. 日常生活功能退化

使用者作答	原始答案	最終更正後答案	特殊計分
B	D	D	無，屬真正錯題

2026年9月21日重新核對考選部正式試題、原始答案及最終更正檔。更正仍僅涉及Q14、Q28，不影響本題。

核心考點

這題問的是「是否已到失智程度」，不是「是否具有阿茲海默病理」。

- **MCI：**已有認知下降，但大致保有日常生活獨立性。
- **失智症：**認知下降已干擾獨立生活。

因此，不能只靠記憶測驗分數或生物標記陽性，便將MCI改判為失智症。Alzheimer’s Association：MCI診斷與功能評估

各選項解析

A．APOE4 allele有無——不是分期界線

這是遺傳風險相關資訊，不直接回答患者是否仍能獨立生活。同一種遺傳背景不能取代臨床功能評估。

B．CSF β-amyloid濃度高低——協助判定病因，不是失智門檻

這是你選的答案。關鍵反例是：**MCI患者也可能已有異常的amyloid相關CSF檢驗**，屬於阿茲海默病所致的MCI，卻尚未達失智程度。

因此，「已出現阿茲海默病理」與「已失去日常生活獨立性」是兩個不同問題。Alzheimer’s Association：MCI due to Alzheimer’s disease

C．腦影像生物標記陽性或陰性——同樣不能單獨分期

例如amyloid PET異常可以出現在MCI階段。影像可協助確認病理背景，但陽性不等於已達失智程度；也不能把所有腦影像檢查都視為同一種標記。2024阿茲海默病診斷與分期準則

D．日常生活功能退化——正確，但要精確理解

最重要的是：**認知退化是否已妨礙獨立完成日常活動。**

評估時可詢問原本能自行處理的服藥、帳務、購物或行程安排，現在是否因認知問題而需要他人接手；也應取得家屬觀察，而不只看患者當下的測驗表現。

MCI不代表做事完全沒有變慢或困難；失智症也不必等到吃飯、穿衣都需要協助才成立。判斷重點是獨立性，而非「任何一點功能下降」。Alzheimer’ s Association：獨立功能評估

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選B可能是將「確認阿茲海默病理的檢查」當成「區分MCI與失智症的指標」。這反映的可能是病因與嚴重程度兩個層次混用；僅憑答案不能確定當時思路。

- **失分類型：**病因判定與臨床分期混淆、檢查與所測構念不匹配。
- **數秒判斷規則：**「標記問病因；MCI或失智，問能否獨立生活。」
- **投資報酬率：高。**可延伸至認知篩檢、家屬病史，以及阿茲海默病不同臨床階段的判讀。

現行證據與國考 / 臨床差異

本次查核的2024年Alzheimer’ s Association準則，明確區分**生物學上的阿茲海默病**與**臨床症狀分期**：疾病病理可以在失智之前存在。該文件是診斷與分期原則，並非逐步治療指引。2024準則官方說明

所以國考答案D仍合理，尤其題幹寫的是「阿茲海默**失智症**」，不是單純問阿茲海默病理是否存在。

臨床上還要避免把關節疾病、視力問題或原本就不熟悉的活動所造成的依賴，直接歸因於認知退化；功能變化需要與患者原有能力及原因一起判斷。

醫學（四）Q68

對話詳解原文

關於酒精誘發（alcohol-induced）之精神疾患，下列描述何者最適當？

- **A.** 若以幻覺為主之酒精誘發之精神病疾患（alcohol-induced psychotic disorder），在幻覺消失後，大部分病人現實感（reality testing）會恢復
- **B.** 酒精誘發之持續失憶疾患（alcohol-induced persisting amnestic disorder），通常很少發生在35歲之後
- **C.** 酒精誘發之情感疾患（alcohol-induced mood disorder），針對憂鬱情緒，宜儘速使用抗憂鬱藥物治療
- **D.** 酒精誘發之焦慮疾患（alcohol-induced anxiety disorder），約有20%的病人自陳有過恐慌發作（panic attack）

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
D	A	A	無，屬真正錯題

已重新核對考選部正式試題、原始答案與最終更正檔。

核心考點

酒精相關精神症狀要分辨：幻覺是否伴隨譫妄、記憶障礙是否持續，以及情緒症狀是否隨戒酒改善。不同病程的處置與預後不能混用。

A．幻覺消失後，多數患者現實檢驗能力恢復——本題最佳答案

這裡的 reality testing 更精確的翻譯是「現實檢驗能力」：能否分辨內在經驗與外界真實事件。

酒精性幻覺症可在意識相對清楚時出現幻聽、恐懼或伴隨妄想，與具有注意力、意識障礙的酒精戒斷譫妄不同。ASAM指引明確要求區分兩者。**意識清楚不等於完整保有病識感或現實檢驗能力。**ASAM 2020酒精戒斷指引

A描述症狀緩解後可恢復的病程，符合本題答案；但不能延伸成「所有人都會完全恢復」。2003年一項52人、三年追蹤研究顯示，酒精性幻覺症的結局具有異質性，不能保證單一路徑。原始追蹤研究

B．持續失憶疾患很少發生於35歲之後——錯誤

這類題目主要聯想到酒精相關的Korsakoff症候群，涉及長期飲酒、營養問題及thiamine缺乏，造成持續的記憶障礙，尤其是形成新記憶的困難。它不同於一次醉酒期間的記憶斷片。Alzheimer’ s Society：Wernicke–Korsakoff症候群

「35歲之後罕見」不符合這種長期累積傷害的臨床背景。Alzheimer’ s Society指出，較廣義的酒精相關腦損傷常在**40至60歲**被診斷；這不是Korsakoff專屬的年齡分布，但也提醒我們不能把酒精相關持續認知障礙想成主要發生於35歲以前。酒精相關腦損傷資料

C．酒精誘發憂鬱情緒宜儘速給抗憂鬱藥——過度概括，因此錯誤

關鍵是先釐清：

- 憂鬱是否主要出現在大量飲酒或戒斷期間？
- 飲酒前是否已有獨立的憂鬱發作？
- 處理酒精問題後，症狀是否持續？
- 是否存在需要立即介入的自殺風險或嚴重精神症狀？

NICE CG115建議先處理酒精問題，因為憂鬱、焦慮可能隨之改善；若戒酒約**3至4週**後仍持續，應再評估並依相應指引治療。NICE指引監測報告

這不代表患者必須「等滿四週才能接受精神科處置」。有高度自殺風險、嚴重症狀或明確獨立情緒疾患者，需要立即評估。C錯在把「出現憂鬱情緒」直接等同於「應立即開始抗憂鬱藥」。

D．約20%曾有恐慌發作——官方不採納；已找到相關數字，但須注意母群體

這次查到Schuckit於**1996年**發表的〈Alcohol, Anxiety, and Depressive Disorders〉全文，描述酒精依賴者中：

> 至少40%曾經歷一次或以上強烈恐慌發作。

文中並引用Kushner等人1990年的文獻。Schuckit原文

因此，D的「20%」與這項常見歷史描述不符。但必須區分三件事：

概念	能否直接互換？
酒精依賴者曾有恐慌發作	是該文描述的群體與事件
酒精誘發焦慮疾患患者曾有恐慌發作	母群體更特定，不能直接套用
符合恐慌症診斷	不等於曾有一次恐慌發作

可以確認歷史文獻寫的是至少40%，不能宣稱已找到命題者的原始引用書目，也不能把40%當成所有現代患者群體的固定比例。這個限制應放進詳解，而不是成為不完成題目的理由。

可能的失分機制、失分類型與判斷規則

由作答結果合理推測：選D可能來自比例記憶不確定，也可能是對A的可恢復性有所保留。僅憑選項，無法斷定你混淆了哪一種疾病。

- **失分類型：**酒精誘發精神疾患的病程與預後、比例的母群體、治療時機。
- **數秒判斷規則：**「酒精幻覺可緩解；持續失憶想B1；酒精相關憂鬱先釐清病程；恐慌發作不等於恐慌症。」
- **投資報酬率：**臨床鑑別與治療順序很高；單背20% / 40%的報酬較低。

現行指引與國考 / 臨床差異

本次查核支持以A作為最佳答案，但臨床須補上以下限制：

- **幻覺不等於譫妄。**應評估注意力、意識、定向及戒斷徵象。
- **可恢復不等於不用治療。**ASAM指出，酒精誘發精神病可能需要精神科會診及抗精神病藥；若合併戒斷，亦須處理戒斷本身。ASAM指引

- **先處理酒精問題不等於忽略憂鬱或自殺風險。**
- **1996年的比例文獻不是最新治療指引。**其用途是核對數字的歷史依據，不能冒充現代精確盛行率。

醫學（四）Q69

對話詳解原文

題目與答案對照

有關皮質下失智症與皮質失智症（subcortical and cortical dementia）的鑑別比較，下列何者最不恰當？

- A. 語文能力：皮質失智症（cortical dementia）早期就會出現失語症（aphasia）
- B. 計算能力：皮質失智症（cortical dementia）早期就容易受影響
- C. 情緒：皮質失智症（cortical dementia）較容易出現憂鬱情緒
- D. 動作速度，如手指輕敲測驗（finger tapping test）：皮質下失智症（subcortical dementia）較慢

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
D	C	C	無，屬真正錯題

本次兩題均已重新核對考選部正式試題、原始答案及最終更正檔。本份更正僅涉及Q14、Q28，不影響Q69、Q71。

核心考點

這題採用的是**傳統神經心理學的典型比較**：

比較項目	皮質型較典型	皮質下型較典型
語言及高階功能	失語、失用、失認等	早期相對保留，但並非完全正常
思考及動作速度	不一定以遲緩為突出表現	處理速度下降、精神動作遲緩
情緒與動機	也可能憂鬱	憂鬱、淡漠是經典描述

因此，**C把傳統比較中的情緒傾向寫反了**。這套概念可追溯至Cummings與Benson的經典整理，並不是新發布的診斷指引。1984年皮質下失智症概念文獻

各選項解析

A．皮質型早期出現失語——國考接受，但措辭偏絕對

語言障礙是重要的皮質功能線索，符合本題的傳統分類方向。

但不能延伸成「所有皮質型失智症一開始一定失語」。現代評估會區分記憶主導、語言主導、視空間主導等症候群；不同患者的先後順序並不相同。DETeCD-ADRD指引的症候群分類

B．皮質型計算能力較早受影響——符合典型比較

計算障礙可見於後部皮質認知功能受損，也可能伴隨讀寫及視空間困難。因此本題將計算能力列為皮質型較易受影響的項目，方向合理。

同樣地，這是典型型態，不是每位患者都必須早期出現失算。DETeCD-ADRD指引表2

C．皮質型較容易憂鬱——本題最不恰當，為答案

傳統皮質下症候群強調處理速度變慢、動機下降、淡漠及憂鬱。因此在這張比較表裡，C的方向相反。

要注意：**淡漠不等於憂鬱，皮質型患者也可能憂鬱。**不能把考試配對變成「看到憂鬱就能定位皮質下」的診斷規則。經典分類、現代失智症評估指引

D．皮質下型手指敲擊較慢——符合典型比較

皮質下相關迴路疾病常伴動作遲緩；手指敲擊測驗正會受到動作速度影響，所以D不是本題要選的錯誤。

但它不具排他性：2023年研究也發現阿茲海默症患者的敲擊速度及規律性可能變差。因此D應讀成**典型相對趨勢**，不是「只有皮質下病變才會慢」。研究團隊對手指敲擊結果的說明

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選D可能是沒有把皮質下迴路與動作遲緩連結起來，或認為手指敲擊屬運動檢查、不應用於失智症比較。也可能是對這套二分法有所疑慮；僅凭答案不能確定實際思路。

- **失分類型：**解剖—功能配對、皮質 / 皮質下症候群、典型差異與例外。
- **數秒判斷規則：**「皮質看語言、計算；皮質下看慢、淡漠與憂鬱。這是典型配對，不是絕對界線。」
- **投資報酬率：高。**可延伸至巴金森相關認知障礙、血管性認知障礙及失智症神經心理型態。

現行指引與國考 / 臨床差異

國考答案C符合傳統比較。現代臨床則不會只靠這張表確診。

2024年12月上線、2025年刊載的DETeCD-ADRD指引，要求整合三層資訊：**功能受損程度、認知行為症候群、可能病因**。因此，「有憂鬱」或「敲擊慢」都只能是整體評估的一部分。正式指引

醫學（四）Q71

對話詳解原文

題目與答案對照

有關注意力不足 / 過動症（ADHD）的病程與預後，下列何者最適當？

- A. 相較於過動的症狀，注意力不足的症狀通常會較早消失痊癒
- B. 由於注意力不足 / 過動症狀隨年齡漸長而改善，通常患者不會有社交功能上的問題
- C. 症狀通常在6～10歲之間會自然逐漸改善
- D. 超過一半比例的患者，ADHD症狀會持續到成人期

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
C	D	D	無，屬真正錯題

核心考點

過動變少，不等於ADHD痊癒。

隨年齡增長，明顯跑跳可能減少，但注意力、組織能力、衝動及功能困難仍可能持續。D談的是「症狀持續」，不是「每位患者成年後都始終符合完整診斷」。NIMH：ADHD隨年齡的表現

各選項解析

A．注意力不足較早消失——方向相反

通常是外顯過動隨成長較不明顯，可能轉為坐立不安；注意力及組織困難則可持續。因此不能把「注意力不足先痊癒」當作典型病程。

B．長大通常不會有社交問題——錯誤

症狀程度減輕，不保證人際功能恢復正常。青少年及成人仍可能有關係、學業或工作困難，不能只看是否還會跑跳。NIMH年齡與功能表現

C．通常在6～10歲自然改善——不能當通則

這個年齡範圍不是ADHD自然痊癒的固定時窗。學業與社交要求增加時，原有注意力困難反而可能更容易被看見。

長期追蹤也顯示，病程常有緩解與再出現症狀的波動，不是到某個兒童年齡便單向改善。MTA長期追蹤研究

D．超過一半持續有症狀至成人——最佳答案

這符合ADHD可持續至成人期的長期病程認識。

MTA研究於2021年上線、2022年刊載，發現該研究樣本約90%至青年成人期仍有殘餘症狀，且多數人的緩解與復發狀態會波動。這支持D的方向，但**不能把90%當成所有患者的固定比例，也不能等同**

完整診斷持續率。MTA原始研究

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是記得「過動會隨成長改善」，卻把它延伸成「ADHD整體症狀通常在6～10歲自然改善」。也可能是對病程年齡記憶不熟；不能據此認定當時的推理。

- **失分類型：**病程時間軸、單一症狀改善與整體緩解混淆、症狀與功能區分。
- **數秒判斷規則：**「過動可能變少，注意與功能問題可留到成年；不要把長大當痊癒。」
- **投資報酬率：極高。**可延伸至成人ADHD、兒少轉成人照護及持續治療需求評估。

現行指引與國考 / 臨床差異

國考答案D合理；臨床應分清：

1. **症狀持續：**仍有注意力、過動或衝動表現。
2. **診斷持續：**是否仍滿足完整診斷條件。
3. **功能損害：**是否影響學習、工作、人際或生活管理。

本次取得的NICE NG87官方指引標示2018年發布、2019年更新，建議在離校年齡重新評估成人期持續治療需求；若有需要，安排成人服務銜接，通常於18歲前完成。它支持持續評估，而不是等孩子自行長好。NICE NG87，第1.1.4項

上述為現行指引與追蹤證據，不將其冒稱為2026年新發布指引。

醫學（四）Q72

本次補寫版 2026-10-07

主題：自殺評估的直接詢問與個別化介入

本次補寫版，2026年10月7日完成。原始詳解尚未回收；以下依正式試題、原始答案、最終更正及所列醫學來源重建。

題目與答案對照

有關自殺個案的評估與介入（intervention），下列敘述何者最適當？

- ① 憂鬱症與自殺的危險（risk）有關，企圖自殺（attempted suicide）個案若經評估為罹患憂鬱症，需積極治療
- ② 懷疑個案可能有自殺意念，需作詳細精神狀態（mental state）評估，但不宜觸及自殺想法，以免強化個案的自殺意念
- ③ 若自殺方式為跳樓，個案的自殺意念較強，再發生自殺行為的危險（risk）也較高
- ④ 人格違常（personality disorder）與自殺的危險（risk）無關
- A. 僅①③
- B. 僅②④
- C. 僅①②③
- D. ①②③④

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
C	A	A	無；本題未列於更正備註

參考來源：考選部正式試題；考選部原始答案；考選部最終更正檔。

個人作答取自本對話已保存的80題作答序列；以上三份官方檔案均於本次補寫重新核對。

核心考點

①與③為國考接受敘述；②與④錯誤。最明確的陷阱是**不宜觸及自殺想法**：專業評估應直接、尊重地詢問，詢問本身不會植入或強化自殺意念。

③應理解為高致死性方式是重要警訊、需要密切後續照護；不能只憑方式就斷言個案心理狀態或精確預測下一次行為。

各選項解析

①．合併憂鬱症須積極治療——正確

對自殺企圖後評估出憂鬱症者，應處理憂鬱與當下安全需要，並安排適當精神科及心理照護。只治療外傷或只說『心情好一點』不夠。

安全評估不應等待憂鬱診斷或藥物生效才開始；其他精神疾病、物質使用與壓力也要一起評估。

②．避免詢問自殺想法——錯誤，也是你所選C多納入的一項

NIMH明確指出，直接詢問自殺想法與行為不會造成或增加這類想法。評估可涵蓋目前意念、計畫、意圖、可取得手段、近期行為、過去企圖及保護因子。

重點是合適的態度與後續照護，不能用『怕問了會更想做』作為不評估的理由。

③．高致死性方式需要提高警覺——國考接受，但避免過度推論

原始長期追蹤研究發現，既往採取某些高致死性方式的人，後續自殺死亡風險可較高，因此需要加強照護。這支持把該方式視為嚴重警訊。

但方式的致死性、個人的自殺意圖、以及後續是否再次非致死企圖，是不同概念。此類研究的主要終點是後續自殺死亡，不能直接當成每一個人的意念強度或再企圖概率。

④．人格違常與自殺風險無關——錯誤

人格障礙，尤其合併情緒失調、衝動性、自傷史或其他精神共病時，與自殺 / 自傷風險有關。不能因此忽視風險，也不能把自傷簡化為『只是引起注意』。

診斷名稱本身仍不足以決定個人危險程度或照護安排，應進行完整的心理社會與當下安全評估。

A / B / C / D組合判斷

①適當、②錯誤、③在考題語境可接受、④錯誤，所以選A，僅①③。C額外納入②，正是本題錯誤所在。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是接受了「詢問會強化自殺想法」這個常見迷思，所以把②也當成適當的評估原則。

這是複習用的可能解釋，不能據此確認你作答當時的實際思路。

失分類型

- 自殺詢問迷思
- 群體風險與個人預測
- 致死性、意圖與行為終點
- 多敘述組合題

數秒判斷規則

> **懷疑自殺要直接問；憂鬱及人格障礙都要評估。高致死性方式是警訊，不能單靠方式替個人下風險結論。**

投資報酬率

極高。可延伸至急診與住院精神評估、安全計畫及心理社會介入。

國考答案與現代臨床差異

- 官方A；③文字把方式、意圖與後續行為寫得較概括，補寫版保留這個限制。
- NICE NG225不建議用風險量表或簡單低中高分類預測自殺、決定是否提供照護；應以個別需求、安全及完整評估為核心。
- 介入應包括處理身體傷害、精神共病、安全計畫、降低取得危險手段的機會及安排後續照護，不能只開藥或只做一次量表。

補寫所用來源

- NIMH 自殺評估常見問題
- NICE NG225 自傷評估與介入
- 自殺企圖方式與後續死亡的原始追蹤研究

醫學（四）Q76

本次補寫版 2026-10-07

主題：兒童AED與嬰兒復甦的年齡門檻

本次補寫版，2026年10月7日完成。原始詳解尚未回收；以下依正式試題、原始答案、最終更正及所列醫學來源重建。

題目與答案對照

關於兒童與嬰兒的心肺復甦，下列何者最適當？

- A. 9歲30公斤重的兒童可以使用成人的自動體外心臟去顫器（Automated External Defibrillator）
- B. 小於1歲的嬰兒檢查脈搏以股動脈為主
- C. 小於1歲的嬰兒異物哽塞可以使用哈姆立克法急救
- D. 急救時胸部按壓深度，至少為胸部前後徑尺寸的四分之一

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
D	A	A	無；本題未列於更正備註

參考來源：考選部正式試題；考選部原始答案；考選部最終更正檔。

個人作答取自本對話已保存的80題作答序列；以上三份官方檔案均於本次補寫重新核對。

核心考點

本題是**年齡門檻與數字規則**：9歲、30公斤可使用成人AED；嬰兒嚴重哽塞不做腹部推擠；兒童 / 嬰兒按壓深度應約為胸部前後徑**三分之一**，不是把四分之一當成合格最低目標。

各選項解析

A．9歲30公斤可用成人AED——正確

2025 AHA / AAP建議8歲以下優先使用有兒童減能裝置的AED。這名孩子9歲、30公斤，符合一般成人AED使用的考題方向。

仍須依設備說明、貼片間距及安全操作使用。臨床若更小的孩子沒有兒童減能設備，也不應因缺少它而延誤必要除顫；成人AED在特定可用資源情境仍可考慮。

B．嬰兒脈搏以股動脈為主——不符合標準教學的最佳答案

醫療人員對嬰兒的BLS脈搏評估，標準教學主要使用肱動脈；兒童較常以頸或股動脈評估。股動脈並非永遠不能觸摸，但B的『以股動脈為主』不是本題標準規則。

評估脈搏不應超過10秒，也不應因找不到脈搏而持續延誤CPR；一般民眾不需先做脈搏檢查。

C．嬰兒哽塞使用哈姆立克——錯誤

傳統所稱哈姆立克法是腹部推擠，不建議用於小於1歲嬰兒。對仍有反應但嚴重氣道異物阻塞的嬰兒，採反覆5次背擊與5次胸部推擠。

若轉為無反應，則改依復甦流程開始CPR；清除口中可見異物，不做盲目指掏。

D．至少四分之一胸徑——作為目標太淺，因此錯誤

AHA / AAP建議嬰兒與兒童胸部按壓深度至少約為前後徑三分之一，嬰兒約4公分、兒童約5公分。四分之一不能作為足夠的按壓深度標準。

不要把『三分之一當然也大於四分之一』的數學包含關係，拿來替代指引實際規定的最低目標；題目是在問能否用這個深度指導復甦。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選D可能是深度分數記憶成四分之一，或因『至少』二字，認為較低門檻也算正確，而沒有按指引核對實際目標。

這是複習用的可能解釋，不能據此確認你作答當時的實際思路。

失分類型

- 年齡別復甦規則
- 分數與深度記憶
- 最低標準與數學包含
- 嬰兒與兒童的操作差異

數秒判斷規則

嬰兒抓肱脈、哽塞背擊配胸推；按壓約三分之一胸徑：嬰4、兒5；9歲30公斤可用成人AED。

投資報酬率

極高。可延伸至兒童BLS、哽塞、AED與復甦品質判讀。

國考答案與現代臨床差異

- 官方A與年齡門檻一致；兒童減能器未提供時，不能把成人AED絕對排除於更小患者之外。
- 2025 AHA / AAP已將嬰兒按壓技術改為單手手掌根部或雙拇指環抱，並移除雙指按壓建議；本題未直接考技術，但複習時應注意新版變更。
- 本題讨论出生後嬰兒及兒童BLS，不能直接套用分娩現場的新生兒復甦流程。

補寫所用來源

- 2025 AHA / AAP Pediatric Basic Life Support
- American Red Cross 嬰兒與兒童脈搏評估

- AHA 2025 單人兒童BLS流程

醫學（四）Q77

對話詳解原文

題目與答案對照

有關失智症（dementia）的敘述，下列何者最不適當？

- A. 失智症最常見的原因是阿茲海默症（Alzheimer's disease）及血管性失智症（vascular dementia）
- B. 失智症的確診不易，需要先排除其他疾病
- C. 失智症加上步履不穩以及尿失禁症狀，應考慮常壓水腦症（normal-pressure hydrocephalus）
- D. 偽性失智症（pseudodementia）專指症狀與真正失智症難以區分的腦炎或中樞神經系統感染

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
A	D	D	無，屬真正錯題

已重新核對考選部正式試題、原始答案及最終更正檔。最終更正僅涉及Q14、Q28，不影響Q77。

核心考點

「偽性失智症」是歷史性描述，傳統上主要指：

> **憂鬱等精神疾病造成明顯認知障礙，臨床表現看起來類似失智症。**

它不是腦炎或中樞神經感染的專稱。腦炎、感染確實可能引起認知改變或快速進展型失智症候群，但應按感染性或發炎性腦病變另行診斷。

各選項解析

A．阿茲海默症與血管性失智症是常見病因——國考判定適當

阿茲海默症是最常見的失智症病因，WHO估計約占60%至70%；血管性失智症也是主要常見病因之一。WHO失智症資料

Alzheimer’ s Association將血管性失智症列為第二常見原因。不過高齡患者經常同時具有阿茲海默病理與腦血管病理，因此臨床上不能將兩者視為必然互斥的純粹類別。Alzheimer’ s Association失智症概述

B．診斷時須評估其他疾病——方向適當，但文字較簡化

失智症不能只靠一個記憶測驗確診。完整評估通常包括：

- 病程及旁觀者病史。
- 日常生活功能。
- 客觀認知測試。
- 身體及神經學檢查。

- 藥物與精神疾病評估。
- 基本檢驗及結構影像。
- 依臨床線索評估譫妄、憂鬱、藥物副作用、甲狀腺異常、營養缺乏、腫瘤、感染或常壓水腦症等原因。

因此B作為國考概括敘述可以接受。NIA失智症診斷流程

現代指引則不宜把失智症簡化為純粹的「排除診斷」。2025年DETeCD-ADRD指引要求同時建立認知行為症候群、功能程度及可能病因；基本檢驗所找的疾病常是加重因子或共病，而不一定是完全可逆、足以單獨模仿典型神經退化的原因。DETeCD-ADRD指引

C．失智樣症狀、步態不穩及尿失禁應考慮NPH——適當

常壓水腦症的經典症候群包括：

1. 步態障礙。
2. 認知障礙。
3. 尿急或尿失禁。

步態異常通常較早、也較突出；不必等三項症狀全部嚴重出現才開始懷疑。診斷仍需結合腦室擴大等影像表現、臨床型態及必要的腦脊髓液引流測試。日本常壓水腦症學會第三版指引

D．偽性失智症專指腦炎或中樞感染——錯誤，為答案

偽性失智症最常與憂鬱症等精神疾病相關；「專指」腦炎或中樞感染明顯錯誤。2023年pseudodementia綜述

而且這個名稱本身容易造成誤解：

- 不代表症狀一定是裝出來的。
- 不代表治療精神疾病後必定完全恢復。
- 不代表患者一定沒有神經退化病理。
- 老年新發憂鬱或行為改變，也可能是神經退化疾病的早期表現。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選A可能是對「血管性失智症是否仍能和阿茲海默症並列最常見原因」有所疑慮，或注意到現代病理分類中混合型失智很常見，卻沒有先辨識D對pseudodementia的定義錯置。

僅憑答案，不能確定當時實際思路。

- 失分類型：相近名稱與病因分類、歷史術語與現代概念混淆。
- 數秒判斷規則：**「偽性失智先想到憂鬱造成的失智樣表現；腦炎或感染是另外的器質性病因，不叫它的專稱。」**
- 投資報酬率：高；可延伸至憂鬱與失智鑑別、快速進展型失智症、譫妄及可治療認知障礙的評估。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

國考答案D正確。

現代臨床與傳統考法的主要差異是：不再把「偽性失智」理解成和真正失智完全二分、而且治療後必然可逆的疾病。

2025年DETeCD-ADRD指引指出，老年新發憂鬱過去常被列為pseudodementia，但情緒症狀亦可能是阿茲海默症或其他神經退化疾病的早期表現，兩者也可以共存。因此即使憂鬱治療後認知有所改善，若仍有持續或進展性功能退化，仍應追蹤及評估神經退化疾病。DETeCD-ADRD精神疾病鑑別說明

醫學（三）Q4

對話詳解原文

題目與答案對照

杵狀指（clubbing finger）的可能相關疾病，下列何者除外？

- A. 原發性肺癌
- B. 轉移性肺腫瘤
- C. 支氣管擴張
- D. 急性肺炎

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
B	D	D	無，屬真正錯題

來源：考選部正式試題、原始答案、最終更正檔。

核心考點

杵狀指應優先聯想到：

- 胸腔惡性腫瘤。
- 慢性化膿性肺病，例如支氣管擴張、肺膿瘍。
- 間質性肺病。
- 發紺性心臟病、感染性心內膜炎及部分肝腸疾病。

單純急性肺炎病程通常太短，不是典型杵狀指病因。

各選項解析

A．原發性肺癌——可造成杵狀指

肺癌是成人後天性杵狀指及續發性肥厚性骨關節病的重要病因。研究中約三成肺癌患者可測得杵狀指，但比例會隨腫瘤類型與判定方法不同。肺癌與杵狀指研究

B．轉移性肺腫瘤——較少見，但可以相關

轉移到肺部的腫瘤也可能引起杵狀指或肥厚性骨關節病，已有肺轉移癌相關病例及文獻紀錄。因此B雖不如原發性肺癌典型，仍不能選為「除外」。肺轉移癌相關杵狀指病例

C．支氣管擴張——典型慢性化膿性肺病原因

反覆感染、痰液滯留及慢性氣道發炎的支氣管擴張，屬經典杵狀指原因之一。若支氣管擴張患者出現杵狀指，也應評估疾病嚴重度及其他共存肺病。杵狀指臨床回顧

D．急性肺炎——本題答案

單純急性肺炎通常不會在短期內造成杵狀指，因此是四項中最不符合者。

但不能將答案過度延伸為「肺部感染絕不造成杵狀指」：肺膿瘍、膿胸、慢性化膿性感染或既存支氣管擴張仍可能相關。肺炎患者若已有杵狀指，應懷疑先前存在的慢性肺病或腫瘤。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選B可能是將惡性腫瘤相關杵狀指限縮為原發性肺癌，或因肺轉移造成杵狀指較罕見而將其排除；也可能沒有先利用「急性」這個病程線索。僅憑答案不能確認當時思路。

- 失分類型：疾病時間軸、慢性體徵與急性疾病配對、典型與罕見病因排序。
- 數秒判斷規則：**「杵狀指先找慢性胸腔病；癌症、支擴可以，單純急性肺炎通常來不及。」**
- 投資報酬率：高；可延伸至肺癌、支氣管擴張、間質性肺病及肥厚性骨關節病鑑別。

最新證據與國考 / 臨床差異

這是病因配對題，沒有需要以新治療指引取代國考答案。國考答案D符合現行臨床認識。

臨床上，杵狀指只是提示病因搜尋的體徵，不能單靠它診斷肺癌或支氣管擴張。新發、無法解釋的杵狀指通常需要依病史與風險進一步評估胸腔、心臟及肝腸疾病。

醫學（三）Q5

對話詳解原文

題目與答案對照

重度酒精性肝硬化的黃疸病人，最不可能出現下列何者身體診察徵象？

- A. Spider nevus
- B. Parotid gland enlargement
- C. Dupuytren's contracture
- D. Corrigan pulse

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
C	D	D	無，屬真正錯題

核心考點

前三項均可與慢性酒精使用或進展性肝病相關；**Corrigan pulse則是慢性主動脈瓣逆流的典型命名徵象。**

各選項解析

A．Spider nevus——可能出現

蜘蛛痣是慢性肝病常見皮膚徵象。研究顯示，肝硬化患者中，酒精使用及肝功能受損程度與蜘蛛痣較密切相關。肝硬化蜘蛛痣研究

但蜘蛛痣也可見於懷孕、高雌激素狀態或健康者，不能單獨確診肝硬化。

B．Parotid gland enlargement——可能出現

慢性酒精使用與進展性肝病可伴隨sialadenosis，即無痛、非發炎性、通常雙側的腮腺腫大。營養異常、自主神經病變、糖尿病等也可能參與。進展性肝病與sialadenosis研究

C．Dupuytren's contracture——可以相關

Dupuytren攣縮是掌腱膜纖維增生造成手指逐漸屈曲攣縮。酒精暴露是已知關聯因子之一，傳統身體診察亦將其列入慢性酒精使用的相關徵象。

但它並不是酒精性肝硬化專屬表現，也受到遺傳、年齡、糖尿病及吸菸等因素影響。Dupuytren疾病回顧

D．Corrigan pulse——最不可能，為答案

Corrigan pulse的核心是：

- 脈搏快速上升。
- 隨後在舒張期快速塌陷。

- 常伴寬脈壓。
- 典型指向慢性、顯著的主動脈瓣逆流。

因此它不是酒精性肝硬化的典型身體徵象。Corrigan pulse與主動脈逆流

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是將Dupuytren攣縮視為獨立的手部疾病，沒有連結到慢性酒精暴露；也可能沒有把Corrigan這個命名脈搏固定配對主動脈瓣逆流。不能據此斷言當時實際思路。

- 失分類型：命名徵象與病因配對、慢性酒精相關體徵、關聯性與疾病特異性。
- 數秒判斷規則：**「蜘蛛痣、腮腺大、掌腱膜攣縮都可見於慢性酒精問題；Corrigan先鎖定主動脈逆流。」**
- 投資報酬率：高；可延伸至慢性肝病身體診察、酒精相關疾病及脈搏型態辨識。

最新證據與國考 / 臨床差異

國考答案D合理。需要注意兩個臨床邊界：

1. 肝硬化可有高動力循環及較強的bounding pulse，但不能直接稱為典型Corrigan pulse；若有寬脈壓、快速塌陷脈或舒張期雜音，仍應評估主動脈逆流。
2. 蜘蛛痣、腮腺腫大及Dupuytren攣縮都不具足夠敏感度或特異度，不能靠身體徵象單獨確診酒精相關肝硬化。

2024年ACG酒精相關肝病指引強調以飲酒史、實驗室、影像及非侵入性纖維化評估建立診斷與分層，而不是由單一外觀徵象決定。ACG 2024酒精相關肝病指引

醫學（三）Q6

新增校正版 · 2026-10-10

題目與答案對照

冠狀動脈循環提供心肌所需之氧氣及養分，下列敘述何者最不適當？

- A. 心肌需氧量（myocardial oxygen demand）的主要決定因子為：心率、心肌收縮強度以及心肌壁張力
- B. 正常冠脈血流在心臟收縮循環中呈現週期式變化，於心室舒張期血流量較多
- C. 在正常、無嚴重狹窄病灶的冠脈循環中，大部分血流阻力來自於近端、心外膜（epicardial）冠脈節段
- D. 除嚴重狹窄病灶外，冠脈痙攣、血栓、先天冠脈異常開口等，也可能導致冠脈血流不足

使用者作答	原始答案	最終答案	特殊計分
B	C	C	無，屬真正錯題

官方來源：正式試題、原始答案、最終更正。個人選項取自原始成績單第二頁，2026-10-10重新核對。

核心考點

正常的大型心外膜冠脈主要負責輸送；主要血流阻力與調控在較小的阻力血管。題幹限定「正常、無嚴重狹窄」，所以不能把病變造成的大血管阻力套進正常生理。

逐選項解析

A：適當。心率、收縮強度與心肌壁張力，是判讀心肌耗氧需求的重要因素；心率與收縮強度增加會提高需求。

B：適當，不是本題答案。左心室收縮時壓迫心肌內血管，舒張時壓迫減輕，因此左心室、尤其心內膜下灌流偏重舒張期。這個敘述不能延伸成所有冠脈、所有心室都只在舒張期有血流。

醫學（三）Q6 · 續

C：最不適當，官方答案。正常近端心外膜冠脈口徑較大，阻力貢獻小；小動脈、微動脈等阻力血管才是主要阻力與流量調控位置。若大型冠脈出現有血行動力意義的狹窄，情況才會改變。

D：適當。它列出固定狹窄之外可能影響冠脈供血的病因，並非聲稱每種異常開口都必然導致缺血。判題時應保留「可能」的條件性。

可能的失分機制

原始成績單確認選B，不能只憑這一個選項確定你當時的思路。複習時可檢驗兩個候選缺口：是否把心肌「收縮時需氧」直接等同「收縮時灌流最多」；是否把看得見的大冠脈當成正常主要阻力來源。兩者都需要再次作答或自述才能確認。

複習標籤

- 冠脈血管層級與阻力位置
- 心肌收縮、需氧量與灌流時相的區分
- 正常生理與嚴重狹窄病變的條件差異

數秒判斷規則

> 大冠脈輸送，小阻力血管調控；左室灌流偏舒張。先讀清「正常、無嚴重狹窄」。

國考與臨床使用界線

答案C符合正常冠脈生理。這不是用單一血管位置判定胸痛病因的規則；大冠脈未見顯著阻塞，也不能直接排除微循環相關缺血。

補寫來源與核對範圍

- Regulation of Coronary Blood Flow in Health and Ischemic Heart Disease（2015）：正常阻力分布、收縮壓迫與舒張期灌流。
- Beyond Coronary Artery Disease: Assessing the Microcirculation（2023）：輸送血管與微循環分工、非阻塞性冠脈疾病的界線。

核對日期：2026-10-10。個人作答已確認；失分原因仍是待驗證假說。

醫學（三）Q7

2026-10-10校正版 · 個人選項及失分推論修正

題目與答案對照

72歲男性，本身有高血壓、第二型糖尿病及慢性阻塞性肺病，本次因肺炎併慢性阻塞性肺病急性惡化住院，持續抱怨心悸、氣促，心電圖如題示，血行動力學穩定。下列選項組合何者正確？

1. 此心律應為心房顫動（atrial fibrillation）
2. 此類心律不整的機轉最可能是reentry
3. 急性心率控制首選靜脈輸注propranolol
4. 頸動脈按摩無法終止此類心律不整
5. 綜合心律不整及共病的血栓風險，應給予抗凝血藥物
6. 此類心律不整無明顯血栓風險，不優先考慮抗凝血
    - A. 僅②④⑤
    - B. 僅①②④⑤
    - C. 僅②③⑥
    - D. ①②③④⑤⑥

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
C	A	A	無，屬真正錯題

來源：正式試題、原始答案、最終更正檔。

核心考點

心電圖可見：

- 下壁導程連續、規則的鋸齒狀flutter waves。
- 沒有正常P波之間的等電位線。
- 心房活動規則，心室反應也相對規則，約為2：1房室傳導。

因此是典型心房撲動，不是「絕對不規則」的心房顫動。典型心房撲動是繞行三尖瓣環、經cavotricuspid isthmus的大型折返心律。

醫學（三）Q7 · 續

各敘述解析

① 心房顫動——錯誤

心房顫動應呈現無規則P波及irregularly irregular的R–R間距。本圖則有規則鋸齒波，符合心房撲動。

② 機轉為**reentry**——正確

典型心房撲動屬右心房大型折返。常見型為逆時針繞行三尖瓣環，心房頻率約250 ~ 330次 / 分。ESC上心室頻脈指引

③ 靜脈**propranolol**是首選——錯誤

穩定的快速心房撲動可依血壓、心室功能及共病選擇：

- β阻斷劑。
- Diltiazem或verapamil。
- 特定情境下digoxin或amiodarone。
- 控制困難時考慮心律轉復。

但propranolol是非選擇性β阻斷劑，本題患者正值肺炎及COPD急性惡化，不能列為固定「首選」。這不代表所有COPD患者都絕對禁用β阻斷劑；臨床可依病況慎選β1選擇性藥物。

④ 頸動脈按摩無法終止——正確

迷走神經刺激可能暫時提高房室傳導阻滯，使flutter waves更清楚，具有診斷輔助價值；但心房撲動的折返環路位於心房，通常不會因此終止。

臨床上頸動脈按摩也不能隨意操作；若有頸動脈雜音、顯著狹窄或近期腦中風 / TIA等風險，應避免。

⑤ 應考慮抗凝血——正確

本題男性72歲，合併高血壓、糖尿病，以常用CHA_2DS_2-VASc架構計算為3分。心房撲動的血栓風險雖可能低於心房顫動，但仍具臨床意義，現行實務通常依類似AF的風險架構決定抗凝。ESC指引的心房撲動抗凝章節

⑥ 無明顯血栓風險——錯誤

與⑤相反。心房撲動也可能形成心房血栓，且與心房顫動經常共存或互相轉換，不能忽略中風預防。

醫學（三）Q7 · 失分校正

可能的失分機制（校正）

原始作答為**C**：僅②③⑥；正確答案**A**：僅②④⑤。兩者共有②，但C多納入③與⑥，並未納入④與⑤。選項組合的差異是可確認事實；不能因此斷定你逐項判斷時的實際思路。

先前以誤記的B推論「主要把心房撲動認成心房顫動」的說法撤回。C不含①，這份作答本身不足以支持那個影像失誤推論。

後續優先檢驗：COPD急性惡化時的速率控制選藥、心房撲動的血栓風險與抗凝，以及迷走神經刺激能顯露波形、卻通常不能終止心房內折返的區分。這些是複習方向，不是已證實的個人認知診斷。

失分類型

- 心電圖形態為教學考點；不再由本次選C推定影像失誤
- 心房撲動與心房顫動鑑別
- 大型折返機轉
- 共病情境下速率控制選藥
- 血栓風險評估

數秒判斷規則

> 鋸齒規則是**flutter**；基線亂、**R–R**絕對不規則是**AF**。**Flutter**不易被迷走刺激終止，但抗凝風險不能忘。

投資報酬率

極高。可延伸至規則型窄QRS心搏過速、2：1房室傳導、迷走刺激 / adenosine的診斷用途、速率控制及心律轉復前抗凝。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

國考答案A合理。現代臨床須再補上：

- 血行動力不穩定時應同步電擊整流，不再先嘗試多種速率控制藥物。
- 穩定患者的藥物選擇取決於左心室功能、血壓、肺病及其他共病，不能背成propranolol固定首選。
- 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS指引第6.8.6節明確建議心房撲動依AF相同風險架構決定抗凝（Class 1，B-NR）；僅有AFL者的專門隨機試驗證據仍有限。指引原文
- 典型心房撲動反覆發作時，cavotricuspid isthmus消融術成功率高，常優於長期反覆使用抗心律不整藥物。ESC上心室頻脈指引

2026-10-10校正：個人C / 官方A，Q7未列於最終更正題。原題與其餘逐項教學保留；原始選項依成績單核對。

醫學（三）Q12

對話詳解原文

題目與答案對照

承上題，王先生接受緊急心導管檢查，發現左前降支完全阻塞，其餘血管無嚴重狹窄，並於胸痛發作後4小時內成功植入藥物塗層金屬支架。其後續處置何者最不適當？

- A. 不論心臟收縮功能是否下降，只要血行動力正常、收縮壓高於100 mmHg，建議投與ACE inhibitor或ARB
- B. 若有心尖部心室瘤及室壁血栓，無出血風險時可考慮抗凝血治療3～6個月
- C. 心肌梗塞24小時內若發生心室頻脈或心室顫動，恢復竇性心律後應預防性給予lidocaine
- D. 應監控血清鎂；若偏低，補充至正常範圍以降低心律不整風險

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
A	C	C	無，屬真正錯題

核心考點

Lidocaine可以治療選定的持續或復發性心室性心律不整，但不能在心律已恢復後常規預防性投與。

預防性lidocaine並未證實改善心肌梗塞患者的總死亡率，還可能造成心搏過緩、傳導阻滯、低血壓及神經毒性。

各選項解析

A．ACEI / ARB——本病例可接受，但敘述稍嫌過廣

患者是：

- 前壁STEMI。
- LAD完全阻塞。
- 有高血壓及糖尿病。
- 血行動力穩定。

即使尚未提供LVEF，他仍具有前壁梗塞、高血壓及糖尿病等使用ACEI / ARB的理由，因此A不是最佳錯誤。

但臨床不能只看「收縮壓高於100」：仍要評估腎功能、血鉀、低血壓、雙側腎動脈狹窄、血管性水腫病史及其他禁忌。2025 ACC / AHA急性冠心症指引

B．已確認左心室血栓可抗凝——方向適當

前壁梗塞、心尖部無動或心室瘤均增加左心室血栓風險。已確認血栓且無明顯出血禁忌時，應考慮口服抗凝並追蹤影像。

傳統教材常列3～6個月；2022年AHA科學聲明則建議心肌梗塞後已確認左心室血栓通常治療約3個月，再依血栓是否消失、心室功能及出血風險調整。AHA / ACC左心室血栓整理

C．恢復竇性心律後預防性lidocaine——錯誤，為答案

若仍有持續或反覆發生的缺血性VT / VF，可依情況使用電擊、amiodarone或lidocaine，同時處理缺血與電解質異常。

但「心律已恢復後例行預防性投與」不是現代標準。系統性回顧未證實預防性lidocaine可降低全因死亡或心室顫動，而且證據品質及安全性均有限。Cochrane預防性lidocaine回顧

D．低鎂補至正常——適當

低鎂會提高心室性心律不整及QT相關心律不整風險，因此應監測並矯正。

但這不能延伸成「鎂正常也要例行高劑量補充」；本選項只說低鎂時補回正常，方向合理。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選A可能是注意到「不論心臟收縮功能」及「只要收縮壓高於100」過度概括，因而認為A不適當。這項質疑有臨床道理，但本病例本身具有前壁STEMI、高血壓及糖尿病，ACEI / ARB仍有充分適應性。

相較之下，C明確主張心律恢復後常規預防性lidocaine，是更直接且具有潛在傷害的錯誤。

失分類型

- 最佳答案排序
- 病例條件與一般敘述的區分
- 心肌梗塞後心室性心律不整
- 治療性與預防性抗心律不整藥物混淆
- 左心室血栓抗凝療程

數秒判斷規則

> **VT / VF正在持續或反覆，可治療；已恢復竇律，不例行用lidocaine「預防」。前壁MI加糖尿病 / 高血壓，ACEI或ARB有理由使用。**

投資報酬率

極高。可延伸至急性心肌梗塞併發症、電風暴、低鉀低鎂、左心室血栓及梗塞後二級預防。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

- 國考答案C與現代證據一致。
- Lidocaine仍有治療角色，但不是MI後所有患者或恢復竇律後的常規預防藥。
- 左心室血栓療程不宜固定背成3～6個月；現代建議多以約3個月及追蹤影像為起點，再個別調整。

- A的文字確實過度簡化；收縮壓高於100 mmHg不是使用ACEI / ARB的唯一條件，但本病例的前壁梗塞、糖尿病及高血壓使A仍可成立。
- 低鎂應補回正常，但正常血鎂不代表需要常規超量補充。

醫學（三）Q16

對話詳解原文

題目與答案對照

關於幽門螺旋桿菌的描述，下列何者正確？

- A. 糞便幽門螺旋桿菌抗體檢測有9成的敏感性與特異性
- B. 快速尿素酶檢驗（rapid urease test）為侵入性檢查
- C. 吹氣試驗（urea breath test）為非侵入性檢查項目，但^{13}C具輻射性，不宜用於小孩及孕婦
- D. 根除幽門螺旋桿菌使用抗生素治療後，建議需在停藥1週後即檢驗是否殺菌成功

題目見考選部醫學（三）正式試題。1302.doc

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
C	B	B	無，屬真正錯題

原始答案及最終更正檔均確認為B；本份更正不涉及Q16。wwwq.moex.gov.tw+1

核心考點

這題要同時分清三件事：

1. 檢查是否需要胃鏡取材。
2. ^{13}C與^{14}C的放射性差異。
3. 根除治療後的正確複驗時機。

快速尿素酶檢驗需要胃鏡取得胃黏膜切片，因此歸類為侵入性檢查，B正確。

各選項解析

A．糞便幽門螺旋桿菌抗體檢測——錯誤

現行常用的是**糞便抗原檢驗（stool antigen test）**，不是把「糞便抗體」當成標準活動性感染檢查。

- 糞便抗原檢驗以免疫分析偵測幽門螺旋桿菌抗原。
- 使用單株抗體的ELISA可具有良好敏感度及特異度。
- 血清抗體可能在根除後持續陽性，因此不適合確認是否根除成功。

選項可能混淆了「使用抗體偵測糞便中的抗原」與「檢測病人的幽門螺旋桿菌抗體」。

B．快速尿素酶檢驗為侵入性檢查——正確

檢驗本身是在切片組織上進行，但胃黏膜切片必須經由上消化道內視鏡取得，因此臨床分類為侵入性檢查。

若患者近期使用PPI、抗生素或鉍劑，菌量下降可能造成偽陰性；不能只因一次陰性便完全排除感染。

C．^{13}C具輻射性——錯誤

^{13}C是穩定、**非放射性**同位素。^{13}C尿素呼氣試驗屬非侵入性檢查，可用於成人、兒童及孕婦；真正具有放射性的是^{14}C。

歐洲共識指出^{13}C尿素可安全重複使用，包括兒童及孕婦，並建議將^{13}C呼氣試驗用於根除後確認。PMC

但「檢查本身安全」不代表所有兒童都應照成人模式直接test-and-treat；兒童是否檢驗仍須依症狀及兒科適應症判斷。

D．停抗生素一週後確認根除——錯誤

一週太早，容易因菌量暫時受抑制造成偽陰性。

2024年ACG指引要求治療者均應確認根除，使用尿素呼氣、糞便抗原或胃黏膜檢查，時機為：

- 抗生素療程完成後至少4週。
- PPI或PCAB停用至少2週。
- 必要時可在等待期間使用H_2阻斷劑或制酸劑銜接。American College of Gastroenterology

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是把^{13}C與具有放射性的^{14}C混淆，或雖辨識出呼氣試驗屬非侵入性，卻未確認同位素性質。

另一個可能是沒有把快速尿素酶檢驗所需的**胃鏡切片取材**納入侵入性判斷；僅憑作答結果不能確定當時思路。

失分類型

- 檢驗工具與檢測標的
- 侵入性與非侵入性檢查
- ^{13}C / ^{14}C同位素辨別
- 根除後複驗時序
- 糞便抗原與抗體混淆

數秒判斷規則

RUT要胃鏡切片，所以侵入；^{13}C不放射；根除確認等抗生素結束至少4週，PPI停至少2週。

投資報酬率

極高。可延伸至消化性潰瘍、胃MALT淋巴瘤、胃癌風險、test-and-treat策略，以及PPI、抗生素與鉍劑造成的偽陰性。

國考答案與現代臨床差異

國考答案B與現行檢查分類一致。現代臨床需補充：

- 糞便抗原與尿素呼氣試驗均可偵測活動性感染及確認根除。
- 血清抗體通常不能用於根除確認。
- 檢查準確度受近期PPI、PCAB、抗生素及鉍劑影響。
- ^{13}C沒有輻射問題；是否替兒童或孕婦檢驗，仍取決於臨床適應症，而非同位素危險性。
- D不只是時間稍短，而是會增加假陰性風險。

醫學（三）Q17

對話詳解原文

題目與答案對照

肝硬化病理特徵中，肝細胞質量減少及血流改變主要是因為何種細胞活化導致？

- A. Kupffer細胞
- B. 肝星狀細胞（hepatic stellate cells）
- C. 肝細胞
- D. 肝臟內皮細胞

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
D	B	B	無，屬真正錯題

官方題目、原始答案及最終更正檔均支持B。1302.doc+2

核心考點

肝星狀細胞平時位於**Disse腔**，具有儲存維生素A等功能。慢性肝損傷後，它會：

1. 受到TGF-β、PDGF及發炎訊號活化。
2. 轉變成肌纖維母細胞樣細胞。
3. 製造膠原及其他細胞外基質。
4. 產生收縮作用。
5. 形成纖維隔、增加竇狀隙阻力並改變肝內血流。

因此本題答案是B。

各選項解析

A．Kupffer細胞——參與啟動及調控，但不是主要纖維化效應細胞

Kupffer細胞是肝臟常駐巨噬細胞，可藉由細胞激素、氧化壓力及發炎訊號促進肝星狀細胞活化。

它在病程中很重要，但主要角色偏向：

- 感知肝損傷。
- 發動或維持發炎反應。
- 調節其他細胞。

不是本題所問的主要膠原與細胞外基質製造細胞。

B．肝星狀細胞——正確

肝星狀細胞活化後是肝纖維化最主要的肌纖維母細胞來源。

命運追蹤研究顯示，在毒性、膽汁鬱積及脂肪性肝損傷模型中，肝星狀細胞形成約82%至96%的肌纖維母細胞，支持其為主要纖維化效應細胞。Nature Communications

除了產生基質，活化的星狀細胞也具收縮性，會提高肝竇阻力並參與門脈高壓形成。

C．肝細胞——主要是受傷及減少的實質細胞

肝細胞受傷、凋亡或壞死會釋出促發炎及促纖維化訊號，也會造成題幹所說的肝細胞質量下降。

但肝細胞本身不是肝硬化中主要的膠原沉積細胞。題目問的是造成纖維化與血流重塑的主要「活化細胞」，仍應選肝星狀細胞。

D．肝臟內皮細胞——參與血管調控，但不是本題最佳答案

肝竇內皮細胞確實參與：

- 肝竇毛細血管化。
- 一氧化氮與血管張力調節。
- 發炎細胞募集。
- 肝星狀細胞活化及血管新生。

這也是使用者所選的選項。然而題幹同時描述肝細胞減少、纖維化及血流改變，主要共同驅動者仍是活化的肝星狀細胞。肝硬化的橋接纖維化會增加肝竇血流阻力，進而造成門脈高壓；內皮與血管活性機轉則是整個網絡的一部分。AASLD

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選D可能是看到「血流改變」便優先聯想到血管內皮細胞，卻沒有把它與前面的「肝細胞質量減少」及肝硬化纖維化整合。

另一種可能是知道內皮細胞參與竇狀隙阻力，卻沒有進一步區分：

- 調控血管及細胞訊號的參與者。
- 真正大量產生膠原、形成纖維隔的主要效應細胞。

不能由答案斷言當時實際思路。

失分類型

- 肝臟細胞—功能配對
- 肝纖維化機轉
- 主要效應細胞與調控細胞
- 門脈高壓與竇狀隙阻力
- 題幹多項結果的共同機轉

數秒判斷規則

> **看到肝纖維化、膠原沉積、Disse腔與肌纖維母細胞，先鎖定肝星狀細胞；Kupffer負責發炎訊號，內皮負責血管調控。**

投資報酬率

極高。可延伸至肝硬化病理、門脈高壓、TGF-β訊號、肝纖維化逆轉、彈性影像及抗纖維化治療研究。

國考答案與現代臨床差異

國考答案B符合目前肝纖維化機轉。

現代觀點需要避免把它簡化成「只有肝星狀細胞參與」：

- Kupffer細胞及其他免疫細胞提供發炎與促纖維化訊號。
- 肝竇內皮細胞參與毛細血管化、血管張力及細胞間訊息。
- 肝細胞死亡提供持續損傷刺激。
- 膽汁鬱積性疾病中，門脈纖維母細胞等其他細胞來源也可能參與。
- 但以主要、跨病因的纖維化效應細胞而言，肝星狀細胞仍是最佳答案。

醫學（三）Q18

對話詳解原文

題目與答案對照

關於肝性腦病變（hepatic encephalopathy）的治療，下列何者正確？

- A. 目前限制蛋白質攝取是肝性腦病變的首選治療方法
- B. 乳果糖（lactulose）透過腸道酸化促進氮代謝物排除，是治療主力
- C. 利用新型全身性抗生素如neomycin與metronidazole可避免副作用
- D. rifaximin因全身吸收率高，常用於急性肝性腦病變治療

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
A	B	B	無，屬真正錯題

正式題幹及選項見考選部試題；原始答案Q18為B，最終更正只涉及Q1、Q8、Q10、Q36、Q38、Q40，不影響本題。1302.doc+2

核心考點

顯性肝性腦病變的處理主軸是：

1. 保護呼吸道並排除其他意識改變原因。
2. 找出並矯正誘因，如感染、消化道出血、便祕、脫水、低血鉀、腎功能惡化或鎮靜藥物。
3. 以lactulose作為治療主力。
4. 反覆發作者常在lactulose基礎上加用rifaximin。

AASLD / EASL指引將lactulose列為episodic overt HE第一選擇，並建議rifaximin作為lactulose的加成治療以預防復發。PubMed+1

各選項解析

A．限制蛋白質為首選——錯誤

常規或長期限制蛋白質可能加重肌少症及營養不良，反而降低骨骼肌代謝氨的能力。傳統指引建議蛋白質約1.2～1.5 g/kg/day；若對動物性蛋白耐受不佳，可調整蛋白來源，而不是全面禁食蛋白。aasld.org

B．Lactulose促進氮代謝物排除——正確

Lactulose在結腸經細菌代謝形成有機酸，可：

- 降低腸腔pH。
- 使較易吸收的NH_3轉為較不易吸收的NH_4^+。
- 產生瀉劑作用，縮短含氮物質在腸道的停留時間。

臨床常調整至每日約2～3次軟便，但過量可造成脫水、高血鈉、吸入風險，甚至再次誘發肝性腦病變。

C．Neomycin與metronidazole可避免副作用——錯誤

兩者並非「新型、可避免副作用」的全身性抗生素。Neomycin可能造成腎毒性及耳毒性；metronidazole長期使用可能造成周邊神經毒性。它們最多屬選定情況下的替代方案，不是優先且無副作用的治療。aasld.org

D．Rifaximin全身吸收率高——錯誤

Rifaximin的特色正是**腸道作用、全身吸收極低**。它常用於：

- Lactulose效果不足或不能耐受時的加成治療。
- 反覆顯性肝性腦病變的次級預防。

因此D不但把吸收特性寫反，也把急性治療與復發預防的主要定位混在一起。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選A可能沿用「氨來自蛋白質，所以先限蛋白」的舊式直覺，沒有納入現代肝硬化照護對肌少症及營養不良的重視；也可能尚未固定lactulose、rifaximin與具全身毒性抗生素的治療排序。

- 失分類型：治療排序、舊式處置與現代策略、藥物作用位置與吸收特性。
- 數秒判斷規則：**「肝性腦病變先找誘因、給lactulose；反覆再加rifaximin，不常規餓蛋白。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至肝硬化營養、上消化道出血、感染、便祕及藥物誘發意識改變。

國考答案與現代臨床差異

國考答案B與現行指引一致，但臨床不能只開lactulose便結束：

- 必須同步矯正誘因及排除其他意識障礙原因。
- Rifaximin的主要角色是加成及復發預防，並非因「吸收率高」。
- 不應常規長期限制蛋白質。
- Lactulose須依排便反應調整，不是劑量越高越好。

醫學（三）Q21

對話詳解原文

題目與答案對照

關於大腸直腸癌的敘述，下列何者正確？

- A. 50歲以下的大腸癌，不論在歐美國家或亞太地區都有逐年增加的趨勢
- B. 腺瘤（adenoma）為癌前病變，幾乎所有的腺瘤都會轉變為癌症，因此大腸鏡檢查時必須將所有偵測到並診斷為腺瘤性息肉的病灶均予以切除
- C. 遺傳性大腸癌當中Lynch syndrome的長期預後較一般散發性大腸直腸癌差
- D. 吸菸是大腸直腸癌最重要的危險因子

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
C	A	A	無，屬真正錯題

官方原始答案及最終答案均為A，且本題不在特殊計分範圍。1302.doc+2

核心考點

早發性大腸直腸癌正在多個地區增加，但各國趨勢並非完全一致。

涵蓋50個國家與地區的登記資料研究顯示，最近十年間25～49歲大腸直腸癌發生率在其中27個國家或地區上升，範圍涵蓋歐美及亞太地區。因此A是本題最佳答案；但不宜過度解讀成每一國、每一年均持續上升。PubMed

各選項解析

A．50歲以下大腸直腸癌於歐美及亞太地區增加——最佳答案

早發性大腸直腸癌的增加已不是單一美國現象，而是見於多個不同經濟及地理區域。

現代篩檢策略也已反映此趨勢：USPSTF將一般風險成人開始篩檢年齡由50歲下修至45歲。這不代表45歲以下完全不會罹癌；有警訊症狀或高風險家族史者仍須依個別情況檢查。United States Preventive Services Taskforce

B．幾乎所有腺瘤都會癌化——錯誤

腺瘤確實是重要癌前病變，大腸鏡發現後通常應完整切除；但只有一部分會沿著腺瘤—癌序列進展。

進展風險受下列因素影響：

- 大小。
- 絨毛成分。
- 高度異生。
- 數量。

- 完整切除與否。

因此B是把「應切除癌前病變」錯誤推論成「幾乎所有腺瘤都必然癌化」。息肉切除後的追蹤間隔也會依病理及數量分層，不是所有患者都使用相同頻率。gastrojournal.org

C．Lynch syndrome長期預後較散發型差——不恰當

Lynch syndrome會增加：

- 終生大腸直腸癌風險。
- 年輕發病機率。
- 異時性大腸癌及其他相關癌症風險。

但「較容易罹癌」不等於「罹癌後預後必然較差」。研究結果會受期別、年齡、MMR / MSI狀態及治療影響；現有比較常顯示Lynch相關癌症存活相近或較佳，不能像C一樣概括為較差。PubMed+2

D．吸菸是最重要危險因子——錯誤

吸菸確實增加大腸直腸癌風險，但只是多項因素之一，不能單列為最重要者。其他因素包括：

- 年齡及家族史。
- Lynch syndrome、FAP等遺傳症候群。
- 發炎性腸道疾病。
- 肥胖、缺乏運動。
- 飲酒及部分飲食型態。

NCI將吸菸、肥胖、缺乏運動及中重度飲酒列為風險增加因素；並未將吸菸指定為單一最重要原因。NCI

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是把Lynch syndrome的高終生罹癌風險、年輕發病及異時性癌風險，直接延伸成確診後的長期存活一定較差；也可能對A使用「不論」的廣泛措辭有所保留。

A的文字確實過度概括，但在四個選項中仍是最符合整體流行病學趨勢的答案。

- 失分類型：發生風險與確診後預後混淆、群體趨勢與絕對敘述、癌前病變進展機率。
- 數秒判斷規則：**「早發CRC多地上升；腺瘤不是顆顆癌化；Lynch高風險不等於預後必差；吸菸只是眾多風險之一。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至大腸癌篩檢年齡、家族史詢問、Lynch syndrome辨識及大腸息肉追蹤。

國考答案與現代臨床差異

國考答案A方向合理，但現代資料顯示各國趨勢具有異質性：

- 不能解讀為所有歐美及亞太國家均逐年增加。
- 一般風險篩檢自45歲開始，不表示有症狀者應等到45歲。

- 年輕患者若有血便、缺鐵性貧血、排便習慣改變、體重下降或家族史，應進一步評估。
- Lynch syndrome的照護重點是遺傳確認、密集監測及相關器官癌症風險管理，而不是先假定預後較差。

醫學（三）Q24

對話詳解原文

題目與答案對照

下列何者不是慢性腎臟病病人之常見危險因子？

- A. 吸菸
- B. 喝酒
- C. 糖尿病
- D. 高血壓

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
A	B	B	無，屬真正錯題

題目、答案及特殊計分狀態已由考選部Q / S / M檔交叉確認；最終更正不影響Q24。1302.doc+1

核心考點

在國考基本框架中：

- 糖尿病、高血壓是CKD最重要且常見的危險背景。
- 吸菸與新發CKD及腎功能惡化具有流行病學關聯。
- 「喝酒」並非與前三項並列的教科書式常見CKD危險因子，因此B是最佳答案。

KDIGO 2024將高血壓與糖尿病列為CKD偵測的最高優先狀態；前瞻性世代研究的統合分析也支持吸菸是新發CKD的獨立危險因子。kdigo.org+2

各選項解析

A．吸菸——屬危險因子，不是答案

吸菸可透過血管內皮功能異常、氧化壓力、發炎及腎絲球硬化等途徑增加腎臟風險。統合分析顯示，現行吸菸者的新發CKD風險高於從未吸菸者，戒菸後風險則會下降。academic.oup.com

KDIGO亦建議所有CKD患者停止使用菸草產品，但這項建議同時著眼於心血管疾病、呼吸道疾病、癌症及整體死亡風險，不能把它簡化成單一腎臟機轉。kdigo.org

B．喝酒——本題最佳答案

一般性的「喝酒」不像糖尿病、高血壓及吸菸，通常不被列為這類基礎題中的常見CKD危險因子。

但不能過度延伸成酒精對腎臟完全無害。重度飲酒可能透過：

- 高血壓。
- 脫水或急性腎損傷。

- 橫紋肌溶解。
- 肝硬化及肝腎症候群。
- 高尿酸與代謝異常。

造成直接或間接傷害。KDIGO也建議合併高尿酸或痛風的CKD患者限制酒精；這與「飲酒是常見獨立CKD危險因子」仍是不同命題。kdigo.org

C．糖尿病——典型危險因子

糖尿病是CKD及腎衰竭的重要病因。KDIGO / ADA建議第二型糖尿病從確診時開始篩檢CKD；第一型糖尿病通常於確診五年後開始。kdigo.org+1

D．高血壓——典型危險因子

高血壓既可能造成CKD，也常因腎功能惡化而加重，形成惡性循環。KDIGO將高血壓、糖尿病及心血管疾病列為CKD偵測的最高優先狀態。kdigo.org

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選A可能是把吸菸主要聯想到肺癌與心血管疾病，低估其與新發CKD及腎病進展的關聯；也可能把酒精造成脫水、肝病等間接腎損傷，直接等同於教科書列舉的常見CKD危險因子。

僅憑答案不能確定當時實際思路。

- 失分類型：危險因子與間接傷害途徑混用、典型與可能相關因素排序。
- 數秒判斷規則：**「CKD常見風險先鎖糖尿病、高血壓、吸菸；酒精可間接傷腎，但不是本題的典型並列項。」**
- 投資報酬率：高；可延伸至CKD篩檢、生活型態調整及危險因子分層。

國考答案與現代臨床差異

國考答案B在四選一的基礎框架下合理，但臨床上不應使用「喝酒 / 不喝酒」二分法。仍要考慮飲酒量、飲酒型態、肝病、高血壓、藥物、脫水及其他共病；也不能僅憑一項生活習慣判定CKD病因。

醫學（三）Q26

對話詳解原文

題目與答案對照

45歲女性，因急性腸胃炎，上吐下瀉，血壓130 / 80 mmHg，血清creatinine 0.8 mg/dL、Na 132 mEq/L。下列何種賀爾蒙分泌上升，是其低鈉血症最可能原因？

- A. Thyroxine
- B. Vasopressin
- C. Aldosterone
- D. Glucocorticoid

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
A	B	B	無，屬真正錯題

考選部原始與最終答案均為B；Q26不在特殊計分清單內。1302.doc+1

核心考點

病理生理鏈是：

> **吐瀉造成水與鈉流失 → 有效循環量下降 → 壓力感受器觸發非滲透性vasopressin / ADH分泌 → 集尿管保水 → 水分保留相對超過鈉 → 低血鈉。**

因此答案是B。

血壓正常、肌酸酐正常，並不能排除早期或輕度低血容量。身體會先啟動交感神經、RAAS及vasopressin等代償，尚未必然出現低血壓或腎前性肌酸酐升高。

2024年低鈉治療標準亦將輕至中度低血容量性低鈉描述為ADH對胃腸道水電解質流失的代償反應。Oxford Academic

各選項解析

A．Thyroxine——不是本題機轉

嚴重甲狀腺功能低下有時可伴低鈉，但不是因為thyroxine分泌上升；本題也沒有甲狀腺疾病線索。

急性吐瀉後低鈉應先依有效循環量與ADH反應解釋，不能看到低鈉就直接套用甲狀腺鑑別。

B．Vasopressin——正確

Vasopressin即抗利尿激素ADH。當有效循環量下降時，即使血漿滲透壓偏低，非滲透性的容量刺激仍可能壓過正常滲透調節，使ADH持續分泌。

其結果是：

- 腎臟濃縮尿液。

- 排除自由水的能力下降。
- 水分相對滯留。
- 血清鈉受到稀釋。

這不是SIADH；低血容量時的ADH上升屬生理性、適當的代償反應。

C · Aldosterone——可能上升，但不是低鈉的直接原因

低血容量可啟動RAAS，使aldosterone增加；但它主要促進：

- 鈉再吸收。
- 鉀與氫離子排出。
- 容量維持。

它的作用方向是保留鈉，不能直接解釋本題的稀釋性低鈉。真正使自由水排除下降的是vasopressin。

D · Glucocorticoid——不符合

Glucocorticoid本身分泌上升並非本題低鈉原因。相反地，腎上腺功能不全造成的cortisol不足，才可能解除對ADH的抑制並形成低鈉；題幹沒有低血壓、高血鉀、色素沉著或類固醇停藥等線索。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選A可能是記得「甲狀腺功能低下可伴低鈉」，卻沒有先把急性吐瀉轉換成有效循環量下降與非滲透性ADH分泌的因果鏈。

也可能因血壓與肌酸酐正常，而過早排除低血容量；僅憑答案不能確定實際思路。

- 失分類型：題幹生理條件轉換、賀爾蒙作用方向、正常檢驗的排除能力。
- 數秒判斷規則：**「吐瀉低鈉：有效循環量下降，非滲透性ADH上升而留水；正常血壓不排除。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至低血容量、SIADH、心衰竭、肝硬化及腎上腺功能不全造成的低鈉鑑別。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

國考答案B與現行生理及治療架構一致。

臨床上若確認低血容量性低鈉：

- 處理持續吐瀉等病因。
- 通常以0.9% saline或平衡晶體液恢復容量。
- 補液後vasopressin刺激消失，可能突然出現大量稀尿，使血鈉上升過快，因此須追蹤尿量與血鈉。Oxford Academic+1
- 若出現嚴重神經症狀，應依症狀緊急給予3%高張鹽水，不能只因病因屬低血容量便延誤。PubMed

本題Na 132且沒有神經症狀，屬輕度低鈉；考點在病理機轉，不是在考高張鹽水適應症。

醫學（三）Q33

對話詳解原文

題目與答案對照

關於inflammatory myositis的myositis-specific antibodies與臨床表現，下列敘述何者最不適當？

- A. anti-MDA5 antibodies：amyopathic dermatomyositis with digital ulcers
- B. anti-NXP2 antibodies：higher risk of cancer
- C. anti-Mi-2 antibodies：a favorable response to treatment
- D. anti-TIF1-γ antibodies：lower risk of cancer

正式題目與選項見考選部試題。1302.doc

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
A	D	D	無，屬真正錯題

原始答案Q33為D；最終更正只涉及Q1、Q8、Q10、Q36、Q38、Q40，不影響本題。

核心考點

四個抗體的高辨識度配對：

抗體	典型關聯
anti-MDA5	臨床無肌病型 / 低肌病型皮肌炎、皮膚潰瘍、快速進展性ILD
anti-NXP2	嚴重肌肉病變、吞嚥困難、鈣化；成人癌症風險可能增加
anti-Mi-2	經典皮肌炎皮疹、通常治療反應及預後較佳
anti-TIF1-γ	成人皮肌炎的重要癌症相關抗體

因此D把anti-TIF1-γ的癌症風險方向完全寫反。

各選項解析

A．Anti-MDA5：amyopathic DM合併digital ulcers——適當

Anti-MDA5皮肌炎常見肌肉症狀輕微或缺乏，卻可有明顯皮膚血管病變與間質性肺病。研究顯示，指腹或甲周潰瘍與anti-MDA5的關聯尤其強；該抗體也需連結快速進展性間質性肺病。

所以A不是把兩個無關特徵硬湊在一起，而是相當典型的表型配對。但並非每位anti-MDA5陽性患者都一定無肌病或有digital ulcers。

B．Anti-NXP2：較高癌症風險——國考判定適當，但證據較有爭議

Anti-NXP2在兒童較常連結calcinosis；成人則可有明顯肌無力、水腫、吞嚥困難及癌症風險。

2023年IMACS成人發病特發性發炎性肌病癌症篩檢指引仍把anti-NXP2列為高風險因子，但也指出其癌症關聯低於anti-TIF1-γ，研究結果會受到年齡、族群及比較組影響。

因此在本題四選一架構中，B可以接受；臨床上則不宜把anti-NXP2陽性直接等同已罹癌。

C．Anti-Mi-2：治療反應較佳——適當

Anti-Mi-2常見於典型皮肌炎，可伴Gottron丘疹、heliotrope rash等明顯皮膚表現。研究中anti-Mi-2陽性患者的治療反應優於一般肌炎對照組，因此C符合傳統及現代疾病表型。

「較佳反應」是群體趨勢，不保證每位患者病情輕微或必然完全緩解。

D．Anti-TIF1-γ：較低癌症風險——錯誤，為答案

Anti-TIF1-γ是成人皮肌炎最重要的癌症風險標記之一，尤其在較高齡發病者更須重視。

IMACS指引將anti-TIF1-γ列為高風險因子，並依發病年齡、其他臨床特徵及整體風險安排基本或加強型癌症篩檢。D將「較高風險」寫成「較低風險」，是本題最直接的反向錯誤。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選A可能是對digital ulcers與anti-MDA5的配對較不熟，或認為潰瘍主要應歸於其他血管病變；也可能沒有先檢查D中「lower risk」是否把anti-TIF1-γ的方向寫反。

僅憑答案不能確定當時實際思路。

- 失分類型：肌炎特異抗體與表型配對、風險方向、明確反向選項辨識。
- 數秒判斷規則：**「MDA5：無肌病、潰瘍、RP-ILD；Mi-2：典型DM、反應佳；TIF1-γ：成人癌症警訊，不可能是低風險。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至皮肌炎分型、間質性肺病、惡性腫瘤篩檢及預後判讀。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

國考答案D與現行證據一致，但臨床上須補充：

- Myositis-specific antibody主要用於表型及風險分層，不能單靠抗體確診癌症。
- IMACS指引主要適用於**成人發病**的特發性發炎性肌病，癌症風險評估著重肌炎發病前後約三年。
- Anti-NXP2的癌症關聯不如anti-TIF1-γ穩定；不能把兩者視為同等強度。
- 即使抗體陰性，只要年齡、吞嚥困難、皮膚壞死、持續高疾病活性等風險存在，仍需評估癌症。

醫學（三）Q34

對話詳解原文

題目與答案對照

病人因為反覆invasive Neisseria感染，懷疑有免疫不全症，下列檢查何者最適當？

- A. Lymphocyte phenotype
- B. CH50 and AP50
- C. Nitroblue tetrazolium（NBT）assay
- D. Immunoglobulin serum levels

正式題目與選項見考選部試題。1302.doc

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
D	B	B	無，屬真正錯題

原始答案Q34為B，最終更正未調整本題。

核心考點

> **反覆侵襲性Neisseria感染，先找補體缺陷。**

尤其需要考慮：

- 末端補體C5～C9缺陷，無法正常形成membrane attack complex。
- Properdin、factor D、factor B等替代路徑缺陷。
- 後天使用C5抑制劑，如eculizumab或ravulizumab。

初步篩檢應同時檢測：

- **CH50：**古典路徑至共同末端路徑的功能。
- **AH50 / AP50：**替代路徑至共同末端路徑的功能。

各選項解析

A．Lymphocyte phenotype——不是最直接的第一項檢查

Lymphocyte phenotype通常以流式細胞儀評估：

- T細胞。
- B細胞。
- NK細胞。
- 必要時再細分不同亞群。

它適合評估聯合免疫缺陷、淋巴球減少或特定病毒感染型態；不是反覆侵襲性Neisseria感染最具辨識力的檢查。

B．CH50 and AP50——正確

功能檢驗的典型判讀：

CH50	AH50 / AP50	主要考慮
低	正常	古典路徑C1、C2或C4缺陷
正常	低	替代路徑factor B、factor D或properdin缺陷
低	低	C3或共同末端路徑C5～C9缺陷

末端補體缺陷會同時影響古典與替代路徑完成膜攻擊複合體的能力，因此兩者通常都下降。PMC

ESID / ERN RITA指引也建議先做各路徑功能檢驗，再依異常型態測量個別補體成分及安排遺傳檢查。若多條路徑同時降低，應考慮共同末端路徑缺陷，但也要排除檢體處理及補體消耗。PMC

C．NBT assay——用於慢性肉芽腫病，不是本題

NBT檢測嗜中性球氧化爆發功能，傳統用來篩檢chronic granulomatous disease。現代多使用DHR 123 flow cytometry，因為可提供更精細的功能及帶因者資訊。PMC

CGD較典型的是反覆感染特定catalase-positive organisms，例如：

- Staphylococcus aureus。
- Serratia。
- Burkholderia cepacia complex。
- Nocardia。
- Aspergillus。

這與反覆侵襲性Neisseria的補體缺陷型態不同。

D．Immunoglobulin serum levels——可評估體液免疫，但不是最佳答案

血清IgG、IgA、IgM可用於評估抗體缺陷，後者常見反覆鼻竇炎、肺炎或其他莢膜菌感染。

但Neisseria感染雖也涉及抗體與莢膜，**反覆侵襲性**感染與末端補體 / 替代路徑缺陷的關聯更具辨識力，所以應先選B。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選D可能是把Neisseria歸入「莢膜菌感染」，因此優先聯想到體液免疫及免疫球蛋白不足，沒有進一步利用「反覆 + 侵襲性Neisseria」這組指向補體缺陷的高特異線索。

- 失分類型：病原體與免疫缺陷配對、評估工具與所測構念、一般感染線索與高辨識度線索排序。

- 數秒判斷規則：**「反覆Neisseria先驗補體：CH50 + AH50 / AP50。NBT查CGD，Ig查體液免疫，lymphocyte phenotype查T / B / NK。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至原發免疫缺陷、補體抑制劑、腦膜炎雙球菌疫苗與反覆感染評估。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

國考答案B與現行診斷架構一致。

CDC於2026年3月更新的臨床資料指出，腦膜炎雙球菌病可能是補體缺陷的第一個表現，復發患者尤其應考慮補體檢測；C3、C5～C9、properdin、factor H及factor D異常皆會增加風險。CDC

臨床上還須注意：

- CH50與AH50異常後，仍須測量個別補體成分及視情況做遺傳分析。
- 急性感染、免疫複合體疾病及檢體處理不當也可能使補體功能降低，不能看到低值便直接診斷先天缺陷。
- 使用eculizumab或ravulizumab者，即使接種疫苗或接受抗菌預防，保護仍不完全；出現相符症狀需立即就醫。CDC
- 真實免疫不全評估仍可視病史加驗免疫球蛋白、HIV、脾臟功能等，但不改變本題首選B。

醫學（三）Q35

對話詳解原文

題目與答案對照

下列何種分子（molecule）不同的isoforms在細胞表面的表現，可被用來區分memory和naïve T淋巴球？

- A. CD45
- B. CD2
- C. CD28
- D. CD44

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
B	A	A	無，屬真正錯題

核心考點

題幹的決勝字是 **isoforms**：

- Naïve T cell：傳統上偏向 **$CD45RA^{+}$ / $CD45RO^{-}$**。
- Memory T cell：傳統上偏向 **$CD45RA^{-}$ / $CD45RO^{+}$**。

CD45由PTPRC基因編碼，可經選擇性剪接產生不同表面型態；CD45RA包含A外顯子，而CD45RO不含A、B、C三個可變外顯子。PMC+1

各選項解析

A．CD45——正確

這是本題唯一符合「同一分子的不同isoforms」並用於區分naïve與memory T細胞的答案。

國考速記：

> **RA = 尚未歷練；RO = 已有回憶。**

但這只是傳統簡化表型，不能把CD45RA陽性直接等同所有naïve細胞。

B．CD2——錯誤，為使用者作答

CD2是多數T細胞及NK細胞表面的黏附、活化與共刺激相關分子；它不是用CD2的不同isoforms來區分naïve與memory T細胞。

C．CD28——錯誤

CD28是重要的共刺激受體。Naïve T細胞通常表現CD28，許多memory T細胞也保留表現；終末分化細胞則可能失去CD28。

因此CD28表現可以提供分化資訊，但不是題幹所問的經典RA / RO isoform配對。

D．CD44——錯誤

CD44可反映活化、黏附及記憶表型，尤其在小鼠研究常以CD44高表現辨識抗原經驗細胞。

人類T細胞的經典分類則使用CD45RA / RO，並搭配CCR7等標記；不能把小鼠常用的CD44配對直接代入本題。PMC

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選B可能是先辨認到「T細胞表面分子」，但沒有把題幹的「不同isoforms」轉換成CD45RA / CD45RO。僅憑作答結果，不能確定當時實際思路。

- 失分類型：表面標記與分化階段分類、同一分子isoform辨識。
- 數秒判斷規則：**「問naïve / memory又強調isoform，直接找CD45的RA / RO。」**
- 投資報酬率：高；可延伸至流式細胞儀、免疫老化、移植免疫及感染後T細胞表型。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

國考答案A正確，但現代流式分析不會只用CD45RA或CD45RO單獨定義T細胞譜系：

典型人類表型	CD45RA	CCR7
Naïve	+	+
Central memory	-	+
Effector memory	-	-
TEMRA	+	-

TEMRA是已分化的效應記憶細胞，卻重新表現CD45RA；memory stem T cell也可呈$CD45RA^+$、$CCR7^+$的naïve-like外觀，需要CD95等其他標記區分。PMC

2025年PNAS研究進一步顯示，急性感染或mRNA疫苗後形成的功能性CD8 memory細胞可以表現CD45RA。這不推翻本題答案，而是提醒：**CD45 isoform適合做初步分類，不等於單一標記即可判定細胞完整功能與來源。**PMC+1

醫學（三）Q42

對話詳解原文

題目與答案對照

下列關於immune thrombocytopenic purpura（ITP）的描述，何者正確？

- A. 與凝血因子缺乏的出血不同的是，ITP常有深部組織（如：肌肉）的出血
- B. 在小孩子中通常為急性表現，較少變成慢性疾病；在成人則多為慢性表現
- C. 血球數據上，大多合併白血球過多與分類異常，並且常有貧血
- D. 骨髓切片常看到megakaryocytes的數量明顯減少，鮮有其他異常

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
C	B	B	無，屬真正錯題

核心考點

典型ITP的四個辨識點：

1. **孤立性血小板低下。**
2. 皮膚及黏膜出血較典型。
3. 兒童較常急性、自限；成人較常持續或慢性。
4. 骨髓巨核細胞通常正常或增加，不是明顯減少。

各選項解析

A．ITP常有深部肌肉出血——錯誤

方向寫反：

- 血小板數量或功能異常：較典型為紫斑、瘀點、鼻血、牙齦出血、月經過多等皮膚黏膜出血。
- 凝血因子缺乏：較典型為延遲出血、關節出血、肌肉或深部軟組織出血。

ITP極嚴重時仍可能發生內臟或顱內出血；這不表示深部肌肉出血是其典型鑑別特徵。

B．兒童較急性，成人較慢性——正確

這是傳統且仍實用的病程概括。

兒童約80%至90%可在12個月內緩解；但仍有約10%至20%未在一年內緩解，青少年發病也比較可能呈現接近成人的延長病程。PMC

因此B的「通常」合理，但不能背成「兒童一定痊癒、成人一定慢性」。

C．大多合併白血球過多、分類異常及貧血——錯誤，為使用者作答

典型原發性ITP應是**孤立性血小板低下**，白血球、分類及血紅素通常正常。

貧血可能因明顯出血、缺鐵或合併自體免疫溶血等原因出現；若有白血球分類異常、無法用出血解釋的貧血或多系血球減少，應重新評估白血病、骨髓疾病、感染、藥物及其他次發原因。American Society of Hematology

D．骨髓巨核細胞明顯減少——錯誤

ITP主要涉及周邊血小板免疫破壞及血小板生成受抑制；傳統骨髓表現為巨核細胞正常或增加，有時伴成熟障礙，不是「明顯減少」。

典型孤立性血小板低下時，現代共識也不要求每位患者例行接受骨髓檢查；出現其他血球異常、器官腫大、骨痛或非典型臨床表現時才需擴大評估。American Society of Hematology+1

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是把ITP與骨髓性疾病或其他系統性血液疾病的多系血球異常混在一起，沒有先使用「孤立性血小板低下」作為篩選條件。不能據此斷言當時的實際推理。

- 失分類型：典型血球組合、兒童與成人病程、初級與次級止血鑑別。
- 數秒判斷規則：**「ITP = 血小板單獨低 + 皮膚黏膜出血；小孩多急、成人較慢性；巨核細胞不會典型地明顯減少。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至血小板低下鑑別、白血病排除、Evans syndrome及出血型態判讀。

最新指引與國考 / 現代臨床差異

國考答案B是合理的概括；現代臨床則以發病時間定義：

- Newly diagnosed：未滿3個月。
- Persistent：3至12個月。
- Chronic：超過12個月。

現行名稱也以 **immune thrombocytopenia** 為主，不再強調purpura，因為患者可能沒有紫斑或明顯出血。

ASH官方頁面目前已提供2026年治療建議更新，但診斷及基本病程仍沿用2019指引與國際共識：ITP是排除其他原因後的孤立性血小板低下，治療須結合出血程度、血小板數、年齡、共病、藥物及生活需求，不能只靠「兒童 / 成人」二分法決定。Hematology.org

醫學（三）Q43

對話詳解原文

題目與答案對照

下列關於血液製品的描述，何者正確？

- A. 一般而言，血庫中的紅血球儲存於攝氏1～6℃，而血小板則置於室溫20～24℃且須輕微搖晃
- B. 經放射線照射的紅血球血品，可以預防輸血相關移植物抗宿主病（TA-GVHD），且不影響其儲存期限
- C. 血小板與血漿製品最好取自男性或從未懷孕的女性，主要目的為降低傳播巨細胞病毒的機會
- D. 冷凍沉澱品（cryoprecipitate）是由新鮮冷凍血漿在37℃加熱後所得的沉澱物，富含fibrinogen，必須立刻輸注且不可再冷凍保存

正式題目見考選部試題。1302.doc

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
D	A	A	無，屬真正錯題

原始答案及最終更正均未調整本題。wwwq.moex.gov.tw+1

核心考點

先分清血品處理的不同目的：

處理 / 選擇	主要目的
照射	預防TA-GVHD
去白血球	減少發熱反應、HLA同種免疫及CMV傳播風險
男性或HLA抗體陰性女性血漿策略	降低TRALI
冷凍沉澱	補充fibrinogen等凝血蛋白

本題唯一完整正確的是A。

各選項解析

A．紅血球1～6℃；傳統血小板20～24℃並持續輕柔振盪——正確

AABB資料顯示：

- 含紅血球製品一般保存於1～6℃。
- 傳統血小板保存於20～24℃，並持續輕柔振盪。

- 血小板效期可依細菌風險控制策略為5、6或7天。Watermarked Version+1

B．照射不影響紅血球效期——錯誤

照射使供者T淋巴球失去增殖能力，可預防TA-GVHD；但也會造成紅血球膜損傷及上清液鉀濃度上升。

依AABB Circular，若原剩餘效期超過28天，照射紅血球的效期改為**照射後28天**；實際上採「照射後28天或原效期，以先到者為準」。因此「不影響儲存期限」錯誤。Watermarked Version+1

C．選擇男性／未懷孕女性主要為降低CMV——目的寫錯

這類高血漿量製品的供者選擇，主要是降低**輸血相關急性肺損傷（TRALI）**：

- 懷孕可能使供者產生HLA或HNA抗體。
- 男性血漿或經檢測沒有HLA抗體的女性血漿，可降低TRALI通報及死亡。

降低輸血傳播CMV風險主要依靠**去白血球製品或CMV血清陰性製品**，不是男性血漿策略。Watermarked Version+1

D．冷凍沉澱由37℃製成且不能冷凍保存——錯誤

正確流程是：

1. 將冷凍血漿在**1～6℃緩慢解凍**。
2. 回收冷不溶性沉澱。
3. 在離心後一小時內置於**−18℃或更低溫重新冷凍保存**。
4. 使用前才在30～37℃解凍；此時不可再冷凍，並應依是否開放系統在4或6小時內輸注。

冷凍沉澱富含fibrinogen、factor VIII、factor XIII及vWF，但D把「製備」與「使用前解凍」兩個階段混在一起。Watermarked Version

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選D可能是抓到「冷凍沉澱富含fibrinogen」及「解凍後需儘速使用」兩個正確片段，卻沒有逐一核對製備溫度、能否冷凍保存及解凍後效期。僅憑答案不能確定當時思路。

- 失分類型：血品製備與保存階段、處理方式與預防目標配對。
- 數秒判斷規則：**「紅血球冷藏、血小板室溫搖；照射防GVHD、男性血漿防TRALI、去白血球降CMV。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至TA-GVHD、TRALI、CMV安全血品及大量輸血處置。

最新證據與國考／現代臨床差異

國考答案A符合現行AABB資料，但臨床上須注意：

- 現已存在依FDA核准程序使用的冷藏血小板；「所有血小板一律室溫保存」不是絕對規則。
- 血小板效期、照射紅血球效期及解凍後血品時限，會隨國家規範、製品種類及是否為封閉系統而異。
- 實際輸血必須以血袋標示與當地血庫規範為準，不能只靠國考口訣。

醫學（三）Q44

對話詳解原文

題目與答案對照

60歲女性，剛診斷多發性骨轉移的第四期肺腺癌，基因檢測發現EML4-ALK融合變化。下列何種治療最適合？

- A. Osimertinib標靶治療
- B. Pemetrexed + platinum化學治療
- C. Alectinib標靶治療
- D. Gefitinib標靶治療

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
D	C	C	無，屬真正錯題

正式題目、原始答案及最終更正均支持C。1302.doc+2

核心考點

> **EML4-ALK融合 → ALK酪胺酸激酶抑制劑。**

四個選項中只有alectinib是ALK TKI。2026年8月修訂的alectinib仿單仍明列其適用於ALK陽性轉移性NSCLC。gene.com

各選項解析

A．Osimertinib——主要針對EGFR

Osimertinib屬第三代EGFR TKI，主要用於具有EGFR致敏突變的NSCLC。題幹已明確給出ALK融合，沒有提供EGFR突變，因此不是最佳答案。

B．Pemetrexed + platinum——可用於非鱗狀NSCLC，但不是本題首選

此化療組合可以用於晚期肺腺癌；但當腫瘤已確認具有可治療的ALK驅動變化，且患者可使用ALK TKI時，應優先採用適合的ALK標靶治療。

化療可在標靶治療不適用、產生抗藥性或後續治療時重新考慮。

C．Alectinib——正確

Alectinib可抑制ALK融合蛋白的致癌訊號，並具有中樞神經系統活性。現行美國仿單建議轉移性ALK陽性NSCLC使用600 mg每日兩次、隨餐服用，持續至疾病進展或發生不可接受毒性。gene.com

ALEX試驗建立了其在未治療ALK陽性晚期NSCLC的一線證據；NCI PDQ亦將ALK抑制劑列入ALK重排患者的標靶治療，並同時整理alectinib與lorlatinib等一線試驗。NCI

D．Gefitinib——主要針對EGFR，為使用者作答

Gefitinib是第一代EGFR TKI，不是ALK抑制劑。不能只看到「肺腺癌 + 標靶治療」便選常見EGFR藥物；必須先依驅動基因配對。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選D可能是記得gefitinib屬肺腺癌標靶藥，卻沒有把EML4-ALK進一步轉換成「必須選ALK TKI」。不能據此斷言當時實際推理。

- 失分類型：驅動基因與標靶藥物配對、腫瘤亞型與治療機轉分類。
- 數秒判斷規則：**「ALK找alectinib；EGFR才找gefitinib或osimertinib。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至EGFR、ALK、ROS1、RET、MET、BRAF及KRAS G12C的治療配對。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

國考答案C仍合理，但現代治療不能簡化成「ALK一律只用alectinib」：

- 第一線已有alectinib、lorlatinib、brigatinib等後代ALK TKI選擇。
- 選藥需考慮腦轉移、毒性差異、共病、交互作用、可近性及患者偏好。
- NCI PDQ已納入lorlatinib之CROWN五年追蹤結果；alectinib則仍有成熟的ALEX療效與安全性資料。NCI
- 骨轉移的止痛、局部放射治療與骨修飾藥物評估，仍須和全身性ALK治療並行，不能由一個選項涵蓋全部臨床處置。

醫學（三）Q46

對話詳解原文

題目與答案對照

有關慢性阻塞性肺病（COPD）的治療，下列敘述何者最不適當？

- A. 症狀嚴重、急性發作頻繁，可以初始治療即給予LABA + LAMA
- B. 一般初始治療可以考慮給予LABA或LAMA單一治療
- C. 使用LABA + LAMA仍常有急性發作，且血中嗜酸性白血球≥100 cells/μL，可考慮轉換成LABA + LAMA + ICS
- D. 依據GOLD指引，治療原則以FEV_1及FEV_1/FVC為主要考量

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
C	D	D	無，屬真正錯題

正式題目見考選部試題；原始及最終答案均為D，最終更正不涉及本題。1302.doc+2

核心考點

COPD治療不能只盯著肺功能數字：

- **FEV_1/FVC：**用於確認持續性氣流受限。
- **FEV_1：**用於氣流受限嚴重度分級、預後及部分非藥物治療評估。
- **藥物選擇與升階：**主要依症狀、急性惡化史、目前治療反應、副作用、共病及血中嗜酸性白血球等因素。

所以D把診斷 / 分級指標誤寫成主要治療決策軸，是最不適當的敘述。GOLD已發布2026年正式報告與Pocket Guide。GOLD

各選項解析

A．症狀嚴重且急性發作頻繁，可初始使用LABA + LAMA——適當

長效β_2促效劑與長效抗膽鹼藥可提供較完整的支氣管擴張。症狀明顯或急性惡化風險較高時，初始雙支氣管擴張治療合理。

現代GOLD還會進一步考慮血中嗜酸性白血球；若急性惡化風險高且嗜酸性白血球很高，部分患者可考慮含ICS的三合一治療。

B．初始可考慮LABA或LAMA單一治療——可以成立，但須看分組

低症狀、低急性惡化風險者，可使用單一支氣管擴張劑；長效藥通常較適合規律控制。

但不能把B讀成所有COPD都應從單藥開始。症狀較多者，現代GOLD更常建議LABA + LAMA。

C．雙支氣管擴張後仍惡化且嗜酸性白血球≥100，可考慮加入ICS——適當

GOLD 2026仍支持：使用LABA + LAMA後持續急性惡化時，血中嗜酸性白血球≥100 cells/μL代表加入ICS較可能產生效益；嗜酸性白血球越高，預期效益通常越大。goldcopd.org

這不是絕對門檻：

- 嗜酸性白血球是連續性預測指標。
- 仍須考慮既往肺炎、ICS副作用、吸菸狀態及急性惡化型態。
- 若嗜酸性白血球很低，ICS預期效益較小，肺炎風險可能更值得重視。

D．以FEV_1及FEV_1/FVC為主要治療考量——錯誤，為答案

肺量計對COPD診斷與嚴重度評估很重要，但藥物治療不能主要按照FEV_1數字升降階。

例如兩位FEV_1相近的患者，若一位幾乎沒有症狀或惡化，另一位反覆住院，治療策略不會相同。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是對「100 cells/μL」是否太低，或對加入ICS的肺炎風險有所疑慮，因而沒有先排除D中更根本的決策架構錯誤。僅憑答案不能確定當時思路。

- **失分類型：**治療升階條件、診斷 / 分級指標與治療指標混用、最佳答案排序。
- **數秒判斷規則：****「FEV_1用來確認與分級；用藥看症狀、惡化與嗜酸性白血球。」**
- **投資報酬率：極高。**可延伸至COPD初始分組、雙支擴張、三合一治療及ICS肺炎風險。

最新指引與國考 / 臨床差異

國考答案D與2026 GOLD方向一致，但臨床比題目更精細：

1. FEV_1仍有重要價值，只是不是主要的單一用藥決策工具。
2. 「≥100」不是自動加ICS的處方門檻，必須先確認確有持續急性惡化。
3. 是否加入或撤除ICS，還要評估氣喘特徵、肺炎史、嗜酸性白血球、治療依從性及吸入器操作。

醫學（三）Q47

對話詳解原文

題目與答案對照

下列各種社區型肺炎致病原檢查，何者具有最高特異性？

- A. Sputum Gram stain
- B. Procalcitonin
- C. Urine Legionella antigen test
- D. Serum Mycoplasma pneumoniae IgG titer

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
D	C	C	無，屬真正錯題

官方原始及最終答案均為C，最終更正不涉及本題。1302.doc+2

核心考點

四個選項中，**Legionella pneumophila serogroup 1尿液抗原**具有最高特異性。

CDC列出的概略效能為：

- 敏感度：70%～100%。
- 特異性：95%～100%。

但它通常只偵測**L. pneumophila serogroup 1**，不能涵蓋全部Legionella菌種與血清群。CDC

各選項解析

A．痰液Gram stain——受檢體品質限制

若取得高品質下呼吸道檢體並看到優勢菌型，Gram stain可以快速提供有用線索；但特異性會受到以下因素影響：

- 唾液或口咽污染。
- 呼吸道定植。
- 先前使用抗生素。
- 檢體品質與判讀差異。

現行CAP指引主要在重症、插管或懷疑MRSA、綠膿桿菌等特定情境強調下呼吸道檢體，而不是把所有痰液Gram stain視為高度特異的病原確認工具。idsociety.org+1

B．Procalcitonin——不是病原鑑定檢查

Procalcitonin是宿主對感染及全身性發炎反應的生物標記，可能協助判斷細菌感染機率或追蹤治療，但不能指出是哪一種致病菌。

其數值亦可能受感染時間、嚴重程度、腎功能及非感染性發炎影響，所以不符合題目所問的高特異性「致病原檢查」。

C．Legionella尿液抗原——正確

優點包括快速、方便，陽性可提供相當具體的證據。CDC把它列為Legionnaires' disease的確認性實驗室證據之一。CDC

限制則是：

- 通常只偵測L. pneumophila serogroup 1。
- 陰性不能排除其他血清群或其他Legionella species。
- 無法取得菌株供臨床與環境來源比較。

因此CDC建議同時取得下呼吸道檢體，以培養或分子方法檢驗。CDC+1

D．單次Mycoplasma IgG——不能確認急性感染

IgG陽性可能只表示過去感染或暴露；單次效價無法可靠證明目前肺炎由Mycoplasma引起。

CDC目前將NAAT列為M. pneumoniae感染的首選檢驗方式。若使用血清學，需依檢驗方法及配對血清、抗體變化綜合判讀。CDC+1

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選D可能是把「血清學可診斷感染」延伸成單次IgG具有高度病原特異性，沒有先區分既往暴露與急性感染。不能據此斷言當時實際思路。

- **失分類型：**評估工具與所測構念、特異性與臨床用途、急性感染與既往暴露。
- **數秒判斷規則：****「Legionella尿抗原陽性很特異，但只抓Lp1；單次Mycoplasma IgG只代表可能曾經遇過。」**
- **投資報酬率：極高。**可延伸至CAP檢驗選擇、抗原 / 抗體 / NAAT差異及檢驗前機率。

最新指引與國考 / 臨床差異

國考答案C合理，但不能把它背成所有CAP患者都應常規接受Legionella尿液抗原：

- ATS / IDSA建議主要在**重症CAP**，或有旅遊史、群聚 / 疫情等流行病學線索時使用。
- Legionella尿液抗原的高特異性不等於涵蓋率高。
- 若臨床高度懷疑Legionella，陰性尿液抗原不能停止評估；應搭配下呼吸道培養或分子檢測。idsa+1

醫學（三）Q49

對話詳解原文

題目與答案對照

有關肋膜腔積液（pleural effusion）的診斷，下列敘述何者錯誤？

- A. 如果肋膜腔積液 amylase level 上升，應該考慮是否有膽道發炎
- B. 如果病人有發燒，肋膜腔積液檢測發現大部分是多形核白血球細胞，而且胸腔電腦斷層發現肺實質無異常，應考慮有腹腔內膿瘍
- C. 藥物引起的肋膜腔積液中，常見有嗜伊紅性白血球
- D. 肋膜腔積液也可能發生在接受冠狀動脈繞道手術之後

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
C	A	A	無，屬真正錯題

題目、原始答案及最終更正檔均已重新取得；更正檔的特殊計分只涉及Q1、Q8、Q10、Q36、Q38及Q40，不影響本題。1302.doc+2

核心考點

肋膜液澱粉酶升高，優先想胰臟、食道及惡性腫瘤，不是膽道發炎。

非特異性澱粉酶升高常見鑑別包括：

- 胰臟炎、胰臟假性囊腫或胰胸膜瘻。
- 食道破裂，常以唾液型澱粉酶為主。
- 惡性腫瘤，尤其肺腺癌等。

因此A把檢驗結果錯誤配對到膽道發炎。現有肋膜液判讀文獻也強調，澱粉酶並非單一病因的專一標記，仍須結合病史、影像、血清數值及必要時的isoenzyme判讀。PMC+2

各選項解析

A．澱粉酶升高考慮膽道發炎——錯誤，為答案

膽囊炎、膽管炎並不是肋膜液高澱粉酶的經典配對。看到這項結果時，國考優先順序應是：

> **胰臟疾病 → 食道破裂 → 惡性腫瘤。**

臨床不能只憑澱粉酶升高鎖定其中一項；例如惡性肋膜積液也可能明顯升高。

B．發燒、PMN為主且肺實質正常，考慮腹腔內膿瘍——國考判定適當

PMN為主表示急性發炎性反應。若胸部CT沒有可解釋積液的肺炎或肺實質病灶，需向膈下與腹腔來源尋找，例如：

- 膈下膿瘍。

- 肝膿瘍。
- 脾臟或其他腹腔感染。

但這只是診斷方向，不能只靠肋膜液細胞分類確診；仍需腹部病史、理學檢查、培養及影像。

C．藥物性肋膜積液可見嗜酸性球——可以成立

藥物引起的肋膜炎是嗜酸性球性肋膜積液的可能原因。曾被報告的藥物包括部分抗心律不整藥、抗生素、抗甲狀腺藥及精神科藥物等；停用致病藥物後通常可改善。PMC+2

但「常見有嗜酸性球」不能背成必要條件：

- 並非所有藥物性積液都有嗜酸性球。
- 嗜酸性球性積液也可能來自氣胸、血胸、惡性腫瘤、感染或寄生蟲。
- 診斷仍依用藥時序、排除其他原因及停藥後反應。

D．CABG後可能出現肋膜積液——正確

冠狀動脈繞道手術後肋膜積液十分常見，多為左側、小量且自行緩解；約一成患者可能形成較大的積液。PubMed+2

積液可與手術創傷、內乳動脈取用、出血、體液負荷或心包切開後症候群相關。若積液大量、持續、發燒或造成呼吸困難，仍要排除感染、心衰竭、乳糜胸及其他術後併發症。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是對「藥物性肋膜積液常見嗜酸性球」的概括敘述有所疑慮，卻沒有先辨識A將高澱粉酶錯配到膽道發炎。僅由作答結果無法確認當時實際思路。

- **失分類型：**肋膜液檢驗與病因配對、診斷指標的特異性、較明確錯項排序。
- **數秒判斷規則：**「肋膜液amylase高：胰、食道、癌；不是先想膽道。」
- **投資報酬率：高。**可延伸至食道破裂、胰胸膜瘻、惡性積液及嗜酸性球性積液鑑別。

現行證據與國考 / 臨床差異

國考答案A合理，現代臨床主要差異是避免將任何單一肋膜液數值視為病因確診：

- 澱粉酶升高不只見於胰臟疾病。
- 細胞分類提供病程線索，但不能單獨證明感染位置。
- 藥物性肋膜炎通常是排除性診斷。
- CABG後積液雖常見，仍須依大小、時序與伴隨症狀判斷是否需要處理。

醫學（三）Q51

對話詳解原文

題目與答案對照

下列有關間質性肺病（interstitial lung disease, ILD）的敘述，何者最適當？

- A. Idiopathic pulmonary fibrosis出現lung basal crackles的機會很低
- B. Respiratory bronchiolitis-associated ILD出現clubbing finger的機會很高
- C. Nonspecific interstitial pneumonia在電腦斷層出現honeycombing的機會很少
- D. Sarcoidosis在電腦斷層不會出現peribronchovascular thickening

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
A	C	C	無，屬真正錯題

官方來源同前；Q51原始與最終答案均為C，無特殊計分。1302.doc+2

核心考點

四個選項是ILD的典型特徵配對：

疾病	典型線索
IPF	雙側肺底吸氣末細爆裂音；UIP型HRCT
RB-ILD	重度吸菸史；杵狀指不常見
NSIP	磨玻璃影、細網狀影、牽引性支氣管擴張；蜂窩化少
Sarcoidosis	沿淋巴路徑及支氣管血管束分布，可有peribronchovascular thickening

所以只有C最適當。

各選項解析

A．IPF很少出現肺底爆裂音——錯誤

IPF典型理學檢查正是雙側肺底、吸氣末的細爆裂音，常被形容為Velcro crackles。

一項前瞻性研究中，初次評估的IPF患者約93%可聽到fine crackles；國際共識亦建議，遇到雙側肺底吸氣性爆裂音時應考慮IPF。PMC+1

但爆裂音不是IPF專屬，也可見於其他纖維化性ILD、肺水腫及部分感染。

B．RB-ILD很常出現杵狀指——錯誤

RB-ILD幾乎都與目前或過去的重度吸菸有關，常見症狀是漸進性呼吸困難及咳嗽。

杵狀指不是典型高頻表現；文獻回顧中可能完全未被報告，或發生率不超過約25%。若RB-ILD樣病人有明顯杵狀指，應重新檢查是否存在IPF、肺癌或其他纖維化性肺病。PMC+1

C．NSIP在CT很少出現蜂窩化——正確

NSIP常見HRCT表現包括：

- 對稱性、下肺較明顯的磨玻璃影。
- 細網狀影。
- 牽引性支氣管擴張。
- 相對保留胸膜下區域。

ATS / ERS分類聲明指出，NSIP在初始影像中的honeycombing通常稀少或缺如；因此C是四項中最適當者。PMC

但少數纖維化性NSIP在長期追蹤中可以進展，甚至出現類似UIP的蜂窩化影像；「少見」不等於「絕不會有」。PMC

D．Sarcoidosis不會有支氣管血管束增厚——錯誤

Sarcoidosis肉芽腫常沿肺部淋巴路徑分布，包括：

- 支氣管血管束。
- 小葉間隔。
- 葉間裂及胸膜下區域。

所以沿支氣管血管束的結節或不規則間質增厚，反而是典型CT型態之一。PMC+2

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選A可能是沒有把肺底細爆裂音辨認為IPF常見臨床線索，或在四個選項間未優先比較C的典型影像特徵。不能由答案斷定當時是否漏看「機會很低」。

- **失分類型：**ILD臨床與影像表型、方向詞判讀、蜂窩化與疾病分類。
- **數秒判斷規則：**「IPF肺底會裂；RB-ILD杵狀指不常；NSIP少蜂窩；sarcoid可沿支氣管血管束。」
- **投資報酬率：極高。**可延伸至UIP / NSIP鑑別、吸菸相關ILD及sarcoidosis影像判讀。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

國考答案C與現行ILD分類架構一致。2025年更新的ATS / ERS特發性間質性肺炎分類仍強調疾病行為、病因背景、影像與病理的整合，不能只憑一個CT徵象命名疾病。European Respiratory Society+1

臨床上的主要限制是：

- NSIP是一種影像 / 病理型態，也可能與結締組織疾病、藥物或其他原因相關。
- Honeycombing少只能支持NSIP，不能單獨確診。
- Peribronchovascular thickening也可見於淋巴管癌病、肺水腫及其他疾病，並非sarcoidosis專屬。

- IPF診斷仍需排除暴露、藥物及結締組織疾病，並整合HRCT與多專科討論。

醫學（三）Q56

對話詳解原文

題目與答案對照

關於威爾森氏症（Wilson's disease）的敘述，下列何者正確？

- A. 主要臨床症狀包含神經 / 精神系統與肝臟相關症狀，而出現肝臟相關症狀者幾乎都大於30歲
- B. 可能影響內分泌系統，如導致青春期延遲或無月經。而腎小管功能受影響時則會導致胺基酸、電解質、鈣、磷和葡萄糖的異常流失
- C. 是由ATP7B變異引起，ATP7B可將肝臟中的鋁離子清除排泄到膽汁並防止腦內鋁蓄積
- D. 早期診斷並接受肝臟移植是最有效治療方式

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
A	B	B	無，屬真正錯題

考選部資料已核對：正式試題、原始答案與最終更正答案均指向B；本份更正僅涉及Q1、Q8、Q10、Q36、Q38、Q40，不影響Q56。1302.doc+2

核心考點

威爾森氏症是 **ATP7B功能異常造成的銅代謝疾病**：

- 膽汁排銅下降，銅先在肝臟累積。
- 超過肝臟儲存能力後，可累及腦、角膜、腎臟等器官。
- 近端腎小管受損可形成Fanconi症候群。
- 早期治療以終身抗銅藥物為主，肝臟移植是特定重症的救援治療。

AASLD資料明確指出，ATP7B負責肝細胞內的銅轉運及膽汁排銅；其功能缺失會造成肝、腦、腎及角膜的銅沉積。Wiley Online Library

各選項解析

A．肝臟症狀幾乎都在30歲後——錯誤

威爾森氏症的肝病表現常比神經精神症狀更早出現：

- 多數兒童患者以肝臟疾病表現。
- 已有5歲以下兒童被診斷，甚至幼兒即可出現肝硬化或急性肝衰竭。
- 症狀性發病年齡很廣，不能以30歲作為肝病表現的下限。

因此，「肝臟症狀幾乎都大於30歲」方向明顯錯誤。Wiley Online Library+1

B．生殖內分泌及腎小管異常——正確

威爾森氏症可伴隨青春期延遲、月經異常或無月經。近端腎小管受損時，可出現Fanconi型表現，包括：

- 胺基酸尿。
- 磷尿。
- 糖尿。
- 尿酸及其他電解質流失。
- 腎小管性酸中毒、低血鉀，甚至骨質脫礦。

AASLD指引列出的腎臟表現包括胺基酸尿、磷尿、顯微血尿與尿液酸化異常，也記載低血鉀相關肌無力。Wiley Online Library

C．ATP7B負責排除鋁——錯誤

ATP7B的關鍵金屬是 **銅，不是鋁**。它參與：

- 將銅納入ceruloplasmin。
- 把多餘銅排入膽汁。

所以應把選項中的「鋁離子 / 腦內鋁蓄積」全部改成銅，才接近正確機轉。

D．早期確診後直接肝移植——錯誤

現行主要治療是終身口服抗銅療法：

- 有症狀或已有器官損傷者：通常以D-penicillamine或trientine等螯合劑起始。
- 部分無症狀或穩定患者：可使用較低劑量螯合劑或鋅。
- 肝移植：主要用於威爾森氏症急性肝衰竭，或對藥物治療無反應的失代償肝病。

AASLD將終身口服藥物列為治療主體，肝移植保留於嚴重或藥物治療失敗者；早期且持續治療者的存活可接近一般人口。Wiley Online Library+1

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選A可能是記得威爾森氏症具有肝臟及神經精神表現，卻把不同表現的典型發病年齡方向記反。肝臟表現可出現在兒童，神經精神表現相對較常在較晚年齡出現。

- 失分類型：症候群時間軸、器官表現與發病年齡。
- 數秒判斷規則：**「Wilson先肝後腦也常見；ATP7B運銅不運鋁；早期先抗銅，肝衰竭才移植。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至不明原因兒童肝病、年輕人動作障礙、Fanconi症候群及急性肝衰竭鑑別。

國考答案與現代臨床差異

國考答案B與現行臨床認識一致。臨床上還要注意：

1. 年齡不能用來排除威爾森氏症；幼兒與高齡者都可能確診。

2. 正常或接近正常的單一銅代謝指標不能獨立排除疾病，需整合ceruloplasmin、24小時尿銅、裂隙燈、ATP7B檢測及必要時肝銅量。
3. Fanconi症候群不是每位患者都會出現；它是可能的肝外表現，不是診斷必要條件。

醫學（三）Q57

對話詳解原文

題目與答案對照

關於代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH）與代謝功能障礙相關脂肪性肝病（MASLD），下列何者正確？

- A. 約40% MASLD成年人患MASH
- B. 腹部影像無法確定哪些MASLD有MASH，目前也沒有可以診斷MASH的特定抽血檢測項目
- C. 所有MASLD都需要適當藥物治療避免肝硬化、肝癌
- D. 每天800 IU vitamin E改善脂肪肝且完全沒有任何不良反應

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
A	B	B	無，屬真正錯題

考選部原始及最終答案均為B，且Q57不在特殊計分題目中。1302.doc+2

核心考點

要分清三件事：

工具	主要能回答的問題
超音波、CT、MRI-PDFF	有無及多少肝脂肪
FIB-4、ELF、彈性影像	纖維化風險與預後分層
肝切片	是否存在肝細胞氣球樣變、分葉性發炎等MASH組織學特徵

因此，一般腹部影像或單一常規抽血不能直接確診MASH。2024年EASL–EASD–EASO指引仍指出，只有肝切片能完整評估氣球樣變、分葉性發炎等顯微特徵並明確確認MASH；非侵入性檢查主要負責纖維化分層。PMC+1

各選項解析

A．約40% MASLD成人患MASH——不能作為固定通則

MASH比例高度受到以下因素影響：

- 一般人口或肝病轉診族群。
- 是否合併第二型糖尿病或肥胖。
- 是否因肝酵素異常而接受肝切片。

- 研究所採診斷方法與取樣偏差。

2024年指引估計，單純脂肪變性者約10%至30%可能進展至脂肪性肝炎及進階肝病，並不是所有MASLD成人都能固定套用40%。PMC

B．影像與特定抽血不能確診MASH——正確

一般影像可以偵測或量化脂肪，彈性影像可估計纖維化，但不能直接觀察MASH的完整組織學組合。

FIB-4、ELF、VCTE及MRE很有臨床價值，但其主要功能是：

- 排除或辨識進階纖維化。
- 決定是否轉介肝臟專科。
- 協助選擇需要進一步評估或治療的高風險患者。

它們不是「一驗陽性便確診MASH」的單一檢驗。Springer Nature Link+1

C．所有MASLD都要藥物治療——錯誤

所有MASLD患者都應接受：

- 飲食及運動介入。
- 體重管理。
- 糖尿病、高血壓、血脂異常及心血管風險治療。
- 依纖維化風險安排追蹤。

但不是每位患者都需要MASH標靶藥物。現行建議聚焦於選定的非肝硬化MASH且具有顯著纖維化者，不是只要影像看到脂肪肝便用藥。PMC

D．Vitamin E完全沒有不良反應——錯誤

「完全沒有任何不良反應」已足以判錯。Vitamin E曾在特定族群研究中顯示部分組織學改善，但：

- 並非所有MASLD患者皆適用。
- 對纖維化及長期臨床結果的證據有限。
- 長期安全性仍有疑慮。

2024年EASL–EASD–EASO指引因缺乏大型第三期試驗的穩健證據及潛在長期風險，不建議將Vitamin E作為MASH標靶治療。PMC

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選A可能是把特定研究、高風險族群或接受肝切片族群的MASH比例，當成所有MASLD成人皆適用的固定盛行率；也可能未先抓住B所描述的「組織學診斷與非侵入性風險分層」界線。

- 失分類型：疾病總類與亞型比例、選擇偏差、檢驗工具與診斷目的。
- 數秒判斷規則：**「影像看脂肪、FIB-4與彈性看纖維化風險；要明確確認MASH組織學，仍看肝切片。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至脂肪肝門診轉介、FIB-4判讀、肝切片適應症與MASH藥物選擇。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

國考答案B的診斷原則仍成立，但「沒有治療藥物」已不是現代臨床現況：

- 美國FDA於**2024年3月14日**加速核准resmetirom，用於非肝硬化、具有中度至進階纖維化的MASH成人，並須搭配飲食及運動。FDA
- 美國FDA於**2025年8月15日**再核准semaglutide用於具有中度至進階纖維化的MASH成人，同樣屬加速核准，仍須後續確認長期臨床效益。FDA

這些進展不影響B，因為：

1. 核准治療只適用於經適當分層的部分患者。
2. 不代表所有MASLD都需要藥物。
3. 現行非侵入性工具雖進步很多，仍不能把一般腹部影像或單一抽血值等同於MASH的組織學確診。

醫學（三）Q60

對話詳解原文

題目與答案對照

下列疾病與建議的治療藥物配對，何者最不適當？

- A. 肺囊蟲肺炎（Pneumocystis jirovecii pneumonia）—trimethoprim-sulfamethoxazole
- B. 蟯蟲感染（Enterobiasis）—mebendazole或albendazole
- C. 糞小桿線蟲過度感染（Strongyloides stercoralis hyperinfection）—praziquantel
- D. 弓蟲腦炎（Toxoplasma encephalitis）—clindamycin + pyrimethamine

題目來源：考選部正式試題。1302.doc

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
D	C	C	無，屬真正錯題

原始答案與最終更正檔均為C；更正檔所列特殊計分題不包含Q60。wwwq.moex.gov.tw+1

核心考點

糞小桿線蟲過度感染應使用ivermectin，不是praziquantel。

現行CDC建議，過度感染或播散性糞小桿線蟲感染使用：

- Ivermectin 200 μg/kg，每日口服。
- 治療至糞便及 / 或痰液檢查陰性持續2週。
- 可行時同時減少或停止免疫抑制治療。CDC

各選項解析

A．PCP—TMP-SMX：配對正確

TMP-SMX是肺囊蟲肺炎的首選治療。現行NIH指引對輕中度及中重度PCP均以TMP-SMX為首選，劑量須依TMP成分及腎功能調整；中重度且PaO_2低於70 mmHg或A–a gradient至少35 mmHg時，還須考慮輔助類固醇。NIH+1

B．蟯蟲—mebendazole或albendazole：配對正確

兩者均可治療蟯蟲；pyrantel pamoate也是選項。藥物可殺成蟲但不能殺卵，因此通常須在2週後重複一劑，並配合手部、寢具及家庭接觸者的感染控制。CDC

C．糞小桿線蟲過度感染—praziquantel：錯誤，為答案

Praziquantel主要用於血吸蟲、其他吸蟲及部分絛蟲感染，不是糞小桿線蟲過度感染的治療。重症時應使用每日ivermectin，不能套用一般慢性感染的短療程便停止。

D．弓蟲腦炎—clindamycin + pyrimethamine：國考接受，但處方不完整

Pyrimethamine加clindamycin是不能耐受sulfadiazine或對其反應不佳時的重要替代方案。然而現代完整處方還應加入：

- **Leucovorin（folinic acid），**降低pyrimethamine的骨髓毒性。
- 此組合不能預防PCP，因此必要時還須另加PCP預防藥物。NIH

所以D在國考的「藥物方向」可以接受，但若按實際處方標準，確實省略了重要藥物。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選D可能是注意到clindamycin + pyrimethamine少了leucovorin，因此判定配對不完整。這項質疑在臨床上完全合理；但單選題要求挑出「最不適當」，C是把糞小桿線蟲的核心治療藥物整個配錯，錯誤程度更大。

- 失分類型：病原體—藥物配對、完整處方與國考簡寫、最佳答案排序。
- 數秒判斷規則：**「Strongyloides重症抓ivermectin；praziquantel先想吸蟲 / 絛蟲。弓蟲用pyrimethamine時別忘leucovorin。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至類固醇治療前糞小桿線蟲篩檢、免疫低下者伺機性感染及抗寄生蟲藥物分類。

國考答案與現代臨床差異

國考答案C明確合理；但D是本題重要的臨床陷阱：

- 考題只考「主要抗弓蟲藥物組合」。
- 實際處方不能省略leucovorin。
- Clindamycin方案不能同時涵蓋PCP預防。
- 因此考場選C，臨床開藥時則必須把D補完整。

醫學（三）Q61

對話詳解原文

題目與答案對照

下列何種抗生素最不推薦用於治療methicillin抗藥性金黃色葡萄球菌（MRSA）感染症？

- A. linezolid
- B. vancomycin
- C. imipenem-cilastatin
- D. teicoplanin

題目來源：考選部正式試題。1302.doc

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
A	C	C	無，屬真正錯題

Q61原始及最終答案均為C。wwwq.moex.gov.tw+1

核心考點

MRSA藉由mecA / mecC相關的低親和性PBP，對一般抗葡萄球菌β-lactam及carbapenem不可靠。

Imipenem-cilastatin不能當作MRSA標準治療。FDA的imipenem仿單明列，methicillin-resistant staphylococci應視為對imipenem抗藥。accessdata.fda.gov

各選項解析

A．Linezolid：具有MRSA活性

Linezolid可用於MRSA肺炎、部分皮膚軟組織感染及其他選定情境，口服生體可用率高、肺部穿透佳。

需注意：

- 長療程可能造成血小板低下、貧血或周邊 / 視神經病變。
- 可能與serotonergic藥物交互作用。
- 「對MRSA有活性」不代表所有感染部位都優先選它；菌血症、心內膜炎及泌尿道感染等仍須依情境選藥。

B．Vancomycin：重要標準治療

Vancomycin仍是侵襲性MRSA感染的重要用藥。嚴重感染的現行監測共識建議以AUC/MIC **400 ~ 600 mg·h/L**為目標，以兼顧療效及腎毒性，而不是只追求偏高的trough濃度。idsociety.org

C．Imipenem-cilastatin：最不推薦，為答案

Imipenem雖廣效，但其廣效主要不能解決MRSA的PBP2a抗藥機轉。不能因它是carbapenem便推論可以涵蓋所有抗藥性革蘭陽性菌。

若經驗性治療同時需要廣泛革蘭陰性菌及MRSA涵蓋，臨床可能是「imipenem處理其他病原 + 另加抗MRSA藥」，不是用imipenem單獨治療MRSA。

D．Teicoplanin：具有MRSA活性

Teicoplanin與vancomycin同屬glycopeptide。更新版英國MRSA治療指引將vancomycin或teicoplanin列為嚴重皮膚軟組織感染、複雜泌尿道感染及骨關節感染等情境的重要選擇。PMC

實際使用仍應依當地藥物可得性、核准適應症、感受性、腎功能及治療藥物監測規則決定。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選A可能是把linezolid的抑菌性、毒性或其不適用於某些深部感染，延伸成「不推薦治療MRSA」；也可能未先用MRSA對一般β-lactam / carbapenem抗藥的核心規則排除C。不能僅憑答案確定當時思路。

- 失分類型：抗生素類別、抗藥機轉、藥物有活性與特定部位首選的區分。
- 數秒判斷規則：**「MRSA：vanco、linezolid、teicoplanin都有角色；一般imipenem不算抗MRSA藥。」**
- 投資報酬率：極高；可延伸至MRSA肺炎、菌血症、骨關節感染、vancomycin監測及經驗性抗生素組合。

國考答案與現代臨床差異

國考答案C與目前臨床原則一致，但須保留兩個例外：

1. **不是所有β-lactam都對MRSA無效。**Ceftaroline、ceftobiprole等特定cephalosporin具有抗MRSA活性，須依適應症、感受性與當地核准狀態使用。
2. **其他三種藥物也不是所有感染部位都能互換。**例如MRSA肺炎常選vancomycin或linezolid；菌血症、心內膜炎、泌尿道或中樞感染則有不同的優先順序與證據限制。更新版MRSA指引即依感染部位分別給予建議。PMC

醫學（三）Q67

對話詳解原文

題目與答案對照

根據Stock Keister等人（2004）的研究，從事家庭醫業時，了解病人對於醫師的期待，有助於醫病之間的滿意度，下列何者不是病人的期待？

- A. 真誠地傾聽（truly listens to me）
- B. 嘗試了解認識我（tries to get to know me）
- C. 任何問題都能幫助我（can help with any problem）
- D. 總能誠實並間接性地提醒我（is always honest and indirect to remind me）

題目原文見考選部正式試題。1302.doc

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
C	D	D	無，屬真正錯題

核心考點

題幹要求依照**指定的2004年研究**作答，不是判斷哪一句在現實中聽起來最合理。

該研究調查1,031人，指出病人重視：

- 醫師願意傾聽及解釋。
- 醫師理解病人並整合照護。
- 持續的醫病關係。
- 誠實、信任及良好溝通。

研究中的重要屬性是 **honest and direct**；D刻意改成 **indirect**，所以D才是「不是病人的期待」。AFP

各選項解析

A．真誠地傾聽——符合研究結果

病人重視醫師真正聽取問題，而非只迅速蒐集診斷所需資訊。傾聽也有助於辨認病人的價值觀、擔憂及真正就診目的。

B．嘗試了解認識病人——符合研究結果

這反映家庭醫學的連續性與全人照護：除了當次症狀，也理解病人的家庭、生活處境、既往病史及長期目標。

C．任何問題都能幫助我——屬原研究列出的期待

這句若按字面閱讀，確實容易被質疑為「醫師不可能解決所有問題」。但在原研究脈絡中，它比較接近：

- 願意承接各類健康問題。
- 能先做初步評估。
- 必要時整合資源或安排轉介。

它不等於家庭醫師必須獨力治癒所有疾病。

D．誠實並間接提醒——錯誤，為答案

研究強調的是誠實且**直接**的溝通，不是以含糊或間接方式讓病人猜測醫師的意思。

現代溝通指引同樣強調反映式傾聽、清楚準確地提供資訊、誠實尊重及共同決策；但這類指引支持的是一般溝通原則，不能取代本題所指定的2004年研究文字。Journal of Clinical Oncology

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選C可能是把「任何問題都能幫助我」按現實醫療能力解讀為不合理的絕對句，卻沒有先依題幹指定研究逐項比對；也可能未優先抓住D的direct → indirect反向改寫。僅憑作答結果不能確認當時實際思路。

- **失分類型：**指定來源未優先、否定問法、原文關鍵字反向改寫、考題語境與現實語意混用。
- **數秒判斷規則：**「題目指定研究就先找原文被改寫處；病人要誠實直接，不是誠實間接。」
- **投資報酬率：高。**可延伸至家庭醫學核心能力、病人中心照護、醫病溝通及共同決策題。

國考答案與現代臨床差異

國考答案D有明確的原始研究依據。

現代臨床不會承諾「任何問題都能由同一醫師解決」；較合理的實務解讀是：家庭醫師願意作為第一接觸、辨認問題、說明能力界線，並整合照護或轉介。這不改變本題依指定研究作答時應選D。

醫學（三）Q69

對話詳解原文

題目與答案對照

有關維生素B12缺乏症（vitamin B12 deficiency）的敘述，下列何者最適當？

- A. 維生素B12主要吸收部位在十二指腸
- B. 測量血清維生素B12濃度是診斷本症正確率最高的方法
- C. 病人接受維生素B12補充治療後，血清高半胱胺酸（homocysteine）濃度會迅速降低
- D. 抗壁細胞抗體（anti-parietal cell antibody）陽性病人，宜每日口服維生素B12 1,000 mcg以有效改善症狀

題目原文見考選部正式試題。1302.doc

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
A	C	C	無，屬真正錯題

核心考點

B12吸收及代謝的三個決勝點：

1. B12自食物釋出後與內在因子結合。
2. **B12 - 內在因子複合體主要在末端迴腸吸收。**
3. B12參與homocysteine轉為methionine，因此缺乏時homocysteine上升；補充後可迅速下降。

治療後homocysteine或MMA通常約在一週內出現改善，所以C最適當。AFP

各選項解析

A．主要在十二指腸吸收——錯誤

胃酸及消化酶先將B12從食物蛋白中釋放，之後再與胃壁細胞製造的內在因子結合；真正主要吸收B12 - 內在因子複合體的位置是**末端迴腸**，不是十二指腸。AFP

B．血清B12是正確率最高的方法——過度絕對

血清總B12是合理的初始檢驗，但不是任何情境下都最準確的單一檢驗：

- 邊界值可能難以判讀。
- 補充品可能使濃度上升。
- 肝病、癌症及運輸蛋白異常可能影響數值。
- 有症狀但總B12結果不確定時，可使用active B12、MMA或homocysteine補強。

2024年NICE指引建議先用總B12或active B12；若結果不確定且仍有臨床疑慮，再考慮MMA等進一步檢驗。NICE

C．補充後homocysteine迅速下降——正確

B12是homocysteine代謝所需的輔因子。缺乏獲得矯正後，homocysteine與MMA等代謝指標可比血球及神經症狀更快改善：

指標或症狀	常見改善時程
Homocysteine、MMA、網狀紅血球	約1週
神經症狀	約6週至3個月
貧血、MCV及其他血球異常	約8週

因此C所稱「迅速降低」方向正確。AFP

D．抗壁細胞抗體陽性即每日口服1,000 mcg——過度簡化

問題有兩層：

1. 抗壁細胞抗體陽性並不必然等於自體免疫性胃炎或已造成B12缺乏。
2. 治療途徑不能只由單一抗體決定。

NICE建議疑似自體免疫性胃炎時先考慮anti-intrinsic factor antibody；若陰性但仍高度懷疑，再考慮抗壁細胞抗體、gastrin、吸收試驗或胃鏡切片。若自體免疫性胃炎是確定或疑似的缺乏原因，指引建議終身肌肉注射B12。NICE

高劑量口服B12確實可利用少量被動吸收，在部分患者有效；但不能從「抗壁細胞抗體陽性」直接推導出所有患者都固定採每日口服1 mg。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選A可能是把胃內釋放B12、與內在因子結合或近端腸道的消化步驟，誤當成主要吸收位置；也可能未把「B12 + 內在因子 = 末端迴腸」視為固定配對。不能據此斷言當時實際思路。

- **失分類型：**解剖位置—生理功能配對、診斷檢驗層級、抗體與疾病確診混淆。
- **數秒判斷規則：**「B12牽內因子，終點在末端迴腸；缺乏使MMA、homocysteine升高，補充後代謝值先下降。」
- **投資報酬率：極高。**可延伸至巨球性貧血、脊髓亞急性聯合退化、迴腸疾病、自體免疫性胃炎及檢驗判讀。

國考答案與現代臨床差異

國考答案C仍符合現行生理及治療反應。

臨床上須補充三項邊界：

- Homocysteine並非B12缺乏專一指標，葉酸不足等情況也可能升高。
- MMA通常較能反映B12相關代謝，但會受到腎功能影響。
- 治療應依病因、嚴重度、神經症狀、吸收能力及病人偏好決定，不能只靠抗體或單一濃度決定。

醫學（三）Q78

對話詳解原文

題目與答案對照

下列何種症狀為診斷急性高山症（acute mountain sickness, AMS）的必要條件？

- A. 噁心與嘔吐（GI symptoms）
- B. 疲憊虛弱（fatigue/weakness）
- C. 頭痛（headache）
- D. 頭暈（dizziness/light-headedness）

使用者作答	原始答案	最終更正答案	特殊計分
D	C	C	無，屬真正錯題

已重新核對考選部正式試題、原始答案及最終更正檔；本卷最終更正僅涉及Q1、Q8、Q10、Q36、Q38、Q40，不影響Q78。1302.doc+2

核心考點

依2018年Lake Louise AMS Score，在近期上升至高海拔的情境下：

- 四個症狀領域為頭痛、腸胃症狀、疲倦 / 虛弱、頭暈 / 輕飄感。
- 總分須至少3分。
- **頭痛必須至少1分。**
- 睡眠障礙已從2018年版本移除。

因此本題答案為 **C，頭痛**。PMC

各選項解析

A．噁心與嘔吐——常見，但不是必要條件

腸胃不適是Lake Louise四個計分領域之一，可以協助累積總分，但患者不一定會出現。

單憑噁心、嘔吐也不能直接診斷AMS，因為脫水、腸胃炎、食物問題、低血糖及藥物副作用都可能有相同表現。

B．疲憊虛弱——常見且非特異，不是必要條件

疲倦、虛弱或倦怠同樣可以計分，但可能只是長途旅行、睡眠不足、劇烈活動或缺乏熱量所致。

所以它需要配合上升時序及其他症狀判讀，不能單獨成為必要條件。

C．頭痛——正確

2018 Lake Louise定義要求總分至少3分，並且其中必須包含頭痛至少1分。

實務上還應確認症狀發生在近期上升至高海拔後。共識文件建議至少經過約6小時再評分，以減少旅途不適或急性缺氧反應造成的混淆。PMC

D．頭暈 / 輕飄感——可計分，但不是必要條件

頭暈是AMS可能症狀之一，但可以完全沒有，因此不是診斷必要條件。

還要區分：

- **頭暈 / 輕飄感：**主觀症狀，可見於AMS，也可能來自脫水、姿勢性低血壓等。
- **共濟失調：**客觀步態或協調障礙，是高海拔腦水腫（HACE）的重要警訊，嚴重程度完全不同。

可能的失分機制

由作答結果合理推測：選D可能是把高海拔常見的頭暈或平衡不適當成AMS的必要症狀，或把「常見症狀」與「診斷硬性條件」混用。僅憑作答結果，不能確定當時實際思路。

- 失分類型：診斷必要條件、常見症狀與必要症狀區分、AMS與HACE警訊鑑別。
- 數秒判斷規則：**「Lake Louise 2018 = 總分至少3，而且頭痛至少1分；頭暈、噁心、疲倦都可以沒有。」**
- 投資報酬率：高；可延伸至AMS診斷、高山頭痛、HACE / HAPE辨識及高海拔旅遊諮詢。

最新證據與國考 / 現代臨床差異

國考答案C與2018 Lake Louise研究定義一致。

2024年Wilderness Medical Society指引仍強調頭痛的核心角色，但提醒：

- Lake Louise Score主要用於研究中的標準化個案辨識。
- 臨床沒有單一特異的理學或實驗室檢查。
- 應結合「未適應者上升後數小時至3日出現不適」、功能受影響程度及替代診斷。
- 脫水、疲勞、一氧化碳中毒、低血糖、低體溫及低鈉血症均可能模仿AMS。doi.org

若出現共濟失調、意識改變或腦病變表現，應視為疑似HACE；需停止上升並迅速下降，必要時給氧、可攜式加壓艙及dexamethasone，不能等待量表分數或頭痛是否典型。journals.sagepub.com